



RUMAH SAKIT  
**PRIMA HUSADA**

**LAPORAN BULAN MEI  
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG  
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

[www.rs-primahusada.com](http://www.rs-primahusada.com)

DAFTAR ISI  
DAFTAR ISI

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar Isi .....                                            | i   |
| Bab I Pendahuluan .....                                     | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1   |
| 1.2 Tujuan .....                                            | 1   |
| Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang .....  | 2   |
| 2.1 Visi .....                                              | 2   |
| 2.2 Misi .....                                              | 2   |
| 2.3 Motto .....                                             | 2   |
| 2.4 7 Nilai Budi Utama .....                                | 2   |
| 2.5 Struktur Organisasi .....                               | 3   |
| Bab III Laporan Kinerja Pelayanan .....                     | 4   |
| 3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) ..... | 4   |
| 3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO .....                | 4   |
| 3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO .....               | 4   |
| 3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut .....                       | 4   |
| 3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan .....                          | 5   |
| 3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada .....            | 6   |
| 3.3 Kinerja Bidang Pelayanan .....                          | 15  |
| 3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik .....                          | 15  |
| 3.3.2 Rawat Inap .....                                      | 18  |
| 3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) .....                       | 27  |
| 3.3.4 High Care Unit (HCU) .....                            | 28  |
| 3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) .....                   | 29  |
| 3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) .....                   | 30  |
| 3.4 Kinerja Bidang Penunjang .....                          | 31  |
| 3.4.1 Instalasi Farmasi .....                               | 31  |
| 3.4.2 Laboratorium .....                                    | 49  |
| 3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran .....                       | 54  |
| 3.4.4 Radiologi .....                                       | 62  |
| 3.4.5 Gizi .....                                            | 67  |
| 3.4.6 CSSD - Laundry .....                                  | 73  |
| 3.5 Kinerja Bidang Umum .....                               | 77  |
| 3.5.1 SDM .....                                             | 77  |
| 3.5.2 IPSRS .....                                           | 86  |
| 3.5.3 Security .....                                        | 95  |
| 3.5.4 Parkir .....                                          | 100 |
| 3.5.5 Humas Marketing .....                                 | 100 |
| 3.5.6 Penjaminan .....                                      | 132 |
| 3.5.7 PIPP – MOD – MPP .....                                | 133 |
| 3.5.8 <i>Cleaning Service</i> .....                         | 141 |
| 3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum .....                       | 142 |
| 3.5.10 IT - SIMRS .....                                     | 144 |
| 3.5.11 Driver .....                                         | 154 |
| 3.5.12 PRIMANTARA .....                                     | 155 |
| 3.6 Komite dan Tim .....                                    | 156 |
| 3.6.1 Komite Mutu .....                                     | 156 |
| 3.6.2 Komite PPI .....                                      | 210 |
| 3.6.3 Tim PKRS .....                                        | 229 |
| 3.6.4 Tim Prognas .....                                     | 230 |
| 3.6.5 Tim PPRA .....                                        | 271 |
| 3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT .....                         | 278 |
| 3.7 Permasalahan Rumah Sakit .....                          | 281 |
| 3.8 Profil SDM .....                                        | 288 |
| Bab IV Kesimpulan dan Saran .....                           | 292 |
| Bab V Penutup .....                                         | 292 |

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

#### **1.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Mei Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG**

#### **2.1 VISI**

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

#### **2.2 MISI**

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

#### **2.3 MOTTO**

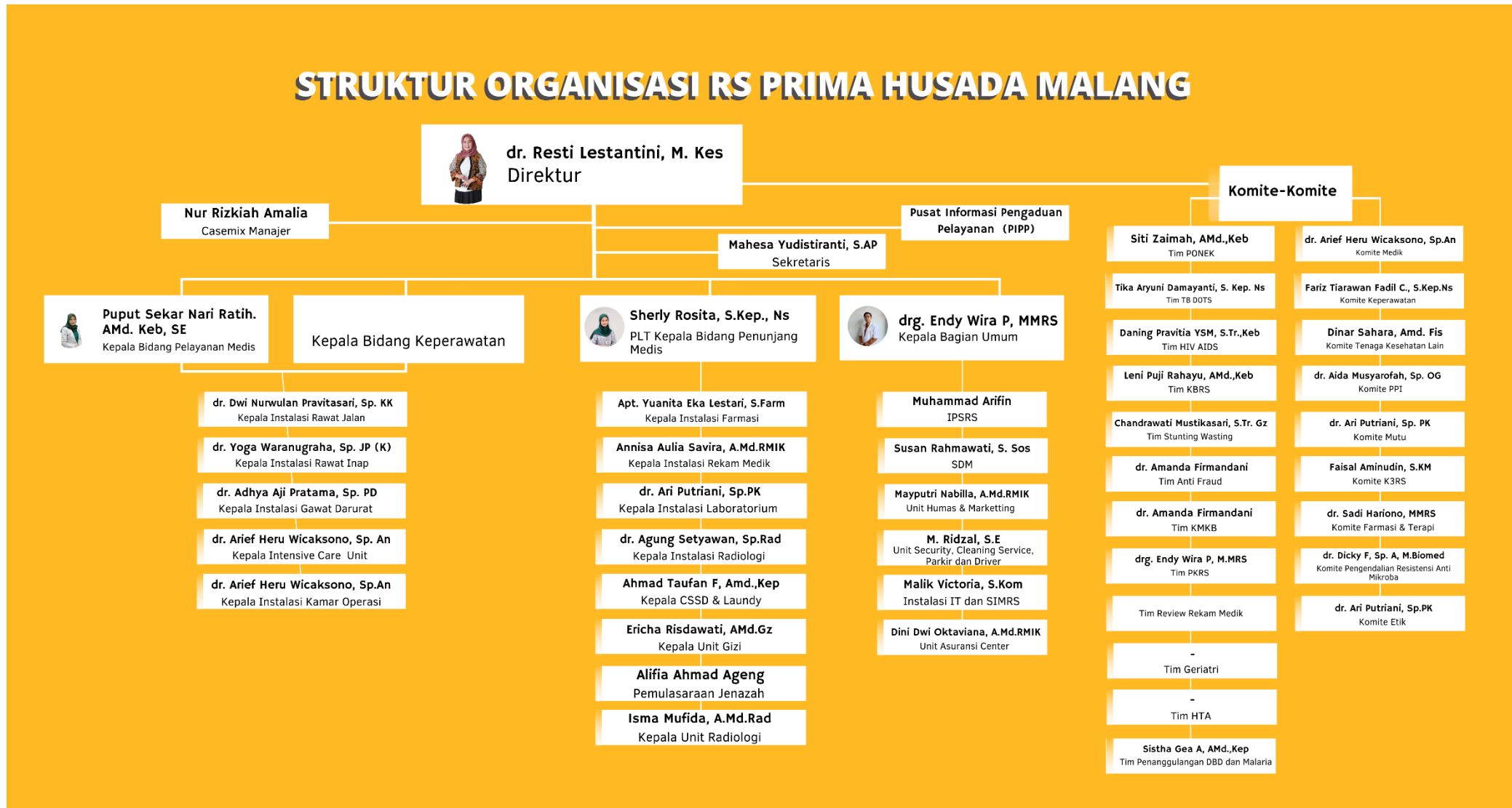
Sahabat Menuju Sehat

#### **2.4 7 NILAI BUDI UTAMA**

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

## 2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



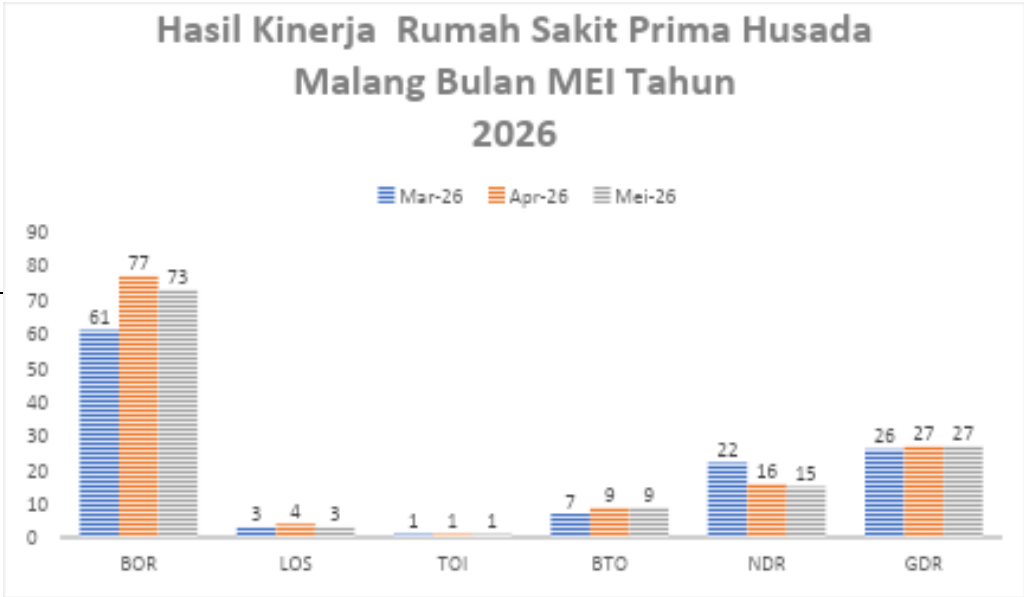
BAB III  
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

| INDIKATOR | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 |
|-----------|------------|------------|----------|
| BOR       | 61         | 77         | 73       |
| LOS       | 3 hari     | 4 hari     | 3 hari   |
| TOI       | 1 hari     | 1 hari     | 1 hari   |
| BTO       | 7 hari     | 9 hari     | 9 hari   |

Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

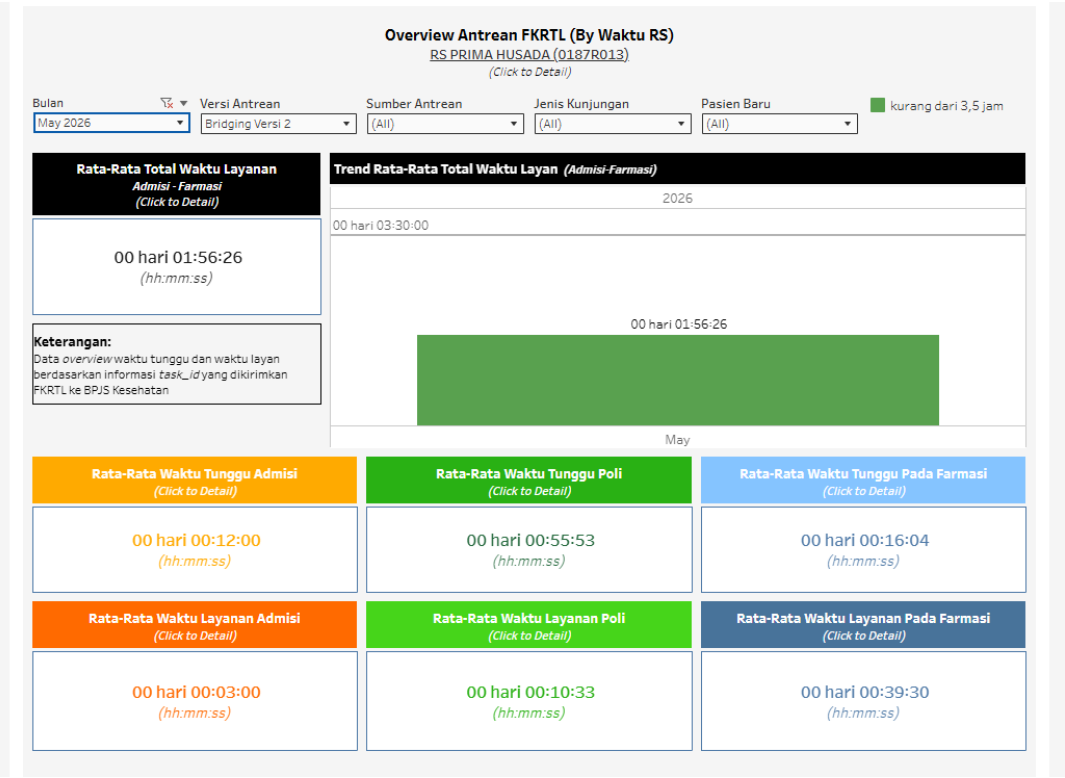


3.1.1 Tabel Analisa, Masalah dan Tindak Lanjut

| INDIKATOR           | ANALISA                                                                                                                                                                     | MASALAH                                                                                | RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOR (73%)           | BOR Mei 2026 sebesar 73%, mengalami penurunan dibanding April (77%) namun masih berada dalam standar ideal Kemenkes (60–85%). Pemanfaatan tempat tidur masih cukup optimal. | Terjadi penurunan utilisasi tempat tidur dibanding bulan sebelumnya.                   | Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan dan dokter penanggung jawab untuk optimalisasi pemanfaatan tempat tidur serta mempercepat proses admisi pasien yang membutuhkan rawat inap. |
| LOS / ALOS (3 hari) | LOS Mei 2026 sebesar 3 hari, sama dengan Maret dan lebih rendah dibanding April (4 hari). Masih dalam batas efisien sesuai karakteristik rumah sakit.                       | Perlu dipastikan LOS yang rendah tidak disebabkan pemulangan pasien yang terlalu dini. | Melakukan monitoring kesesuaian lama perawatan berdasarkan diagnosis dan clinical pathway serta evaluasi kasus readmisi.                                                                  |
| TOI (1 hari)        | TOI Mei 2026 sebesar 1 hari, menunjukkan tempat tidur yang kosong dapat segera terisi kembali. Nilai masih sesuai standar ideal (1–3 hari).                                 | Tidak ditemukan masalah signifikan.                                                    | Mempertahankan koordinasi antara ruang perawatan, admission, dan IGD agar pemanfaatan tempat tidur tetap optimal.                                                                         |

|              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BTO (9 kali) | BTO Mei 2026 sebesar 9 kali, meningkat dibanding Maret (7 kali) dan sama dengan April (9 kali). Menunjukkan frekuensi penggunaan tempat tidur cukup baik.             | Tingginya frekuensi pergantian pasien berpotensi meningkatkan beban kerja petugas dan risiko infeksi. | Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pembersihan tempat tidur dan pengendalian infeksi serta monitoring beban kerja petugas.                                                                  |
| NDR (15‰)    | NDR Mei 2026 sebesar 15‰, mengalami penurunan dibanding Maret (22‰) dan April (16‰), menunjukkan perbaikan mutu pelayanan. Namun masih di atas standar ideal (< 10‰). | Angka kematian pasien setelah dirawat ≥48 jam masih relatif tinggi.                                   | Melakukan audit kematian (death review), evaluasi ketepatan diagnosis dan terapi, serta peningkatan monitoring pasien berisiko tinggi.                                                            |
| GDR (27‰)    | GDR Mei 2026 sebesar 27‰, sama dengan April dan sedikit meningkat dibanding Maret (26‰). Nilai masih di atas standar ideal (< 25‰).                                   | Angka kematian keseluruhan masih cukup tinggi.                                                        | Melakukan analisis penyebab kematian, peningkatan kewaspadaan dini pasien kritis, evaluasi sistem rujukan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan. |

3.1 Terkait BPJS Kesehatan



| NO | KETERANGAN            |         | BULAN (2026)           |          |          |          |          |          |   |
|----|-----------------------|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
|    |                       |         | Rata - rata Tahun 2025 | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6 |
| 1  | Total Waktu Layanan   | 2:12:37 | 01:46:32               | 1:46:40  | 1:41:56  | 1:43:59  | 1:32:41  | 1:56:26  |   |
| 2  | Waktu Tunggu Admisi   | 0:11:52 | 0:08:14                | 0:12:00  | 00:12:00 | 0:12:00  | 0:12:00  | 0:12:00  |   |
| 3  | Waktu Layanan Admisi  | 0:07:49 | 0:06:01                | 0:03:00  | 0:03:00  | 0:03:00  | 0:03:00  | 0:03:00  |   |
| 4  | Waktu Tunggu Poli     | 1:03:51 | 0:58:16                | 00:56:31 | 00:53:52 | 00:50:51 | 00:55:59 | 00:55:53 |   |
| 5  | Waktu Layanan Poli    | 0:14:56 | 0:09:55                | 0:10:13  | 0:10:01  | 0:09:30  | 0:10:20  | 0:10:33  |   |
| 6  | Waktu Tunggu Farmasi  | 0:14:47 | 0:09:02                | 0:09:57  | 0:14:48  | 0:16:30  | 0:17:06  | 0:16:04  |   |
| 7  | Waktu Layanan Farmasi | 0:54:42 | 0:36:47                | 0:32:48  | 0:36:36  | 0:31:05  | 0:33:49  | 0:39:30  |   |

**Analisis :**  
Pada bulan ini masih Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan tahun 2025.

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan   | Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika                                     |
| Do     | Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer     |
| Study  | Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.                       |
| Action | 1. Menghubungi programmer<br>2. Monitoring evaluasi<br>3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev |

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.3 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

| NO                               | UNIT | PENGEMBANGAN PELAYANAN | PROGRESS PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | KENDALA                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                | IRJA | Poli Harmoni           | 1. Bulan April 2026 ada 1 pasien untuk poli harmoni.<br><br>2. Pengembangan stifin tidak hanya untuk individu saja, targetnya adalah keluarga, pasangan, corporate dan tim<br><br>3. Mempromosikan kembali stifin di poli harmoni dengan update flyer : Rp. 750.000 free cek Golda, free konsultasi | 1. Kunjungan pasien masih sedikit<br><br>2. Dengan standart harga yang cukup tinggi, dibutuhkan untuk marketing lebih konsisten dan mengenalkan ke masyarakat luas tidak hanya lewat sosmed melainkan grup |



|   |                  |                                               | gizi,free konseling<br>terapi wicara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | komunitas atau<br>organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | IRJA-Poli<br>MCU | Penerimaan MCU<br>corporate                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Humas menghubungi Perusahaan untuk penawaran MCU</li> <li>2. Surat penawaran untuk Perusahaan sudah di acc PT dengan tarif margin yang paling rendah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MCU Perusahaan BSI masih belum bisa terlaksana karena ada kendala IKS dengan Mandiri Inhealth.</li> <li>2. BSI menggunakan Mandiri inhealth untuk general check up 38 karyawannya</li> <li>3. Karena di malang hanya ada 3 RS yang di tetapkan untuk MIH, sehingga PHM belum bisa menerima MCU tsb tahun ini, bisa pengajuan untuk tahun depan</li> <li>4. Koordinasi dan follow up kembali terkait pengajuan RSPHM sebagai RS penerima layanan MCU Perusahaan</li> </ol> |
| 4 | IRJA-IRNA        | Meningkatkan kewaspadaan pelaporan kasus PD31 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karena wabah KLB campak di berbagai daerah, dinkes menghimbau RS untuk waspada terhadap peningkatan kasus campak</li> <li>2. Pelaporan dan pengambilan sampel harus real time dan dilaporkan ke puskesmas agar dipantau dan di petakan daerah yang positif terpapar</li> <li>3. Meningkatkan komunikasi dengan puskesmas baik di grup maupun tata laksana pelaporan kasus</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasus pelaporan yang sulit ada di rawat jalan, karena pasien sudah KRS dan kesulitan dalam pengambilan sampel</li> <li>2. Koordinasi dengan PKM agar diteruskan ke Perawat desa untuk ditindaklanjuti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | IRJA             | Absensi fingerprint DPJP                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitigasi resiko untuk kepatuhan DPJP</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan fingerprint dimulai</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>terhadap HFIS, setiap praktek poli atau yang terdaftar di HFIS wajib melakukan absensi datang dan pulang</p> <p>2. Membuat surat edaran terkait pelaksanaan dan pendaftaran fingerprint tanggal 29 mei 2026</p> <p>3. Pendaftaran fingerprint dilakukan oleh SDM, yanmed, karu irja dan dibantu IT</p> | <p>tanggal 4 Juni 2026</p> <p>2. Pemasangan fingerprint tanggal 3 juni 2026 koordinasi dengan IPSRS dan IT</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.2.2 Bidang Penunjang

| NO                            | UNIT         | PENGEMBANGAN PELAYANAN                                | PROGRESS PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                                      | KENDALA                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT |              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 1.                            | Depo Farmasi | 1. KPO Elektronik (E-KPO)                             | <p>a. Fitur cetak KPO sudah terlaksana pada tanggal 17 Desember 2025.</p> <p>b. Belum tersedia cover untuk arsip KPO pasien.</p> <p>c. Jumlah KPO tertinggal : 185.</p>                                                                                                    | Cover KPO tidak acc oleh managemen. Rencana menggunakan scan barcode untuk melihat data e-kpo.                             |
|                               |              | 2. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart       | <p>a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam vaccine refirigerator disertai Log tag.</p> <p>b. Tersedia cctv dan smart door lock.</p>     | Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan vaccine refirigerator. |
|                               |              | 3. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi | Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien | Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.                                   |

|  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                             | menggunakan google spreadsheet primantara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|  |  | 4. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis                                                                   | a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga vokasi farmasi kurang (jika ada staf yang sakit).<br>b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak.<br>c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu.<br>d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis. | Pengajuan fitur ke progamer.                                       |
|  |  | 5. Pengambilan obat dengan TTD elektronik                                                                                   | a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah.<br>b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.                                          | Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik. |
|  |  | 6. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi. | Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.                                                                       | Pengajuan fitur ke progamer.                                       |
|  |  | 7. Penambahan Fitur Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota, Laporan Resep Iter, Dan Laporan Resep PRB Di SIMRS        | Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu:<br>a. Format "Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota", berisi: nomor, nomor registrasi, tanggal registrasi, no. rm, nama pasien, nama dokter unit asal, no. kartu, no.                                                                                                                         | Pengajuan fitur ke progamer.                                       |

|  |  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                      | <p>sep, no. nota, tgl. Nota, nama obat, jumlah obat, hasil pemeriksaan penunjang.</p> <p>b. Format laporan resep iter, berisi: nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter.</p> <p>c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKRTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.</p> |                                                                                           |
|  |  | 8. Rekam medis beralih ke E-RM                                       | <p>Fitur E-RM yang sudah tersedia di SIMRS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonsiliasi obat</li> <li>- Daftar pemberian obat</li> <li>- Catatan Riwayat Penggunaan Obat</li> <li>- Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi - Rawat Inap</li> <li>- Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS :</li> <li>- Pemantauan Terapi Obat</li> </ul> <p>Fitur E-RM yang belum tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Terapi Obat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : Pemantauan Terapi Obat. Dalam antrian progamer. |
|  |  | 9. ERM :Pemberian edukasi penggunaan obat pulang (Pasien rawat inap) | <p>Penambahan fitur Pemberian Edukasi Penggunaan Obat Pulang. Data "Resep Final" langsung muncul sesuai obat yang ada di "Ringkasan Pulang" bagian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pengajuan fitur ke progamer.                                                              |

|    |                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                |                                                                                                    | “Obat Pulang” sehingga farmasi bisa langsung ttd serah terima obat di depo farmasi.                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|    |                | 10. Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan                 | Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan sudah tersedia di resep namun belum ada keterangan di kolom penerima obat “Pasien telah menerima KIE serta instruksi obat oleh petugas farmasi”. Mengajukan fitur di SIMRS agar langsung tercetak di kolom penerima obat | Pengajuan ke fitur progamer.              |
|    |                | 11. Penambahan fitur potensi PRB                                                                   | Belum tersedia fitur identifikasi obat-obatan rutin dinotifikasi dalam SIMRS farmasi untuk dijadikan data potensi PRB dan disampaikan ke DPJP.                                                                                                                                                          | Pengajuan ke fitur progamer.              |
|    |                | 12. Penambahan fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu                 | a. Belum tersedia fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu<br>b. Meminimalisir waktu tunggu pasien yang menunggu di farmasi dan mengurangi complain pasien.                                                                                                                  | Pengajuan ke fitur progamer.              |
|    |                | 13. Penambahan fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep                          | Belum tersedia fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep, agar DPJP mengetahui obat yang akan habis kurang dari 6 bulan                                                                                                                                                                | Pengajuan ke fitur progamer.              |
|    |                | 14. Penambahan fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep                                  | Belum tersedia fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep untuk memudahkan DPJP jika terjadi kekosongan obat bisa langsung substitusi obat yang lain sesuai kelas terapi tanpa perlu konfirmasi ke farmasi.                                                                                     | Pengajuan ke fitur progamer.              |
|    |                | 15. Penambahan fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama                              | a. Tersedia fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama.<br>b. Memudahkan DPJP saat input resep agar tidak terjadi input resep yang sama dan mempercepat farmasi proses resep.                                                                                                               | Pengajuan ke fitur progamer.              |
| 2. | Gudang Farmasi | 1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran | a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024.                                                                                                                                                                                                                                  | Monitoring dan evaluasi system elektronik |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | stok. | <p>b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024.</p> <p>c. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024.</p> <p>d. Scan barcode di SIMRS sudah di trial. Hasil evaluasi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerimaan barang memerlukan waktu lama karna scanning hanya untuk pencarian nama barang namun jumlah, no. batch dan expired data di ketik manual.</li><li>- Penyiapan barang memerlukan waktu lama dan meningkatkan kebutuhan tenaga.</li><li>- Penggunaan sistem barcode menambah tahapan kerja karena petugas harus melakukan scanning satu per satu pada item yang disiapkan sehingga proses penyiapan menjadi lebih panjang dan memperlambat alur kerja.</li><li>- Proses terhambat karena harus menambah master barcode terlebih dahulu.</li><li>- Membutuhkan waktu lebih lama dalam pencarian item. Petugas harus melakukan pencarian manual dengan scroll daftar item sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan dan menambahkan master barang.</li><li>- Monitoring barang yang belum disiapkan menjadi sulit/kurang efektif</li></ul> |  |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                              |             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |             |                                                                                                  | <p>karena petugas harus mengklik nama barang terlebih dahulu untuk melihat jumlah keluar, sehingga menyulitkan monitoring barang yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sudah disiapkan,</li> <li>• belum disiapkan,</li> <li>• maupun yang masih kurang.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses scanning terhambat, membutuhkan input manual, dan memperlambat penyiapan barang.</li> <li>- Efisiensi operasional belum tercapai. Proses masih membutuhkan tambahan tenaga dan waktu dibandingkan metode sebelumnya.</li> <li>- Menyebabkan ketidaksesuaian data, kebingungan dalam monitoring stok, dan potensi kesalahan pencatatan distribusi barang.</li> </ul> |                                                                                               |
|                              |             | 2. Perluasan Gudang Farmasi                                                                      | a. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Follow up pengadaan katrol.                                                                   |
| <b>Instalasi Rekam Medis</b> |             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| 1.                           | Rekam Medis | 1. Aplikasi ERM IRJA                                                                             | <p>1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM</p> <p>2. Kendala teknis sistem</p> <p>3. Keterbatasan SDM dan adaptasi pengguna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sebagian besar poli telah menggunakan ERM, namun Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM |
|                              |             | 2. Pengiriman data kunjungan dan diagnosis pasien rawat jalan (ERM maupun non-ERM) ke SATU SEHAT | <p>Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari.</p> <p>Temuan dan TL :</p> <p>a. ERM yang belum lengkap dan valid.</p> <p>TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monitoring dan Evaluasi.                                                                      |

|                          |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              |                                                                          | <p>b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK.<br/>TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK.</p> <p>c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap.<br/>TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.</p> |                                                                                                                                                                                   |
|                          |              | 3. APM (Pendaftaran pasien BPJS yang sudah reservasi melalui mobile JKN) | <p>Pasien BPJS yang sudah reservasi Mobile JKN tidak dapat diproses di APM masih harus diarahkan ke loket.<br/>TL: Memaksimalkan petugas menjaga APM dan memberikan arahan pada pasien.</p>                                                               | Sebagian pasien BPJS sudah menggunakan APM, namun masih terdapat kegagalan proses pendaftaran. Sosialisasi ulang kepada pasien terkait alur APM dan Mobile JKN.                   |
|                          |              | 4. Retensi dan Pemusnahan Berkas DRM                                     | <p>1. Masih terdapat penumpukan DRM inaktif<br/>2. Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan<br/>3. Proses digitalisasi (scan) belum seluruhnya selesai</p>                                                                                                  | <p>1. Melanjutkan pemilahan DRM sesuai jadwal retensi<br/>2. Prioritas penyelesaian DRM kematian dan DRM inaktif lama<br/>3. Penjadwalan kegiatan scanning sebelum pemusnahan</p> |
| <b>Unit Laboratorium</b> |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| 1                        | Laboratorium | 1. Pengembangan Pelayanan LIS                                            | Pemasangan server dan proses dari vendor sudah slesai, menunggu proses blicing dari SIMRS Rumah sakit.                                                                                                                                                    | Proses Blicing SIMRS                                                                                                                                                              |
| <b>Unit Gizi</b>         |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| 1                        | Gizi         | Pemesanan diet dari klinik Mitra (luar).                                 | <p>-Sudah ada kerjasama terkait pemesanan diet dari klinik luar.<br/>-Sudah dibuatkan SPO dan alur pemesanan diet melalui spreadsheet dan whatsapp.<br/>-Sudah dilakukan pengajuan tarif pelayanan pemesanan diet pada PT.</p>                            | -Masih menunggu hasil pengajuan tarif untuk klaim pelayanan pemesanan diet dari PT.                                                                                               |
| <b>SSD-LAUNDRY</b>       |              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| 1                        | CSSD-Laundry | Monitoring pelayanan berbasis elektronik                                 | <p>-Sudah dilakukan dokumentasi indikator steril digital dengan spreadsheet.<br/>-Sudah dilakukan</p>                                                                                                                                                     | -Monitoring kepatuhan pengisian                                                                                                                                                   |



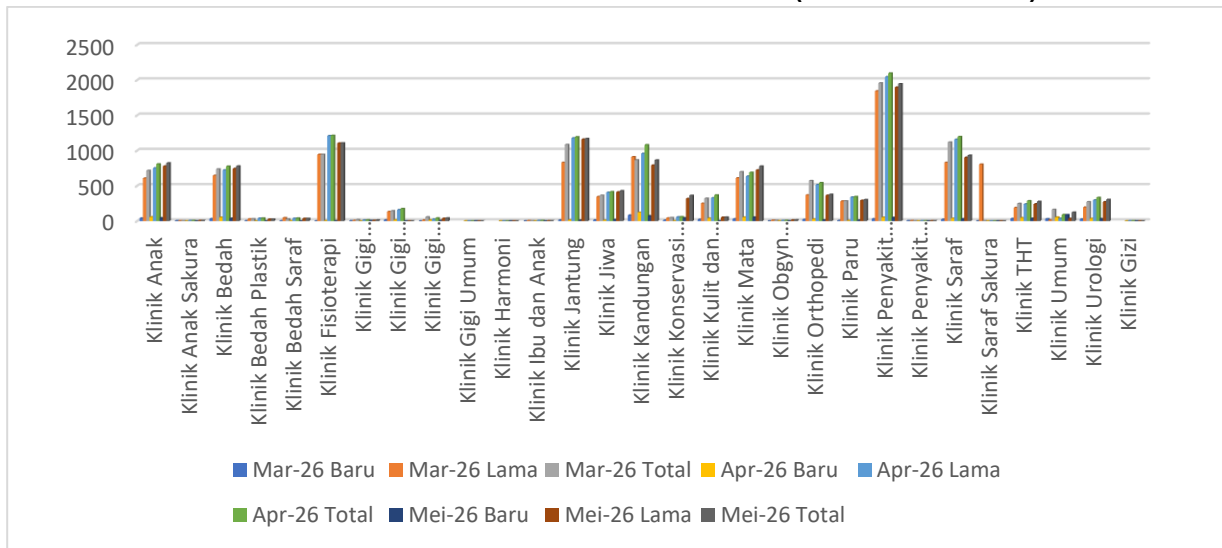
|          |           |                                          |                                                        |                                                                 |
|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |           |                                          | pencatatan serah terima paper less dengan spreadsheet. |                                                                 |
| ADIOLOGI |           |                                          |                                                        |                                                                 |
| 1        | Radiologi | Pengadaan upgrade system IT (SIMRS/PACS) | -Sudah dilakukan pengajuan bulan Maret 2026            | -Belum ditindaklanjuti programmer, menunggu antrian pengerjaan. |

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan  
3.3.3 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru (Maret – Mei 2026)

| Nama Unit                    | Mar-26 |      |       | Apr-26 |      |       | Mei-26 |      |       |
|------------------------------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|
|                              | Baru   | Lama | Total | Baru   | Lama | Total | Baru   | Lama | Total |
| Klinik Anak                  | 40     | 606  | 715   | 56     | 752  | 808   | 43     | 779  | 822   |
| Klinik Anak Sakura           | 2      | 2    | 3     | 1      | 5    | 6     | 1      | 5    | 6     |
| Klinik Bedah                 | 32     | 645  | 736   | 52     | 723  | 775   | 37     | 742  | 779   |
| Klinik Bedah Plastik         | 2      | 28   | 29    | 1      | 38   | 39    | 0      | 25   | 25    |
| Klinik Bedah Saraf           | 3      | 45   | 28    | 3      | 37   | 40    | 0      | 34   | 34    |
| Klinik Fisioterapi           | 0      | 943  | 943   | 4      | 1209 | 1213  | 2      | 1104 | 1106  |
| Klinik Gigi Ortodonti        | 2      | 7    | 18    | 1      | 13   | 14    | 5      | 7    | 12    |
| Klinik Gigi Pedodontis       | 14     | 133  | 144   | 15     | 159  | 174   | 0      | 0    | 0     |
| Klinik Gigi Periodonti       | 1      | 12   | 56    | 14     | 27   | 41    | 6      | 36   | 42    |
| Klinik Gigi Umum             |        |      |       | 0      | 1    | 1     | 0      | 0    | 0     |
| Klinik Harmoni               |        |      |       | 0      | 1    | 1     | 0      | 0    | 0     |
| Klinik Ibu dan Anak          | 0      | 4    | 3     | 0      | 5    | 5     | 0      | 3    | 3     |
| Klinik Jantung               | 13     | 830  | 1083  | 15     | 1177 | 1192  | 9      | 1159 | 1168  |
| Klinik Jiwa                  | 12     | 344  | 364   | 10     | 405  | 415   | 17     | 411  | 428   |
| Klinik Kandungan             | 82     | 909  | 865   | 122    | 958  | 1080  | 72     | 791  | 863   |
| Klinik Konservasi Gigi       | 10     | 42   | 47    | 2      | 56   | 58    | 44     | 318  | 362   |
| Klinik Kulit dan Kelamin     | 21     | 250  | 321   | 39     | 328  | 367   | 2      | 52   | 54    |
| Klinik Mata                  | 29     | 610  | 696   | 53     | 635  | 688   | 54     | 723  | 777   |
| Klinik Obgyn Sakura          | 0      | 9    | 8     | 2      | 5    | 7     | 3      | 12   | 15    |
| Klinik Orthopedi             | 20     | 369  | 571   | 28     | 514  | 542   | 13     | 364  | 377   |
| Klinik Paru                  | 6      | 281  | 283   | 6      | 338  | 344   | 10     | 292  | 302   |
| Klinik Penyakit Dalam        | 30     | 1844 | 1956  | 51     | 2045 | 2096  | 48     | 1897 | 1945  |
| Klinik Penyakit Dalam Sakura | 3      | 4    | 2     | 0      | 3    | 3     | 1      | 2    | 3     |
| Klinik Saraf                 | 22     | 830  | 1118  | 37     | 1158 | 1195  | 29     | 902  | 931   |
| Klinik Saraf Sakura          | 0      | 804  | 2     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0    | 0     |
| Klinik THT                   | 33     | 190  | 247   | 45     | 240  | 285   | 36     | 240  | 276   |
| Klinik Umum                  | 29     | 15   | 162   | 53     | 36   | 89    | 88     | 35   | 123   |
| Klinik Urologi               | 27     | 194  | 272   | 35     | 297  | 332   | 32     | 271  | 303   |
| Klinik Gizi                  |        |      |       | 1      | 2    | 3     | 0      | 0    | 0     |

Grafik Pasien Lama dan Baru Bulan (Maret - Mei 2026)



Analisis :

|   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Total kunjungan rawat jalan dan IGD bulan Mei 2026 sebanyak 11.821 kunjungan. Kunjungan didominasi pasien BPJS Kesehatan sebanyak 9.243 kunjungan (78,19%), diikuti pasien umum sebanyak 2.189 kunjungan (18,52%). |
| 2 | Kunjungan tertinggi terdapat pada Klinik Penyakit Dalam (1.945 kunjungan), diikuti Klinik Jantung (1.168 kunjungan), Klinik Fisioterapi (1.106 kunjungan), dan IGD (1.065 kunjungan).                              |
| 3 | Sebagian besar kunjungan merupakan pasien lama sebanyak 10.938 kunjungan (92,53%), sedangkan pasien baru hanya 883 kunjungan (7,47%).                                                                              |
| 4 | Klinik Umum memiliki proporsi pasien baru yang tinggi (88 pasien baru dan 35 pasien lama).                                                                                                                         |
| 5 | Beberapa klinik memiliki kunjungan sangat rendah bahkan tidak ada kunjungan, seperti Klinik Gigi Pedodontis, Klinik Gigi Umum, Klinik Harmoni, Klinik Gizi, dan Klinik Saraf Sakura.                               |
| 6 | Kunjungan IGD mencapai 1.065 kunjungan dengan dominasi pasien umum dan BPJS.                                                                                                                                       |
| 7 | Kunjungan pasien dari BPJS TK (188 kunjungan), Asuransi Swasta (167 kunjungan), Perusahaan (32 kunjungan), dan Jasa Raharja (2 kunjungan) masih relatif rendah.                                                    |
| 8 | Klinik Mata (777 kunjungan), Klinik Kandungan (863 kunjungan), Klinik Saraf (931 kunjungan), dan Klinik Bedah (779 kunjungan) menunjukkan kunjungan yang stabil dan tinggi.                                        |

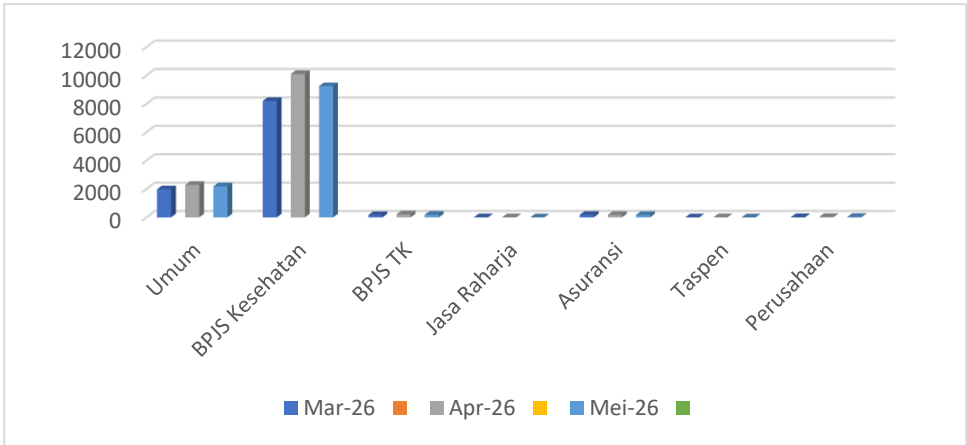
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

### 1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

| No    | Jenis Pembayaran | Mar-26 | %     | Apr-26 | %      | Mei-26 | %      |
|-------|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | Umum             | 1978   | 19%   | 2290   | 17,86% | 2189   | 18,52% |
| 2     | BPJS Kesehatan   | 8204   | 78%   | 10099  | 78,78% | 9243   | 78,19% |
| 3     | BPJS TK          | 161    | 2%    | 213    | 1,66%  | 188    | 1,59%  |
| 4     | Jasa Raharja     | 11     | 0%    | 7      | 0,05%  | 2      | 0,02%  |
| 5     | Asuransi         | 175    | 2%    | 178    | 1,39%  | 167    | 1,41%  |
| 6     | Taspen           | 5      | 0%    | 6      | 0,05%  | 0      | 0,00%  |
| 7     | Perusahaan       | 17     | 0%    | 27     | 0,21%  | 32     | 0,27%  |
| TOTAL |                  |        | 10551 | 100%   | 12820  | 100%   | 11821  |

#### 1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



#### Analisis :

- 1 Total kunjungan pasien poli mengalami peningkatan berturut-turut: Februari 11.506, Maret 10.551, April 12.820. April naik 21,5% dibanding Maret.
- 2 Kunjungan bulan Maret sempat menurun dibanding Februari (-8,3%), kemudian meningkat signifikan di April.
- 3 Pasien BPJS Kesehatan mendominasi seluruh kunjungan: Feb 9.112, Mar 8.204, Apr 10.099. Kontribusi April sekitar 78,8% dari total pasien.
- 4 Pasien Umum meningkat konsisten: Feb 1.966, Mar 1.978, Apr 2.290. Naik 15,8% dari Maret ke April.
- 5 Pasien BPJS TK meningkat pada April menjadi 213 pasien dari Maret 161 pasien.
- 6 Jasa Raharja menurun terus: Feb 15, Mar 11, Apr 7 pasien.
- 7 Asuransi Swasta relatif stabil: Feb 194, Mar 175, Apr 178 pasien.
- 8 TASPEN stagnan rendah: 5, 5, 6 pasien.
- 9 Perusahaan menurun dari 29 (Feb) menjadi 17 (Mar), naik ke 27 (Apr) namun belum kembali seperti Februari.
- 10 Semua segmen pasien meningkat pada April, terutama BPJS dan Umum.
- 11 Struktur pasar rumah sakit masih didominasi pembayar pemerintah/jaminan sosial.
- 12 Tren April menunjukkan momentum pertumbuhan positif.

#### Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

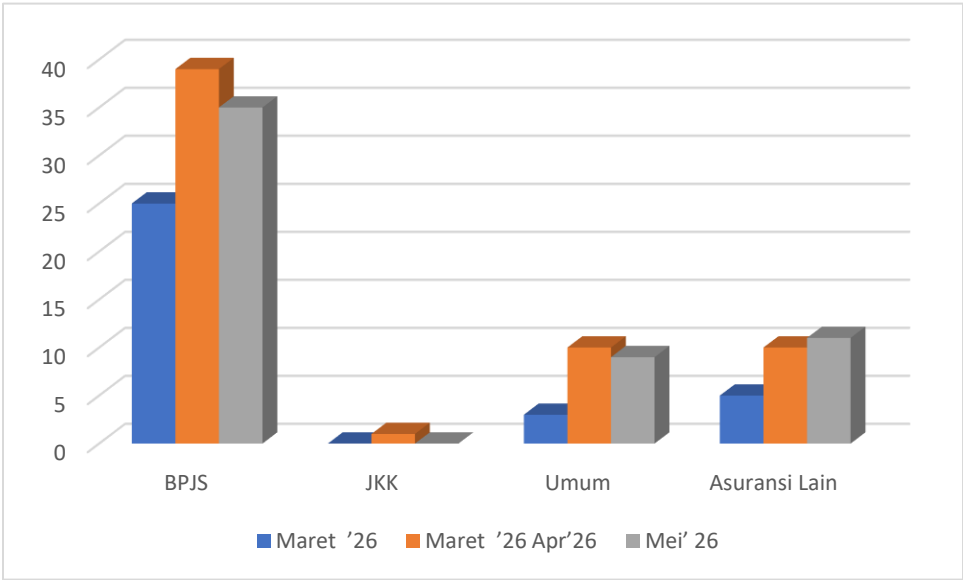
3.1.3 Rawat Inap

3.1.3.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Maret - Mei 2026)

| NO           | Hal           | Maret . '26 | Apr'26 | Mei' 26 | Persentaser terhadap bulan sebelumnya |
|--------------|---------------|-------------|--------|---------|---------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 25          | 39     | 35      | ↓10,25%                               |
| 2            | JKK           | 0           | 1      | 0       | ↓100%                                 |
| 3            | Umum          | 3           | 10     | 9       | ↓1%                                   |
| 4            | Asuransi Lain | 5           | 10     | 11      | ↓100%                                 |
| Total Pasien |               | 51          | 33     | 60      | 55                                    |

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| No. | Bulan      | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                               |                                                                                                            | Total Pasien                                                                   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | BPJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umum                                                    | JKK                           | JR/Asuransi                                                                                                |                                                                                |
| 1   | MARET 2026 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                       | 0                             | 5                                                                                                          | 33                                                                             |
|     | Analisa    | Bulan Maret pasien BPJS mengalami penurunan drastis dari 34 menjadi 25                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulan Maret pasien Umum turun drastic dari 10 menjadi 3 | Pasien JKK bulan Maret kosong | Untuk pasien asuransi di bulan Maret mengalami penurunan juga karena pasien banyak yg memakai BPJS dan COB | Total bulan Maret jumlah pasien mengalami penurunan drastic dari 51 menjadi 33 |
|     | RTL        | Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai |                                                         |                               |                                                                                                            |                                                                                |

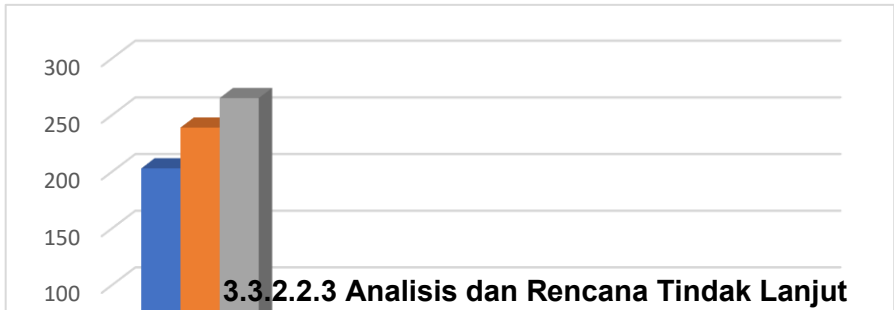
|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                               |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   | kelanjutan perawatan pasca rawat inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                               |
| 2 | <b>APRIL 2026</b> | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                   | 1                                                                 | 10                                                                        | 60                                                                            |
|   | Analisa           | Bulan APRIL pasien BPJS mengalami kenaikan agak banyak dari 25 menjadi 39                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bulan April pasien umum mengalami kenaikan drastis dari 3 menjadi 10 | Pasien JKK bulan April ada 1 dikarenakan px JKK naik kelas ke VIP | Untuk pasien asuransi di bulan APRIL mengalami kenaikan dari 5 menjadi 10 | Total bulan APRIL jumlah pasien mengalami kenaikan drastis dari 33 menjadi 60 |
|   | <b>RTL</b>        | Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap                    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                               |
| 3 | <b>MEI 2026</b>   | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                    | 0                                                                 | 11                                                                        | 55                                                                            |
|   | Analisa           | Bulan MEI pasien BPJS mengalami penurunan dari 39 menjadi 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bulan MEI pasien umum mengalami penurunan dari 10 menjadi 9          | Pasien JKK bulan Mei tidak                                        | Untuk pasien asuransi di bulan Mei naik sedikit dari 10 ke 11             | Total bulan MEI jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 60 menjadi 55     |
|   | <b>RTL</b>        | Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                               |

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Maret-Mei 2026)

| NO           | Hal           | Maret'26 | April'26 | Mei'26 | Prosentase terhadap bulan sebelumnya |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 203      | 239      | 265    | ↑10%                                 |
| 2            | JR            | 1        | 0        | 1      | ↑100%                                |
| 3            | Umum          | 12       | 7        | 13     | ↑46%                                 |
| 4            | Asuransi Lain | 0        | 1        | 7      | ↑85%                                 |
| Total Pasien |               | 216      | 247      | 286    | 286                                  |

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

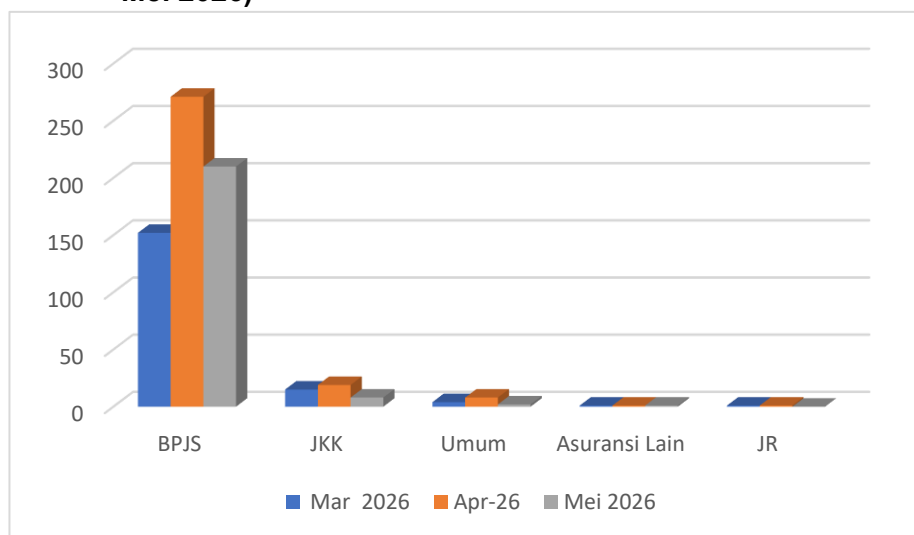
| No | Bulan                             | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | BPJS                                                                                                                                                                                           | Umum                                                                                                                                                                                                     | JR                                                                                                                                                                   | Asuransi                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 0                                 | BPJS                                                                                                                                                                                           | JR                                                                                                                                                                                                       | Pasien umum                                                                                                                                                          | Asuransi Lain                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Analisis capaian 3 bulan terakhir | Pasien BPJS mengalami peningkatan di bulan februari dan mengalami penurunan sebesar 7% di bulan maret, serta meningkat lagi sebebsar 15% di bulan April Mengalami peningkatan 10% di bulan Mei | Pasien umum mengalami peningkatan sebesar 66% pada Maret dan mengalami penurunan sejumlah 71% di bulan April, dikarenakan semua orang mempunyai BPJS, dan mengalami peningkatan sebesar 46% di bulan mei | Pasien JR mengalami penurunan 200% pada bulan maret dan mengalami penurunan lagi di bulan April sebanyak 100%, serta di bulan mei mengalami peningkatan sebesar 100% | Pasien Asuransi sama dengan bulan sebelumnya dan mengalami penurunan 100% di bulan April karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai jaminan asuransi, di bulan mei pasien asuransi mengalami peningkatan sebesar 85% | Jumlah pasien di BPJS di bulan Februari mengalami peningkatan sebanyak 6% dan mengalami penurunan di bulan maret sebesar 7% dan penurunan 200% pada pasien umum pada bulan februari dan mengalami peningkatan 66% di bulan maret dan kenaikan 66% pasien JR pada bulan februari serta mengalami penurunan sebesar 200% di bulan maret Dan pada bulan April pasien BPJS mengalami peningkatan sebebsar 15% serta jumlah keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 13% Pada bulan Mei jumlah keseluruhan pasien mengalami peningkatan sebebsar 14% yaitu sejumlah 286 |
|    | RTL                               | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya<br>Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret – Mei 2026)

| NO           | HAL           | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Persentase 2026 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 1            | BPJS          | 152      | 271      | 210      | ↓ 22.50 %       |
| 2            | JKK           | 15       | 19       | 8        | ↓ 57,89%        |
| 3            | Umum          | 4        | 8        | 2        | ↓ 75 %          |
| 4            | Asuransi Lain | 1        | 1        | 1        | 0 %             |
| 5            | JR            | 1        | 1        | 0        | ↓ 100 %         |
| Total Pasien |               | 173      | 300      | 221      | ↓ 26,33 %       |

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)



3.1.1.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

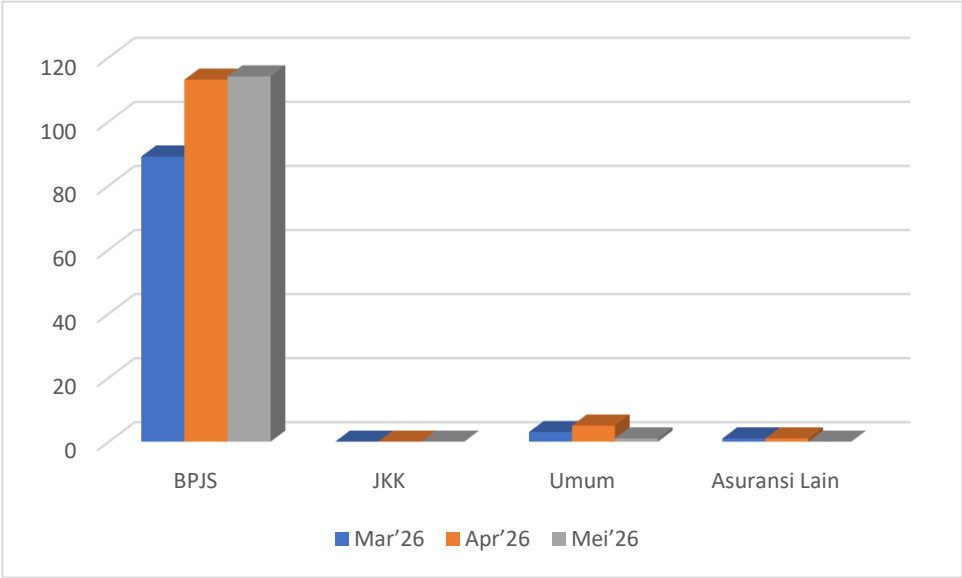
| No | Bulan                     | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                         | Kesimpulan                                                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | BPJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umum                                                                                                              | JKK                                                                                                                                        | JR/Asuransi                                                                                                             |                                                                                                                  |
| 1  | Analisis capaian Mei 2026 | Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan Mei 2026 sebanyak 79 pasien dibandingkan bulan April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasien Umum pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sebanyak 6 pasien karena tidak mempunyai BPJS maupun asuransi | Jumlah Pasien JKK pada bulan Mei 2026 menurun sebanyak 6 pasien kebanyakan pasien lodingan (operasi elektif) yang menggunakan penjamin JKK | Jumlah pasien JR bulan Mei 2026 tidak ada yang menggunakan penjamin JR, Untuk pasien Asuransi 1 pasien dibulan Mei 2026 | Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir banyak pada bulan Mei dengan jumlah pasien sebanyak 221 pasien |
| 2  | RTL                       | 1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya<br>2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap<br>3. Evaluasi antrian operasi elektif<br>4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif<br>5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit<br>6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh. |                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                  |

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Februari – April 2026)

| NO           | HAL           | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Prosentase terhadap bulan sebelumnya |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 89       | 113      | 114      | ↑0,87%                               |
| 2            | JKK           | 0        | 0        | 0        | 0                                    |
| 3            | Umum          | 3        | 5        | 1        | ↓80%                                 |
| 4            | Asuransi Lain | 1        | 1        | 0        | ↓100%                                |
| Total Pasien |               | 93       | 119      | 115      | ↓3,36%                               |

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| No | Bulan                       | RAWAT INAP                                                                           |                                                                                 |                                                    |                                                                                    | Kesimpulan                                                                                                         |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | BPJS                                                                                 | Umum                                                                            | JKK                                                | JR/Asuransi                                                                        |                                                                                                                    |
| 1  | Analisis capaian Maret 2026 | Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak<br>↑14,60% dari bulan sebelumnya    | Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak<br>↓33,33% dari bulan sebelumnya | Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya. | Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak<br>↓66,66% dari bulan sebelumnya | Pada bulan Maret 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar<br>↑10,75%% |
|    | RTL                         | 1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya |                                                                                 |                                                    |                                                                                    |                                                                                                                    |



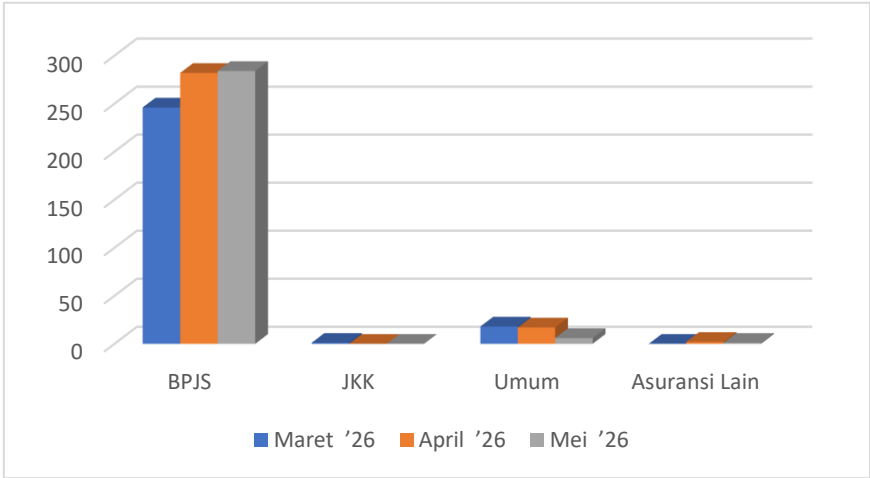
|   |                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                       |                                                                               |                                                                                                               |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Analisis capaian April 2026 | Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑ 21,23% dari bulan sebelumnya   | Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑40% dari bulan sebelumnya | Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.                                    | Pasien Asuransi / JR sama dengan kunjungan bulan sebelumnya                   | Pada bulan April 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑ 22%  |
|   | RTL                         | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya |                                                                             |                                                                                       |                                                                               |                                                                                                               |
| 3 | Analisis capaian Mei 2026   | Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑0,87% dari bulan sebelumnya     | Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak ↓80% dari bulan sebelumnya   | Pasien JKK sama mengalami penurunan sebanyak ↓100% dengan kunjungan bulan sebelumnya. | Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓100% dari bulan sebelumnya | Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar ↓3,36% |
|   | RTL                         | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya |                                                                             |                                                                                       |                                                                               |                                                                                                               |

### 3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

#### 3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)

| NO           | HAL           | Maret '26 | April '26 | Mei '26 | Prosentase terhadap bulan sebelumnya |
|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 246       | 282       | 284     | ↑ 0,7%                               |
| 2            | JKK           | 1         | 0         | 0       | 0%                                   |
| 3            | Umum          | 18        | 17        | 6       | ↓ 64,7%                              |
| 4            | Asuransi Lain | 0         | 2         | 1       | ↓100 %                               |
| Total Pasien |               | 265       | 301       | 291     | ↓3,32                                |

#### 3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

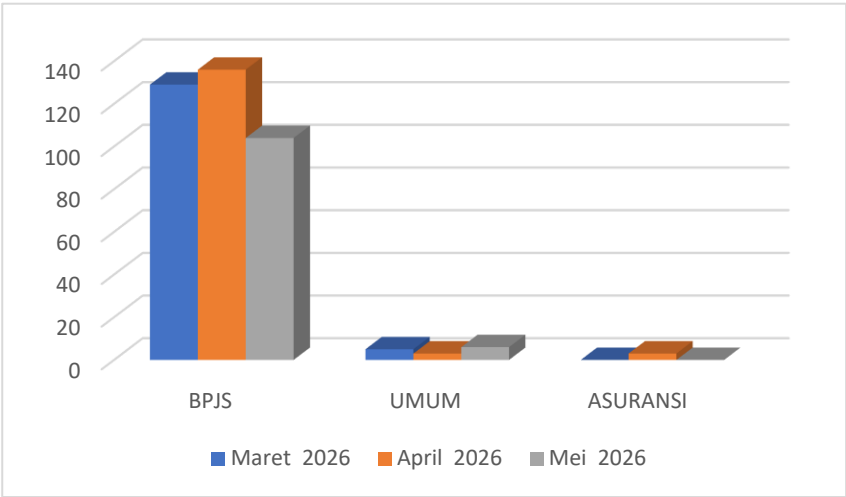
| Bulan                                              | Rawat Inap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                          | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | BPJS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umum                                                                                                                                               | JKK                                                                        | JR/Asuransi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir | Pasien BPJS mengalami terjadi peningkatan pada bulan mei 2026 yaitu sebanyak 2 pasien disebabkan banyaknya kunjungan pasien di IGD dengan penjamin kelas 3                                                                                                                                                                                                 | Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan mei 2026 yaitu sebanyak 11 pasien, yang datang ke IGD rata rata menggunakan penjamin BPJS untuk kelas 3 | Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan mei 2026 yaitu sebanyak 0 pasien | Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami penurunan 100% pada bulan mei 2026 | secara keseluruhan, total pasien mengalami peningkatan dari 265 pasien pada Maret menjadi 301 pasien pada April (naik 13,6%), kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 291 pasien pada Mei (turun 3,3% dibanding April). Meskipun terjadi penurunan pada Mei, jumlah pasien masih lebih tinggi dibandingkan bulan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa volume pelayanan rumah sakit selama periode tersebut relatif stabil |
| RTL                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya</li><li>2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap</li><li>3. Evaluasi antrian operasi elektif</li><li>4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif</li><li>5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan</li></ol> |                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)

| NO           | HAL      | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | (Persentase terhadap bulan sebelumnya) |
|--------------|----------|------------|------------|----------|----------------------------------------|
| 1            | BPJS     | 129        | 136        | 104      | 0,23%                                  |
| 2            | UMUM     | 5          | 3          | 6        | 0,5%                                   |
| 3            | ASURANSI | 0          | 3          | 0        | 1%                                     |
| Total Pasien |          | 134        | 142        | 110      | 0,22%                                  |

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

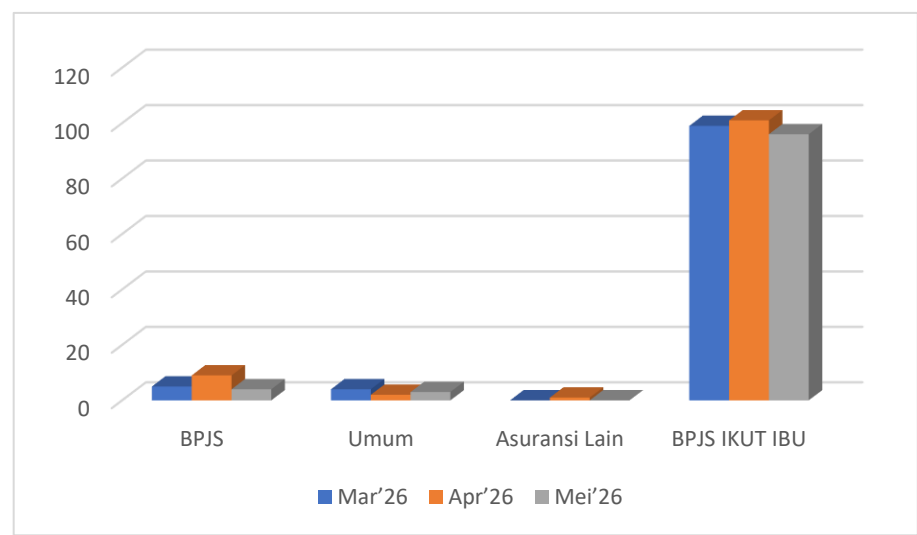
| No | Bulan                                  | RAWAT INAP                                                                       |                                                                                  |                                                        | Kesimpulan                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        | BPJS                                                                             | Umum                                                                             | JR/Asuransi                                            |                                                                                                                    |
|    | Analisis capaian Bulan Februari- April | Pasien BPJS pada bulan Mei mengalami Penurunan 0,23 %                            | Pasien umum pada bulan Mei mengalami kenaikan 0,5%                               | Tidak ada Pasien Asuransi pada bulan Mei               | Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana |
|    | RTL                                    | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan | Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD |                                                                                                                    |

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)

| NO           | HAL           | TARGET/BULAN | Mar'26 | Apr'26 | Mei'26 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 7            | 5      | 9      | 4      | ↓3,85%                               |
| 2            | Umum          | 2            | 4      | 2      | 3      | ↑2,89%                               |
| 3            | Asuransi Lain | 1            | 0      | 1      | 0      | 0                                    |
| 4            | BPJS IKUT IBU | 100          | 99     | 101    | 96     | ↓4,95%                               |
| Total Pasien |               | 110          | 107    | 108    | 113    | ↓7,96%                               |

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| No | Bulan      | Rawat Inap                                                                   |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                   | Total Pasien |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            | BPJS                                                                         | UMUM                                                                         | ASURANSI                                       | BPJS IKUT IBU                                                                                                                                                     |              |
| 1  | Maret 2026 | 5                                                                            | 4                                                                            | 0                                              | 99                                                                                                                                                                | 108          |
|    |            | Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 4,63% | Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 3,7%   | Tidak ada pasien asuransi                      | Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 91,7%                                                                                                            |              |
|    |            | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya     | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya     | Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan | Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil. |              |
| 2  | April 2026 | 9                                                                            | 2                                                                            | 1                                              | 101                                                                                                                                                               | 113          |
|    |            | Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 7,96%    | Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,77% | ada 1 pasien asuransi                          | Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 89,38%                                                                                                           |              |
|    |            | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya     | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya     | Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan | Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil. |              |

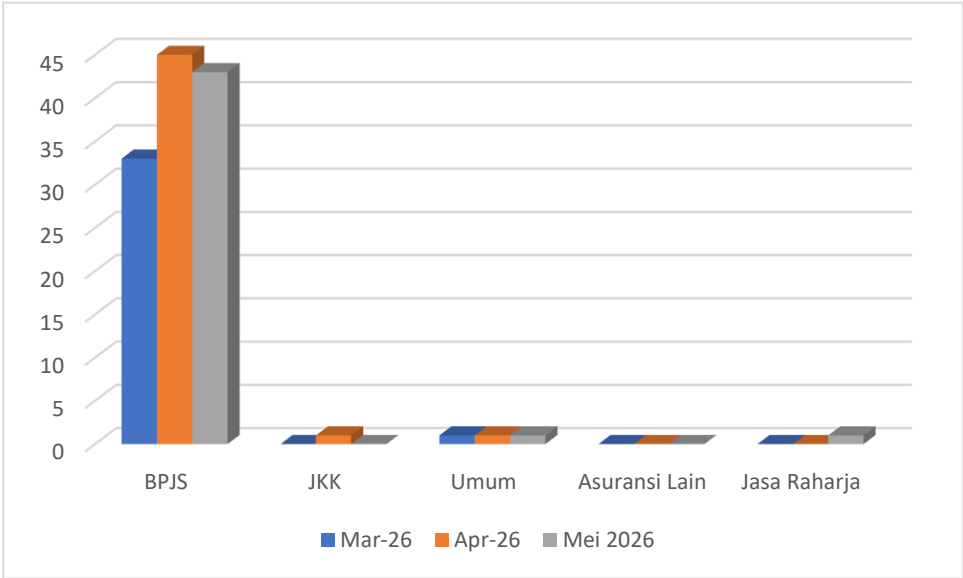
|   |          |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                   |     |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 |          | 4                                                                          | 3                                                                           | 0                                              | 96                                                                                                                                                                | 104 |
|   | Mei 2026 | Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 3,85% | Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,89% | Tidak ada pasien asuransi                      | Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 4,95%                                                                                                           |     |
|   |          | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya   | Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya    | Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan | Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil. |     |

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)

| NO           | Cara Bayar    | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | Prosentase terhadap bulan sebelumnya |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 33       | 45       | 43       | ↓0,04%                               |
| 2            | JKK           | 0        | 1        | 0        | ↓100%                                |
| 3            | Umum          | 1        | 1        | 1        | Tetap                                |
| 4            | Asuransi Lain | 0        | 0        | 0        | Tetap                                |
| 5            | Jasa Raharja  | 0        | 0        | 1        | ↑Tetap                               |
| Total Pasien |               | 34       | 47       | 45       | ↓0,04%                               |

3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

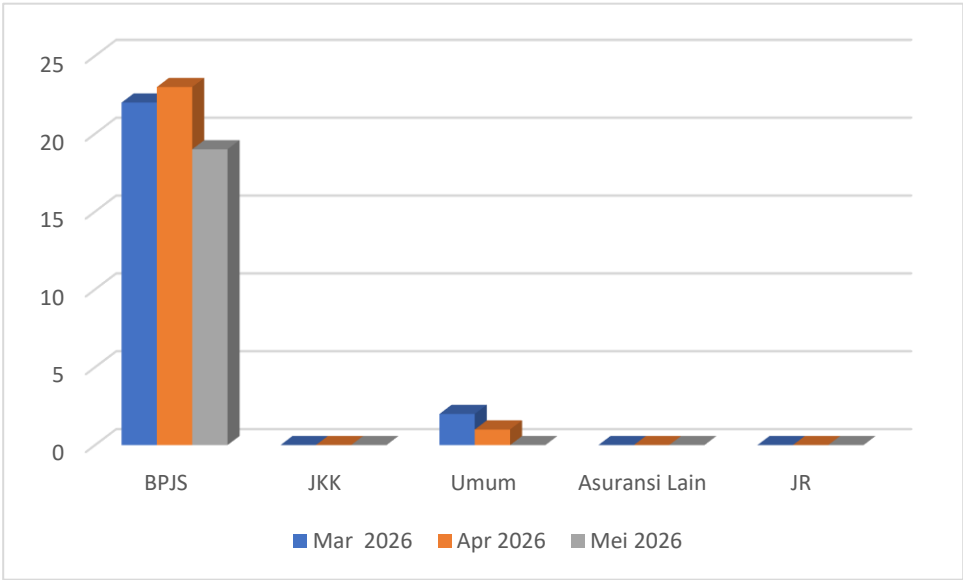
| NO. | BULAN | RAWAT INAP |      |     |             | KESIMPULAN |
|-----|-------|------------|------|-----|-------------|------------|
|     |       | BPJS       | UMUM | JKK | JR/ASURANSI |            |

|   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                            |                                                                                                                        |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Analisis 3 bulan terakhir | Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Mei 2026 mengalami penurunan 0,04% dibandingkan bulan sebelumnya                                                                                                                                                                                  | Pasien umum dalam 3 bulan terakhir jumlahnya tetap di bulan mei ada 1 pasien | Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada 1 di bulan april | ada 1 pasien penjamin JR di bulan Mei 2026 | Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,04 % dibandingkan dari bulan sebelumnya. |
| 2 | RTL                       | 1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya<br>2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU<br>3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit<br>4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat<br>5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU |                                                                              |                                                        |                                            |                                                                                                                        |

3.1.2
High Care Unit (HCU)
3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)

| NO           | HAL           | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 22       | 23       | 19       | ↓0,20%                               |
| 2            | JKK           | 0        | 0        | 0        | Tetap                                |
| 3            | Umum          | 2        | 1        | 0        | ↓100%                                |
| 4            | Asuransi Lain | 0        | 0        | 0        | Tetap                                |
| 5            | JR            | 0        | 0        | 0        | Tetap                                |
| Total Pasien |               | 24       | 24       | 19       | ↓0,20%                               |

3.1.1.1
Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

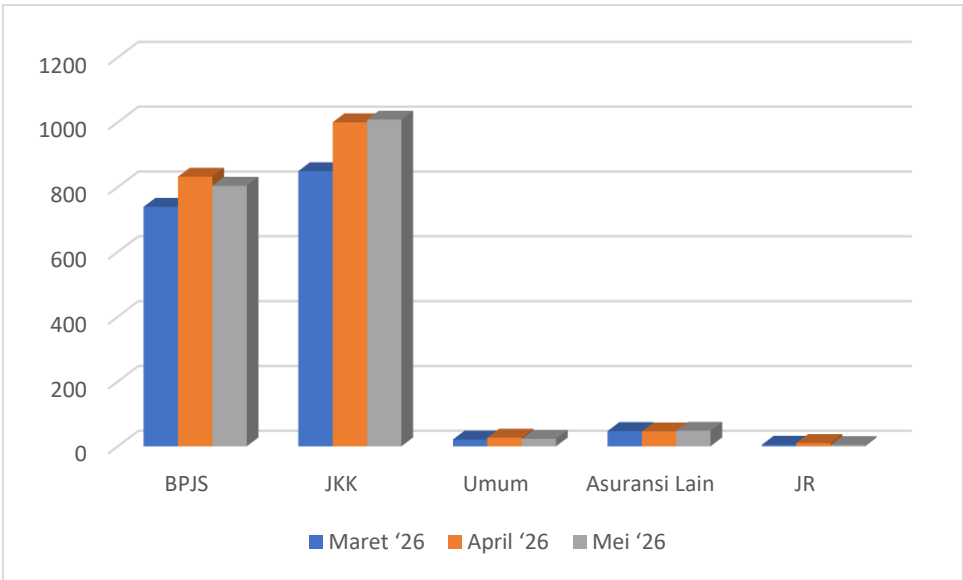
| NO. | BULAN AGUSTUS             | RAWAT INAP                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                                               | KESIMPULAN                                                                 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                           | BPJS                                                                                                                                                                                                                                                          | UMUM                                                                                                    | JKK                                          | JR/ASURANSI                                   |                                                                            |
| 1   | Analisis 3 bulan terakhir | Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan april 2026 mengalami peningkatan 0,04% dibandingkan bulan lalu                                                                                                                                   | Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan April 2026 turun 0,5% dari bulan sebelumnya | Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir | Tidak ada Pasien JR/Asuransi bulan April 2026 | Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada sama dari bulan sebelumnya |
| 2   | RTL                       | 1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya<br>2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU<br>3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit<br>4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat |                                                                                                         |                                              |                                               |                                                                            |

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret-Mei 2026)

| NO           | HAL           | Maret '26 | April '26 | Mei '26 | PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA |
|--------------|---------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|
| 1            | BPJS          | 739       | 832       | 804     | ↓3,36%                               |
| 2            | JKK           | 849       | 1.000     | 1.008   | ↑1,1%                                |
| 3            | Umum          | 21        | 27        | 23      | ↓14,8%                               |
| 4            | Asuransi Lain | 47        | 46        | 48      | ↑4,2%                                |
| 5            | JR            | 5         | 10        | 4       | ↓60%                                 |
| Total Pasien |               | 1.661     | 1.915     | 1.887   | ↓1,4 %                               |

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| No | BULAN    | INSTALASI GAWAT DARURAT                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Januari  | BPJS                                                                                                                                                         | UMUM                                                                                                                                    | JKK                                                                                                                                                                                            | ASURANSI                                                                                                                                      | JR                                                                                                                               | TOTAL PASIEN                                                                                                                      |
|    | Analisis | Kunjungan pasien BPJS di bulan Mei mengalami penurunan 3,36%                                                                                                 | Kunjungan pasien UMUM dari bulan Mei mengalami peningkatan 1,1%                                                                         | Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengalami penurunan sebanyak 14,8% dari bulan April 2026                                                                                                   | Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain pada bulan Mei 2026 mengalami peningkatan 4,2% dari bulan April 2026                            | Kunjungan pasien dengan jaminan JR bulan Mei mengalami penurunan 60% dari bulan April 2026                                       | Total kunjungan pasien IGD semua jaminan di bulan Mei 2026 mengalami penurunan 1,4%                                               |
|    | RTL      | Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang | Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal | Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang | Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi | Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi | Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre) |

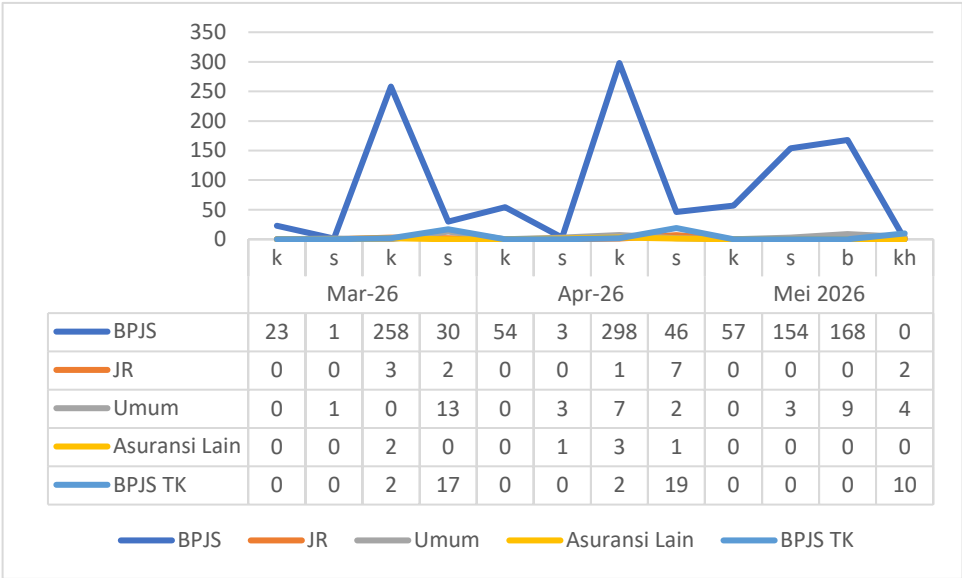
3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret-Mei 2026)

| NO | HAL           | Mar 2026 |   |     |    | Apr 2026 |   |     |    | Mei 2026 |     |     |    |
|----|---------------|----------|---|-----|----|----------|---|-----|----|----------|-----|-----|----|
|    |               | k        | s | k   | s  | k        | s | k   | s  | k        | s   | b   | kh |
| 1  | BPJS          | 23       | 1 | 258 | 30 | 54       | 3 | 298 | 46 | 57       | 154 | 168 | 0  |
| 2  | JR            | 0        | 0 | 3   | 2  | 0        | 0 | 1   | 7  | 0        | 0   | 0   | 2  |
| 3  | Umum          | 0        | 1 | 0   | 13 | 0        | 3 | 7   | 2  | 0        | 3   | 9   | 4  |
| 4  | Asuransi Lain | 0        | 0 | 2   | 0  | 0        | 1 | 3   | 1  | 0        | 0   | 0   | 0  |
| 5  | BPJS TK       | 0        | 0 | 2   | 17 | 0        | 0 | 2   | 19 | 0        | 0   | 0   | 10 |
|    | Total Pasien  | 352      |   |     |    | 447      |   |     |    | 413      |     |     |    |



Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret-Mei 2026)



3.1.4.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| No. | BULAN    | Instalasi Kamar Operasi                                                 |                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Maret    | Kecil                                                                   | Sedang                                                                                                 | Besar                                                                                                  | Khusus                                                                                     |
|     | Analisis | Jumlah pasien ODC Pacho meningkat karena ada perubahan kategori operasi | Jumlah pasien meningkat karena ada perubahan kategori operasi.                                         | Operasi besar menurun karena banyak kategori operasi besar yang berubah menjadi sedang                 | Operasi khusus menurun karena banyak yang turun menjadi kategori operasi besar atau sedang |
|     | RTL      | Tingkatkan capaian dengan meningkatkan jumlah pasien operasi            | Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM | Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM | Tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.                                         |

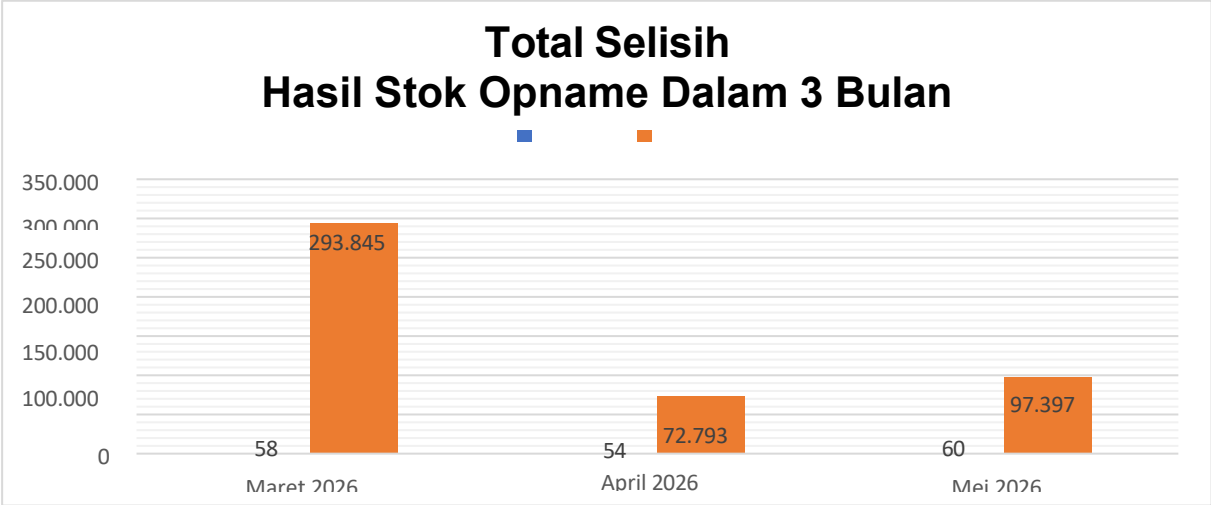
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Maret - Mei 2026

| Unit          | Stok    | Maret 2026 |                  | April 2026 |                  | Mei 2026 |                  |
|---------------|---------|------------|------------------|------------|------------------|----------|------------------|
|               |         | Jumlah     | Nilai            | Jumlah     | Nilai            | Jumlah   | Nilai            |
| GUDANG        | Fisik   | 858.275    | 1.683.188.894,52 | 858.275    | 1.683.188.894,52 | 590.337  | 1.223.051.252,46 |
|               | Sistem  | 858.275    | 1.683.188.894,52 | 858.275    | 1.683.188.894,52 | 590.337  | 1.223.051.252,46 |
|               | Selisih | 0          | 0                | 0          | 0                | 0        | 0                |
| DEPO FARMA SI | Fisik   | 241.864    | 643.787.152,87   | 241.864    | 643.787.152,87   | 225.240  | 598.610.614,39   |
|               | Sistem  | 241.841    | 644.009.405,22   | 241.841    | 644.009.405,22   | 225.276  | 598.630.103,01   |
|               | Selisih | 24         | -222.252,35      | 24         | -222.252,35      | 60       | 97.397           |
| IKO           | Fisik   | 3.370      | 80.672.655,09    | 3.370      | 80.672.655,09    | 2.870    | 83.093.295,68    |
|               | Sistem  | 3.370      | 80.672.655,09    | 3.370      | 80.672.655,09    | 2.870    | 83.093.295,68    |
|               | Selisih | 0          | 0                | 0          | 0                | 0        | 0                |
| Total Selisih |         | 666        | -222.252         | 24         | -222.252         | 60       | 97.397           |

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Maret - Mei 2026



| No                                                                                                                                                   | Analisa                                                                            | Akar Masalah                                                                                                                        | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0).<br>Analisa :                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                    | Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan.               | -                                                                                                                                   | Supervisi secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar <b>Rp 97.397</b> , hal ini disebabkan karena : |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                    | Ketidaksesuaian antara jumlah obat yang di input dan jumlah obat yang disiapkan.   | Staf Farmasi tidak melakukan double check terkait ketepatan obat dan jumlah obat sebelum di serahkan pada petugas kie atau perawat. | 1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.<br>2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala.<br>3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki. |
| 2                                                                                                                                                    | Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD dan inputan resep di SIMRS. | 1. Staf Farmasi tidak melakukan double check dengan perawat<br>2. Siap obat dan bmhp hanya menggunakan etiket tanpa melihat resep   | 1. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan → supervisi oleh kains farmasi.<br>2. Perbaikan alur ERM khususnya peresepan IGD diinput terlebih dahulu dan resep manual hanya untuk pasien KLL (case emergency) jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.                             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                  | Ketidaksesuaian antara Input resep BMHP poli dan jumlah yang di ambil.                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan awal BMHP poli yang tidak sesuai dengan inputan resep.</li> <li>2. Akhir shift farmasi cek penjualan dan ditemukan penjualan berlebih dan retur penjualan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat wajib menulis permintaan bmhp (utang input resep) dan input sesuai yang terpakai.</li> <li>2. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.</li> </ol> |
| 4                                                                                  | Hutang input resep saat SO berjalan.                                                                                                                                                                       | Kurang pencatatan saat pelaksanaan SO.                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PJ shift rekap pengeluaran saat stok opname berlangsung.</li> <li>2. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.</li> </ol>                                  |
| IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa : |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat patuh melakukan input resep;</li> <li>2. Retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan;</li> <li>3. Stok opname harian IKO</li> </ol> | -                                                                                                                                                                                                                         | Supervisi secara berkala                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.1.1.1 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan April - Oktober 2026)

#### 1. Depo Farmasi

| No. | Kode   | Nama Barang                             | Satuan | Harga Beli | Tgl. Expired | No. Batch | Jumlah Fisik Baik |        |        | Total Harga | Laporan Penjualan Jan 25 – Mei 26 (Depo+IKO) | Keterangan                                                                                                                           | Indikasi                                                      | Tindak Lanjut dan Hasil                                                  |
|-----|--------|-----------------------------------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                         |        |            |              |           | Mar 26            | Apr 26 | Mei 26 |             |                                              |                                                                                                                                      |                                                               |                                                                          |
| 1.  | F00606 | Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros    | Amp    | 1.532      | 30/07/2026   | 76803001  | 25                | 23     | 23     | 35.236      | 18                                           | Faktur pembelian terakhir tanggal 06/03/2025 dari distributor sejumlah 30 ampul.                                                     | Untuk sedasi, status epilepticus. Penggunaan obat slow moving | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                           |
| 2.  | F00672 | Rifampicin tab 450 mg (hibah)           | Tab    | 0          | 30/08/2026   | TSJ02853  | 36                | 144    | 47     | 0           | 1.046                                        | Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 07/02/2026 sejumlah 112 tablet.                              | Untuk terapi tuberculosis                                     | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                           |
| 3.  | F05117 | Skycellflu quadrivalent - dextra medica | Vial   | 167.200    | 30/08/2026   | Q0225009  | 0                 | 6      | 5      | 836.000     | 48                                           | Faktur pembelian terakhir tanggal 28/04/2026 dari distributor sejumlah 8 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. | Untuk vaksin influenza                                        | Program vaksin ICV dan poli anak. Koordinasi dengan humas dan marketing. |

|    |        |                                      |     |        |            |            |     |     |     |           |       |                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                 |
|----|--------|--------------------------------------|-----|--------|------------|------------|-----|-----|-----|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4. | F00951 | Benang t-plain 4-0 p119 - triton     | Pcs | 60.500 | 30/09/2026 | 210918IN   | 12  | 9   | 9   | 544.500   | 24    | Faktur pembelian terakhir tanggal 01/09/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs.                                       | Digunakan untuk operasi                                                              | Tukar barang dengan kode lain ke distributor pada H-1 bulan ED. |
| 5. | F01389 | Foley cath no 18 - rusch             | Pcs | 19.250 | 30/10/2026 | P20K04     | 7   | 1   | 1   | 19.250    | 35    | Faktur pembelian terakhir tanggal 10/04/2025 dari distributor sejumlah 10 pcs.                                       | Dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine                   | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                  |
| 6. | F00182 | cendo tonor mds - cendo              | Pcs | 6.934  | 30/10/2026 | 37R6023    | 305 | 300 | 285 | 1.976.190 | 200   | Faktur pembelian terakhir tanggal 19/02/2024 dari distributor sejumlah 200 pcs.                                      | Untuk pengobatan glaukoma sudut terbuka kronis dan hipertensi okular.                | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                  |
| 7. | F00030 | Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros | Amp | 7.000  | 31/10/2026 | 76307001-2 | 13  | 11  | 8   | 56.000    | 749   | Nota pembelian terakhir tanggal 20/10/2025 dari RS PHS sejumlah 30 amp. Termasuk obat emergensi.                     | Meredakan gejala gangguan pernapasan akibat asma, emfisema, bronkitis, PPOK.         | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                  |
| 8. | F00635 | Proferro tab - fahrenheit            | Tab | 8.000  | 30/10/2026 | IRJ220     | 218 | 183 | 143 | 1.144.000 | 1.289 | Faktur pembelian tanggal 23/04/2025 dari distributor sejumlah 450 tab (ED 30/10/2026). Penataan tidak FEFO di gudang | Membantu memenuhi kebutuhan zat besi pada keadaan anemia karena kekurangan zat besi. | Diberi stiker near ED dan dikeluarkan terlebih dahulu.          |

|     |        |                              |      |        |            |        |    |    |     |           |     |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                |
|-----|--------|------------------------------|------|--------|------------|--------|----|----|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |        |                              |      |        |            |        |    |    |     |           |     | farmasi karna faktur terakhir 15/01/2026 sejumlah 300 tab ED 30/09/2027.                                                                 |                                                                                                                           |                                                |
| 9.  | F00653 | Quetvell tab 200 mg - novell | Tab  | 10.640 | 30/10/2026 | 26I026 | -  | -  | 255 | 2.713.200 | 987 | Faktur pembelian terakhir tanggal 04/06/2026 dari distributor sejumlah 360 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. | Mengatasi episode manik akut gangguan bipolar, skizofrenia, mencegah gangguan bipolar, dan fase depresi gangguan bipolar. | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 10. | F05144 | Repimid tab 100 mg - novell  | Tab  | 2.520  | 30/10/2026 | EHJ160 | -  | 45 | 310 | 781.200   | 487 | Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 200 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. | Tukak lambung dalam kombinasi dengan penghambat pompa proton, antikolinergik atau antagonis H2; gastritis.                | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 11. | F05121 | Teorol caps - novell         | Caps | 2.211  | 30/10/2026 | 264085 | 37 | 30 | 16  | 35.376    | 48  | Faktur pembelian terakhir tanggal 25/12/2025 dari distributor sejumlah 90 kaps. Penerimaan obat dengan ed < 1                            | Suplemen untuk Meningkatkan absorpsi kalsium di usus & reabsorpsi kalsium di ginjal serta                                 | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |

|                        |        |                                              |     |         |            |             |   |   |   |         |           |                                                                               |                                                                          |                                                |
|------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|---------|------------|-------------|---|---|---|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        |        |                                              |     |         |            |             |   |   |   |         |           | tahun dari distributor.                                                       | mengurangi resiko fraktur & jatuh.                                       |                                                |
| 12.                    | F00546 | Nutrisi lactogen lactose free 400 g - nestle | Klg | 116.036 | 31/10/2026 | 51100346 AD | 1 | 1 | 1 | 116.036 | 2         | Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 box. | Sumber nutrisi atau sebagai makanan pendamping bagi bayi usia 0-12 bulan | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| Sub Total Depo Farmasi |        |                                              |     |         |            |             |   |   |   |         | 8.256.988 |                                                                               |                                                                          |                                                |

## 2. Gudang Farmasi

| No. | Kode   | Nama Barang                  | Satuan | Harga Beli | Tgl. Expired | No. Batch | Jumlah Fisik Baik |        |        | Total Harga | Keterangan                                                                                                                                                    | Indikasi                                                                   | Tindak Lanjut dan Hasil             |
|-----|--------|------------------------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     |        |                              |        |            |              |           | Mar 26            | Apr 26 | Mei 26 |             |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                     |
| 1.  | F04921 | Forixtra injeksi - kalbe     | Vial   | 156.250    | 30/06/2026   | a1250005  | -                 | -      | 12     | 1.875.000   | Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 12 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.                         | Mencegah pembekuan darah / deep vein thrombosis (DVT) dan emboli paru akut | Proses tukar ED jauh ke distributor |
| 2.  | F00968 | Benang t-vio 2-0 v9 - triton | Pcs    | 83.000     | 30/07/2026   | 230701BV  | 24                | 24     | 24     | 1.992.000   | Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/12/2023 dari distributor sejumlah 24 pcs → Proses tukar barang dengan distributor | Untuk operasi                                                              | Proses tukar ED jauh ke distributor |

|    |        |                                                  |     |        |                |          |       |       |       |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|----|--------|--------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3. | F01413 | Guedel airway<br>50 mm/no 00 -<br>forsch         | Pcs | 10.800 | 30/07/<br>2026 | 2114423h | 2     | 2     | 2     | 21.600  | Penerimaan obat dengan ed<br>< 1 tahun dari distributor<br>tanggal 08/01/2026 sebanyak<br>5 pcs. Bisa di retur H-1 bulan<br>mendekati kedaluwarsa. | Digunakan untuk<br>mempertahankan<br>saluran napas tetap<br>terbuka.                                                                                                                                                                              |                                                      |
| 4. | F00696 | Sanprima forte<br>kaps - sanbe                   | Tab | 2.100  | 30/07/<br>2026 | CG2905   | 300   | 300   | 300   | 630.000 | Penggunaan obat slow<br>moving. Faktur pembelian<br>terakhir tanggal 29/11/2022<br>dari distributor sejumlah 400<br>tablet.                        | Infeksi saluran<br>kemih (UTI);<br>Bronkitis akut; Otitis<br>media; Shigellosis,<br>gastroenteritis;<br>Infeksi saluran<br>empedu;<br>Pneumocystis<br>jirovecii pneumonia<br>(PCP) terapi &<br>profilaksis; Infeksi<br>kulit & jaringan<br>lunak. | SE Obat Near ED di<br>edarkan ke DPJP tgl<br>080626. |
| 5. | F00395 | Isoniazid tab 300<br>mg (hibah) -<br>kimia farma | Tab | 0      | 30/08/<br>2026 | h41603n  | 504   | 404   | 304   | 0       | Penerimaan hibah dari Dinkes<br>Kesehatan dengan ed<br>< 1 tahun pada tanggal<br>24/05/2025 sejumlah 300 tab.                                      | Untuk terapi<br>tuberculosis                                                                                                                                                                                                                      | SE Obat Near ED di<br>edarkan ke DPJP tgl<br>080626. |
| 6. | F00672 | Rifampicin tab<br>450 mg (hibah)                 | Tab | 0      | 30/08/<br>2026 | TSG75153 | 1.282 | 1.082 | 1.082 | 0       | Penerimaan hibah dari Dinkes<br>Kesehatan dengan ed<br>< 1 tahun pada tanggal<br>07/02/2026 sejumlah 112<br>tablet.                                | Untuk terapi<br>tuberculosis                                                                                                                                                                                                                      | SE Obat Near ED di<br>edarkan ke DPJP tgl<br>080626. |



|     |        |                                        |      |         |            |          |     |    |     |           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                          |
|-----|--------|----------------------------------------|------|---------|------------|----------|-----|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | F00695 | Sanoskin oxy 30 g - interbat           | Tub  | 422.750 | 30/08/2026 | 215      | 2   | 1  | 1   | 422.750   | Faktur pembelian terakhir tanggal 03/06/2024 dari distributor sejumlah 10 tube. Penggunaan obat death moving karna harga mahal dan tidak bisa di klaim asuransi JKK dan JR mulai tahun 2025. | Digunakan pada luka superfisial dan luka dalam misalnya tukak dalam tungkai.                                     | Retur sudah diterima distributor tgl 25/05/2026.                         |
| 8.  | F05117 | Skycellflu quadrivalent - dexta medica | Vial | 167.200 | 30/08/2026 | Q0225009 | 10  | 3  | 2   | 334.400   | Faktur pembelian terakhir tanggal 28/04/2026 dari distributor sejumlah 8 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor                                                          | Untuk vaksin influenza                                                                                           | Program vaksin ICV dan poli anak. Koordinasi dengan humas dan marketing. |
| 9.  | F00494 | Miconazole cr 2% 10 g - kimia farma    | Tub  | 3.407   | 30/09/2026 | 14171700 | 102 | 92 | 92  | 313.444   | Faktur pembelian terakhir tanggal 18/12/2025 dari distributor sejumlah 120 tube. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor                                                        | Antibiotik topikal                                                                                               | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                           |
| 10. | F00806 | Vaksin rotateq - gsk                   | Vial | 245.395 | 30/10/2026 | z007996  | 9   | 9  | 9   | 2.208.555 | Faktur pembelian terakhir tanggal 12/09/2025 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor                                                         | Mencegah infeksi saluran cerna akibat 5 strain Rotavirus (Pentavalen) yang menular lewat makanan terkontaminasi. | Retur ke distributor H-1 bulan ED.                                       |
| 11. | F00653 | Quetvell tab 200                       | Tab  | 10.640  |            | 26L026   | -   | -  | 180 | 1.915.200 | Faktur pembelian terakhir tanggal 04/06/2026 dari distributor sejumlah 360 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.                                                     | Mengatasi episode manik akut gangguan bipolar, skizofrenia, mencegah                                             | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626.                           |

|                          |        |                                              |     |         |            |             |   |     |     |            |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|---------|------------|-------------|---|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                          |        | mg - novell                                  |     |         | 30/10/2026 |             |   |     |     |            |                                                                                                                                          | gangguan bipolar, dan fase depresi gangguan bipolar.                                                       |                                                |
| 12.                      | F05144 | Repimid tab 100 mg - novell                  | Tab | 2.520   | 30/10/2026 | EHJ160      | - | 100 | 200 | 504.000    | Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 200 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. | Tukak lambung dalam kombinasi dengan penghambat pompa proton, antikolinergik atau antagonis H2; gastritis. | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 13.                      | F00546 | Nutrisi lactogen lactose free 400 g - nestle | Klg | 116.036 | 31/10/2026 | 51100346 AD | 2 | 2   | 2   | 232.072    | Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 box.                                                            | Sumber nutrisi atau sebagai makanan pendamping bagi bayi usia 0-12 bulan                                   | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| Sub Total Gudang Farmasi |        |                                              |     |         |            |             |   |     |     | 10.449.021 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                |

3. IKO

| No. | Kode   | Nama Barang              | Satuan | Harga Beli | Tgl. Expired | No. Batch | Jumlah Fisik Baik |        |        | Total Harga | Keterangan                                                                    | Indikasi                                                           | Tindak Lanjut dan Hasil                        |
|-----|--------|--------------------------|--------|------------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |        |                          |        |            |              |           | Mar 26            | Apr 26 | Mei 26 |             |                                                                               |                                                                    |                                                |
| 1.  | F01389 | Foley cath no 18 - rusch | Pcs    | 19.250     | 30/07/2026   | T21H05    | 5                 | 3      | 3      | 57.750      | Faktur pembelian terakhir tanggal 10/04/2025 dari distributor sejumlah 10 pcs | Dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |

|               |        |                                  |     |         |            |             |    |    |    |            |                                                                                |               |                                                |
|---------------|--------|----------------------------------|-----|---------|------------|-------------|----|----|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 2.            | F00972 | Benang t-vio 5-0 v38 – triton    | Pcs | 85.000  | 30/08/2026 | 230801RA    | 10 | 12 | 12 | 1.020.000  | Faktur pembelian terakhir tanggal 27/07/2024 dari distributor sejumlah 12 pcs. | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 3.            | F01370 | Extension tube 75 cm - terumo    | Pcs | 16.800  | 30/08/2026 | 210909B     | 2  | 2  | 2  | 33.600     | Faktur pembelian terakhir tanggal 09/03/2023 dari distributor sejumlah 11 pcs. | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 4.            | F01400 | Foley cath silicon no 8 - rusch  | Pcs | 222.000 | 30/08/2026 | KME20J1263  | 4  | 4  | 4  | 888.000    | Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs. | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 5.            | F00944 | Benang t-mono 6-0 m54 - triton   | Pcs | 144.000 | 30/09/2026 | 230902MA    | 9  | 7  | 3  | 432.000    | Faktur pembelian terakhir tanggal 07/08/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs  | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 6.            | F01382 | Foley cath 3 way no 20 - rusch   | Pcs | 66.150  | 30/09/2026 | KMA20KI055  | 10 | 10 | 10 | 661.500    | Faktur pembelian terakhir tanggal 21/10/2025 dari distributor sejumlah 2 pcs.  | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| 7.            | F01394 | Foley cath silicon no 10 - rusch | Pcs | 110.000 | 30/09/2026 | KME20K30008 | 1  | 1  | 1  | 110.000    | Faktur pembelian terakhir tanggal 25/01/2025 dari distributor sejumlah 7 pcs.  | Untuk operasi | SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 080626. |
| Sub Total IKO |        |                                  |     |         |            |             |    |    |    | 3.202.850  |                                                                                |               |                                                |
| Grand Total   |        |                                  |     |         |            |             |    |    |    | 21.908.859 |                                                                                |               |                                                |

### 3.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

| Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Near ED terbesar berada di Gudang Farmasi sebesar Rp10.449.021 (47,7%), disusul Depo Farmasi Rp8.256.988 dan IKO Rp3.202.850.</li> <li>2. Terdapat beberapa item dengan nilai stok tinggi dan risiko kedaluwarsa besar, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quetvell 200 mg Rp2.713.200 di Depo Farmasi.</li> <li>• Vaksin Rotateq Rp2.208.555 di Gudang Farmasi.</li> <li>• Benang T-Vio 2-0 Rp1.992.000 di Gudang Farmasi.</li> <li>• Cendo Tonor MDS Rp1.976.190 di Depo Farmasi.</li> <li>• Forixtra Injeksi Rp1.875.000 di Gudang Farmasi.</li> </ul> </li> <li>3. Beberapa item termasuk kategori slow moving/death moving, seperti Phenobarbital injeksi, Sanprima Forte, Benang operasi tertentu, dan Sanoskin Oxy sehingga berpotensi menjadi stok mati apabila tidak segera dilakukan intervensi.</li> <li>4. Sebagian item Near ED disebabkan oleh penerimaan barang dari distributor atau hibah dengan sisa masa kedaluwarsa kurang dari 1 tahun, seperti Skycellflu, Quetvell, Repimid, Forixtra, Rifampicin, dan Isoniazid.</li> <li>5. Sudah dilakukan beberapa tindak lanjut berupa penyebaran Surat Edaran Obat Near ED kepada DPJP, program pemasaran vaksin, pemberian stiker Near ED, serta proses retur atau tukar barang ke distributor.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring mingguan terhadap seluruh item Near ED dengan nilai persediaan tinggi untuk memastikan pergerakan stok sebelum masa kedaluwarsa.</li> <li>2. Mengoptimalkan penggunaan obat Near ED melalui penyebaran informasi kepada DPJP dan unit pelayanan agar item yang masih sesuai indikasi diprioritaskan penggunaannya.</li> <li>3. Melakukan percepatan proses retur atau tukar barang ke distributor pada item yang memenuhi syarat retur, terutama alat kesehatan dan vaksin dengan nilai persediaan tinggi.</li> <li>4. Memastikan penerapan sistem FEFO (First Expired First Out) secara konsisten pada seluruh area penyimpanan farmasi untuk mencegah penumpukan stok dengan ED lebih dekat.</li> <li>5. Berkoordinasi dengan Humas dan Marketing untuk meningkatkan pemanfaatan vaksin dan produk slow moving yang masih memiliki peluang penggunaan sebelum kedaluwarsa.</li> <li>6. Melakukan evaluasi pengadaan terhadap item slow moving dan death moving agar jumlah pembelian berikutnya disesuaikan dengan tren pemakaian aktual.</li> <li>7. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan atau redistribusi obat hibah yang mendekati masa kedaluwarsa dan masih memiliki stok tinggi.</li> <li>8. Memperketat proses penerimaan barang dari distributor dengan mempertimbangkan sisa masa kedaluwarsa agar tidak menambah jumlah item Near ED di rumah sakit.</li> </ol> |

3.2.1.6 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Mei 2026

| No    | Instalasi                 | Umum | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan | Asuransi Swasta | Jasa Raharja | Total  |
|-------|---------------------------|------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1     | Instalasi Rawat Inap      |      |                |                      |                 |              |        |
|       | Jumlah Resep Obat Racikan | 17   | 287            | 0                    | 0               | 0            | 304    |
|       | Jumlah Resep Obat Jadi    | 518  | 7532           | 0                    | 277             | 40           | 8367   |
|       | Jumlah Resep Obat         | 535  | 7819           | 0                    | 277             | 40           | 8671   |
| 2     | IGD                       |      |                |                      |                 |              |        |
|       | Jumlah Resep Obat Racikan | 131  | 25             | 0                    | 0               | 0            | 156    |
|       | Jumlah Resep Obat Jadi    | 1498 | 2630           | 0                    | 187             | 19           | 4334   |
|       | Jumlah Resep Obat         | 1629 | 2655           | 0                    | 187             | 19           | 4490   |
| 3     | Instalasi Rawat Jalan     |      |                |                      |                 |              |        |
|       | Jumlah Resep Obat Racikan | 276  | 1531           | 0                    | 1               | 1            | 1809   |
|       | Jumlah Resep Obat Jadi    | 910  | 6760           | 0                    | 262             | 2            | 7934   |
|       | Jumlah Resep Obat         | 1186 | 8391           | 0                    | 263             | 3            | 9743   |
| 4     | IKO                       |      |                |                      |                 |              |        |
|       | Jumlah Resep Obat Racikan | 0    | 0              | 0                    | 0               | 0            | 0      |
|       | Jumlah Resep Obat Jadi    | 40   | 1041           | 0                    | 54              | 4            | 1139   |
|       | Jumlah Resep Obat         | 40   | 1041           | 0                    | 54              | 4            | 1139   |
| TOTAL |                           | 3390 | 19.806         | 0                    | 781             | 66           | 24.043 |

Analisis:

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan total resep yaitu : bulan April 2026 sebanyak 3.584 resep umum dan bulan Mei 2026 sebanyak 3.390 resep umum.
2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan total resep yaitu : bulan April 2026 sebanyak 21.024 resep BPJS Kesehatan dan bulan Mei 2026 sebanyak 19.806 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan total resep yaitu : bulan bulan April 2026 sebanyak 1.054 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Mei 2026 sebanyak 847 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan April 2026 mengalami penurunan :
  - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
  - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
  - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
  - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
  - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
  - DPJP tidak praktek karena libur lebaran,
  - Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap.

**Rencana Tindak Lanjut:**

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
- 4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
- 6. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
- 7. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

**3.2.1.7 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret - Mei 2026**

| No | Kegiatan                              | Standard | Pencapaian |        |        | Keterangan                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|----------|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |          | Mar 26     | Apr 26 | Mei 26 |                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | Pengkajian resep                      | 100%     | 98,87%     | 99,39% | 99,47% | Jumlah pengkajian resep yaitu<br>Maret 2026 = 21.292<br>April 2026 = 25.662<br>Mei 2026 = 24.043<br>Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu<br>Maret 2026 = 240<br>April 2026 = 157<br>Mei 2026 = 127 |
| 2  | Dispensing Sediaan Steril             | 100%     | 100%       | 100%   | 100%   | Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.                                                                                                                         |
| 3  | Pemantauan Terapi Obat (PTO)          | 100%     | 100%       | 100%   | 100%   | Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan                                                                                                                              |
| 4  | Kejadian Efek Samping Obat            | 0        | 0          | 0      | 0      | Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat                                                                                                                                                               |
| 5  | Edukasi Obat pada pasien dan keluarga | 100%     | 100%       | 100%   | 100%   | Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat                                                                                                                                            |
| 6  | Konseling                             | 100%     | 100%       | 100%   | 100%   | Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)                                                  |
| 7  | Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah     | TDD      | TDD        | TDD    | TDD    | Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.                                                                                                                        |
| 8  | Visite Ronde Besar                    | 100%     | 0%         | 0%     | 0%     | Tidak ada visite ronde besar                                                                                                                                                                                |

|    |                                           |      |      |      |      |                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Visite Pasien/<br>Farmasi Klinik          | 100% | 100% | 100% | 100% | Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM. |
| 10 | Pelayanan Informasi Obat (PIO)            | 100% | 100% | 100% | 100% | Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape                                             |
| 11 | Obat tertinggal yang tidak diambil pasien | 0    | 39   | 35   | 31   | Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur             |

Analisa :

1. Pengkajian resep :

Penulisan resep yang lengkap bulan Mei 2026 mengalami peningkatan mendekati target 100% jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan April 2026 sebanyak 99,39% dan bulan Mei 2026 sebanyak 99,47%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep :

- Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS.
- Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 127 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
- Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TVF, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
- Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF. Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
- Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF).
- Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.

3. Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.

4. Kejadian Efek Samping Obat

- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Mei 2026 tidak ditemukan kejadian efek samping obat.
- Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.

5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga

- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
- Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.

6. **Konseling**  
Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7. **Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah** : Tidak ada pelayanan di RS.
8. **Visite Ronde Besar**  
Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.
9. **Visite Pasien/ Farmasi Klinik**  
Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap
10. **Pelayanan Informasi Obat (PIO)**  
PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
11. **Obat tertinggal yang tidak diambil pasien**  
Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan total resep yang di retur yaitu bulan April 2026 sebanyak 35 dan bulan Mei 2026 sebanyak 31. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.

**Tindak Lanjut :**

1. **Pengkajian resep :**
  - Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi.
  - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
  - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
2. **Dispensing Sediaan Steril**
  - Pelatihan penyiapan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TTK, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
  - Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
  - Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik
3. **Pemantauan Terapi Obat (PTO)** : supervisi secara berkala
4. **Kejadian Efek Samping Obat**
  - Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.



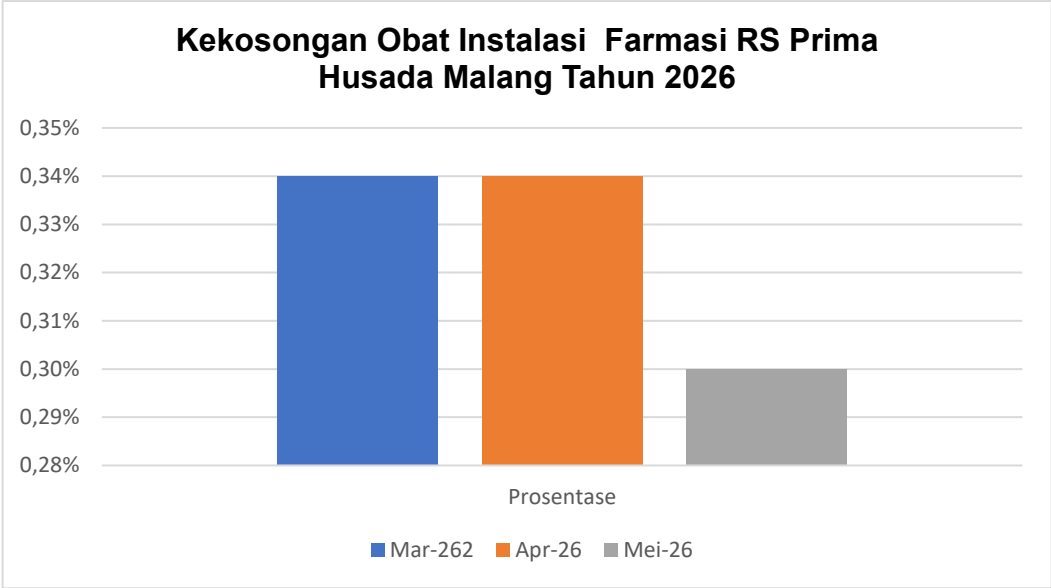
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
  - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
  - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
  - Menganalisa laporan ESO.
  - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
  - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
  - Konsul ke DPJP terkait keluhan pasien dan advice DPJP obat di stop.
5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
  6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
  7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
  8. Visite Ronde Besar  
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
  9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
  10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)  
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
  11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
    - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
    - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
    - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

| No                                  | Tanggal               | Nama Obat                 | Golongan Obat  | Distributor             | Tindak Lanjut                     |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1                                   | 01/03/2026-31/03/2026 | Borraginol-N Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |
| 2                                   | 01/03/2026-31/03/2026 | Borraginol-S Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |
| 3                                   | 01/03/2026-31/03/2026 | Pramivex 0.125 mg         | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg     |
| 4                                   | 01/03/2026-31/03/2026 | Pramivex 0.25 mg          | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg     |
| Total prosentase Maret 2026 = 0.34% |                       |                           |                |                         |                                   |
| 1                                   | 01/04/2026-30/04/2026 | Borraginol-N Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |
| 2                                   | 01/04/2026-30/04/2026 | Borraginol-S Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |
| 3                                   | 01/04/2026-30/04/2026 | Pramivex 0.125 mg         | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg     |
| 4                                   | 01/04/2026-30/04/2026 | Pramivex 0.25 mg          | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg     |
| Total prosentase April 2026 = 0.34% |                       |                           |                |                         |                                   |
| 1                                   | 01/05/2026-31/05/2026 | Borraginol-N Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |
| 2                                   | 01/05/2026-31/05/2026 | Borraginol-S Suppositoria | Hemoroid       | PT. United Dico Citas   | Substitusi Superhoid suppositoria |

|                                   |                       |                   |                |                         |                               |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3                                 | 01/05/2026-15/05/2026 | Pramivex 0.125 mg | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg |
| 4                                 | 01/05/2026-31/05/2026 | Pramivex 0.25 mg  | Anti parkinson | PT. Antar Mitra Sembada | Substitusi Pramifrol 0.375 mg |
| Total prosentase Mei 2026 = 0.30% |                       |                   |                |                         |                               |

1.2.1.11 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Maret - Mei 2026



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Pramivex 0,125 mg dan Pramivex 0.25 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.12 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Mei 2026

| No | Kegiatan                     | Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan | Jumlah | Alasan | Keterangan                         |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| 1  | Pemusnahan Obat              | -                               | -      | -      | Tidak ada pemusnahan obat          |
| 2  | Obat/ BMHP Substandar/ Rusak | -                               | -      | -      | Tidak ada barang substandar/ rusak |
| 3  | Recall                       | -                               | -      | -      | Tidak ada recall                   |

### 1.2.2. Laboratorium

**Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Maret – Mei 2026**

| Jenis Pemeriksaan  | Target | Mar 26 | Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%) | Apr 26 | Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%) | Mei 26 | Prosentase terhadap Bulan Sebelumnya (%) |
|--------------------|--------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| HEMATOLOGI         | 1950   | 1427   | ↓5,2%                                    | 1727   | ↑17,3%                                   | 1677   | ↓ 2,9%                                   |
| FAAL HEMOSTASIS    | 716    | 710    | ↓3,1%                                    | 823    | ↑13,7%                                   | 748    | ↓ 9,3%                                   |
| HEMATOLOGI LAIN    | 1      | 0      | ↓>100%                                   | 1      | ↑100%                                    | 0      | ↓ 100%                                   |
| URINALISIS         | 418    | 232    | ↓11,1%                                   | 278    | ↑16,5%                                   | 252    | ↓ 9,3%                                   |
| ANALISA FEACES     | 30     | 22     | ↑36,3%                                   | 17     | ↓ 22,7                                   | 15     | ↓ 11,7%                                  |
| FUNGSI HATI        | 611    | 281    | ↑1,0%                                    | 397    | ↑29,2%                                   | 311    | ↓ 21,6%                                  |
| LEMAK DARAH        | 806    | 744    | ↑0,5%                                    | 828    | ↑10,14%                                  | 956    | ↑1,1%                                    |
| GINJAL HIPERTENSI  | 1394   | 1257   | ↑9,8%                                    | 1570   | ↑19,9%                                   | 1515   | ↓ 3,5%                                   |
| GULA DARAH         | 1187   | 2080   | ↓1,18%                                   | 2662   | ↑21,8%                                   | 2458   | ↓ 7,6%                                   |
| JANTUNG            | 583    | 515    | ↑2,9%                                    | 669    | ↑23,0%                                   | 716    | ↑6,5%                                    |
| ELEKTROLIT DAN BGA | 334    | 176    | ↓10,2%                                   | 242    | ↑27,27%                                  | 242    | 0%                                       |
| IMUNO SEROLOGI     | 481    | 137    | ↓19,8%                                   | 165    | ↑16,9%                                   | 212    | ↑22,1%                                   |
| REMATIK            | 6      | 4      | ↓50%                                     | 3      | ↓25%                                     | 6      | ↑50%                                     |
| ENDOKRINOLOGI      | 60     | 44     | ↓38,0                                    | 81     | ↑46,6%                                   | 94     | ↑13,8                                    |
| REPRODUKSI         | 44     | 47     | ↓21,6                                    | 32     | ↑31,9%                                   | 52     | ↑38,4%                                   |
| MIKROBIOLOGI       | 32     | 43     | ↑20,9                                    | 56     | ↑23,2%                                   | 55     | ↓ 1,7%                                   |
| Jumlah             | 8654   | 7719   | ↓4,5%                                    | 9551   | ↑23,7%                                   | 9303   | ↓ 2,5%                                   |

#### Analisis :

Secara umum, jumlah pemeriksaan laboratorium bulan Mei 2026 mencapai 9.303, mengalami penurunan sebesar 2,5% dibandingkan bulan April, namun masih berada di atas target yang ditetapkan. Pemeriksaan dengan volume tertinggi didominasi oleh gula darah, hematologi, dan ginjal hipertensi. Beberapa parameter mengalami peningkatan seperti pemeriksaan jantung dan reproduksi, sementara fungsi hati menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan laboratorium tetap baik dengan capaian di atas target, namun perlu evaluasi pada parameter yang mengalami penurunan.

#### Rencana Tindak Lanjut :

1. Dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pemeriksaan yang mengalami penurunan jumlah, khususnya pada pemeriksaan fungsi hati dan hemostasis, dengan meninjau faktor penyebab seperti jumlah kunjungan pasien, pola rujukan klinis, serta ketersediaan alat dan bahan.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien serta unit pelayanan terkait guna mendorong optimalisasi permintaan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis.

3. Memastikan ketersediaan reagen, bahan kontrol, serta optimalisasi fungsi alat laboratorium agar tidak terjadi hambatan pelayanan yang dapat mempengaruhi jumlah pemeriksaan.
4. Melakukan upaya promosi layanan laboratorium, khususnya untuk pemeriksaan dengan volume rendah, melalui edukasi kepada pasien maupun tenaga medis terkait pentingnya pemeriksaan tersebut.
5. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap tren jumlah pemeriksaan setiap bulan guna mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan serta sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.
6. Tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang telah mencapai target dengan melakukan pengawasan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.

#### 1.2.2.1 Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Mei 2026

| No | Tanggal    | No RM  | Unit | Jenis Specimen | Pemeriksaan    | Alasan Kerusakan | Tindakan           |
|----|------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1  | 1/5/2026   | 191485 | 4A   | DARAH          | ELEKTROLIT     | LISIS            | MINTA SAMPEL ULANG |
| 2  | 7/5/2026   | 081846 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 3  | 8/5/2026   | 244644 | IGD  | DARAH          | ELEKTROLIT-BGA | SAMPEL VENA      | MINTA SAMPEL ULANG |
| 4  | 8/5/2026   | 142054 | 4A   | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 5  | 9/5/2026   | 248975 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 6  | 9/5/2026   | 116512 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 7  | 15/5/2026  | 207530 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 8  | 17/5/2026  | 249368 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 9  | 21/5/2026  | 166583 | IGD  | DARAH          | DL             | CLOTTING         | MINTA SAMPEL ULANG |
| 10 | 27/05/2026 | 154248 | ICU  | DARAH          | HBA1C          | CLOTTING         | MINTA SAMPEL       |



|    |            |        |     |       |                    |                              |                          |
|----|------------|--------|-----|-------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |            |        |     |       |                    |                              | ULANG                    |
| 11 | 28/05/2026 | 249872 | IGD | DARAH | FH                 | LISIS,<br>KURANG<br>DARI 1CC | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 12 | 29/05/2026 | 053066 | IGD | DARAH | ELEKTROLIT-<br>BGA | SAMPEL<br>VENA               | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 13 | 29/05/2026 | 249892 | IGD | DARAH | ELEKTROLIT-<br>BGA | SAMPEL<br>VENA               | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 14 | 29/05/2026 | 183152 | ICU | DARAH | ELEKTROLIT         | LISIS                        | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 15 | 29/05/2026 | 082707 | IGD | DARAH | DL                 | CLOTTING                     | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 16 | 31/05/2026 | 250045 | IGD | DARAH | DL                 | CLOTTING                     | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |
| 17 | 31/05/2026 | 250164 | IGD | DARAH | DL                 | CLOTTING                     | MINTA<br>SAMPEL<br>ULANG |

#### Analisis :

Berdasarkan data kerusakan sampel laboratorium selama bulan Mei 2026, tercatat sebanyak 17 kejadian kerusakan sampel yang seluruhnya berasal dari spesimen darah dengan berbagai jenis pemeriksaan diantaranya DL paling dominan, Elektrolit BGA, HbA1c dan FH. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan rutin masih memiliki tingkat kesalahan pre-analitik yang cukup tinggi. Sebagian besar kerusakan berasal dari unit IGD dan IRNA 4A serta ICU. Tingginya angka kerusakan sampel di IGD kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi kerja yang cepat dan tekanan tinggi sehingga berpotensi meningkatkan kesalahan pre-analitik, khususnya dalam proses pengambilan, penanganan, dan pengiriman sampel.

#### Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi dan penegasan kembali standar operasional prosedur pengambilan dan penanganan sampel kepada seluruh petugas terkait, khususnya pada unit IGD dan ICU.
2. Menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai teknik pengambilan sampel yang benar, termasuk pencegahan clotting, hemolisis, serta pemilihan jenis spesimen yang sesuai dengan pemeriksaan.
3. Melakukan pemantauan rutin terhadap angka penolakan sampel setiap bulan serta evaluasi penyebab untuk mencegah kejadian berulang.
4. Memperkuat komunikasi antara laboratorium dan unit pengirim terkait kesesuaian spesimen dan persyaratan pemeriksaan.
5. Memberikan umpan balik langsung kepada unit pengirim setiap terjadi penolakan sampel sebagai bentuk evaluasi dan pembelajaran.
6. Meningkatkan pengawasan pada tahap pre-analitik sebagai bagian dari program manajemen mutu laboratorium guna menurunkan angka penolakan sampel.



### 1.2.2.2 Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik (Permeriksaan Rujukan)

| No | Golongan PA   | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Prosentase terhadap bulan sebelumnya |
|----|---------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|
| 1  | PA Golongan 1 | 7          | 9          | 4        | ↓55,5%                               |
| 2  | PA Golongan 2 | 1          | 5          | 5        | 0%                                   |
| 3  | PA Golongan 3 | 53         | 103        | 84       | ↓18,44%                              |
| 4  | Total         | 61         | 126        | 93       | ↓26,19%                              |

#### Analisis:

Jumlah pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) mengalami peningkatan dari 61 pemeriksaan pada Maret 2026 menjadi 126 pemeriksaan pada April 2026 (↑106,6%), kemudian menurun menjadi 93 pemeriksaan pada Mei 2026 (↓26,19%). Penurunan terutama terjadi pada PA Golongan 1 yang turun dari 9 menjadi 4 pemeriksaan (↓55,5%) dan PA Golongan 3 yang turun dari 103 menjadi 84 pemeriksaan (↓18,44%). Meskipun terjadi penurunan pada bulan Mei, jumlah pemeriksaan masih lebih tinggi dibandingkan bulan Maret, menunjukkan pemanfaatan layanan Patologi Anatomi tetap berjalan dengan baik. Perlu dilakukan monitoring tren rujukan dan permintaan pemeriksaan untuk menjaga stabilitas capaian layanan.

#### Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring jumlah pemeriksaan PA secara berkala setiap bulan.
2. Berkoordinasi dengan DPJP untuk mengoptimalkan pengiriman spesimen sesuai indikasi klinis.
3. Memastikan tidak terjadi kendala pengiriman sampel dan administrasi pemeriksaan.
4. Melakukan evaluasi penyebab penurunan pemeriksaan PA Golongan 1 dan Golongan 3 pada bulan Mei.
5. Menyampaikan hasil capaian layanan PA dalam rapat mutu dan rapat unit terkait.
6. Mempertahankan mutu pelayanan dan waktu penyelesaian hasil pemeriksaan agar kepercayaan pengguna layanan tetap terjaga.

### 1.2.2.3 Permintaan Labu Darah pada Bank Darah Rumah Sakit

| No | Bulan    | Permintaan Labu darah |    |    |    | Total Permintaan Labu darah |
|----|----------|-----------------------|----|----|----|-----------------------------|
|    | Golda    | A                     | AB | O  | B  |                             |
| 1  | Januari  | 21                    | 6  | 24 | 29 | 80                          |
| 2  | Februari | 16                    | 27 | 37 | 7  | 87                          |
| 3  | Maret    | 33                    | 11 | 57 | 40 | 141                         |
| 4  | April    | 15                    | 32 | 30 | 7  | 84                          |
| 5  | Mei      | 21                    | 11 | 24 | 22 | 78                          |

Catatan: Tidak ada hasil incompatible crossmatch pada Bulan Mei 2026



**Tabel Jumlah Permintaan Return Labu Darah Mei 2026**

| No | Bulan    | Permintaan Return Labu darah |    |    |    | Total Permintaan Labu darah |
|----|----------|------------------------------|----|----|----|-----------------------------|
|    | Golda    | A                            | AB | O  | B  |                             |
| 1  | Januari  | 4                            | 1  | 4  | 2  | 11                          |
| 2  | Februari | 2                            | 6  | 0  | 0  | 8                           |
| 3  | Maret    | 14                           | 11 | 20 | 20 | 65                          |
| 4  | April    | -                            | 2  | 4  | -  | 6                           |
| 5  | Mei      | 2                            | 7  | 6  | 5  | 15                          |

**Analisis:**

Jumlah permintaan labu darah pada bulan Mei 2026 sebanyak 78 kantong, mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2026 sebanyak 84 kantong ( $\downarrow 7,1\%$ ). Golongan darah yang paling banyak diminta pada bulan Mei adalah golongan O (24 kantong) dan golongan B (22 kantong). Selama bulan Mei 2026 tidak ditemukan hasil incompatible crossmatch, yang menunjukkan proses pemeriksaan pra-transfusi dan pelayanan bank darah telah berjalan dengan baik. Namun demikian, jumlah return labu darah meningkat menjadi 15 kantong dibandingkan bulan April yang hanya 6 kantong. Peningkatan return terutama terjadi pada golongan darah AB (7 kantong) dan O (6 kantong), yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan darah dengan penggunaan aktual di unit pelayanan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengurangi angka return dan menjaga efisiensi pengelolaan darah.

**Rencana Tindak Lanjut:**

1. Melakukan monitoring permintaan dan return labu darah setiap bulan.
2. Melakukan evaluasi penyebab peningkatan return darah bersama unit pengguna dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
3. Mengoptimalkan perencanaan kebutuhan darah berdasarkan tren penggunaan per unit pelayanan.
4. Meningkatkan koordinasi antara DPJP, ruang perawatan, kamar operasi, dan BDRS sebelum pengajuan permintaan darah.
5. Memastikan kepatuhan prosedur pemesanan darah untuk mengurangi pembatalan transfusi yang tidak terencana.
6. Mempertahankan mutu pelayanan pra-transfusi sehingga tetap tidak terjadi incompatible crossmatch.
7. Melaporkan hasil evaluasi penggunaan dan return darah dalam rapat mutu laboratorium/BDRS secara berkala.



### 3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Mei 2026

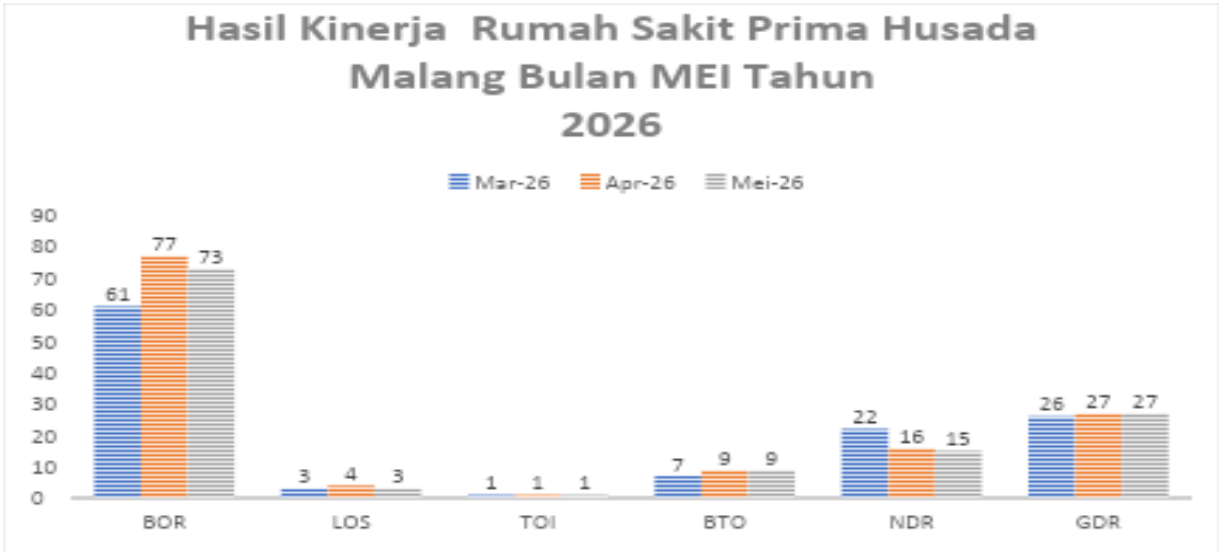
| Indikator                     | Keterangan                                                        | Rumus                                                                           | Data                                                             | Standar Depkes         | Laporan  | Ruang |       |       |       |        |       |      |      |      |     |      |     |     |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-------|
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        |          | LT 2C | LT 2A | LT 3A | LT 3C | LT 4ab | LT 5C | LT 6 | LT 7 | LT 8 | MTS | NICU | HCU | ICU | TOTAL |
| BOR (Bed Occupancy Rate)      | Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu | $(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$ | Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode | 60 - 80 %              | Maret 26 | 44    | 59    | 0     | 60    | 54     | 56    | 70   | 59   | 62   | 63  | 32   | 56  | 27  | 61    |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | April 26 | 62    | 61    | 32    | 70    | 78     | 68    | 87   | 76   | 87   | 71  | 20   | 53  | 39  | 77    |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | Mei 26   | 52    | 54    | 0     | 97    | 64     | 62    | 72   | 75   | 76   | 57  | 34   | 34  | 38  | 73    |
| ALOS (Average Length of Stay) | Rata-rata lama rawat seorang pasien                               | $LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$                                            | jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar                        | 6 - 9 hari             | Maret 26 | 3     | 4     | 0     | 2     | 3      | 3     | 3    | 3    | 3    | 2   | 3    | 4   | 5   | 3     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | April 26 | 3     | 3     | 4     | 3     | 4      | 4     | 4    | 4    | 4    | 3   | 3    | 7   | 5   | 4     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | Mei      | 3     | 3     | 0     | 3     | 3      | 3     | 3    | 3    | 3    | 2   | 5    | 3   | 5   | 3     |
| 3TOI (Turn Over Interval)     | Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati                | $((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$   | Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar               | 1 - 3 hari             | Maret 26 | 3     | 1     | 0     | 1     | 1      | 1     | 0    | 1    | 1    | 0   | 10   | 0   | 6   | 1     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | April 26 | 1     | 2     | 5     | 1     | 1      | 1     | 0    | 1    | 0    | 4   | 5    | 1   | 10  | 1     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | Mei      | 2     | 2     | 0     | 0     | 1      | 1     | 1    | 1    | 1    | 1   | 10   | 5   | 8   | 1     |
| BTO (Bed Turn Over)           | Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode                | $\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$                                       | jumlah pasien. Jumlah TT                                         | 4 - 5 kali             | Maret 26 | 5     | 5     | 0     | 8     | 6      | 6     | 8    | 7    | 7    | 11  | 2    | 4   | 3   | 7     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  | (dalam hitungan bulan) | April 26 | 8     | 8     | 5     | 9     | 9      | 8     | 9    | 8    | 9    | 4   | 3    | 11  | .3  | 9     |
|                               |                                                                   |                                                                                 |                                                                  |                        | Mei 26   | 7     | 7     | 0     | 11    | 8      | 8     | 7    | 9    | 9    | 9   | 2    | 4   | 2   | 9     |





| NDR (Net Death Rate)   | Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit | $(\sum Px \text{ Mati} > 48 \text{ jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$ | Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar | <25‰ | Maret 26 | 0  | 0  | 0 | 0 | 10 | 32 | 22 | 0  | 23 | 0   | 0   | 0   | 684 | 22 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
|                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                     |      | April 26 | 0  | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 | 28 | 0  | 10 | 0   | 625 | 0   | 0   | 16 |
|                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                     |      | Mei 26   | 0  | 0  | 0 | 0 | 8  | 8  | 45 | 10 | 9  | 0   | 0   | 250 | 438 | 15 |
| GDR (Gross Death Rate) | Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit                   | $(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$                 | Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar     | <45‰ | Maret 26 | 0  | 0  | 0 | 0 | 10 | 32 | 22 | 12 | 23 | 0   | 842 | 0   | 0   | 26 |
|                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                     |      | April 26 | 16 | 22 | 0 | 0 | 14 | 17 | 36 | 0  | 20 | 125 | 750 | 0   | 0   | 27 |
|                        |                                                                                      |                                                                                       |                                                     |      | Mei 26   | 0  | 13 | 0 | 0 | 8  | 8  | 56 | 19 | 18 | 0   | 0   | 625 | 875 | 27 |

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Mei 2026



| INDIKATOR           | ANALISA                                                                                                                                                                     | MASALAH                                                                                               | RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOR (73%)           | BOR Mei 2026 sebesar 73%, mengalami penurunan dibanding April (77%) namun masih berada dalam standar ideal Kemenkes (60–85%). Pemanfaatan tempat tidur masih cukup optimal. | Terjadi penurunan utilisasi tempat tidur dibanding bulan sebelumnya.                                  | Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan dan dokter penanggung jawab untuk optimalisasi pemanfaatan tempat tidur serta mempercepat proses admisi pasien yang membutuhkan rawat inap. |
| LOS / ALOS (3 hari) | LOS Mei 2026 sebesar 3 hari, sama dengan Maret dan lebih rendah dibanding April (4 hari). Masih dalam batas efisien sesuai karakteristik rumah sakit.                       | Perlu dipastikan LOS yang rendah tidak disebabkan pemulangan pasien yang terlalu dini.                | Melakukan monitoring kesesuaian lama perawatan berdasarkan diagnosis dan clinical pathway serta evaluasi kasus readmisi.                                                                  |
| TOI (1 hari)        | TOI Mei 2026 sebesar 1 hari, menunjukkan tempat tidur yang kosong dapat segera terisi kembali. Nilai masih sesuai standar ideal (1–3 hari).                                 | Tidak ditemukan masalah signifikan.                                                                   | Mempertahankan koordinasi antara ruang perawatan, admission, dan IGD agar pemanfaatan tempat tidur tetap optimal.                                                                         |
| BTO (9 kali)        | BTO Mei 2026 sebesar 9 kali, meningkat dibanding Maret (7 kali) dan sama dengan April (9 kali). Menunjukkan frekuensi penggunaan tempat tidur cukup baik.                   | Tingginya frekuensi pergantian pasien berpotensi meningkatkan beban kerja petugas dan risiko infeksi. | Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur pembersihan tempat tidur dan pengendalian infeksi serta monitoring beban kerja petugas.                                                          |
| NDR (15%)           | NDR Mei 2026 sebesar 15%, mengalami penurunan dibanding Maret (22%) dan April (16%),                                                                                        | Angka kematian pasien setelah dirawat ≥48 jam masih relatif tinggi.                                   | Melakukan audit kematian (death review), evaluasi ketepatan diagnosis dan terapi, serta peningkatan                                                                                       |



|           |                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | menunjukkan perbaikan mutu pelayanan. Namun masih di atas standar ideal (< 10‰).                                                    |                                                | monitoring pasien berisiko tinggi.                                                                                                                                                                |
| GDR (27‰) | GDR Mei 2026 sebesar 27‰, sama dengan April dan sedikit meningkat dibanding Maret (26‰). Nilai masih di atas standar ideal (< 25‰). | Angka kematian keseluruhan masih cukup tinggi. | Melakukan analisis penyebab kematian, peningkatan kewaspadaan dini pasien kritis, evaluasi sistem rujukan, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan. |

### 3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Mei 2026

| NO | CODE ICD 10 | DIAGNOSIS                                                           | JUMLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | E11.4       | With neurological complications                                     | 475    |
| 2  | I51.9       | Decomp Cordis / Heart disease, unspecified                          | 330    |
| 3  | E11.9       | DM Tanpa komplikasi / Without complications                         | 298    |
| 4  | I25.9       | Chronic ischemic heart disease, unspecified                         | 269    |
| 5  | I11.9       | HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 263    |
| 6  | I63.9       | CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified                       | 241    |
| 7  | K04.1       | Necrosis of pulp                                                    | 220    |
| 8  | F41.2       | Mixed anxiety and depressive disorder                               | 208    |
| 9  | A09.9       | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin                   | 191    |
| 10 | R10.4       | Colic Abdomen / Other and unspecified abdominal pain                | 187    |

### 3.1.1.1 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan April 2026

| NO  | KODE  | DIAGNOSA                              | TOTAL |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|
| 1.  | I63.9 | Cerebrovascular Accident Infark       | 52    |
| 2.  | A09.9 | Gastroenteritis Acute                 | 48    |
| 3.  | J18.9 | Pneumonia                             | 42    |
| 4.  | E14.9 | Diabetes Mellitus Hyperglukemia       | 33    |
| 5.  | A49.9 | Bacterial Infection                   | 31    |
| 6.  | D24   | Tumor Mammae                          | 21    |
| 7.  | I20.0 | Unstable Angina Pectoris              | 20    |
| 8.  | A90   | Dengue Fever                          | 19    |
| 9.  | J44.1 | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 19    |
| 10. | M72.6 | Necrotizing Fascitis                  | 19    |

#### Analisis :

Berdasarkan data 10 besar diagnosis bulan Mei 2026, pola penyakit di rumah sakit masih didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) terutama Diabetes Mellitus, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Pada pelayanan rawat jalan, diagnosis terbanyak adalah DM dengan komplikasi neurologis (E11.4) sebanyak 475 kasus, diikuti penyakit jantung (I51.9) sebanyak 330 kasus, dan DM tanpa komplikasi (E11.9) sebanyak 298 kasus. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan penyakit kronis serta perlunya penguatan program pengelolaan penyakit kronis dan edukasi pasien.

Pada pelayanan rawat inap, diagnosis terbanyak adalah CVA Infark (I63.9) sebanyak 52 kasus, diikuti Gastroenteritis Akut (A09.9) sebanyak 48 kasus dan Pneumonia (J18.9) sebanyak 42 kasus. Selain itu, masih ditemukan kasus infeksi seperti Bacterial Infection, Dengue Fever, dan



Necrotizing Fascitis yang memerlukan perhatian dalam aspek pencegahan infeksi, penggunaan antibiotik rasional, dan surveilans penyakit infeksi. Tingginya kasus stroke, penyakit jantung, dan diabetes baik pada rawat jalan maupun rawat inap menunjukkan bahwa PTM masih menjadi beban utama pelayanan rumah sakit.

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Rawat Jalan:
  - 1) Mengoptimalkan program pengelolaan penyakit kronis (DM, hipertensi, penyakit jantung) melalui edukasi dan monitoring kepatuhan pasien.
  - 2) Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terkait faktor risiko PTM.
  - 3) Mengoptimalkan Program lansia dengan pemnyakit kronis bagi pasien DM dan hipertensi.
  - 4) Meningkatkan skrining komplikasi DM untuk mencegah progresivitas penyakit.
  - 5) Melakukan monitoring tren kasus PTM secara berkala sebagai dasar perencanaan layanan.
2. Rawat Inap:
  - 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway kasus stroke, pneumonia, dan diabetes.
  - 2) Mengoptimalkan Program PPRA terutama pada kasus infeksi bakteri, pneumonia, dan necrotizing fascitis.
  - 3) Meningkatkan kepatuhan pemeriksaan kultur dan sensitivitas pada kasus infeksi yang memerlukan antibiotik spektrum luas.
  - 4) Memperkuat edukasi pasien dan keluarga terkait pencegahan kekambuhan stroke, diabetes, dan penyakit jantung.
  - 5) Melakukan evaluasi berkala terhadap tren penyakit infeksi dan non-infeksi sebagai dasar penyusunan program mutu dan keselamatan pasien.

3.1.1.2 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Maret 2026

| KELENGKAPAN |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
|-------------|------------------------|-----|------|---|-----------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------------------|-------|------|------|
| DPJP        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| BULAN       | Ringkasan Keluar Masuk |     |      |   | Pengkajian Awal Medis |       |      |      | CPPT |       |      |      | Ringkasan Pulang |       |      |      |
|             | Σ L                    | %   | Σ TL | % | Σ L                   | %     | Σ TL | %    | Σ L  | %     | Σ TL | %    | Σ L              | %     | Σ TL | %    |
| Januari     | -                      | -   | -    | - | 1090                  | 93,70 | 61   | 6,30 | 1080 | 93,37 | 69   | 5,16 | 1147             | 99,66 | 4    | 0,34 |
| Februari    | -                      | -   | -    | - | 920                   | 84    | 119  | 16%  | 929  | 86,4  | 110  | 13,6 | 1005             | 97    | 34   | 3    |
| Maret       | -                      | -   | -    | - | 1001                  | 95,30 | 54   | 16   | 1000 | 94,93 | 55   | 5,07 | 1031             | 96,67 | 24   | ,33  |
| April       | 1244                   | 99  | 12   | 1 | 1070                  | 88    | 149  | 12   | 1113 | 89    | 142  | 11   | 1162             | 93    | 94   | 7    |
| Mei         | 14                     | 100 | 0    | 0 | 996                   | 85    | 179  | 15   | 1039 | 87    | 157  | 13   | 1087             | 93    | 81   | 7    |
| Juni        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Juli        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Agustus     |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| September   |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Oktober     |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |

| KELENGKAPAN |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
|-------------|------------------------|-------|------|------|------|----|------|---|--------------------|-----|------|-----|---------------------------|-----|------|----|
| PERAWAT     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| BULAN       | Pengkajian Keperawatan |       |      |      | CPPT |    |      |   | Asuhan Keperawatan |     |      |     | Resume Keperawatan / SBAR |     |      |    |
|             | Σ L                    | %     | Σ TL | %    | Σ L  | %  | Σ TL | % | Σ L                | %   | Σ TL | %   | Σ L                       | %   | Σ TL | %  |
| Januari     | 1013                   | 97,18 | 38   | 2,82 | -    | -  | -    | - | 1051               | 100 | 0    | 0   | 1051                      | 100 | 0    | 0  |
| Februari    | 1008                   | 98    | 27   | 2    | -    | -  | -    | - | 1034               | 100 | 2    | 0,3 | 1036                      | 100 | 0    | 0  |
| Maret       | 1047                   | 100   | 7    | 0    | -    | -  | -    | - | 1043               | 100 | 11   | 0   | 1054                      | 100 | 0    | 0  |
| April       | 1148                   | 91    | 107  | 9    | 1203 | 96 | 52   | 4 | 1203               | 96  | 52   | 4   | 1220                      | 97  | 35   | 3  |
| Mei         | 1112                   | 93    | 84   | 8    | 1154 | 96 | 42   | 4 | 1171               | 98  | 25   | 2   | 1080                      | 90  | 116  | 10 |
| Juni        |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Juli        |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Agustus     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| September   |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Oktober     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |

| KELENGKAPAN |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
|-------------|----------------------|----|------|----|------|-----|------|------|---------------------|-----|------|----|------|----|------|----|
| BULAN       | AHLI GIZI            |    |      |    |      |     |      |      | APOTEKER            |     |      |    |      |    |      |    |
|             | Pengkajian Awal Gizi |    |      |    | CPPT |     |      |      | Rekonsialisasi Obat |     |      |    | CPPT |    |      |    |
|             | Σ L                  | %  | Σ TL | %  | Σ L  | %   | Σ TL | %    | Σ L                 | %   | Σ TL | %  | Σ L  | %  | Σ TL | %  |
| Januari     | 556                  | 52 | 484  | 48 | 1040 | 100 | 0    | 0    | 1133                | 100 | 0    | 0  | 1010 | 91 | 123  | 9  |
| Februari    | 528                  | 61 | 398  | 39 | 926  | 100 | 0    | 0    | 1027                | 100 | 0    | 0  | 965  | 94 | 62   | 6  |
| Maret       | 587                  | 65 | 341  | 35 | 927  | 100 | 1    | 0,07 | 1034                | 90  | 13   | 10 | 291  | 33 | 756  | 67 |
| April       | 564                  | 99 | 99   | 3  | 1130 | 99  | 11   | 1    | 1206                | 97  | 42   | 3  | 1171 | 99 | 13   | 1  |
| Mei         | 517                  | 98 | 8    | 2  | 1061 | 99  | 14   | 1    | 1121                | 94  | 72   | 6  | 1067 | 98 | 21   | 2  |
| Juni        |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Juli        |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Agustus     |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| September   |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Oktober     |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada bulan Mei 2026, kelengkapan dokumentasi oleh DPJP menunjukkan bahwa Ringkasan Keluar Masuk mencapai 100%, sehingga seluruh dokumen yang diperiksa telah terisi lengkap. Namun masih ditemukan ketidaklengkapan pada Pengkajian Awal Medis sebesar 15% (179 dokumen), CPPT sebesar 13% (157 dokumen), dan Ringkasan Pulang sebesar 7% (81 dokumen). Dibandingkan bulan April, capaian Pengkajian Awal Medis dan CPPT mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan DPJP dalam melengkapi dokumentasi medis secara tepat waktu karena berpengaruh terhadap kesinambungan pelayanan, mutu rekam medis, dan pemenuhan standar akreditasi.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

Pada bulan Mei 2026, kelengkapan dokumentasi keperawatan menunjukkan hasil yang cukup baik. **Asuhan Keperawatan mencapai 96%, CPPT Keperawatan 98%, dan Pengkajian Keperawatan 93%.** Namun demikian, **Resume Keperawatan/SBAR masih memiliki ketidaklengkapan sebesar 10% (116 dokumen),** yang merupakan angka ketidaklengkapan tertinggi pada dokumentasi keperawatan. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas komunikasi saat transfer pasien dan kesinambungan pelayanan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Pada bulan Mei 2026, dokumentasi oleh Ahli Gizi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Pengkajian Awal Gizi sebesar 98% dan CPPT sebesar 99%. Sementara itu, dokumentasi oleh Apoteker juga menunjukkan capaian yang baik, dengan Rekonsiliasi Obat sebesar 94% dan CPPT sebesar 98%. Meskipun capaian sudah tinggi, masih ditemukan ketidaklengkapan pada rekonsiliasi obat sebanyak 72 dokumen (6%), sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mendukung keselamatan pasien terutama pada transisi pelayanan.

---

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:

- 1) Melakukan monitoring kelengkapan rekam medis DPJP setiap minggu.
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi kepada masing-masing DPJP sebagai umpan balik.
- 3) Mengoptimalkan peran Kepala SMF dan Komite Medik dalam pengawasan kepatuhan dokumentasi.
- 4) Melakukan reminder kepada DPJP untuk melengkapi rekam medis sebelum pasien pulang.
- 5) Melakukan audit rekam medis secara berkala dan membahas hasilnya dalam rapat mutu.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

- 1) Melakukan supervisi pengisian Resume Keperawatan/SBAR oleh kepala ruang.
- 2) Mengingatkan perawat penanggung jawab pasien untuk melengkapi dokumen sebelum pasien pulang.
- 3) Melakukan audit dokumentasi keperawatan secara rutin.
- 4) Memberikan edukasi dan refreshment terkait pentingnya dokumentasi keperawatan yang lengkap.
- 5) Menjadikan kelengkapan rekam medis sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja ruangan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:

- 1) Meningkatkan monitoring kepatuhan rekonsiliasi obat pada pasien masuk, pindah ruang, dan pulang.
- 2) Melakukan audit dokumentasi farmasi dan gizi secara berkala.
- 3) Memberikan umpan balik kepada petugas yang belum melengkapi dokumentasi sesuai standar.
- 4) Memastikan dokumentasi dilakukan secara real time pada saat pelayanan diberikan.
- 5) Mempertahankan capaian CPPT Gizi dan Farmasi yang telah mencapai  $\geq 98\%$ .

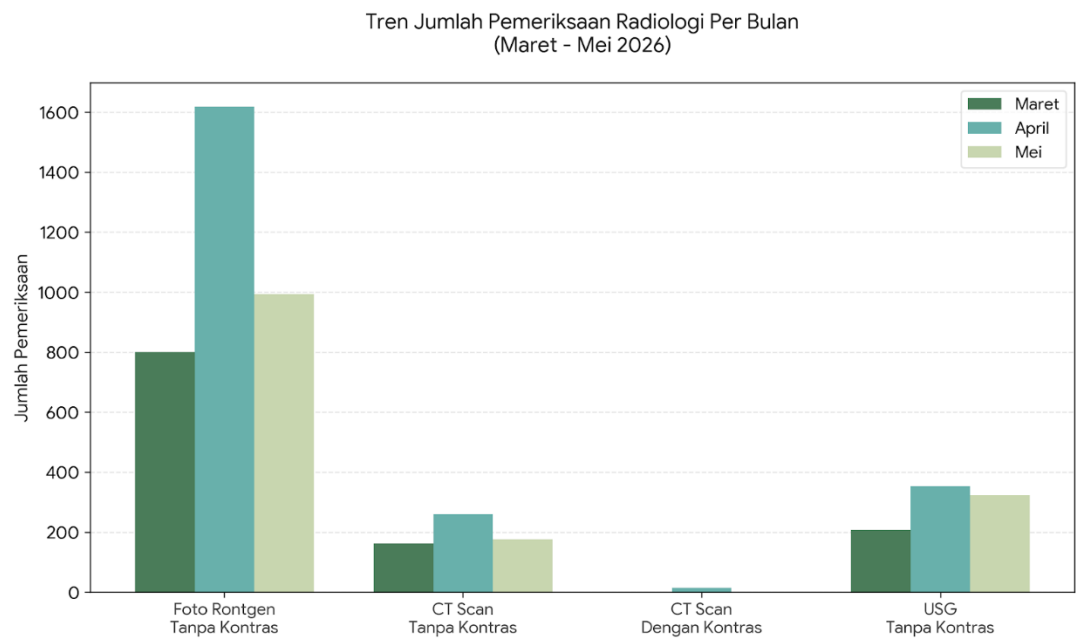
1.2.4 Radiologi

1.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei 2026

| NO | JENIS PEMERIKSAAN                | PENJAMIN        | BULAN |      |     |
|----|----------------------------------|-----------------|-------|------|-----|
|    |                                  |                 | MAR   | APR  | MEI |
| 1. | FOTO RONTGEN TANPA BAHAN KONTRAS | UMUM            | 149   | 324  | 180 |
|    |                                  | BPJS KESEHATAN  | 586   | 1105 | 702 |
|    |                                  | BPJS TK         | 20    | 157  | 44  |
|    |                                  | ASURANSI SWASTA | 37    | 10   | 17  |
|    |                                  | JASA RAHARJA    | 9     | 22   | 5   |
|    |                                  | RSPHS           | -     | -    | -   |
|    |                                  | RSDH            | -     | -    | 46  |
|    |                                  | TOTAL           | 801   | 1618 | 994 |
| 2. | CT SCAN TANPA KONTRAS            | UMUM            | 19    | 22   | 18  |
|    |                                  | BPJS KESEHATAN  | 136   | 195  | 131 |
|    |                                  | BPJS TK         | 1     | 4    | 1   |
|    |                                  | ASURANSI SWASTA | 3     | 4    | 1   |
|    |                                  | JASA RAHARJA    | 4     | 6    | 4   |
|    |                                  | RSPHS           | -     | 29   | 21  |
|    |                                  | RSDH            | -     | -    | -   |
|    |                                  | TOTAL           | 163   | 260  | 176 |
| 3. | CT SCAN DENGAN KONTRAS           | UMUM            | 0     | 0    | -   |
|    |                                  | BPJS KESEHATAN  | 2     | 6    | -   |
|    |                                  | BPJS TK         | 0     | 0    | -   |
|    |                                  | ASURANSI SWASTA | 0     | 0    | -   |
|    |                                  | JASARAHARJA     | 0     | 0    | -   |
|    |                                  | RSPHS           | -     | 9    | -   |
|    |                                  | RSDH            | -     | -    | -   |
|    |                                  | TOTAL           | 2     | 15   | 0   |
| 4. | USG TANPA KONTRAS                | UMUM            | 30    | 1    | 3   |
|    |                                  | BPJS KESEHATAN  | 174   | 351  | 320 |
|    |                                  | BPJS TK         | 0     | 1    | -   |
|    |                                  | ASURANSI SWASTA | 4     | 1    | -   |
|    |                                  | JASARAHARJA     | 0     | 0    | -   |
|    |                                  | RSPHS           | -     | -    | -   |
|    |                                  | RSDH            | -     | -    | -   |
|    |                                  | TOTAL           | 208   | 354  | 323 |



1.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Mei 2026



| Analisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Review Hasil Berdasarkan PDSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Secara total, kunjungan Radiologi di bulan Mei lebih menonjol di pemeriksaan Foto Rontgen dan Foto Rontgen mengalami penurunan dariapada bulan April.</div> <div>2. Kerusakan CT Scan yang dikarenakan :<div>a. Penggunaan yang sering</div><div>b. Usia CT Scan melebihi 6 tahun</div></div> <div>Menyebabkan pemeriksaan di lakukan di RS rekanan, dalam hal ini mengakibatkan:<div>a. Pemborosan pada penggunaan alat tranportasi ambulance</div><div>b. Terhambatnya penatalaksanaan jika kondisi pasien tidak transportable</div></div> | <div>Plan :<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan pemasaran untuk pemeriksaan radiologi melalui MCU</li><li>Melakukan maintenace alat radiologi secara berkala agar tidak terjadi kerusakan.</li><li>Menertibkan pengisian checklist pemelihaaan dan pemantauan alat dengan benar</li></ul></div> <div>Do :<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan pemasaran terkait radiologi melalui program MCU</li><li>Membuat SPO pemeliharaan alat radiologi</li></ul></div> <div>Study<ul style="list-style-type: none"><li>Terjadi tren kenaikan pemeriksaan total</li><li>Peningkatan terbesar pada pemeriksaan Radiodiagnostik terutama pemeriksaan Thorax rontgen, hal ini dikarenakan permintaan thorax untuk MCU meningkat.</li><li>Terjadinya penurunan di kunjungan CT Scan di karenakn alat trobel atau eror di setiap bulannya</li></ul></div> <div>Action:<ul style="list-style-type: none"><li>Melanjutkan monitoring bulanan untuk melihat pola peningkatan volume.</li><li>Kolaborasi dengan Humas Marketing dalam penawaran MCU</li><li>Maintenance dan pengecekan alat secara berkala dan tertib</li></ul></div> |

Tabel Jumlah Laporan Pembacaan Ulang Hasil Radiologi Tahun 2026

| NO                  | NAMA DOKTER              | NAMA PASIEN                                                                           | BACAAN AWAL                                           | BACAAN ULANG                                                                                  | TOTAL |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bulan Januari 2026  |                          |                                                                                       |                                                       |                                                                                               |       |
| 1                   | dr. AgungSp.Rad (K)      | Abd Salam                                                                             | Brain Atrofi Senilis                                  | Brain Atrofi senilis, Infark                                                                  | 1     |
| 2                   | dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad | -                                                                                     | -                                                     | -                                                                                             | -     |
| Bulan Februari 2026 |                          |                                                                                       |                                                       |                                                                                               |       |
| 1                   | dr. AgungSp.Rad (K)      | Damiasih / 135744                                                                     | Infark akut di periventrike                           | Tambahan bacaan Hydrocefalus obstrukti                                                        | 1     |
| 2                   | dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad | M Danendra Al Hussien / 201495                                                        | Normal                                                | Normal                                                                                        | 1     |
| Bulan Maret 2026    |                          |                                                                                       |                                                       |                                                                                               |       |
| 1                   | dr. AgungSp.Rad (K)      | Asiyo Waga/24520                                                                      | Fraktur distal ulna dan radius                        | Tambahan bacaan keterlibatan intra articular (epiphyse)                                       | 1     |
| 2                   | dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad | Sumarmi/011074                                                                        | Fractura caput Os Humerus sinistra.Dislokasi sendi(+) | Tambahan bacaan fraktur epiphisis                                                             | 1     |
| Bulan April 2026    |                          |                                                                                       |                                                       |                                                                                               |       |
| 1                   | dr. Agung, Sp.Rad (K)    | 1. Gusti fardi/192214<br>2. Ummu aimanah/231796<br>3. Tasir/091111                    | Normal<br>Normal<br>Susp cerebritis                   | Infark sub akut Infark sub akut Cerebritis                                                    | 3     |
| 2                   | dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad | 1. Ngadinem/125411<br>2. Rasmini/247707<br>3. Kasanah/248579                          | Cardiomegali<br>Normal<br>Bronchitis                  | Cardiomegali, Pneumonia Atelectasis Paru kiri. Kp Duplex                                      | 3     |
| Bulan Mei 2026      |                          |                                                                                       |                                                       |                                                                                               |       |
| 1                   | dr. AgungSp.Rad (K)      | 1. Sugito/245224<br>2. Sumardji/249022                                                | Prostat enlargement<br>Pneumonia                      | Vesicolitiasis, Prostat enlargement Tetap pneumonia                                           | 2     |
| 2                   | dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad | 1. Kasanah/248579<br>2. Romadlon/249845<br>3. Wisnu attar/206655<br>4. Sriamah/128436 | KP<br>OA<br>Dislokasi<br>Cardiomegali                 | KP, Infected bronchiectais Fractura os Patela Tidak ada efyphyse Fraktur costae,cardio megali | 4     |

Analisis :

Untuk bulan Mei 2026 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak sesuai dengan kondisi pasien pada surat permintaan radiologi sehingga dokter radiolog kurang menambahkan hasil bacaan tersebut.

Secara umum ditemukan discrepancy pembacaan pada sebagian besar kasus dengan diagnose diatas. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan standardisasi interpretasi, diskusi kasus, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kesesuaian hasil pembacaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.
- 3. Melakukan evaluasi terhadap kualitas hasil imaging untuk memastikan gambar diagnostik optimal.
- 4. Meningkatkan komunikasi antara dokter radiologi dan dokter pengirim terkait kondisi klinis pasien.
- 5. Menyusun standar interpretasi dan pelaporan radiologi untuk mengurangi variasi pembacaan.
- 6. Melakukan pembelajaran kasus (case review) pada hasil dengan discrepancy signifikan sebagai bahan peningkatan mutu pelayanan radiologi.

1.2.4.3 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

| JENIS PEMERIKSAAN   | Rata-rata bulan Maret |                                                             | Rata-rata bulan April |                                                            | Rata-rata bulan Mei |                                                            |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | Selesai Periksa       | Selesai Pembacaan                                           | Selesai Periksa       | Selesai Pembacaan                                          | Selesai Periksa     | Selesai Pembacaan                                          |
| RO THORAX           | 00:03:20              | 00:25:00 (waktu efektif)<br>00:180:00 (diatas jam 12 malam) | 00:02:40              | 00:15:00 (waktu efektif)<br>05:00:00 (diatas jam 12 malam) | 00:03:10            | 00:45:34 (waktu efektif)<br>04:32:24 (diatas jam 12 malam) |
| RO VERTEBRAE        | -                     | -                                                           | -                     | -                                                          | -                   | -                                                          |
| RO ABDOMEN          | -                     | -                                                           | -                     | -                                                          | 00:08:00            | 00:28:00(waktu elektif)                                    |
| RO EKSTREMITAS      | -                     | -                                                           | -                     | -                                                          | -                   | -                                                          |
| RO SKULL            | -                     | -                                                           | -                     | -                                                          | -                   | -                                                          |
| USG                 | 00:08:00              | 00:05:00                                                    | 00:05:00              | 00:05:00                                                   | 00:05:00            | 00:05:51                                                   |
| CT SCAN NON KONTRAS | 00:05:00              | 00:30:00 (waktu efektif)<br>24:00:00 (diatas jam 12 malam)  | 00:05:00              | 00:30:00 (waktu efektif)<br>18:49:00 (diatas jam 12 malam) | 00:05:00            | 01:33:52 (waktu efektif)<br>05:45:00 (diatas jam 12 malam) |
| CT SCAN KONTRAS     | 00:15:00              | 00:25:00 (waktu efektif)<br>24:00:00 (diatas jam 12 malam)  | 00:15:00              | 00:25:00 (waktu efektif)<br>18:49:00 (diatas jam 12 malam) | -                   | -                                                          |
| RADIOLOGI CITO      | 00:10:00              | 00:04:00 (waktu elektif)<br>00:25:00 (diatas jam 12 malam)  | 00:10:00              | 00:04:00 (waktu elektif)<br>00:25:00 (diatas jam 12 malam) | 00:10:00            | 00:04:00 (waktu elektif)<br>00:20:00 (diatas jam 12 malam) |

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

| JENIS PEMERIKSAAN | Rata-rata bulan Maret |                                                                  | Rata-rata bulan April |                                                                  | Rata-rata bulan April |                                                                  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                   | Selesai Periksa       | Selesai Pembacaan                                                | Selesai Periksa       | Selesai Pembacaan                                                | Selesai Periksa       | Selesai Pembacaan                                                |
| RO THORAX         | 00:03:04              | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:03:04              | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:03:00              | 0:43:38 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |

|                     |          |                                                                  |          |                                                                  |          |                                                                  |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| RO VERTEBRAE        | 00:04:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:04:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:04:00 | 0:27:26 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |
| RO ABDOMEN          | 00:10:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:10:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:10:00 | 0:20:48 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |
| RO EKSTREMITAS      | 00:02:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:02:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) | 00:02:00 | 0:28:37 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |
| RO SKULL            | 00:02:00 | 0:10:00 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |          |                                                                  | 00:03:00 | 0:23:30 (pada saat jam praktek)<br>24:00:00 (diluar jam praktek) |
| USG                 | 00:15:00 | 00:10:00                                                         | 00:05:00 | 00:10:00                                                         | 00:05:00 | 00:06:18                                                         |
| CT SCAN NON KONTRAS | -        | -                                                                | -        | -                                                                | -        | -                                                                |
| CT SCAN KONTRAS     | -        | -                                                                | -        | -                                                                | -        | -                                                                |
|                     |          |                                                                  |          |                                                                  |          |                                                                  |
| RADIOLOGI CITO      | 00:10:00 | 0:10:00                                                          | 00:10:00 | 0:15:00                                                          | 00:10:00 | 0:15:00                                                          |

Analisa :

Berdasarkan data bulan Mei 2026, waktu penyelesaian pemeriksaan (selesai periksa) pada seluruh modalitas radiologi masih berada dalam rentang yang baik dan relatif konsisten. Namun terdapat peningkatan waktu pada proses pembacaan hasil (expertise) dibandingkan bulan April, terutama pada pemeriksaan RO Thorax dan CT Scan Non Kontras.

Pada dr. Agung Setyawan, Sp.Rad(K), rata-rata waktu pembacaan RO Thorax pada jam efektif meningkat dari 15 menit menjadi 45 menit 34 detik, sedangkan CT Scan Non Kontras meningkat dari 30 menit menjadi 1 jam 33 menit 52 detik. Meskipun demikian, waktu tersebut masih dapat diterima mengingat kompleksitas interpretasi kasus dan adanya pemeriksaan yang dilakukan di luar jam kerja sehingga pembacaan menyesuaikan jadwal dokter radiologi.

Pada dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad(K), rata-rata waktu pembacaan RO Thorax selama jam praktik meningkat dari 10 menit menjadi 43 menit 38 detik. Peningkatan serupa juga terlihat pada pemeriksaan RO Vertebrae, RO Abdomen, RO Ekstremitas, dan RO Skull. Sementara itu, pemeriksaan USG dan Radiologi Cito tetap menunjukkan waktu respon yang baik dan sesuai kebutuhan pelayanan.

Secara umum, pelayanan radiologi bulan Mei tetap berjalan dengan baik tanpa adanya laporan keterlambatan yang berdampak pada pelayanan pasien. Perbedaan waktu pembacaan sebagian besar dipengaruhi oleh variasi jumlah kasus, kompleksitas kasus, serta adanya pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring respon time pemeriksaan dan pembacaan hasil radiologi setiap bulan.
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis pemeriksaan yang mengalami peningkatan waktu pembacaan, terutama RO Thorax dan CT Scan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan dokter radiologi terkait penyelesaian expertise pada jam pelayanan aktif.
4. Memastikan hasil pemeriksaan prioritas (cito, IGD, ICU, dan rawat inap) mendapatkan pembacaan

sesuai standar waktu pelayanan.

- 5. Melakukan analisis beban kerja dokter radiologi untuk mengantisipasi peningkatan volume pemeriksaan.
- 6. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi radiologi (LIS/PACS) untuk mempercepat distribusi dan validasi hasil pemeriksaan.
- 7. Mempertahankan respon time pemeriksaan USG dan Radiologi Cito yang telah menunjukkan kinerja baik.

1.2.4.4 Tabel PMI dan PME di Radiologi

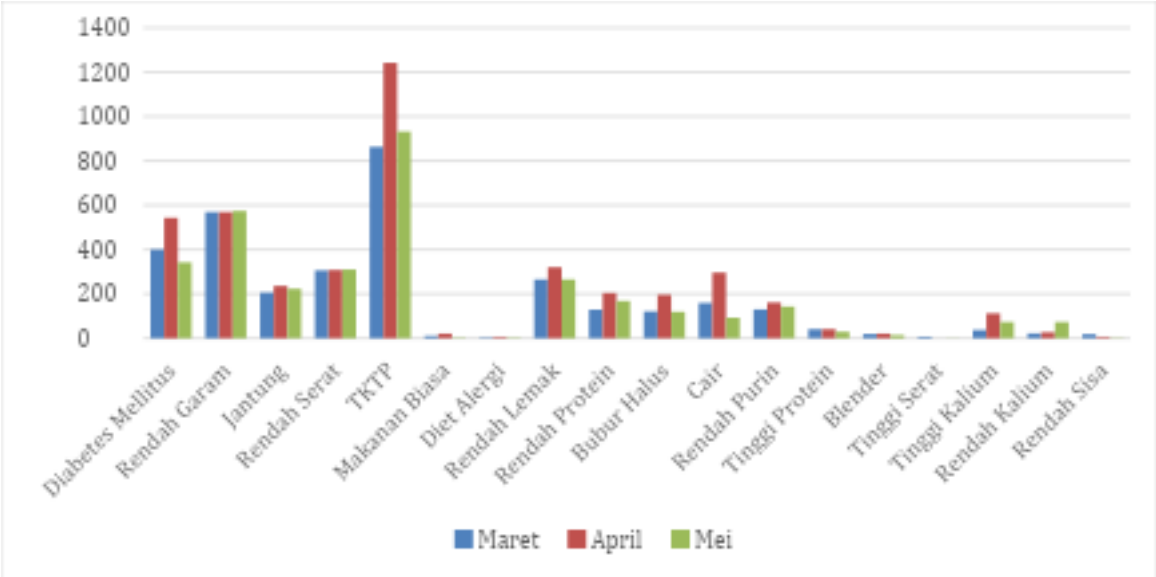
| No | Nama Alat (Merk dan Tipe) | No. Seri | Frekuensi |         |         | Terakhir Kalibrasi    | PJ    | Pihak Ketiga (Kalibrator) |
|----|---------------------------|----------|-----------|---------|---------|-----------------------|-------|---------------------------|
|    |                           |          | Mingguan  | Bulanan | Tahunan |                       |       |                           |
| 1  | Rontgen Stationer         | -        | -         | -       | √       | 08/09/2025-08/09/2026 | IPSRs | PT Inti Presisi Medica    |
| 2  | Rontgen Portable          |          |           |         | √       | 08/09/2025-08/09/2026 | IPSRs | PT Inti Presisi Medica    |
| 3  | CT Scan                   | -        | -         | -       | √       | 02/09/2025-02/09/2026 | IPSRs | PT Inti Presisi Medica    |
| 4  | USG                       |          |           |         | √       | 04/09/2025-04/09/2026 | IPSRs | PT Inti Presisi Medica    |

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit 2026

| No     | Nama Diet         | Jumlah pesanan diet |                  |                | Persentase terhadap bulan sebelumnya (%) |
|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|
|        |                   | Bulan Maret 2026    | Bulan April 2026 | Bulan Mei 2026 |                                          |
| 1.     | Diabetes Mellitus | 400                 | 543              | 342            | ↓37,0                                    |
| 2.     | Rendah Garam      | 569                 | 569              | 574            | 0,9                                      |
| 3.     | Jantung           | 206                 | 236              | 223            | ↓5,5                                     |
| 4.     | Rendah Serat      | 306                 | 308              | 310            | 0,6                                      |
| 5.     | TKTP              | 863                 | 1242             | 932            | ↓25,0                                    |
| 6.     | Makanan Biasa     | 11                  | 21               | 3              | ↓85,7                                    |
| 7.     | Diet Alergi       | 4                   | 6                | 3              | ↓50,0                                    |
| 8.     | Rendah Lemak      | 265                 | 320              | 265            | ↓17,2                                    |
| 9.     | Rendah Protein    | 129                 | 204              | 168            | ↓17,6                                    |
| 10.    | Bubur Halus       | 121                 | 196              | 119            | ↓39,3                                    |
| 11.    | Cair              | 159                 | 296              | 93             | ↓68,6                                    |
| 12.    | Rendah Purin      | 130                 | 161              | 143            | ↓11,2                                    |
| 13.    | Tinggi Protein    | 41                  | 41               | 29             | ↓29,3                                    |
| 14.    | Blender           | 19                  | 21               | 14             | ↓33,3                                    |
| 15.    | Tinggi Serat      | 7                   | 0                | 1              | 0,0                                      |
| 16.    | Tinggi Kalium     | 37                  | 112              | 73             | ↓34,8                                    |
| 17.    | Rendah Kalium     | 22                  | 27               | 73             | ↑170,4                                   |
| 18.    | Rendah Sisa       | 18                  | 6                | 2              | ↓66,7                                    |
| Jumlah |                   | 3307                | 4309             | 3321           | ↓22,9                                    |

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit 2026



Analisis :

Jumlah pemesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Jumlah pemesanan diet menurun 22,9% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada diet cair (menurun 68,6%), sedangkan peningkatan tertinggi terjadi pada diet rendah kalium (>100%). Secara umum jumlah perubahan pemesanan diet dikarenakan adanya pengaruh fluktuasi jumlah pasien dan variasi kasus penyakit.

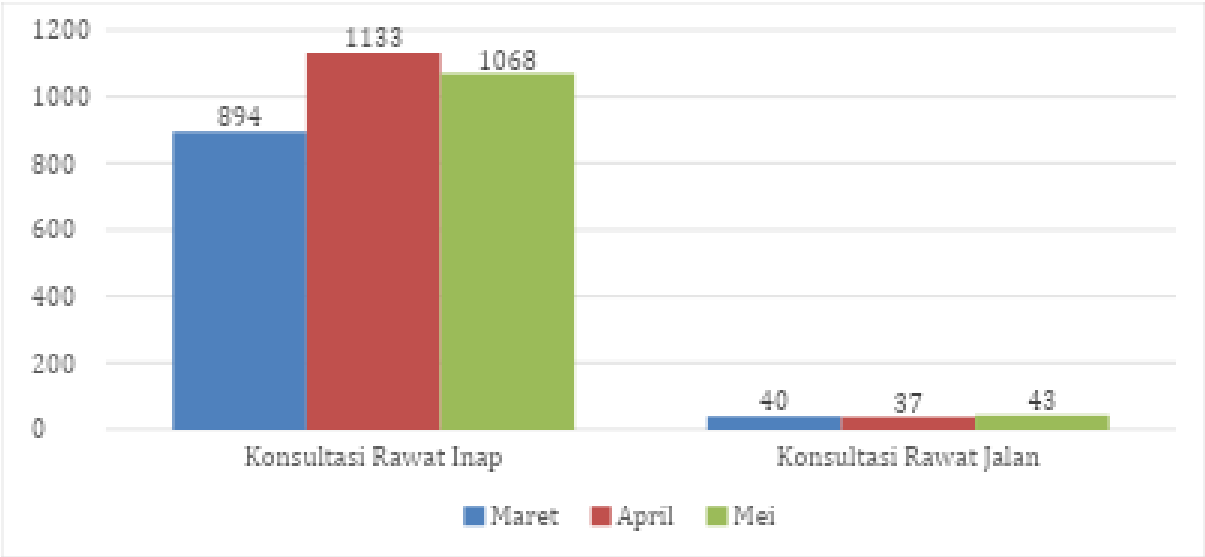
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Pertahankan evaluasi kesesuaian pesanan diet dengan memastikan tidak ada kesalahan input diet oleh ahli gizi.
- 2. Monitoring tren penyakit untuk mengidentifikasi diagnosis terbanyak yang memerlukan diet khusus.
- 3. Evaluasi penurunan jumlah penurunan permintaan diet (diet cair), menelusuri apakah terjadi perubahan pola pelayanan atau penurunan kasus.
- 4. Menelaah tren kasus penyakit ginjal dan gangguan elektrolit pada peningkatan permintaan diet rendah kalium dan memastikan diet yang diberikan sudah sesuai.
- 5. Melakukan monitoring bulanan dengan melihat tren permintaan diet pasien

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi 2026

| No. | Indikasi               | Jumlah Pasien Maret 2026 | Jumlah Pasien April 2026 | Jumlah Pasien Mei 2026 |
|-----|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.  | Konsultasi Rawat Inap  | 894                      | 1133                     | 1068                   |
| 2.  | Konsultasi Rawat Jalan | 40                       | 37                       | 43                     |

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada 2026



**Analisis :**  
Hasil monitoring konsultasi gizi Bulan Mei 2026 menunjukkan jumlah konsultasi rawat inap menurun 5,7% dibanding bulan April. Hal ini seiring dengan penurunan jumlah pasien rawat inap. Konsultasi rawat jalan mengalami peningkatan 16,2%. Secara umum pelayanan konsultasi gizi rawat inap telah dilakukan secara optimal, namun pemanfaatan layanan konsultasi gizi rawat jalan masih cukup rendah hal ini dapat disebabkan karena belum optimalnya jumlah rujukan konsul gizi dari DPJP poli. Kurangnya sosialisasi juga dapat menyebabkan ketidaktahuan dan kurang optimalnya pelayanan konsul gizi rawat jalan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Melakukan evaluasi cakupan konsultasi gizi rawat inap dengan membandingkan jumlah konsultasi dengan jumlah pasien yang beresiko malnutrisi.
  2. Meningkatkan konsultasi gizi rawat jalan dengan sosialisasi layanan konsultasi gizi kepada dokter poli dan edukasi pasien DM, HT, CKD, obesitas, asam urat untuk kontrol gizi berkala.
  3. Melakukan monitoring tren bulanan dengan membandingkan data konsultasi dengan data BOR dan melakukan analisa penyebab terjadinya penurunan.
  4. Penguatan promosi layanan gizi melalui leaflet, media sosial, video edukasi, dan mengadakan edukasi gizi pada komunitas pasien kronis.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Mei 2026

| No | Keluhan                          | Jumlah Komplain Bulan Maret 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Komplain Bulan April 2026 | Jumlah Komplain Bulan Mei 2026 |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Benda asing dalam makanan pasien | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                | 1                              |
|    | ISI KOMPLAINAN                   | Keluarga pasien atas nama Dian Indriani komplain terkait ditemukannya benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                |
|    | Analisis                         | Kejadian ditemukannya benda asing berupa kecoak pada snack pasien (roti bolu) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan higiene dan sanitasi makanan serta ketidakpatuhan terhadap SOP distribusi makanan. Berdasarkan hasil penelusuran, petugas penyaji mengakui telah melakukan pemorsian snack sejak sore hari untuk distribusi keesokan harinya, sehingga terdapat kemungkinan makanan terpapar lingkungan dalam waktu yang cukup lama dan memungkinkan masuknya serangga pada malam hari. Kejadian ini berpotensi menurunkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan gizi, menimbulkan risiko kontaminasi pangan, serta berdampak pada keselamatan pasien apabila tidak segera dilakukan perbaikan. |                                  |                                |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RTL | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pembinaan kepada petugas terkait pemorsian snack yang tidak sesuai dengan SOP.</li> <li>• Melakukan sosialisasi ulang SOP pemorsian, penyimpanan, dan distribusi makanan kepada seluruh petugas Instalasi Gizi.</li> <li>• Memastikan makanan dan snack diporsikan mendekati waktu distribusi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Meningkatkan pengawasan oleh penanggung jawab shift terhadap proses pemorsian dan penyimpanan makanan.</li> <li>• Melakukan inspeksi sanitasi dapur, ruang penyimpanan, dan area distribusi untuk memastikan bebas dari hama dan vektor.</li> <li>• Berkoordinasi dengan petugas pengendalian hama (pest control) untuk melakukan evaluasi dan pengendalian vektor secara berkala.</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi kejadian serupa serta mencatatnya sebagai insiden mutu untuk mencegah kejadian berulang.</li> </ul> |
|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) 2026

| No | Menu         | Rincian Menu                                 | Total Sisa Makanan (kg) |          |          | Keterangan                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                              | Mar 2026                | Apr 2026 | Mei 2026 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | Karbohidrat  | Nasi                                         | 57,8                    | 68,8     | 74,7     | 75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien                                                |
|    |              | Nasi Tim                                     | 82,2                    | 98,8     | 91,7     |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Total        |                                              | 167,2                   | 138      | 166,1    |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. | Snack        | Roti Kukus                                   | 0                       | 0        | 0        | Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulan April tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat pengambilan alat makan snack pasien |
|    |              | Setup Pisang                                 | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Kacang Hijau                                 | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Kue Hongkong                                 | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Terang Bulan                                 | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Bubur Sagu                                   | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Kue Lumpur                                   | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Puding                                       | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Donat                                        | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Tahu Fantasi                                 | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Brule Bomb                                   | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Total        |                                              | 0                       | 0        | 0        |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | Menu 1       |                                              |                         |          |          | Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.                                                                                                                                |
|    | Bulan        |                                              | Mar 2026                | Apr 2026 | Mei 2026 |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Pagi         | Semur (Tahu, Buncis, Bakso)                  | 2,7                     | 3,8      | 4,1      |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Rolade Ayam                                  |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Tambahan VIP | Tempe Goreng                                 |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Siang        | Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi) | 2,6                     | 4,5      | 3,8      |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Ayam Kecap                                   |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|    |              | Tahu Bumbu Tomat                             |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Tambahan VIP | Telur Ceplok                                 |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |



|    |              |                                                        |          |          |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|    | Sore         | Sup (Suun, wortel, polong, bakso)                      | 2,4      | 4,2      | 3,7      |
|    |              | Perkedel kentang ayam                                  |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Ayam fillet panggang teflon                            |          |          |          |
|    | Total        |                                                        | 7,7      | 12,5     | 11,6     |
| 2. | Menu 2       |                                                        |          |          |          |
|    | Bulan        |                                                        | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 |
|    | Pagi         | Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)                | 4        | 4,7      | 3,5      |
|    |              | Tahu Rempah (Remet)                                    |          |          |          |
|    |              | Abon                                                   |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Telur Rebus                                            |          |          |          |
|    | Siang        | Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)          | 3,9      | 4,6      | 3,7      |
|    |              | Ayam Wijen                                             |          |          |          |
|    |              | Bakwan Jagung                                          |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Telur Gulung                                           |          |          |          |
|    | Sore         | Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)          | 3,4      | 4,2      | 3,3      |
|    |              | Telur dadar tebal                                      |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Tempe goreng                                           |          |          |          |
|    | Total        |                                                        | 11,3     | 13,5     | 10,5     |
| 3. | Menu 3       |                                                        |          |          |          |
|    | Bulan        |                                                        | Mar 2026 | Apr 2026 | Mei 2026 |
|    | Pagi         | Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)                    | 3,9      | 4,2      | 3,7      |
|    |              | Tahu Krispy                                            |          |          |          |
|    |              | Abon                                                   |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Telur Ceplok                                           |          |          |          |
|    | Siang        | Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)           | 3,9      | 4        | 3,9      |
|    |              | Rolade Ayam                                            |          |          |          |
|    |              | Tahu Goreng                                            |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Tempe Bacem                                            |          |          |          |
|    | Sore         | Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram) | 3,9      | 0,5      | 3,9      |
|    |              | Telur rebus                                            |          |          |          |
|    | Tambahan VIP | Tempe goreng                                           |          |          |          |
|    | Total        |                                                        | 11,7     | 8,7      | 11,5     |
| 4. | Menu 4       |                                                        |          |          |          |

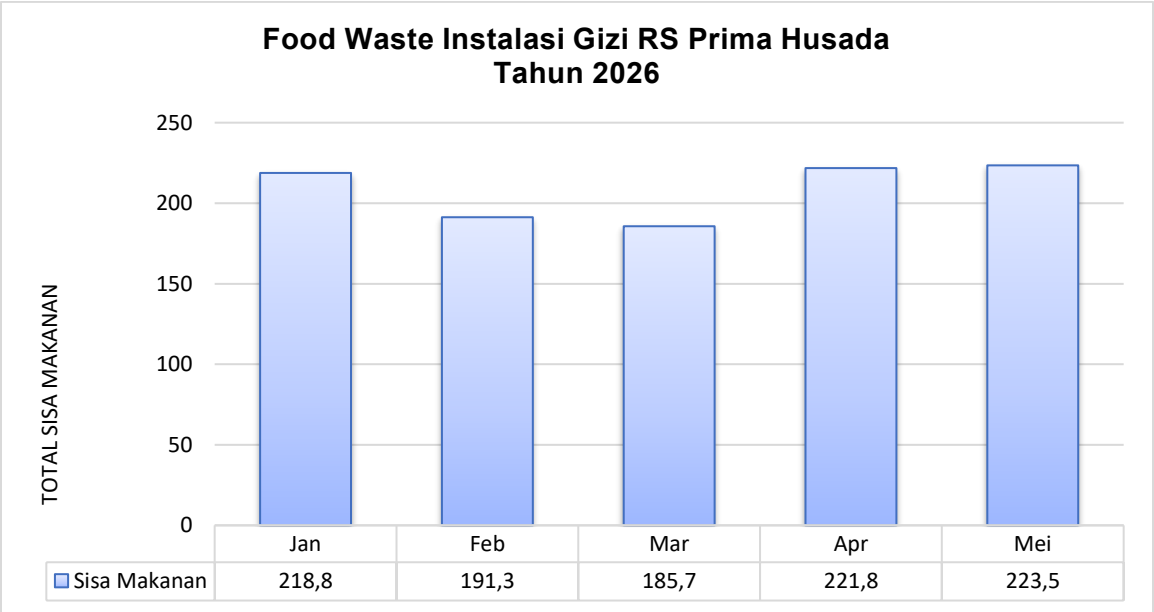
| Bulan                       |                                                   | Mar<br>2026 | Apr<br>2026 | Mei<br>2026 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Pagi                        | Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)        | 3,7         | 3,8         | 4,8         |
|                             | Tahu Nugget                                       |             |             |             |
|                             | Abon                                              |             |             |             |
| Tambahan VIP                | Oseng Bakso Mekar                                 |             |             |             |
| Siang                       | Sup (Oyong, Wortel, Jagung)                       | 2,7         | 4,2         | 3,8         |
|                             | Ayam Kecap                                        |             |             |             |
|                             | Jamur Krispy                                      |             |             |             |
| Tambahan VIP                | Tahu Bacem                                        |             |             |             |
| Sore                        | Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sasu polong orang | 2,8         | 0,9         | 4           |
|                             | Jamur goreng                                      |             |             |             |
|                             | abon                                              |             |             |             |
| Total                       |                                                   | 9,2         | 8,9         | 12,6        |
| 5.                          | Menu 5                                            |             |             |             |
| Bulan                       |                                                   | Mar<br>2026 | Apr<br>2026 | Mei<br>2026 |
| Pagi                        | Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)       | 3           | 2,7         | 4,5         |
|                             | Opor Tahu                                         |             |             |             |
|                             | Oper Telur                                        |             |             |             |
| Tambahan VIP                | Tempe Goreng                                      |             |             |             |
| Siang                       | Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)             | 2,9         | 3,9         | 3,6         |
|                             | Ayam Bombay                                       |             |             |             |
|                             | Bakwan Jagung                                     |             |             |             |
| Tambahan VIP                | Tahu Krispy                                       |             |             |             |
| Sore                        | Soto ayam                                         | 4           | 4           | 2,8         |
|                             | Telur rebus                                       |             |             |             |
|                             | VIP= Perkedel ayam                                |             |             |             |
| Total                       |                                                   | 10,9        | 9,9         | 10,9        |
| Total Sisa Menu tanpa KH    |                                                   | 53,3        | 54,2        | 51,7        |
| Total Keseluruhan dengan KH |                                                   | 191,3       | 221,8       | 223,5       |

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

| No | Bulan         | Total Sisa Makanan (kg) |
|----|---------------|-------------------------|
| 1. | Januari 2026  | 218,8                   |
| 2. | Februari 2026 | 191,3                   |
| 3. | Maret 2026    | 185,7                   |
| 4. | April 2026    | 221,8                   |
| 5. | Mei 2026      | 223,5                   |
| 6. | Juni 2026     | -                       |
| 7. | Juli 2026     | -                       |
| 8. | Agustus 2026  | -                       |

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 9.  | September 2026 | - |
| 10. | Oktober 2026   | - |
| 11. | November 2026  | - |

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



**Analisis :**  
 Pada bulan Mei 2026 total sisa makanan pasien tercatat 223,5 kg, meningkat sebesar 1,7 kg ( $\pm 0,8\%$ ) dibandingkan April 2026 (221,8 kg) dan menjadi nilai tertinggi pada periode Januari – Mei 2026. Dibandingkan Maret 2026 (185,7 kg), kenaikannya mencapai 37,8 kg ( $\pm 20,4\%$ ). Hal ini menunjukkan bahwa masalah sisa makanan belum membaik dan cenderung menetap pada level tinggi selama dua bulan terakhir.

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Melakukan evaluasi rutin terhadap jumlah food waste setiap bulan.
2. Mengelompokkan sisa makanan berdasarkan jenis diet, bangsal, dan status puasa/prosedur agar penyebab dominan dapat diidentifikasi.
3. Memastikan makanan diporsikan dan didistribusikan mendekati waktu konsumsi serta suhu penyajian sesuai standar.
4. Melakukan visite pasien dengan sisa makanan tinggi oleh ahli gizi untuk memodifikasi tekstur/menu bila diperlukan.
5. Malkukan standarisasi metoda penimbangan dan pencatatan sisa makanan agar data antar-bangsal konsisten dan dapat dibandingkan.

1.4.7 CSSD – Laundry

1.4.7.1 CSSD

1.4.7.2 Tabel Jumlah Pemakaian Alat Sterilisasi 2026

| No | Nama Alat | Jumlah Penggunaan |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |           | JAN               | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1  | Memert    | 124               | 112 | 121 | 118 | 121 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Autoklaf  | 17                | 16  | 15  | 17  | 17  |     |     |     |     |     |     |     |

Analisis:  
 Pada bulan Mei 2026, penggunaan alat sterilisasi **Memert** sebanyak **121 kali** dan **Autoklaf** sebanyak **17 kali**. Penggunaan Memert tetap stabil dan berada pada tingkat

yang sama dengan bulan Maret, sedangkan penggunaan Autoklaf juga stabil dibandingkan bulan April. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan sterilisasi selama bulan Mei tetap tinggi dan dapat terlayani dengan baik tanpa adanya gangguan yang berdampak pada proses sterilisasi. Stabilitasnya frekuensi penggunaan kedua alat mengindikasikan bahwa operasional CSSD berjalan sesuai kebutuhan pelayanan unit pengguna serta tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam proses sterilisasi alat dan bahan medis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan monitoring penggunaan alat sterilisasi secara rutin setiap bulan.
- 2. Memastikan pelaksanaan preventive maintenance dan kalibrasi alat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- 3. Memastikan ketersediaan indikator sterilisasi dan bahan pendukung sterilisasi selalu mencukupi.
- 4. Melakukan monitoring hasil uji fungsi alat dan hasil indikator sterilisasi untuk menjamin efektivitas proses sterilisasi.
- 5. Mempertahankan kepatuhan petugas terhadap SOP sterilisasi dan dokumentasi penggunaan alat.

Tabel Jumlah permintaan alat steril dari unit perawatan Tahun 2026

| NO | NAMA UNIT     | JUMLAH PENGGUNAAN |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------|-------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |               | JAN               | FEB | MAR | APR  | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1  | IKO           | 445               | 456 | 461 | 480  | 466 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | IRJA          | 115               | 106 | 126 | 136  | 130 |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | IGD           | 106               | 121 | 121 | 129  | 101 |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | IRNA 2 A      | 1                 | -   | 1   | 1    | 5   |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | IRNA 3 A      | 1                 | 1   | 1   | 2    | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | IRNA 4 A      | 2                 | 3   | 4   | 4    | 5   |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | IRNA 6 A      | 5                 | 3   | 4   | 5    | 8   |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | IRNA 7 A      | 9                 | 9   | 9   | 11   | 10  |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  | IRNA 8 A      | 8                 | 7   | 3   | 8    | 5   |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | IRNA 2 C      | 2                 | 2   | 2   | 3    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 11 | ICU/HCU       | 4                 | 3   | 2   | 3    | 2   |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 | IRNA 3 C      | 4                 | 2   | 1   | 0    | 5   |     |     |     |     |     |     |     |
| 13 | IRNA 4C/MATER | 178               | 171 | 189 | 197  | 126 |     |     |     |     |     |     |     |
| 14 | PERINA        | 65                | 46  | 55  | 57   | 34  |     |     |     |     |     |     |     |
| 15 | IRNA 5 C      | 4                 | 3   | 3   | 2    | 1   |     |     |     |     |     |     |     |
|    | JUMLAH        | 949               | 933 | 982 | 1038 | 901 |     |     |     |     |     |     |     |

Analisis :

Pada bulan Mei 2026, total penggunaan layanan CSSD tercatat sebanyak 901 kali, mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2026 yang mencapai 1.038 kali (↓13,2%). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penggunaan dari unit IRNA 4C/Mater yang turun dari 197 menjadi 126 penggunaan (↓36,0%) dan Perina yang turun dari 57 menjadi 34 penggunaan (↓40,4%). Meskipun demikian, IKO tetap menjadi pengguna terbesar dengan 466 penggunaan (51,7% dari total penggunaan), diikuti IRJA sebanyak 130 penggunaan dan IRNA 4C/Mater sebanyak 126 penggunaan. Beberapa unit menunjukkan peningkatan penggunaan dibanding bulan sebelumnya, antara lain IRNA 6A (dari 5 menjadi 8 penggunaan), IRNA 4A (dari 4 menjadi 5 penggunaan), dan IRNA 3C (dari 0 menjadi 5 penggunaan). Secara umum, penurunan total penggunaan pada bulan Mei masih berada dalam batas yang wajar dan kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan aktivitas pelayanan pada beberapa unit pengguna utama, khususnya ruang rawat inap maternitas dan perinatologi.

**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Melakukan monitoring penggunaan layanan CSSD per unit setiap bulan untuk mengidentifikasi tren kebutuhan sterilisasi.
2. Melakukan evaluasi bersama unit dengan penurunan penggunaan signifikan (IRNA 4C/Mater dan Perina) untuk mengetahui faktor penyebab penurunan.
3. Memastikan kesiapan alat, bahan sterilisasi, dan SDM CSSD agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pelayanan seluruh unit.
4. Melakukan koordinasi dengan IKO sebagai pengguna terbesar untuk memastikan ketersediaan instrumen steril sesuai jadwal tindakan.
5. Memantau kesesuaian penggunaan alat steril dengan jumlah tindakan pelayanan pada masing-masing unit.
6. Menyajikan laporan penggunaan CSSD secara berkala dalam rapat mutu sebagai bahan evaluasi efektivitas pelayanan sterilisasi.

**Tabel Rekap Produksi Kassa dan Linen Steril Tahun 2026**

| No | Nama Produksi      | Jumlah Produksi Kassa (Pouches) |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|--------------------|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                    | JAN                             | FEB  | MAR  | APR  | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| *  | BAHAN BJ           |                                 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1  | Kasa IKO           | 685                             | 685  | 690  | 715  | 660 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Kasa Deapress      | 274                             | 270  | 276  | 280  | 220 |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Kasa Bigkass       | 134                             | 166  | 133  | 134  | 132 |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Kasa Tampon Hidung | 20                              | 20   | 20   | 20   | 20  |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | Kasa Tampon Roll   | 15                              | 15   | 15   | 15   | 15  |     |     |     |     |     |     |     |
| *  | BAHAN HIDROFIL     |                                 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1  | Kasa Ruang         | 1081                            | 1079 | 1310 | 1391 | 995 |     |     |     |     |     |     |     |
| *  | LINEN STERIL       |                                 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1  | Linen IKO          | 206                             | 201  | 213  | 221  | 230 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Linen Mata         | 11                              | 8    | 8    | 11   | 12  |     |     |     |     |     |     |     |

**Analisis:**

Pada bulan Mei 2026 terjadi penurunan produksi pada sebagian besar jenis kassa steril, terutama Kasa Ruang dan Kasa Deapress, sementara produksi linen steril menunjukkan peningkatan. Kondisi ini masih sejalan dengan kebutuhan pelayanan dan tidak menimbulkan gangguan distribusi kepada unit pengguna. Monitoring kebutuhan dan perencanaan produksi yang tepat perlu terus dilakukan untuk menjaga efektivitas pelayanan CSSD

**Rencana Tindak Lanjut:**

1. Melakukan monitoring produksi kassa dan linen steril berdasarkan tren permintaan dari unit pengguna.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian antara jumlah produksi dengan jumlah distribusi untuk menghindari overstock maupun kekurangan stok.
3. Memastikan ketersediaan bahan baku kassa, linen, dan bahan pendukung sterilisasi tetap mencukupi.
4. Melakukan koordinasi dengan unit pengguna terkait estimasi kebutuhan bulanan agar

- produksi lebih tepat sasaran.
5. Mempertahankan ketersediaan stok minimum (buffer stock) untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan mendadak.
  6. Melakukan evaluasi bulanan terhadap jenis produk yang mengalami penurunan atau peningkatan signifikan sebagai dasar perencanaan produksi berikutnya.

1.4.7.2 Laundry

Tabel Jumlah Pencucian Linen 2026

| No | Nama Alat     | Jumlah Pencucian |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|----|---------------|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |               | JAN              | FEB  | MAR  | APR  | MEI  | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1  | Infeksius     | 2496             | 2256 | 2278 | 2366 | 2189 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Non infeksius | 2402             | 2309 | 2443 | 2480 | 2568 |     |     |     |     |     |     |     |

Tabel Jumlah linen kotor setiap unit Tahun 2026

| No | Nama Unit  | Jumlah Penggunaan |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------|-------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |            | JAN               | FEB  | MAR  | APR  | MEI  | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1  | IKO        | 2.030             | 1869 | 1812 | 2005 | 1847 |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | IRJA       | 107               | 100  | 123  | 120  | 147  |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | IGD        | 173               | 175  | 232  | 240  | 224  |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | IRNA 2 A   | 155               | 143  | 165  | 193  | 177  |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | IRNA 3 A   | 80                | 55   | 14   | 127  | 15   |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | IRNA 4 A   | 248               | 247  | 247  | 269  | 261  |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | IRNA 6 A   | 172               | 164  | 182  | 167  | 180  |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | IRNA 7 A   | 166               | 155  | 187  | 158  | 179  |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  | IRNA 8 A   | 191               | 168  | 171  | 198  | 170  |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | IRNA 2 C   | 280               | 248  | 193  | 201  | 246  |     |     |     |     |     |     |     |
| 11 | ICU        | 202               | 218  | 201  | 198  | 221  |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 | IRNA 3 C   | 342               | 389  | 400  | 410  | 428  |     |     |     |     |     |     |     |
| 13 | MATERNITAS | 425               | 356  | 382  | 390  | 341  |     |     |     |     |     |     |     |
| 14 | IRNA 5 C   | 232               | 183  | 195  | 196  | 241  |     |     |     |     |     |     |     |
| 15 | M.S        | 58                | 56   | 28   | 31   | 29   |     |     |     |     |     |     |     |
| 16 | Umum       | 9                 | 7    | 24   | 9    | 14   |     |     |     |     |     |     |     |
| 17 | CSSD       | 13                | 7    | 11   | 11   | 9    |     |     |     |     |     |     |     |
| 18 | DAPUR/GIZ  | 9                 | 7    | 6    | 6    | 5    |     |     |     |     |     |     |     |
| 19 | RAD        | 9                 | 11   | 8    | 8    | 6    |     |     |     |     |     |     |     |
| 20 | LAB        | 8                 | 7    | 6    | 7    | 7    |     |     |     |     |     |     |     |

Analisa:

Volume pencucian linen bulan Mei masih didominasi oleh linen non infeksius.

IKO tetap menjadi kontributor terbesar linen kotor sehingga perlu dilakukan pemantauan efisiensi penggunaan linen. Kenaikan penggunaan linen pada beberapa ruang rawat perlu dievaluasi apakah sesuai dengan peningkatan BOR, jumlah tindakan, atau adanya penggantian linen yang lebih sering.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan linen per tindakan di IKO untuk memastikan penggunaan linen sesuai standar kebutuhan pelayanan.
2. Melakukan evaluasi penggunaan linen berdasarkan jumlah pasien, BOR, dan frekuensi penggantian linen di ruang perawatan.
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan pemilahan linen infeksius dan non infeksius sesuai SPO untuk meningkatkan ketepatan klasifikasi linen.

- 4. Melakukan monitoring penggunaan linen per unit secara rutin dan memberikan umpan balik kepada unit dengan penggunaan tertinggi sebagai upaya efisiensi.
- 5. Melakukan evaluasi distribusi dan penggunaan linen non infeksius untuk memastikan penggunaan sesuai kebutuhan pelayanan dan mencegah pemborosan.

Tabel Pemakaian Chemical Laundry Tahun 2026

| No | Nama Chemical   | Jumlah Penggunaan |        |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                 | JAN               | FEB    | MAR    | APR    | MEI    | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
| 1  | Clax built lite | 1                 | 1      | 2      | 2      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | CLAX 100        | 1                 | 1      | 2      | 2      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | CLAX sonril     | 1                 | 1      | 1      | 2      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | CLAX neutral    | 1                 | 1      | 1      | 2      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | CLAX soft       | 1                 | 1      | 1      | 1      | 1      |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  | Snapy           | 15 L              | 0      | 5      | 15 L   | 20 L   |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  | Rapika          | 14 pcs            | 28 pcs | 20 pcs | 15 pcs | 0 L    |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  | Bayklin         | 15 L              | 17 L   | 16 L   | 18 L   | 14 L   |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  | Softener        | 0                 | 0      |        |        | 10 L   |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 | Liquid matic    | 30 L              | 30 L   | 33 L   | 20 L   | 11,2 L |     |     |     |     |     |     |     |

Analisa:  
Penggunaan chemical utama laundry (Clax Built Lite, Clax 100, Clax Sonril, Clax Neutral, dan Clax Soft) pada bulan Mei relatif stabil dan cenderung menurun dibanding April, masing-masing sebesar 1 kemasan. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah pencucian linen infeksius pada bulan Mei.

- Rencana tindak Lanjut:
- 1. Melakukan evaluasi kebutuhan dan pola penggunaan Snapy untuk memastikan penggunaan sesuai standar operasional laundry.
  - 2. Memantau kesesuaian penggunaan disinfektan dengan volume linen infeksius yang diproses setiap bulan.
  - 3. Melakukan evaluasi kebutuhan penggunaan Rapika dan memastikan tidak terdapat kendala ketersediaan stok.
  - 4. Melakukan pengecekan stok dan evaluasi efisiensi penggunaan untuk memastikan kebutuhan operasional tetap terpenuhi.
  - 5. Melakukan monitoring penggunaan Softener untuk memastikan efektivitas penggunaan dan menghindari pemakaian berlebihan.

4.4 Kinerja Bidang Umum

1.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

| NO | UNIT                  | PENDIDIKAN                    | TOTAL | JUMLAH | TETAP | TIDAK TETAP | RESIGN |
|----|-----------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| 1  | Direktur              | Dokter Umum                   | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 2  | Kabid Pelayanan Medis | D3 Kebidanan                  | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 3  | Kabid Penunjang Medis | Profesi Ners                  | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 4  | Kabid Keperawatan     | Profesi Ners                  | 0     | 0      | 0     | 0           | 0      |
| 5  | Kabid Umum            | Dokter Gigi Umum              | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 6  | Casemix Manager       | SMK                           | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 7  | Farmasi               | Profesi Apoteker              | 39    | 12     | 6     | 6           | 0      |
|    |                       | S1 Farmasi                    |       | 3      | 2     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Analis Farmasi dan Makanan |       | 1      | 1     | 0           | 0      |

|    |                   |                                        |    |    |    |   |   |
|----|-------------------|----------------------------------------|----|----|----|---|---|
|    |                   | D3 Farmasi                             |    | 22 | 14 | 8 | 1 |
|    |                   | SMK                                    |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                   | S1 Manajemen                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 8  | Asuransi Center   | D3 Asuransi Kesehatan                  | 10 | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                   | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |    | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                   | SMK                                    |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                   | SMA                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 9  | CSSD              | D3 Keperawatan                         | 3  | 2  | 1  | 1 | 0 |
|    |                   | SMA                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                   | SMK                                    |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 10 | Fisioterapi       | S1 Fisioterapi                         | 5  | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Fisioterapi                         |    | 3  | 2  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Terapi Wicara                       |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
| 11 | Gizi              | S1 Ilmu Gizi                           | 16 | 2  | 2  | 0 | 0 |
|    |                   | D4 Gizi dan Dietetika                  |    | 2  | 2  | 0 | 1 |
|    |                   | D3 Ahli Gizi                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
|    |                   | SMK                                    |    | 6  | 0  | 6 | 0 |
|    |                   | SMA                                    |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                   | SMP                                    |    | 3  | 2  | 1 | 0 |
| 12 | Humas & Marketng  | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2  | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                   | S1 Teknik Informatika                  |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
| 13 | ICU dan HCU       | Profesi Ners                           | 10 | 5  | 5  | 0 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 4  | 2  | 2 | 0 |
|    |                   | D3 Kebidanan                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 14 | IGD               | Profesi Ners                           | 23 | 10 | 8  | 2 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 9  | 7  | 2 | 0 |
|    |                   | D4 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
|    |                   | D3 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 15 | IKO               | Profesi Ners                           | 11 | 7  | 7  | 0 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 4  | 4  | 0 | 0 |
|    |                   | D3 Kebidanan                           |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 16 | IPCN              | Profesi Ners                           | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 17 | IPSRS             | S1 Tenik Elektro                       | 6  | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                   | S1 Kesehatan Masyarakat                |    | 1  | 1  | 0 | 1 |
|    |                   | D3 Teknik Elektromedis                 |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                   | SMK                                    |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 18 | IRJA              | Profesi Ners                           | 28 | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 15 | 14 | 1 | 0 |
|    |                   | D4 Keperawatan Gigi                    |    | 1  | 0  | 1 | 1 |
|    |                   | Profesi Kebidanan                      |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Kebidanan                           |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 19 | IRNA 2C           | Profesi Ners                           | 7  | 5  | 4  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 20 | IRNA 2A, 3A, & 4A | Profesi Ners                           | 17 | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 9  | 6  | 3 | 0 |
| 21 | IRNA 3C Anak      | Profesi Ners                           | 12 | 4  | 2  | 2 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                   | D3 Kebidanan                           |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 22 | IRNA 5C           | Profesi Ners                           | 9  | 3  | 1  | 2 | 0 |
|    |                   | D3 Keperawatan                         |    | 6  | 4  | 2 | 0 |



|    |                      |                                        |    |    |    |   |   |
|----|----------------------|----------------------------------------|----|----|----|---|---|
| 23 | IRNA 6A, 7A, & 8A    | Profesi Ners                           | 22 | 9  | 4  | 5 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 24 | Maternitas           | Profesi Kebidanan                      | 10 | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D4 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 7  | 7  | 0 | 0 |
| 25 | Neonatologi          | Profesi Ners                           | 8  | 3  | 2  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 4  | 4  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 26 | Keuangan & Akuntansi | S1 Ekonomi                             | 8  | 2  | 2  | 0 | 1 |
|    |                      | S1 Akuntansi                           |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | S1 Manajemen                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMK                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 27 | Laboratorium         | D4 Analis Kesehatan                    | 9  | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Analis Kesehatan                    |    | 8  | 6  | 2 | 0 |
| 28 | Laundry              | SMK                                    | 5  | 2  | 1  | 1 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 2  | 1  | 1 | 0 |
|    |                      | SMP                                    |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
| 29 | Rekam Medis          | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 8  | 8  | 8  | 0 | 0 |
| 30 | Pendaftaran          | S1 Sastra Inggris                      | 13 | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                      | S1 Kesehatan Masyarakat                |    | 1  | 1  | 0 | 1 |
|    |                      | D3 Asuransi Kesehatan                  |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |    | 6  | 5  | 1 | 0 |
|    |                      | D1 Administrasi Perkantoran            |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMK                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 31 | PIPP & MPP           | Profesi Ners                           | 4  | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                      | D4 Kebidanan                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 32 | PMKP                 | Profesi Ners                           | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 33 | Radiologi            | D3 Radiodiagnostik & Radioterapi       | 6  | 6  | 4  | 2 | 0 |
| 34 | SDM                  | S1 Sosial                              | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 35 | Sekretaris           | S1 Administrasi Publik                 | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 36 | SIMRS & IT           | S1 Teknik Informatika                  | 3  | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 37 | Umum & Rumah Tangga  | S1 Ekonomi                             | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 38 | Cleaning Service     | SMK                                    | 39 | 12 | 7  | 5 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 22 | 18 | 4 | 0 |
|    |                      | SMP                                    |    | 5  | 5  | 0 | 0 |
| 39 | Security             | SMK                                    | 10 | 4  | 2  | 2 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 6  | 6  | 0 | 0 |
| 40 | Driver               | D1 Administrasi Perkantoran            | 6  | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 4  | 3  | 1 | 0 |
|    |                      | SMP                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 41 | Gudang Umum          | SMP                                    | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 42 | Staf Orientasi       | Profesi Ners                           | 3  | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 TVF                                 |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Analis Kesehatan                    |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | SMK                                    |    | 1  | 0  | 1 | 0 |

|                   |                                                    |                             |     |     |     |     |   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
|                   |                                                    |                             |     |     |     |     |   |
| Total Karyawan    |                                                    |                             | 363 | 363 | 273 | 90  | 6 |
| 43                | Dokter IGD                                         | Dokter Umum                 | 9   | 9   | 0   | 9   | 1 |
| 44                | Dokter Casemix                                     | Dokter Umum                 | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 45                | Dokter Spesialis Penyakit Dalam                    | Pendidikan Dokter Spesialis | 5   | 5   | 1   | 4   | 0 |
| 46                | Dokter Spesialis Anak                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3   | 0 |
| 47                | Dokter Spesialis Bedah Umum                        | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4   | 0 |
| 48                | Dokter Spesialis Bedah Plastik                     | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 49                | Dokter Spesialis Bedah Saraf                       | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 50                | Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi          | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4   | 0 |
| 51                | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                    | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 52                | Dokter Spesialis Mata                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3   | 0 |
| 53                | Dokter Spesialis THT                               | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 54                | Dokter Spesialis Paru                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3   | 0 |
| 55                | Dokter Spesialis Saraf                             | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4   | 0 |
| 56                | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah        | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3   | 0 |
| 57                | Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology        | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3   | 0 |
| 58                | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin                 | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 59                | Dokter Spesialis Urologi                           | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 60                | Dokter Spesialis Anestesi                          | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 1   | 2   | 0 |
| 61                | Dokter Spesialis Radiologi                         | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 62                | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2   | 0 |
| 63                | Dokter Spesialis Patologi Klinik                   | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 64                | Dokter Spesialis Patologi Anatomi                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 65                | Dokter Spesialis Gigi Periodontis                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 66                | Dokter Spesialis Gigi Pedodontis                   | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 67                | Dokter Spesialis Gigi Orthodontis                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| 68                | Dokter Spesialis Konservasi Gigi                   | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| Total Dokter      |                                                    |                             | 66  | 66  | 2   | 64  | 1 |
| Total Keseluruhan |                                                    |                             | 429 | 429 | 275 | 154 | 7 |

Keterangan :  
Pada bulan Mei terdapat 5 staf dan 1 dokter resign.

### 3.5.1.1 Update STR / SIP

| NO | NAMA                                      | PROFESI | TANGGAL KEJADIAN | KETERANGAN                  |
|----|-------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------|
| 1  | Neneng Aprilia Pangestuti, A.Md.Kep       | Perawat | 09/04/2026       | SIP Perpanjangan            |
| 2  | Bagus Ardiansyah Putra, S.Kep.Ns          | Perawat | 17/04/2026       | SIP Perpanjangan            |
| 3  | Septian Teguh Imanda, AMd.Kep             | Perawat | 22/04/2026       | SIP Perpanjangan            |
| 4  | Ineke Yulkarnain, S. Kep., Ns             | Perawat | 06/04/2026       | SIP Baru                    |
| 5  | Nike Kristanti,S.Kep.,Ns ( Alih Jenjang ) | Perawat | 22/04/2026       | SIP Alih Jenjang Pendidikan |

Keterangan :  
Pada bulan April 2026 terdapat 5 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

| NO | PROFESI                      | JUMLAH YANG DIBUTUHKAN | TERPENUHI | KEKURANGAN | PENYEBAB                                                 | RENCANA TINDAK LANJUT                                                                                 |
|----|------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terapi Okupasi               | 1                      | 0         | 1          | Sulit mencari kandidat terapis okupasi                   | Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi |
| 2  | Dokter Spesialis Bedah Mulut | 1                      | 0         | 1          | Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut | Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut                                                            |
| 3  | Dokter Spesialis Radiologi   | 1                      | 0         | 1          | Belum mendapatkan kandidat                               | Dibutuhkan yang Perempuan                                                                             |
| 4  | Dokter Umum IGD              | 2                      | 0         | 2          | Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.  | Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.                                               |
| 5  | Dokter Casemix               | 1                      | 0         | 1          | Mengganti dokter yang akan resign                        | Proses seleksi sudah dilakukan oleh PT. Menunggu hasil.                                               |

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

| NO | TANGGAL                        | JENIS ORIENTASI | NAMA STAF                      | PENDIDIKAN | PROFESI | SPMJ (TANGGAL MASUK) | KETERANGAN            |
|----|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 1  | 25 Februari 2026 – 24 Mei 2026 | Khusus          | Nuril Maulidatul Qorida, S. KM | S1         | PMKP    | 25 Februari 2025     | Penempatan Sekre PMKP |
| 2  | 01 April 2026 – 30 Juni 2026   | Khusus          | Mohammad Rizki Hidayat         | SMK        | CS      | 01 April 2026        | Penempatan CS         |
| 3  | 01 Mei 2026 – 31 Juli 2026     | Khusus          | Putri Sofiana Sari, Amd. Farm  | D3         | TVF     | 01 Mei 2026          | Penempatan Farmasi    |

Keterangan : Pada bulan Mei 2026 ada 3 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

| NO | JUDUL DIKLAT | JENIS DIKLAT | JUMLAH PESERTA |             | TANGGAL PELAKSANAAN | SERTIFIKAT |       | HASIL EVALUASI DALAM KINERJA SEHARI-HARI |             |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------------|------------|-------|------------------------------------------|-------------|
|    |              |              | HADIR          | TIDAK HADIR |                     | ADA        | TIDAK | PATUH                                    | TIDAK PATUH |
|    |              |              |                |             |                     |            |       |                                          |             |

Keterangan:

Pada bulan April 2026 belum ada diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

| NO | UNIT                  | PENILAIAN KINERJA | CATATAN KHUSUS |       | HASIL EVALUASI |   |   |   | KESIMPULAN                                                                                        |
|----|-----------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                   | Baik           | Jelek | SB             | B | C | K |                                                                                                   |
| 1  | Direktur              | Umum              | 1              | 0     | 0              | 1 | 0 | 0 | Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.              |
| 2  | Kabid Pelayanan Medis | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0 | 0 | 0 | Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. |
| 3  | Kabid Penunjang Medis | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0 | 0 | 0 | Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. |
| 5  | Kabid Umum            | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0 | 0 | 0 | Unit Kabid Umum & Keuangan                                                                        |

| NO | UNIT                     | PENILAIAN KINERJA | CATATAN KHUSUS |       | HASIL EVALUASI |    |   |   | KESIMPULAN                                                                                           |
|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                   | Baik           | Jelek | SB             | B  | C | K |                                                                                                      |
|    |                          |                   |                |       |                |    |   |   | secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                               |
| 6  | Casemix Manager          | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0  | 0 | 0 | Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. |
| 7  | Farmasi                  | Umum              | 38             | 0     | 7              | 21 | 7 | 1 | Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                  |
| 8  | Asuransi Center          | Umum              | 10             | 0     | 6              | 3  | 0 | 1 | Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.          |
| 9  | CSSD                     | Umum              | 3              | 0     | 2              | 1  | 0 | 0 | Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                     |
| 10 | Fisioterapi              | Umum              | 5              | 0     | 0              | 4  | 1 | 0 | Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.              |
| 11 | Gizi                     | Umum              | 16             | 0     | 9              | 7  | 0 | 0 | Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                     |
| 12 | Humas & Marketing & PKRS | Umum              | 2              | 0     | 0              | 2  | 0 | 0 | Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.   |
| 13 | ICU dan HCU              | Umum              | 10             | 0     | 7              | 3  | 0 | 0 | Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                |
| 14 | IGD                      | Umum              | 23             | 0     | 17             | 6  | 0 | 0 | Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.                       |
| 15 | IKO                      | Umum              | 11             | 0     | 10             | 1  | 0 | 0 | Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                      |
| 16 | IPCN                     | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0  | 0 | 0 | Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                      |
| 17 | IPSRs                    | Umum              | 6              | 0     | 4              | 2  | 0 | 0 | Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                    |
| 18 | IRJA                     | Umum              | 28             | 0     | 18             | 7  | 3 | 0 | Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                     |
| 18 | IRNA 2C                  | Umum              | 7              | 0     | 7              | 0  | 0 | 0 | Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                  |
| 19 | IRNA 2A, 3A, & 4A        | Umum              | 16             | 0     | 14             | 2  | 0 | 0 | Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                |
| 20 | IRNA 3C Anak             | Umum              | 12             | 0     | 12             | 0  | 0 | 0 | Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.             |
| 21 | IRNA 5C                  | Umum              | 8              | 0     | 5              | 3  | 0 | 0 | Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                  |
| 22 | IRNA 6A, 7A, & 8A        | Umum              | 21             | 0     | 20             | 1  | 0 | 0 | Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja               |

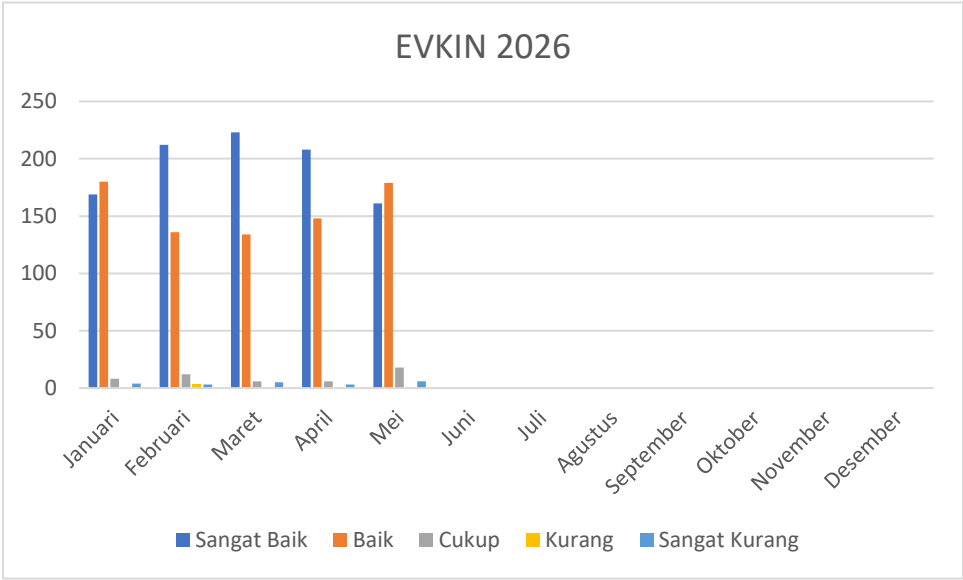
| NO | UNIT                 | PENILAIAN KINERJA | CATATAN KHUSUS |       | HASIL EVALUASI |    |   |   | KESIMPULAN                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|-------------------|----------------|-------|----------------|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |                   | Baik           | Jelek | SB             | B  | C | K |                                                                                                                                                                        |
|    |                      |                   |                |       |                |    |   |   | umum.                                                                                                                                                                  |
| 23 | Maternitas           | Umum              | 10             | 0     | 7              | 3  | 0 | 0 | Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                 |
| 24 | Neonatologi          | Umum              | 8              | 0     | 7              | 1  | 0 | 0 | Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                |
| 25 | Keuangan & Akuntansi | Umum              | 9              | 0     | 2              | 7  | 0 | 0 | Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                   |
| 26 | Laboratorium         | Umum              | 8              | 0     | 2              | 6  | 0 | 0 | Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                               |
| 27 | Laundry              | Umum              | 5              | 0     | 1              | 4  | 0 | 0 | Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                    |
| 28 | Rekam Medis          | Umum              | 7              | 0     | 2              | 5  | 0 | 0 | Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                |
| 29 | Pendaftaran          | Umum              | 14             | 0     | 3              | 10 | 0 | 1 | Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                |
| 30 | PIPP & MPP           | Umum              | 4              | 0     | 4              | 0  | 0 | 0 | Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.<br>Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan. |
| 31 | PMKP                 | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0  | 0 | 0 | Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                |
| 32 | Radiologi            | Umum              | 6              | 0     | 4              | 2  | 0 | 0 | Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                  |
| 33 | SDM                  | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0  | 0 | 0 | Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                        |
| 34 | Sekretaris           | Umum              | 1              | 0     | 1              | 0  | 0 | 0 | Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                 |
| 35 | SIMRS & IT           | Umum              | 3              | 0     | 1              | 2  | 0 | 0 | Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                   |
| 36 | Umum & Rumah Tangga  | Umum              | 1              | 0     | 0              | 1  | 0 | 0 | Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                       |
| 37 | Cleaning Service     | Umum              | 40             | 0     | 23             | 17 | 0 | 1 | Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                           |
| 38 | Security             | Umum              | 12             | 0     | 10             | 2  | 0 | 0 | Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                   |
| 39 | Driver               | Umum              | 6              | 0     | 3              | 2  | 1 | 0 | Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.                                                                                     |
| 40 | Gudang               | Umum              | 1              | 0     | 0              | 1  | 0 | 0 | Unit Gudang Umum secara                                                                                                                                                |

| NO | UNIT | PENILAIAN KINERJA | CATATAN KHUSUS |       | HASIL EVALUASI |   |   |   | KESIMPULAN                                                      |
|----|------|-------------------|----------------|-------|----------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|
|    |      |                   | Baik           | Jelek | SB             | B | C | K |                                                                 |
|    | Umum |                   |                |       |                |   |   |   | keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. |

**Analisis :**  
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Mei 2026.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



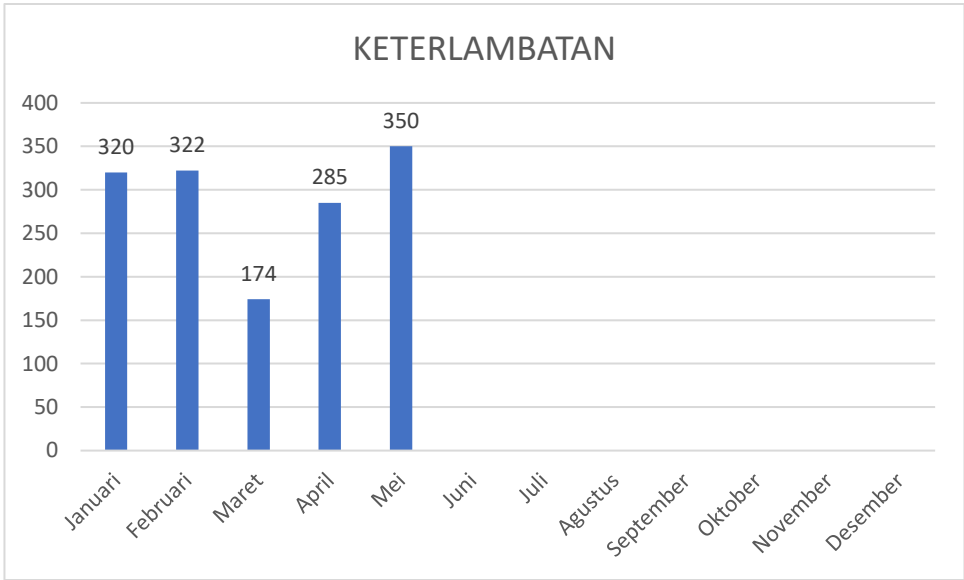
| Kategori      | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Sangat Baik   | 169     | 212      | 223   | 208   | 161 |      |      |         |           |         |          |          |
| Baik          | 180     | 136      | 134   | 148   | 179 |      |      |         |           |         |          |          |
| Cukup         | 8       | 12       | 6     | 6     | 18  |      |      |         |           |         |          |          |
| Kurang        | 0       | 3        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| Sangat Kurang | 4       | 3        | 5     | 3     | 6   |      |      |         |           |         |          |          |
| TOTAL         | 361     | 366      | 368   | 365   | 364 |      |      |         |           |         |          |          |

**Analisa :**  
 Secara umum terdapat kenaikan kategori sangat baik.

- Rencana Tindakanlanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
  2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
  3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
  4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

|               | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| KETERLAMBATAN | 320     | 332      | 174   | 285   | 350 |      |      |         |           |         |          |          |



**Analisa :**  
Secara umum terdapat peningkatan jumlah keterlambatan pada bulan ini

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
  - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
  - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

| NO | UNIT            | JUMLAH KONSELING GRUP | JUMLAH KONSELING INDIVIDU |                     |                             |                            |                 |       |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
|    |                 |                       | KONTRAK N-ED              | TERKAIT TATA TERTIB | TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU | TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI | TERKAIT MANRISK | KARIR |
| 1  | Manajerial RS   | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 2  | SDM             | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 3  | Asuransi Center | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 1     |
| 4  | IRNA 2C         | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 5  | IRNA 3C Anak    | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 6  | IRNA 3A & 4A    | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 7  | IRNA 5C         | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 8  | IRNA 6A & 7A    | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 9  | Maternitas      | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 1     |
| 10 | Neonatologi     | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 11 | IGD             | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 1     |
| 12 | ICU             | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 13 | HCU             | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 14 | IKO             | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 15 | Gizi            | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 16 | Farmasi         | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 1     |
| 17 | Laboratorium    | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 18 | Radiologi       | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 19 | Rekam Medis     | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 1     |
| 20 | Pendaftaran     | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 21 | CSSD            | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 22 | Laundry         | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |
| 23 | Keuangan &      | 0                     | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0               | 0     |

|       |                       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | Akuntansi             |   |   |   |   |   |   |   |
| 24    | PIPP                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25    | MPP                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26    | Umum Cleaning Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27    | SIMRS                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28    | DRIVER                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29    | Security              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30    | IRJA                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31    | Rehab Medik           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32    | Kasir Parkir          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33    | Parkir                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

**Analisis :**  
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

### 3.5.1.6.1 Supervisi

| Jenis                | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|----------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Supervisi (2x/bulan) | 0       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |

**Analisaais:**  
 Belum dilakukan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

### 3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

| NO | NAMA STAF                  | UNIT ASAL | UNIT BARU                 |
|----|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1  | Sherly Rosita, S. Kep., Ns | IPCN      | PLT Kabid Penunjang Medik |

**Analisis :** Pada bulan Mei 2026 terdapat 1 staf yang mutasi.

## 3.5.2 IPSRS

### 3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintanance Alat Medis

|                             | Target | Jan    | Feb    | Mar    | Apr | Mei   | Juni | Juli | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Capaian Maintenance Ruangan |        | 58,97% | 82,05% | 64,10% | 72% | 92.3% |      |      |     |     |     |     |     |



| BULAN     | TOTAL ALAT | CAPAIAN | PROSENTASE |
|-----------|------------|---------|------------|
| Januari   | 276        | 119     | 43,12%     |
| Februari  | 276        | 138     | 50%        |
| Maret     | 276        | 124     | 44,93%     |
| April     | 276        | 112     | 41%        |
| Mei       | 276        | 195     | 70.65%     |
| Juni      |            |         |            |
| Juli      |            |         |            |
| Agustus   |            |         |            |
| September |            |         |            |
| Oktober   |            |         |            |
| November  |            |         |            |

| TOTAL ALAT (PERBAIKAN) | TOTAL ALAT |
|------------------------|------------|
| Januari                | 8          |
| Februari               | 16         |
| Maret                  | 13         |
| April                  | 16         |
| Mei                    | 22         |
| Juni                   |            |
| Juli                   |            |
| Agustus                |            |
| September              |            |
| Oktober                |            |
| November               |            |

**Analisa :**  
 Pada bulan ini capaian adalah 92,3% untuk ruangan naik dari bulan sebelumnya dan 70.65% untuk capaian per jumlah alat.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

**3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis**

**3.5.2.2.1 Air Conditioner**

**3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split**

| BULAN  | CAPAIAN | TARGET | PROSENTASE |
|--------|---------|--------|------------|
| JAN-26 | 25      | 64     | 39.06%     |
| FEB-26 | 40      | 64     | 62.50%     |
| MAR-26 | 27      | 64     | 42.19%     |
| APR-26 | 2       | 64     | 3.13%      |
| MEI-26 | 45      | 64     | 70.03%     |

**Analisa :**  
 Dilakukan pemeliharaan AC secara rutin dan berkala sesuai target.  
 Peningkatan jumlah maintenance ac di karenakan mesin cuci ac sudah di belikan yang baru,karena mesin lama bulan kemarin mengalami kerusakan dan part yang mesin cuci lama part tidak ada di toko.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

| NO | BULAN     | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| 1  | Januari   | 4x/bulan                   | 3x/bulan | 60%        | Belum mencapai target |
| 2  | Februari  | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 80%        | Belum mencapai target |
| 3  | Maret     | 4x/bulan                   | 3x/bulan | 60%        | Belum mencapai target |
| 4  | April     | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 80%        | Belum mencapai target |
| 5  | Mei       | 4x/bulan                   | 3x/bulan | 60%        | Belum mencapai target |
| 6  | Juni      | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| 7  | Juli      | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| 8  | Agustus   | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| 9  | September | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| 10 | Oktober   | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| 11 | November  | 4x/bulan                   |          |            |                       |

**Analisis :**  
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi berkala  
Melalui link :  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvgSZrNmPuELgYBKbs0Ud89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143>

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

| Bulan     | Jumlah Target (satu bulan) | Capaian  | Prosentase | Keterangan            |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari   | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari  | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Maret     | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| April     | 4x/bulan                   | 3x/bulan | 75%        | Belum mencapai target |
| Mei       | 4x/bulan                   | 1x/bulan | 25%        | Belum mencapai target |
| Juni      | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| Juli      | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| Agustus   | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| September | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| Oktober   | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| November  | 4x/bulan                   |          |            |                       |
| Desember  | 4x/bulan                   |          |            |                       |

- Analisis :**
1. Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target
  2. Kendala : Adanya Perbaikan listrik dan grounding Klinik Mutiara Sehat PTP
    - 1) Perbaikan grounding Poli mata
    - 2) Perbaikan listrik gudang sipil ( gudang upi )

3) Perbaikan instalasi listrik poli mata dan ruang IT

Rencana Tindak Lanjut :  
Monitoring dan Evaluasi

- 1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
- 2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
- 3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7 SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497>
- 4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
- 5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
- 6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP  
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwTuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

| Mei 2026   |             |                   |            |        |                   |            |        |
|------------|-------------|-------------------|------------|--------|-------------------|------------|--------|
| Tanggal    | Stok Liquid | Sebelum pengisian | Penggunaan | Satuan | Keterangan        | Pengiriman | Satuan |
| 01/05/2026 | 1363        | 3253              | 0          | MMHG   | sesudah pengisian | 1890       | MMHG   |
| 01/05/2026 | 3253        | 3200              | 53         | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 02/05/2026 | 3200        | 2914              | 286        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 03/05/2026 | 2914        | 2631              | 283        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 04/05/2026 | 2631        | 2366              | 265        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 05/05/2026 | 2366        | 2101              | 265        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 06/05/2026 | 2101        | 1829              | 272        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 07/05/2026 | 1829        | 1514              | 315        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 08/05/2026 | 1514        | 1205              | 309        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 08/05/2026 | 1205        | 3288              | 0          | MMHG   | sesudah pengisian | 2083       | MMHG   |
| 09/05/2026 | 3288        | 2954              | 334        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 10/05/2026 | 2954        | 2634              | 320        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 11/05/2026 | 2634        | 2305              | 329        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 12/05/2026 | 2305        | 1954              | 351        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 13/05/2026 | 1954        | 1605              | 349        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 14/05/2026 | 1605        | 1212              | 393        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 15/05/2026 | 1212        | 960               | 252        | MMHG   |                   |            | MMHG   |
| 16/05/2026 | 872         | 3024              | 0          | MMHG   | sesudah pengisian | 2152       | MMHG   |

|                                                 |      |      |             |      |                   |        |      |
|-------------------------------------------------|------|------|-------------|------|-------------------|--------|------|
| 16/05/2026                                      | 3024 | 2783 | 241         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 17/05/2026                                      | 2724 | 2427 | 297         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 18/05/2026                                      | 2427 | 2108 | 319         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 19/05/2026                                      | 2108 | 1793 | 315         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 20/05/2026                                      | 1793 | 1504 | 289         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 21/05/2026                                      | 1504 | 1227 | 277         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 22/05/2026                                      | 1227 | 961  | 266         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 23/05/2026                                      | 961  | 660  | 301         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 23/05/2026                                      | 660  | 3244 | 0           | MMHG | sesudah pengisian | 2584   | MMHG |
| 24/05/2026                                      | 3244 | 3022 | 222         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 25/05/2026                                      | 3022 | 2728 | 294         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 26/05/2026                                      | 2728 | 2397 | 331         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 27/05/2026                                      | 2397 | 2090 | 307         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 28/05/2026                                      | 2090 | 1531 | 559         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 29/05/2026                                      | 1531 | 3303 | 0           | MMHG | sesudah pengisian | 1772   | MMHG |
| 29/05/2026                                      | 3303 | 3149 | 154         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 30/05/2026                                      | 3149 | 2842 | 307         | MMHG |                   |        | MMHG |
| 31/05/2026                                      | 2842 | 2515 | 327         | MMHG |                   |        | MMHG |
| Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini        |      |      | 8295        | MMHG |                   |        | MMHG |
| Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini |      |      |             |      |                   | 8591   | MMHG |
| Rata-rata penggunaan oksigen per hari           |      |      | 571.4444444 | MMHG |                   |        |      |
| Rata- rata pengisian liquid per bulan ini       |      |      |             |      |                   | 3436.4 | MMHG |

**Analisis :**  
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

| BULAN     | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari   | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari  | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Maret     | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| April     | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Mei       | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Juni      | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Juli      | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Agustus   | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| September | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Oktober   | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| November  | 1x/bulan                   |          |            |                       |

**Analisis :**

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

**Rencana Tindak Lanjut :**

Monitoring dan evaluasi melalui link:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd\\_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY\\_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059)

**1.5.2.2.7 Filter Air**

**3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air**

| BULAN     | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari   | 1x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari  | 1x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Maret     | 1x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| April     | 1x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Mei       | 1x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Juni      | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Juli      | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Agustus   | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| September | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| Oktober   | 1x/bulan                   |          |            |                       |
| November  | 1x/bulan                   |          |            |                       |

**Analisis :**

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**

Monitoring dan evaluasi melalui

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcawU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

**1.5.2.2.8 Lift**

**1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift**

| NO | LOKASI                   | KONDISI |
|----|--------------------------|---------|
| 1  | Lift Gedung A Pasien     | Baik    |
| 2  | Lift Gedung A Pengunjung | Baik    |
| 3  | Lift Gedung B            | Baik    |
| 4  | Lift Gedung C Umum       | Baik    |
| 5  | Lift Gedung C Karyawan   | Baik    |
| 6  | Lift Gedung D (Garansi)  | Baik    |

**1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift**

| BULAN    | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari  | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |

|           |          |          |      |                       |
|-----------|----------|----------|------|-----------------------|
| Maret     | 1x/bulan | 1x/bulan | 100% | sudah mencapai target |
| April     | 1x/bulan | 1x/bulan | 100% | sudah mencapai target |
| Mei       | 1x/bulan | 1x/bulan | 100% | sudah mencapai target |
| Juni      |          |          |      |                       |
| Juli      |          |          |      |                       |
| Agustus   |          |          |      |                       |
| September |          |          |      |                       |
| Oktober   |          |          |      |                       |
| November  |          |          |      |                       |
| Desember  |          |          |      |                       |

**Analisis :**  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi melalui link  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK\\_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017)

**1.5.2.2.9    UPS**  
**1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS**

| BULAN    | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari  | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Maret    | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| April    | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Mei      | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Juni     |                            |          |            |                       |
| Juli     |                            |          |            |                       |

|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
| Agustus   |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |
| Oktober   |  |  |  |  |
| November  |  |  |  |  |
| Desember  |  |  |  |  |

**Analisis :**  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi melalui link  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83\\_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOK6Lufn7skng/edit?usp=sharing)

1.5.2.2.10 Air Minum

| NAMA                  | LOKASI            | KONDISI |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Instalasi Air Minum 1 | Lantai 1 Gedung C | Baik    |

| BULAN     | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN  | PROSENTASE | KETERANGAN            |
|-----------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|
| Januari   | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Februari  | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Maret     | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| April     | 1x/bulan                   | 1x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Mei       | 4x/bulan                   | 4x/bulan | 100%       | sudah mencapai target |
| Juni      |                            |          |            |                       |
| Juli      |                            |          |            |                       |
| Agustus   |                            |          |            |                       |
| September |                            |          |            |                       |
| Oktober   |                            |          |            |                       |
| November  |                            |          |            |                       |
| Desember  |                            |          |            |                       |

Analisa :  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan  
RTL :  
monitoring dan evaluasi melalui link  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya\\_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0)

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

| NAMA                          | LOKASI    | KONDISI |
|-------------------------------|-----------|---------|
| Filter Air Bersih Poli Gigi 1 | Lantai 2D | Baik    |
| Filter Air Bersih Poli Gigi 2 | Lantai 2D | Baik    |

| BULAN     | JUMLAH TARGET (SATU BULAN) | CAPAIAN | PROSENTASE            | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Januari   | 4x/bulan                   | 100%    | sudah mencapai target | 4x/bulan   |
| Februari  | 4x/bulan                   | 100%    | sudah mencapai target | 4x/bulan   |
| Maret     | 4x/bulan                   | 100%    | sudah mencapai target | 4x/bulan   |
| April     | 4x/bulan                   | 100%    | sudah mencapai target | 4x/bulan   |
| Mei       | 4x/bulan                   | 100%    | sudah mencapai target | 4x/bulan   |
| Juni      |                            |         |                       |            |
| Juli      |                            |         |                       |            |
| Agustus   |                            |         |                       |            |
| September |                            |         |                       |            |
| Oktober   |                            |         |                       |            |
| November  |                            |         |                       |            |
| Desember  |                            |         |                       |            |

Analisa :  
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan  
RTL :  
monitoring dan evaluasi melalui link  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya\\_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0)

1.5.2.2.12 Rekapitan Kegiatan External

| Bulan     | Jumlah Kegiatan | Waktu yang Dibutuhkan |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| Januari   | 19              | 47 jam 27 menit       |
| Februari  | 12              | 37 jam 7 menit        |
| Maret     | 15              | 33 jam 47 menit       |
| April     | 12              | 24 jam 9 menit        |
| Mei       | 6               | 14 jam 14 menit       |
| Juni      |                 |                       |
| Juli      |                 |                       |
| Agustus   |                 |                       |
| September |                 |                       |
| Oktober   |                 |                       |
| November  |                 |                       |
| Desember  |                 |                       |

| MEI 2026   |       |                               |               |          |         |        |     |       |  |
|------------|-------|-------------------------------|---------------|----------|---------|--------|-----|-------|--|
| DATE       | TIME  | URAIAN PEKERJAAN              | UNIT AREA     | PETUGAS  | SELESAI | HASIL  | JAM | MENIT |  |
| 05/05/2026 | 14:00 | perbaikan kompresor poli gigi | klินิก karlos | M Arifin | 16:00   | normal | 2   |       |  |
|            | 16:15 | pengecekan nilai              | klินิก        | M Arifin | 17:30   | sesuai | 1   | 45    |  |



|                      |       |                                                                 |                                                                                                                                                      |                  |       |         |    |    |    |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|----|----|----|
|                      |       | grounding                                                       | ptp                                                                                                                                                  |                  |       |         |    |    |    |
|                      | 18:22 | perbaikan ac poli gigi                                          | <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | Dian T           | 18:40 | selesai |    | 32 |    |
| 14/05/2026           | 09:00 | Support it penarikan kabel internet,perapihan kabel pendaftaran | <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | M Arifin         | 12:12 | selesai | 3  |    |    |
| 20/05/2026           | 14:00 | pemasnagan pompa proyek mbg dgn team pak yadi                   | <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | Yonatan d        | 17:15 | selesai | 5  | 15 |    |
| 21/05/2026           | 14:00 | perbaikan ac dan perbaikan listrik                              | <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div> | M Arifin, Dian T | 16:30 | selesai | 2  |    |    |
| TOTAL JAM DINAS LUAR |       |                                                                 |                                                                                                                                                      |                  |       |         |    | 13 | 92 |
| PEMBULATAN           |       | EMPAT BELAS JAM 14 MENIT                                        |                                                                                                                                                      |                  |       |         | 14 | 14 |    |

Keterangan :  
 Total 14 jam 14 menit untuk perbantuan eksternal.

Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

### 1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

| NO | JENIS AKTIVITAS                  | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|----------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Angka kejadian kehilangan barang | 0       | 0        | 1     | 1     | 0   |      |      |     |     |     |     |     |

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



**Analisa :**  
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

| NO | JENIS AKTIVITAS                  | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV |
|----|----------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Angka kejadian kehilangan barang | 6       | 1        | 4     | 0     | 4   |      |      |     |     |     |     |

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

| ANGKA KEJADIAN BERPOTENSI KEHILANGAN BARANG |                                                                                                                                              |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tanggal                                     | KETERANGAN                                                                                                                                   | RTL                   |
| 07 – 05 – 2026                              | Telah ditemukan dompet berisi atm ,ktp serta , uang tunai milik pengunjung di are jalan masjid rs prima husada , barang diamankan di pos igd | Sudah diambil pemilik |
| 11 – 05 – 2026                              | Telah ditemukan hp milik pengunjung di kursi roda depan igd , diamankan di pos igd                                                           | Sudah diambil pemilik |
| 10 – 05 – 2026                              | Telah ditemukan tas milik pengunjung di area selasar poli paru                                                                               | Sudah diambil pemilik |
| 19 – 05 – 2026                              | Telah ditemukan dompet milik pengunjung di area pot bunga samator , diamankan di pos igd                                                     | Sudah diambil pemilik |

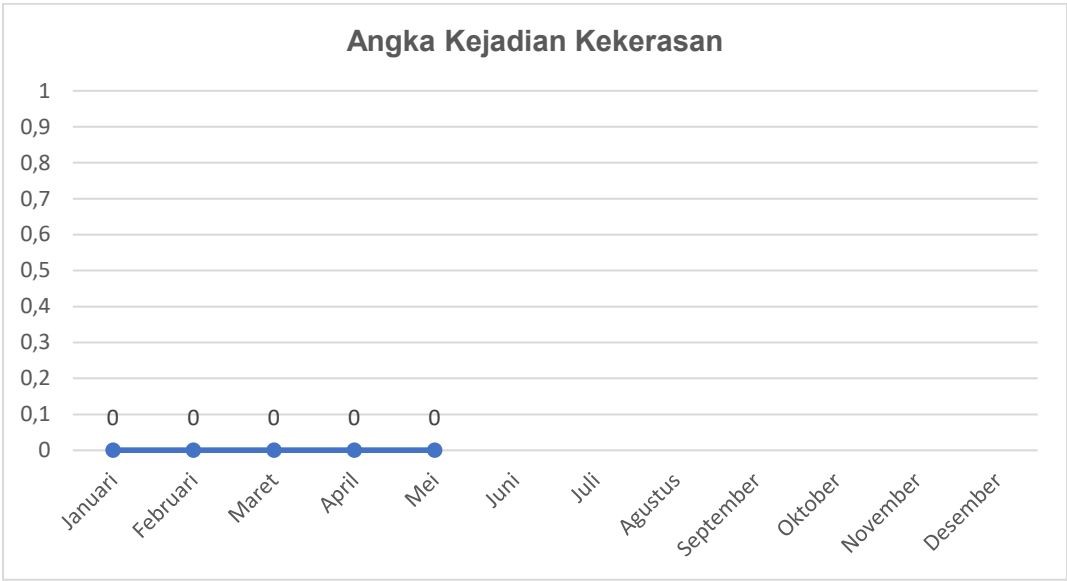
**Analisis :**  
Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :  
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

| NO | JENIS AKTIVITAS          | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV |
|----|--------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1. | Angka kejadian kekerasan | 0       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |     |     |     |     |

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

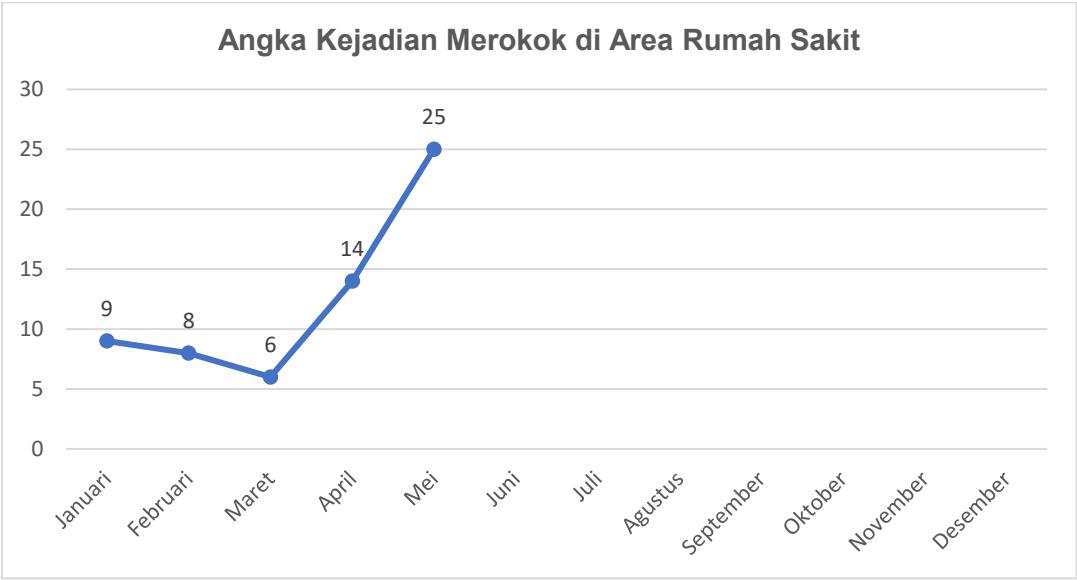


**Analisis :**  
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :  
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

| NO | JENIS AKTIVITAS                            | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|--------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit | 9       | 8        | 6     | 14    | 25  |      |      |     |     |     |     |     |



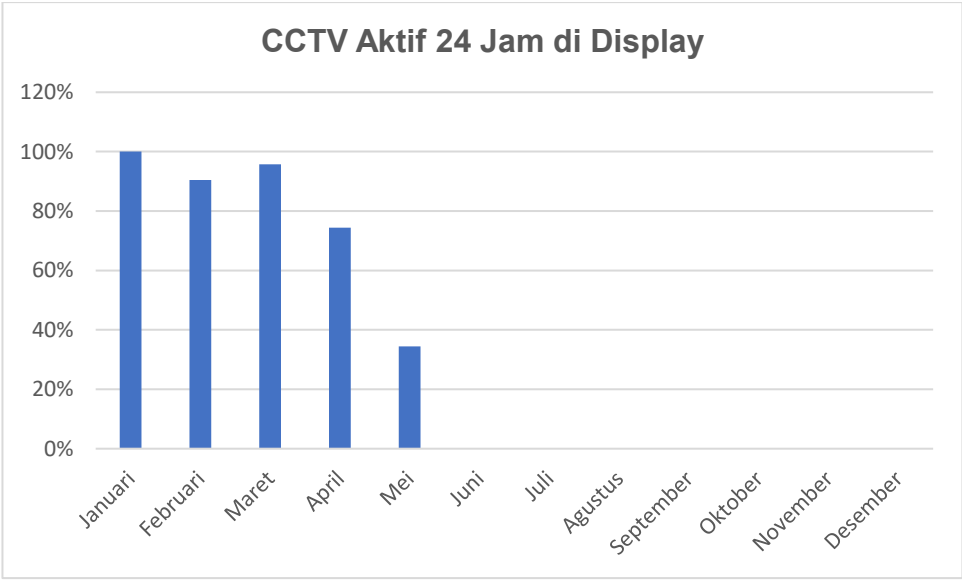
**Analisis :**  
Angka 25 ini ditemukan karena peningkatan keaktifan patrol

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

**3.5.3.6 CCTV Aktif 24 Jam di Display**

**Tabel Angka CCTV Aktif 24 Jam di Display**

| Jenis Aktivitas                   | Jan  | Febr   | Mar    | Apr    | Mei    | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CCTV Aktif 24 Jam di displaySakit | 100% | 90.48% | 95,70% | 74.44% | 34,41% |     |     |     |     |     |     |     |



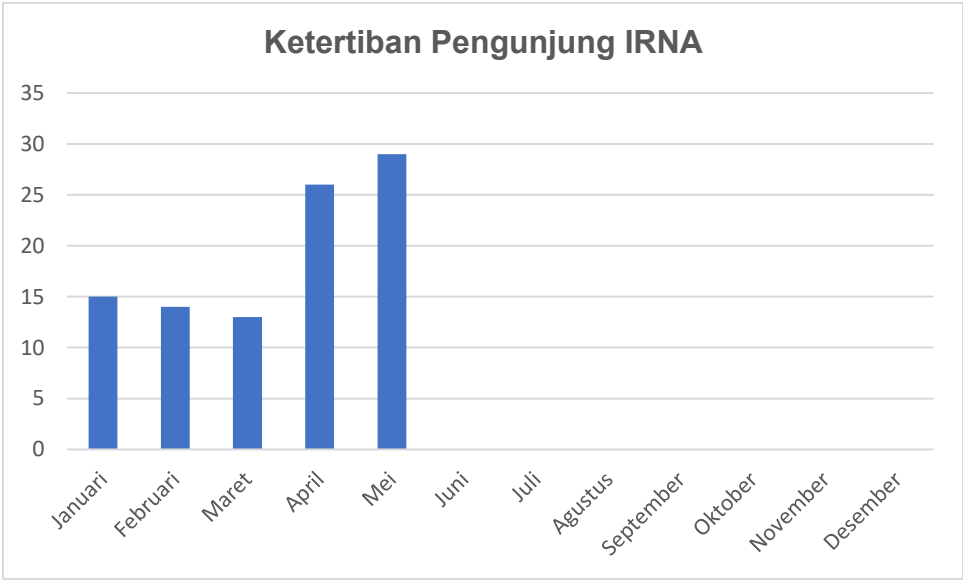
Analisa :  
Bulan ini lebih Rendah ada 1 cctv yaitu cctv depan USG radiologi terpantau off karena. Sudah di TL oleh Tim IT namun membutuhkan waktu lama karena tidak ada stock. Order unit baru.

Rencana Tindak Lanjut :  
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.3.7 Ketertiban Pengunjung IRNA

Tabel Ketertiban Pengunjung IRNA

| Jenis Aktivitas            | Jan | Febr | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ketertiban Pengunjung IRNA | 15  | 14   | 13  | 26  | 29  |     |     |     |     |     |     |     |

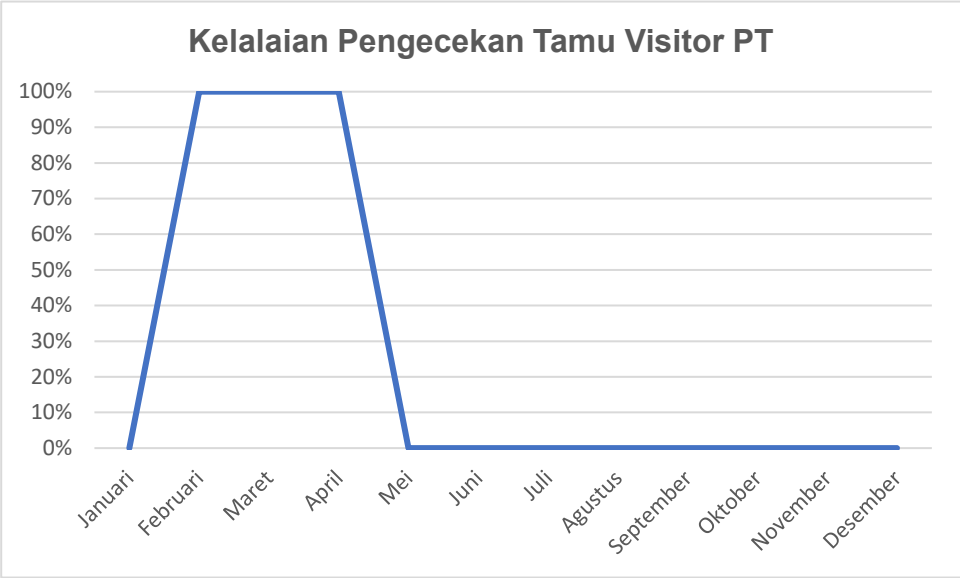


Analisa :  
Sudah di TL oleh Tim security. Analisa tidak adanya one gate system untuk IRNA.

Rencana Tindak Lanjut :  
Monitoring evaluasi.

3.5.3.8 CCTV Kelalaian Pengecekan Tamu Visitor PT

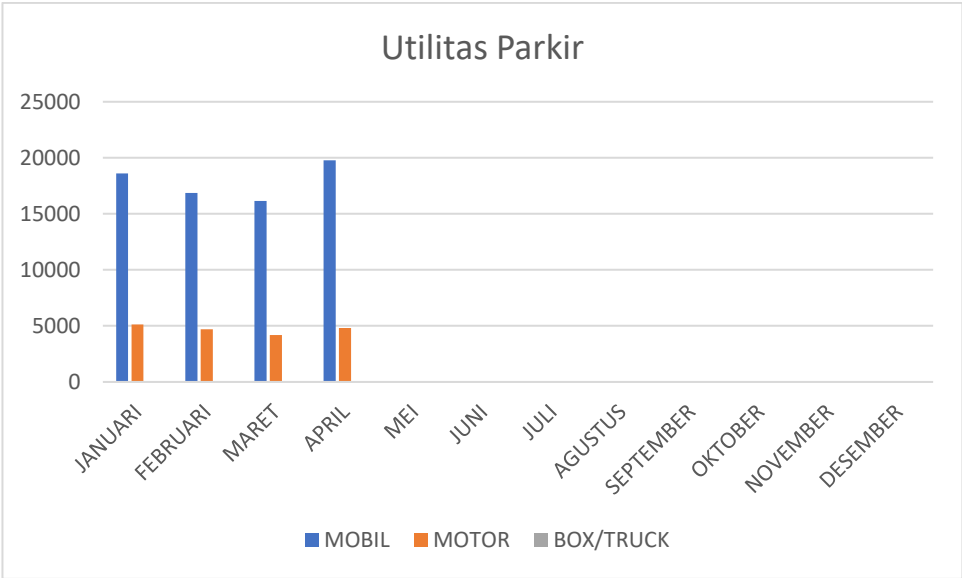
| Jenis Aktivitas                      | Jan | Febr | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kelalaian pengecekan tamu visitor PT | 0   | 1    | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     |     |



**Analisa :** Minim kesalahan dalam petugas security di IGD.

**Rencana Tindak Lanjut :** Monitoring evaluasi.

**3.5.4 Parkir**



**Analisis :**  
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan evaluasi

**3.5.5 Humas Marketing**

**3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)**

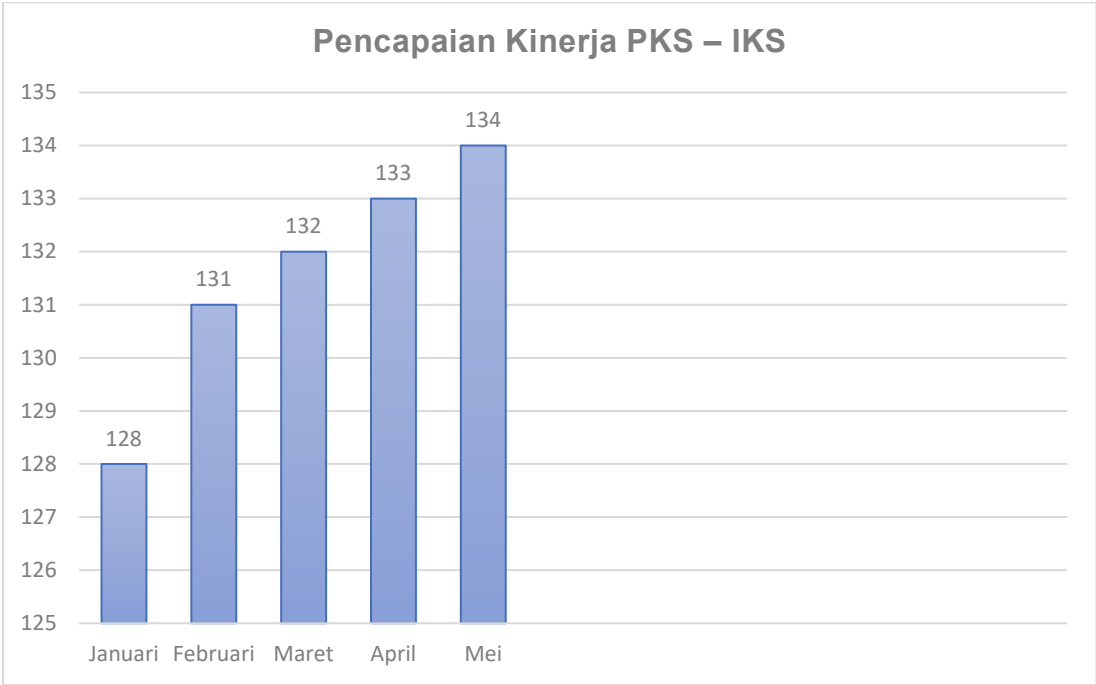
**3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2026**

| No | Bulan   | Target     | Jumlah  |    |      |             |                   |              |
|----|---------|------------|---------|----|------|-------------|-------------------|--------------|
|    |         |            | Berlaku | ED | Baru | Kurang Baru | Progres           | Total Kurang |
| 1  | Januari | 1 IKS baru | 128     | 1  | 1    | 0           | 1 (Proses review) | 1            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |     |   |   |   |                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----|---|---|---|------------------------------------------|---|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Februari | 1 IKS baru | 131 | 2 | 1 | 2 | 1 (Proses Perpanjangan 2)                | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maret    | 1 IKS baru | 132 | 1 | 1 | 2 | 2 (Proses perpanjangan)                  | 2 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | April    | 1 IKS baru | 133 | 2 | 1 | 0 | 2 (Proses Perpanjangan)                  | 1 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mei      | 1 IKS baru | 134 | 1 | 1 | 0 | 2 (Proses Perpanjangan, 1 Proses Review) | 3 |
| <p>Analisis ;</p> <p>1. Pada bulan Mei 2026, Perpanjangan MOU dengan Klinik Wijaya Husada masih dalam Tahap Review Pihak ke-2, Perpanjangan MOU dengan Harris Hotel dalam Tahap Review Pihak RS, MOU Baru dengan PT Indiratex Spindo dan MOU Baru dengan Asuransi Astra Life selesai.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut :</p> <p>1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua</p> |          |            |     |   |   |   |                                          |   |

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru 2025

| No | Nama PKS                                   | Progres Pengurusan | Kendala                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1  | PT Global Excel                            | Review             | Perbedaan template draft PKS |
| 2  | PT Malang Intermedia Pers                  | Review             | Proses Review                |
| 3  | Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng          | TTD Pihak ke-2     | Selesai                      |
| 4  | PT Mane Indonesia                          | Review             | Proses Pihak Kedua           |
| 5  | TPA Halodoc                                | Review             | Proses Tanda Tangan          |
| 6  | Klinik Waras Wiris                         | Review             | Selesai                      |
| 7  | SLB tingkat Nasional Bagian C              | Review             | Selesai                      |
| 8  | PMI Kota Malang                            | Review             | Selesai                      |
| 9  | PMI Kabupaten Malang                       | TTD Pihak ke-2     | Menunggu TTD                 |
| 10 | SK dan PKS Tim Penerjemah untuk Akreditasi | Review             | Selesai                      |
| 11 | MOU Kementerian Agama Kabupaten Malang     | Review             | Selesai                      |
| 12 | MOU Klinik Muslimat Singosari              | Review             | Proses Pihak Kedua           |
| 13 | MOU klinik BLK Singosari                   | Review             | Proses Pihak Kedua           |
| 14 | RSUD Lawang                                | TTD Pihak ke-2     | Menunggu TTD                 |
| 15 | Asuransi Astra Life                        | Review             | Selesai                      |
| 16 | Panti Nirmala                              | TTD Pihak ke-2     | Menunggu TTD                 |
| 17 | Panglima Sudirman                          | Review             | Proses Review                |
| 18 | Klinik Muslimat Singosari                  | TTD Pihak ke-2     | Selesai                      |
| 19 | Klinik Wijaya Husada                       | Review             | Proses Review                |
| 20 | PT CV Kurnia Edi Peni (KEP)                | Selesai            | Selesai                      |
| 21 | PT Indiratex Spindo                        | Review             | Proses Review                |
| 22 | Hotel Harris                               | Review             | Review Hasil MOU lalu        |



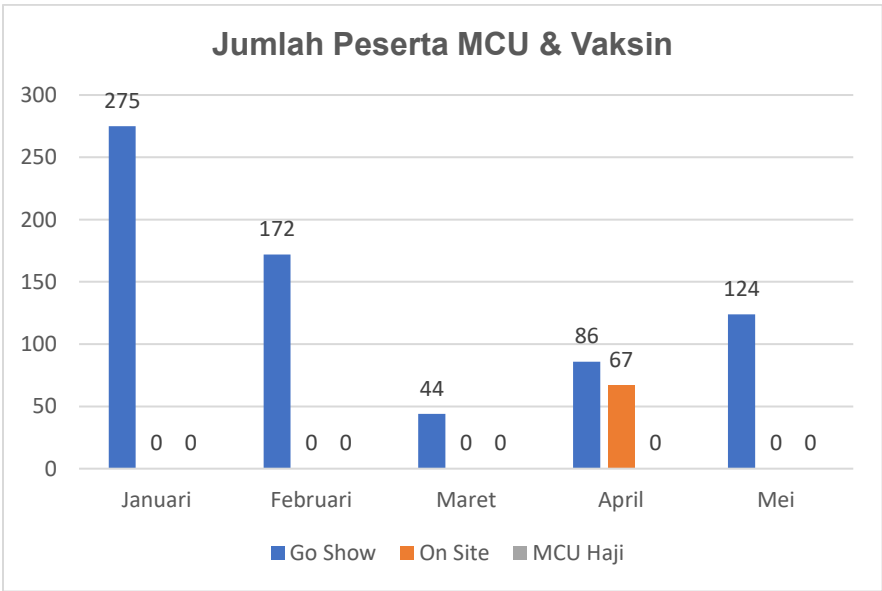
**3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)**

**1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2026**

| No | Bulan    | Target | Jumlah Pasien GOSHOW | ON SITE |
|----|----------|--------|----------------------|---------|
| 1  | Januari  | 150    | 275                  | -       |
| 2  | Februari | 150    | 172                  | -       |
| 3  | Maret    | 150    | 44                   | -       |
| 4  | April    | 150    | 86                   | 67      |
| 5  | Mei      | 150    | 124                  | -       |

Analisis ;  
Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Mei mengalami penurunan kunjungan sebesar 29 pasien atau sekitar 18.95% dari periode sebelumnya.

- Rencana Tindak Lanjut :
- 1. Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media
  - 2. Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU





1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

| NO | BULAN    | INSTANSI                         | HASIL                                                                                                     |
|----|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Januari  | PT Sinergi Pangan                | Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit                                                       |
|    |          | Travel Kbih Al Muchsinin         | Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM                                                       |
|    |          | Travel King Salman               | Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM                                                        |
| 2  | Februari | PT Pangan Lestari Malang         | Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit                                                       |
|    |          | PT Riset Perkebunan Nusantara    | Sudah terlaksana MCU dengan 1 Orang di Rumah Sakit                                                        |
| 3  | Maret    | PT Multi Daya Mitra              | Tidak berhasil karena Harga Tinggi                                                                        |
|    |          | PT Bangun Sarana Wreksa          | Belum terlaksana karena perubahan Pimpinan dan Penawaran masih diajukan kembali                           |
| 4  | April    | PT Bangun Sarana Wreksa          | Pimpinan belum ingin melaksanakan MCU                                                                     |
|    |          | PT indonesian Tobacco Tbk        | Sudah Terlaksana dengan 2 Peserta di Rumah Sakit                                                          |
|    |          | PT Arthawena                     | Pelaksanaan MCU ikut dengan kegiatan Skrining Klinik Mutiara Sehat                                        |
|    |          | PT Green Mountains Natural Foods | Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 67 Peserta di Perusahaan                                               |
|    |          | Penelitian FK UMM                | Sudah Terlaksana dengan 11 Peserta di Rumah Sakit                                                         |
| 5  | Mei      | Bank BSI                         | Belum terlaksana karena adanya prosedur penjaminan dengan asuransi MIH dan masih tahap koordinasi kembali |

### 3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

| Target                | No | Tanggal    | Instansi                       | Kegiatan Yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Yang Diperoleh                                                                                                                                                         | Tindak Lanjut                        |
|-----------------------|----|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 Kunjungan per bulan | 1  | 12/01/2026 | PT TENTREM                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |
|                       | 2  | 12/01/2026 | PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                             | Follow up ulang akhir bulan          |

|  |   |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                      |
|--|---|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 3 | 12/01/2026 | PT ARTHAWENA SAKTI GEMILANG | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |
|  | 4 | 12/01/2026 | PT BANGUN SARANA WREKSA     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu</li> </ol>  | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |

|  |   |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                             |
|--|---|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  | 5 | 12/01/2026 | CV AUMIRETA<br>ANGGUN    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon | Follow up ulang akhir bulan |
|  | 6 | 12/01/2026 | PT CIPTA<br>SANDHI DARMA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon | Follow up ulang akhir bulan |

|  |   |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|--|---|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 7 | 12/01/2026 | PT INTAN PRAMADITA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu</li> <li>3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |
|  | 8 | 12/01/2026 | PT INDOMARINE      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu</li> <li>3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi</li> </ol>             | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |

|  |    |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                      |
|--|----|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 9  | 12/01/2026 | PT LAWANGMAS<br>PRIMAPACK<br>INDONESIA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                            | Follow up ulang akhir bulan          |
|  | 10 | 12/01/2026 | PT MALINDO<br>INTITAMA RAYA            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |

|  |    |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
|--|----|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 11 | 12/01/2026 | PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU,</li> <li>3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |
|  | 12 | 15/01/2026 | PT OTSUKA                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                                                                                            | Follow up ulang akhir bulan          |

|  |    |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                             |
|--|----|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 13 | 15/01/2026 | PT RAGAM RAYA RASA  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Mendapatkan Respon positif terkait penawaran | Follow up ulang akhir bulan |
|  | 14 | 15/01/2026 | PT KHARISMA SELARAS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Mendapatkan Respon positif terkait penawaran | Follow up ulang akhir bulan |



|  |    |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                             |
|--|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 15 | 15/01/2026 | PT ADI PUTRO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Mendapatkan Respon positif terkait penawaran | Follow up ulang akhir bulan |
|  | 16 | 15/01/2026 | PT USTEGRA   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Mendapatkan Respon positif terkait penawaran | Follow up ulang akhir bulan |

|  |    |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                      |
|--|----|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 17 | 15/01/2026 | PT INDOSTAR<br>BUILDING<br>MATERIAL | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                             | Follow up ulang akhir bulan          |
|  | 18 | 15/01/2026 | PT SUMBER<br>ALFARIA                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |

|  |    |            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                      |
|--|----|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | 19 | 15/01/2026 | PT WIM (KTG)             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up kembali untuk Kegiatan MCU |
|  | 20 | 20/01/2026 | PT SINAR TAMAN PLASTINDO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                             | Follow up ulang akhir bulan          |

|  |    |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|--|----|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 21 | 20/01/2026 | PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | Belum ada respon                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Follow up ulang akhir bulan                     |
|  | 22 | 31/01/2026 | Kegiatan Senam Yoga Lansia   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga</li> <li>2. Jumlah peserta 56 orang</li> <li>3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan</li> </ol>                                                                                                                        | Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya |
|  | 23 | 03/02/2026 | PT Pangan Lestari            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU,</li> <li>3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru</li> <li>4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up untuk Agreement Letter                |

|  |    |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|--|----|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 | 06/02/2026 | PT Multi Daya Mitra     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU,</li> <li>3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru</li> <li>4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up ulang                                                                                                                          |
|  | 25 | 09/02/2026 | PT Bangun Sarana Wreksa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone</li> <li>2. Harga yang dapat di negosiasikan,</li> <li>3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite</li> <li>4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif,</li> <li>2. PIC tertarik dalam program MCU,</li> <li>3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru</li> <li>4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan</li> </ol> | Follow up ulang akhir bulan                                                                                                              |
|  | 26 | 11/02/2026 | Puskesmas Lawang        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya.</li> <li>2. Diskusi kendala pelayanan pasien.</li> <li>3. Informasi program Vaksinasi dan MCU</li> </ol>                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas menyampaikan koordinasi dengan tim pelayanan sudah baik dan bagus karena selalu direspon dengan cepat</li> <li>2. Puskesmas menyampaikan bahwa adanya beberapa</li> </ol>                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik</li> <li>2. Melakukan koordinasi</li> </ol> |

|  |    |            |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |
|--|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |            |               |                                                                                                                                                | <p>pasien yang sudah tidak aktif BPJSnya, walaupun pemberitahuan Program BPJS baru dinformasikan tetapi dari bulan januari sudah ada peserta BPJS yang dinonaktifkan dan harus melakukan konfirmasi ke pihak desa menerima informasi layanan terbaru.</p> <p>Kritik dan Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas menyampaikan untuk Itir pasien yang mendapatkan obat yang bisa didapatkan di Faskes apakah bisa jika di PRBkan saja</li> <li>2. Puskesmas menyampaikan mohon dibantu untuk menginformasikan kepada pasien terkait SRB diberikan ke Puskesmas dan pasien tidak perlu membawa SRB ketika menuju ke RS</li> </ol> | <p>dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala</p>                                                 |
|  | 27 | 11/02/2026 | Klinik Garuda | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya.</li> <li>2. Diskusi kendala pelayanan pasien.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS sudah baik dan selalu direspon dengan cepat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik</li> </ol> |

|  |  |  |  |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>3. Informasi program Vaksinasi dan MCU</p> | <p>2. Klinik menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal di klinik dari yang biasanya buka sampai dengan jam 20.00, berubah hanya sampai jam 15.00, sehingga beberapa peserta klinik ada yang berganti ke faskes lain.</p> <p>Kritik dan Saran :</p> <p>1. Klinik menyampaikan bahwa ada satu pasien yang diminta untuk kembali ke klinik dengan memberikan surat pemeriksaan dari IGD dan meminta untuk dibuatkan rujukan, apakah bisa dibantu untuk pemeriksaan dari IGD diberikan surat keterangan bila memang hasil pemeriksaan di IGD menyatakan Perlu untuk dibuatkan rujukan maka pasien diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan agar klinik bisa mengkonfirmasi dengan data tersebut</p> | <p>2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|  |    |            |                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 28 | 11/02/2026 | Puskesmas Singosari | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya.</li> <li>2. Diskusi kendala pelayanan pasien.</li> <li>3. Informasi program Vaksinasi dan MCU</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS cukup baik dan selalu direspon dengan cepat</li> </ol> <p>Kritik dan Saran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puskesmas menyampaikan untuk PRB pasien dari RS PHM masih sedikit sedangkan rapot puskesmas di BPJS merah di RS PHM</li> <li>2. Puskesmas menyampaikan ada satu pasien dengan 2 rujukan yang aktif dan 1 rujukan tersebut obatnya di PRB kan, tetapi dari RS memberikan Obat untuk 2 rujukan sehingga ketika Puskesmas memberikan klaim ke Kimia Farma, mereka meminta untuk obat tersebut dikembalikan karena pihak kimia farma tidak bisa mengklaim obat PRB yang diberikan oleh RS</li> <li>3. Pihak Puskesmas meminta tolong untuk ketika ada pasien yang membutuhkan dua rujukan apakah bisa jika</li> </ol> |  |
|--|----|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>diselangi untuk jadwal kontrolnya sehingga habisnya berbeda</p> <p>4. Puskesmas menyampaikan untuk diagnosa dokter dicky masih dibuat berbeda dengan kondisi asli pasien, seperti cholelithiasis dibuat ulcerative</p> <p>5. Pihak Puskesmas meminta saran untuk Print Out resume pulang pasien karena data tersebut digunakan jika ada audit dari BPJS</p> <p>6. Adapun penolakan dari IGD untuk rujukan jantung dari Puskesmas Singosari di bulan Desember rujukan jantung dengan hasil EKG SVT, dari RS Prima husada menginformasikan bahwa tindakan PCI belum ada dan pasien hanya bisa ditindak rawat inap saja sedangkan ketika puskesmas konfirmasi ke marsudi rujukan langsung diterima dengan tindakan kejut jantung sesuai dengan</p> |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |    |            |                                   |                                                                                                         |                                                           |                                                    |
|--|----|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |    |            |                                   |                                                                                                         | SOAP yg diberikan oleh tim puskesmas                      |                                                    |
|  | 29 | 16/02/2026 | PMI Kabupaten Malang              | Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kabupaten Malang                                          | Sudah diterima oleh PIC PMI Kabupaten Malang              | Follow up MOU                                      |
|  | 30 | 16/02/2026 | PMI Kota Malang                   | Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kota Malang                                               | Sudah diterima oleh PIC PMI Kota Malang                   | Follow up MOU                                      |
|  | 31 | 24/02/2026 | SLB Tingkat Nasional Bagian C     | Menyampaikan dokumen MOU dengan SLB Tingkat Nasional Bagian C untuk kebutuhan Penerjemah Bahasa Isyarat | Sudah diterima oleh PIC SLB Tingkat Nasional Bagian C     | Follow up MOU                                      |
|  | 32 | 24/02/2026 | PMI Kota Malang                   | Pengambilan MOU yang sudah selesai                                                                      | Sudah diterima oleh Humas                                 | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 33 | 24/02/2026 | Kementrian Agama Kabupaten Malang | Menyampaikan dokumen MOU dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang untuk kebutuhan Bimbingan kerohanian  | Sudah diterima oleh PIC Kementrian Agama Kabupaten Malang | Follow up MOU                                      |
|  | 34 | 27/02/2026 | Kementrian Agama Kabupaten Malang | Pengambilan MOU yang sudah selesai                                                                      | Sudah diterima oleh Humas                                 | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 35 | 27/02/2026 | SLB Tingkat Nasional Bagian C     | Pengambilan MOU yang sudah selesai                                                                      | Sudah diterima oleh Humas                                 | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 36 | 10/03/2026 | Klinik Waras Wiris                | Mengantarkan MOU yang sudah selesai                                                                     | Sudah diterima oleh Ibu Kholifa                           | Bina komunikasi untuk menjalin                     |

|  |    |            |                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|--|----|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |            |                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | kerjasama yang baik                                                                                       |
|  | 37 | 10/03/2026 | Fitness Plus Singosari        | 1. Mengantarkan MOU yang sudah selesai<br>2. Koordinasi terkait Cross selling yang akan terjadi antara Fitness Plus Singosari dengan RS PHM | 1. Sudah diterima oleh Mba Nanda<br>2. Koordinasi dilakukan terkait kerjasam Flyer Membership Fitness Plus<br>3. Voucher MCU RSPHM<br>4. Penempatan desain Banner untuk diletakkan di Fitness Plus | Menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Bidang dan Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 38 | 14/03/2026 | Klinik Losari Medika          | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama wahyu                                                                                                                                                | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                        |
|  | 39 | 14/03/2026 | Bidan Indi (KRI Putra Husada) | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama diandra                                                                                                                                              | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                        |
|  | 40 | 14/03/2026 | Klinik BLK                    | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh PIC Ibu Ria                                                                                                                                                                    | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                        |
|  | 41 | 14/03/2026 | Klinik Mitra Prima Care       | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh PIC Dokter tari                                                                                                                                                                | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                        |
|  | 42 | 14/03/2026 | Puskesmas Lawang              | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni                                                                                                                                                                   | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                        |
|  | 43 | 16/03/2026 | CV Aumireta Anggun            | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                      | Sudah diterima oleh Team Security                                                                                                                                                                  | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang                                                             |

|  |    |            |                                  |                                        |                                          |                                                    |
|--|----|------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |    |            |                                  |                                        |                                          | baik                                               |
|  | 44 | 16/03/2026 | PT Kemas Super Indonesia         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Security Pak Suryono | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 45 | 16/03/2026 | PT Malindo Intitama Raya         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Security Pak Gunawan | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 46 | 16/03/2026 | PT Molindo Raya Industri         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Security Pak Yudi    | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 47 | 16/03/2026 | PT Bangun Sarana Wreksa          | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Bapak Nanda          | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 48 | 16/03/2026 | PT Pesta Pora Abadi              | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 49 | 16/03/2026 | PT Kencana Tiara Gemilang        | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Security Andik       | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 50 | 16/03/2026 | PT Lawangmas Primapack Indonesia | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Bapak Dian       | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 51 | 16/03/2026 | Puskesmas Ardumuljo              | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Mailing Ibu Vale | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |

|  |    |            |                         |                                        |                                                |                                                    |
|--|----|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 52 | 16/03/2026 | Klinik Garuda           | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Ibu Dinda              | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 53 | 16/03/2026 | Klinik Brawijaya Lawang | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC TU Pak Rizza           | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 54 | 16/03/2026 | DPM Lidya Putri         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh ibu resi                   | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 55 | 16/03/2026 | DPM Suhariningsih       | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Rosia      | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 56 | 16/03/2026 | DPM Farida Rusniah      | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Bapak Setiani          | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 57 | 16/03/2026 | KRI Muslimat Singosari  | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Ibu devi putri         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 58 | 16/03/2026 | Klinik Wijaya Husada    | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Ibu Yeni               | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 59 | 16/03/2026 | DPM Wulandarti Wien     | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Anak atas nama Ibu Nastiti | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 60 | 17/03/2026 | PT Jasa Raharja         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC bapak Hari             | Bina komunikasi untuk menjalin                     |

|  |    |            |                               |                                        |                                          |                                                    |
|--|----|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |    |            |                               |                                        |                                          | kerjasama yang baik                                |
|  | 61 | 17/03/2026 | Klinik Kartini Medika         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Security Rendy       | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 62 | 17/03/2026 | Klinik Nayaka 02              | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Dokter Virda         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 63 | 17/03/2026 | DPM Arry Budiarti             | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Suami                | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 64 | 18/03/2026 | DPM Ida Bagus D.              | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh dr Ida Bagus         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 65 | 18/03/2026 | PKM Singosari                 | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Dokter syamsu        | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 66 | 18/03/2026 | DPM Yosephine Pratiwi         | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Novi | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 67 | 18/03/2026 | PT Kharisma Selaras           | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Ibu Lina             | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 68 | 18/03/2026 | PT Indostar Building Material | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026 | Sudah diterima oleh Ibu Riri             | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |

|  |    |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--|----|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | 69 | 18/03/2026 | Relawan Siaga Utara (RESITA) | Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026                                                                                                                                                                                                              | Sudah diterima oleh Istri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 70 | 07/04/2026 | Nestle Bear Brand            | Mengantarkan kiriman Susu Kloter pertama untuk RS Prima Husada Malang Tahun 2026                                                                                                                                                                    | Sudah diterima dan sudah diinformasikan untuk bukti penerimaan kepada pihak Bear Brand                                                                                                                                                                                                                                                             | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 71 | 15/04/2026 | Fitness Plus Singosari       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengantarkan Banner dan Voucher diskon untuk membership dan Karyawan dari Fitness Plus</li> <li>2. Koordinasi terkait dengan promo membership Fitness Plus kepada Staff RS Prima Husada Malang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah disampaikan terkait dengan mekanisme penggunaan voucher dan diterima dengan baik oleh pihak Fitness Plus Singosari</li> <li>2. Permintaan Promo untuk karyawan RS Prima Husada Malang sudah di proses, jika ada peserta yang akan daftar membership maka akan dibantu daftar dari Humas</li> </ol> | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 72 | 22/04/2026 | Klinik Muslimat Singosari    | Mengirimkan Perpanjangan MOU dengan Klinik                                                                                                                                                                                                          | Sudah diterima oleh ibu Devi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 73 | 27/04/2026 | Relawan Ambulance (Resita)   | Menyerahkan MOU dan Susu Bear Brand serta monitoring apakah ada kesulitan ketika mengantarkan pasien ke RS Prima Husada                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Susu Bear Brand sudah diterima, MOU sudah diterima langsung dengan Pak Jali</li> <li>2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik</li> </ol>                                                                                                         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 74 | 27/04/2026 | Indonesian Tobacco Tbk.      | Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Perusahaan                                                                                                                                                                                             | Sudah diterima oleh bapak Bryllian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bina komunikasi untuk menjalin                     |

|  |    |            |                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|--|----|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |            |                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kerjasama yang baik                                                                                                               |
|  | 75 | 27/04/2026 | Shanaya Resort                   | Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Shanaya Resort                                                                                                                  | Sudah diterima oleh mba Stefani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                                                |
|  | 76 | 27/04/2026 | PT Green Mountains Natural Foods | 1. Menyerahkan Tabung Sampling untuk pemeriksaan FL dan penyampaian terkait alur dan tata cara sampling<br>2. Cek Lokasi untuk bis MCU                                       | 1. Sudah diterima oleh Ibu Harnanik.<br>2. Sudah dilakukan pengecekan terakit dengan Lokasi Bis MCU dan semua aman                                                                                                                                                                                                                                                            | Bina komunikasi untuk Koordinasi pelaksanaan MCU                                                                                  |
|  | 77 | 28/04/2026 | CV Karunia Edi Peni              | Menyerahkan MOU serta monitoring apakah ada kesulitan ketika Koordinasi dengan RS Prima Husada                                                                               | 1. MOU sudah diterima oleh tim Humas RS<br>2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik                                                                                                                                                                                                                                   | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik                                                                                |
|  | 78 | 07/05/2026 | Mandiri InHealth                 | 1. Koordinasi layanan MCU untuk penjaminan karyawan BSI Malang<br>2. Koordinasi terkait pergantian E-PKS Mandiri InHealth dan New Branding Mandiri InHealth menjadi InHealth | 1. Sudah disampaikan bahwa kebutuhan RS adalah pembuatan portal MCU untuk karyawan BSI<br>2. Pihak Mandiri InHealth menjelaskan bahwa permintaan MCU terlalu mendadak dan akses untuk portal MCU harus dengan approval terlebih dahulu menggunakan BA MCU dan BA itu tidak melekat dengan MOU,<br>3. permintaan reimburse sendiri harus berasal dari Perusahaan atau Bank BSI | 1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik<br>2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala |



|  |    |             |                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|--|----|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |    |             |                                 |                                                                                                                       | <p>kemudian akan disampaikan ke HO, karena peraturan untuk industri besar harus terorganisir dengan cabang" yg lain, jika portal dibuka dan karyawan datang hanya sedikit dan tidak ada kepastian jumlah karyawan setiap tahunnya, maka pihak Mandiri juga tidak mau membuka portal GCU/MCU</p> <p>4. E-PKS sudah harus diisi dengan template sesuai portal PROVEN</p> |                                                    |
|  | 79 | 12 Mei 2026 | Pocari Sweat                    | Penyampaian dan pemberian Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat. | Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 1 box Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang                                                                                                                                                                                                                                        | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 80 | 21 Mei 2026 | PT Djojonegoro C-1000           | Penyampaian dan pemberian You-C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat.                    | Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 270 pcs You-C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang                                                                                                                                                                                                                                                         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 81 | 25 Mei 2026 | PT Lucky Mom Indonesia (Makuku) | Penyampaian produk Makuku, dan keinginan untuk masuk kedalam program PKRS yaitu Senam Hamil                           | Sudah disampaikan bahwa untuk proses masuk ke RS bisa dengan bersurat terlebih dahulu agar dapat didisposisikan kepada pimpinan                                                                                                                                                                                                                                        | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |
|  | 82 | 29 Mei 2026 | Jasa Raharja Malang             | Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PT Jasa Raharja Malang                                                      | Sudah diterima oleh PIC PT Jasa Raharja Malang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik |

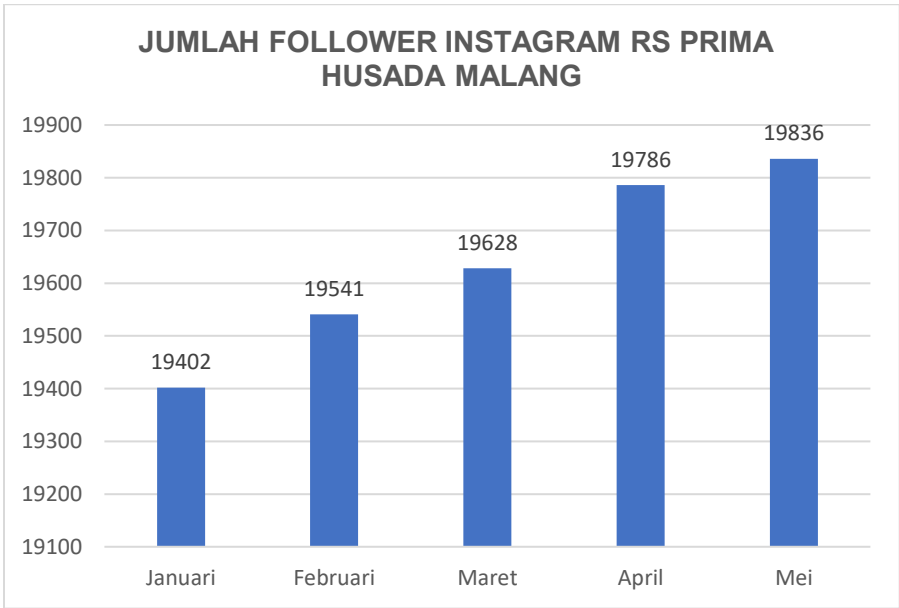
**Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026**

| <b>Target</b>  | <b>No</b> | <b>Tanggal</b> | <b>Instansi</b>                  | <b>Kegiatan Yang Dilakukan</b>                                       | <b>Hasil Yang Diperoleh</b>                                                     | <b>Tindak Lanjut</b>              |
|----------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MCU dan Vaksin | <b>1</b>  | 09/01/2026     | PT Sinergi Pangan Gemilang       | Program MCU Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang         | Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang | Hasil Pemeriksaan telah diberikan |
| MCU dan Vaksin | <b>2</b>  | 14/01/2026     | KBIH Al Muchsinin                | Program Vaksin 24 jamaah Travel                                      | Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026             | Sudah selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>3</b>  | 26/01/2026     | KBIH Alfattah Singosari          | Program Vaksin 9 jamaah Travel                                       | Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026              | Sudah selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>4</b>  | 26/01/2026     | Travel King Salman               | Program Vaksin 5 jamaah Travel                                       | Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang       | Sudah selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>5</b>  | 04/02/2026     | PT Riset Perkebunan Nusantara    | Program MCU Karyawan Baru di RS dengan PT Riset Perkebunan Nusantara | Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 1 Orang  | Sudah selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>6</b>  | 19/02/2026     | PT Pangan Lestari Malang         | Program MCU Karyawan di RS dengan PT Pangan Lestari Malang           | Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang | Sudah selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>7</b>  | 29/04/2026     | PT Green Mountains Natural Foods | Program MCU Karyawan di RS dengan PT Green Mountains Natural Foods   | Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 67 Orang | Sudah Selesai                     |
| MCU dan Vaksin | <b>8</b>  | 04/05/2025     | Shanaya Resort                   | Program MCU Karyawan baru di RS dengan Shanaya Resort                | Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 2 Orang  | Sudah Selesai                     |

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

| JUMLAH KONTEN BARU                   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI   | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| FEED FOTO                            | 12      | 5        | 16    | 13    | 12    |      |      |         |           |         |          |          |
| REELS                                | 4       | 6        | 6     | 8     | 4     |      |      |         |           |         |          |          |
| STORY                                | 13      | 31       | 28    | 22    | 57    |      |      |         |           |         |          |          |
| TOTAL                                | 29      | 41       | 50    | 43    | 73    |      |      |         |           |         |          | 0        |
|                                      |         |          |       |       |       |      |      |         |           |         |          |          |
| JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA) | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI   | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| FEED FOTO                            | 13      | 5        | 16    | 14    | 12    |      |      |         |           |         |          |          |
| FEED VIDEO                           | 4       | 6        | 6     | 8     | 4     |      |      |         |           |         |          |          |
| REELS                                | 4       | 6        | 6     | 8     | 4     |      |      |         |           |         |          |          |
| STORY                                | 89      | 85       | 53    | 82    | 58    |      |      |         |           |         |          |          |
| TOTAL                                | 110     | 102      | 81    | 112   | 78    |      |      |         |           |         |          |          |
|                                      |         |          |       |       |       |      |      |         |           |         |          |          |
| JENIS                                | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI   | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)  | 19402   | 19541    | 19628 | 19786 | 19836 |      |      |         |           |         |          |          |
|                                      |         |          |       |       |       |      |      |         |           |         |          |          |
| JENIS                                | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI   | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER          | 311     | 242300   | 177   | 285   | 240   |      |      |         |           |         |          |          |
| TARGET                               | 300     | 300      | 300   | 300   | 300   | 300  | 300  | 300     | 300       | 300     | 300      | 300      |



Analisa :

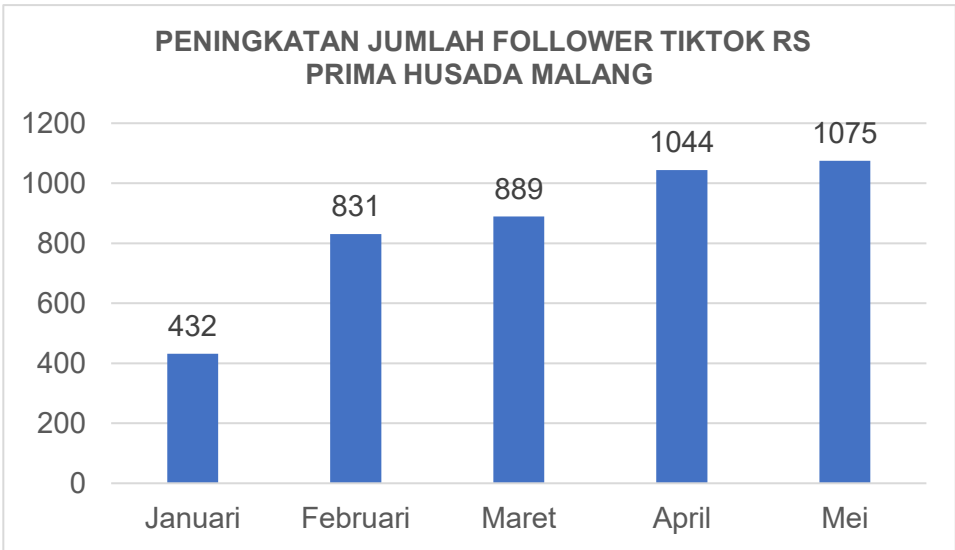
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 50 Followers atau sebesar 0.25% dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

| JENIS                                        | JANUA<br>RI | FEBRU<br>ARI | MARE<br>T | APRIL | MEI  | JUNI | JULI | AGUST<br>US | SEPTEMB<br>ER | OKTOB<br>ER | NOVEMBE<br>R | DESEMB<br>ER |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------|------|------|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| JUMLAH<br>KONTEN<br>BARU                     | 2           | 9            | 5         | 5     | 3    |      |      |             |               |             |              |              |
| TARGET                                       | 12          | 12           | 12        | 12    | 12   | 12   | 12   | 12          | 12            | 12          | 12           | 12           |
|                                              |             |              |           |       |      |      |      |             |               |             |              |              |
| JENIS                                        | JANUA<br>RI | FEBRU<br>ARI | MARE<br>T | APRIL | MEI  | JUNI | JULI | AGUST<br>US | SEPTEMB<br>ER | OKTOB<br>ER | NOVEMBE<br>R | DESEMB<br>ER |
| JUMLAH<br>FOLLOWER<br>(CUT OFF<br>TANGGAL 1) | 432         | 831          | 889       | 1044  | 1075 |      |      |             |               |             |              |              |
|                                              |             |              |           |       |      |      |      |             |               |             |              |              |
| JENIS                                        | JANUA<br>RI | FEBRU<br>ARI | MARE<br>T | APRIL | MEI  | JUNI | JULI | AGUST<br>US | SEPTEMB<br>ER | OKTOB<br>ER | NOVEMBE<br>R | DESEMB<br>ER |
| JUMLAH<br>PENINGKATA<br>N<br>FOLLOWER        | 23          | 399          | 58        | 155   | 31   |      |      |             |               |             |              |              |
| TARGET                                       | 100         | 100          | 100       | 100   | 100  | 100  | 100  | 100         | 100           | 100         | 100          | 100          |
|                                              |             |              |           |       |      |      |      |             |               |             |              |              |
| JENIS                                        | JANUA<br>RI | FEBRU<br>ARI | MARE<br>T | APRIL | MEI  | JUNI | JULI | AGUST<br>US | SEPTEMB<br>ER | OKTOB<br>ER | NOVEMBE<br>R | DESEMB<br>ER |
| JUMLAH LIKE                                  | 1876        | 3374         | 3753      | 4477  | 4676 |      |      |             |               |             |              |              |



Analisa :

Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 31 Followers atau sebesar 2,97% dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :

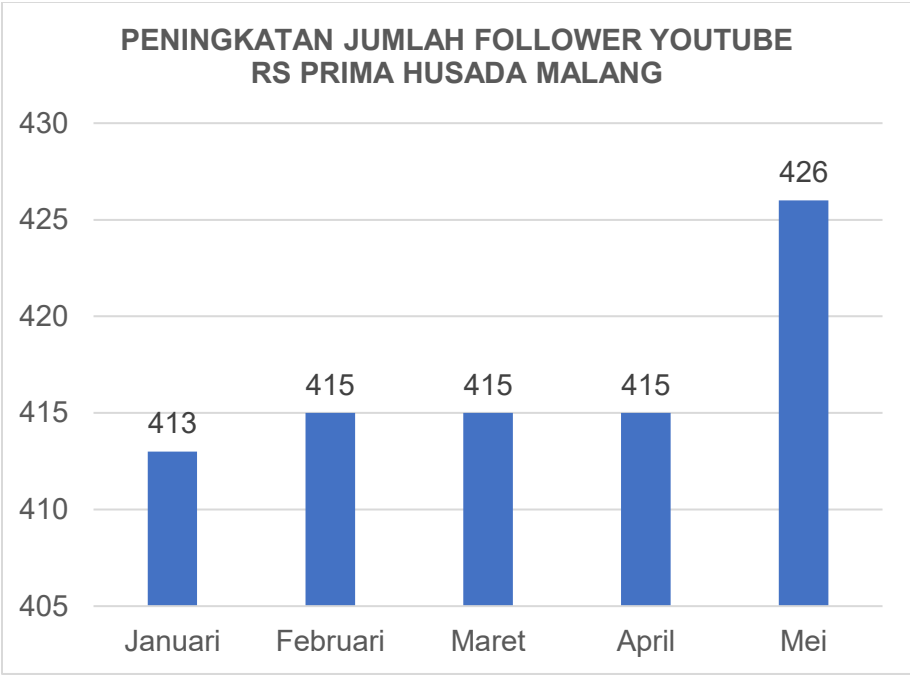
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

| JENIS                 | JANUA<br>RI | FEBRU<br>ARI | MARE<br>T | APRI<br>L | ME<br>I | JUN<br>I | JU<br>LI | AGUST<br>US | SEPTEMB<br>ER | OKTOB<br>ER | NOVEMBE<br>R | DESEMB<br>ER |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| JUMLAH<br>KONTEN BARU | 0           | 0            | 0         | 0         | 0       |          |          |             |               |             |              |              |

|        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| JENIS                   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MAY | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
|-------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| JUMLAH SUBS             | 413     | 415      | 415   | 415   | 426 |      |      |         |           |         |          |          |
|                         |         |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
| JENIS                   | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MAY | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| JUMLAH PENINGKATAN SUBS | 5       | 2        | 0     | 0     | 11  |      |      |         |           |         |          | 0        |
| TARGET                  | 20      | 20       | 20    | 20    | 20  | 20   | 20   | 20      | 20        | 20      | 20       | 20       |

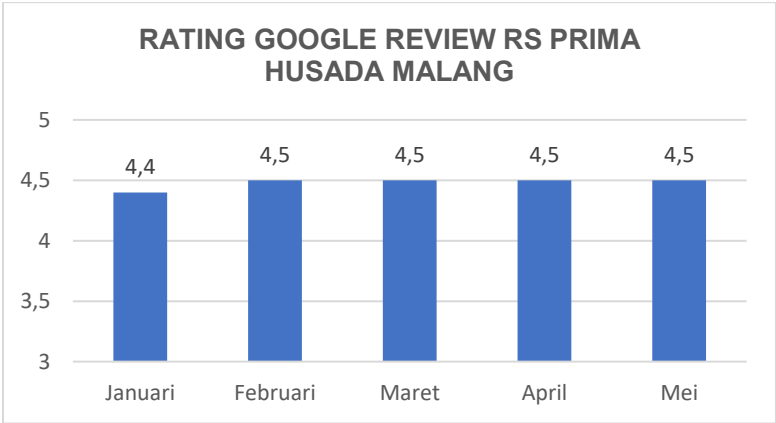


**Analisa :**  
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 11 Followers atau sebesar 2,65% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
  2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
  3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

**Google Review**

| PROGRESS      | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| JUMLAH RATING | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |     |     |     |     |     |     |     |



| BULAN    | RATE CAPAIAN GOOGLE REVIEW |         |
|----------|----------------------------|---------|
|          | POSITIF                    | NEGATIF |
| Januari  | 122                        | 4       |
| Februari | 133                        | 3       |
| Maret    | 114                        | 5       |
| April    | 149                        | 9       |
| Mei      | 111                        | 5       |

Analisa :

1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya
2. Pengisian Google Review mengalami penurunan 42 review atau sekitar 26,58% dibanding bulan sebelumnya.
3. Pengisian Google Review dengan Rate Positif mengalami penurunan 38 review atau sekitar 25,50% dibanding bulan sebelumnya.
4. Pengisian Google Review dengan Rate Negatif mengalami penurunan 4 Review atau sekitar 44.44% dibanding bulan sebelumnya.

Rencana Tindal Lanjut :

1. Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

### 3.5.5 Penjaminan

#### 3.5.5.1 Piutang

##### 3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

| PERIODE MEI 2026 : |                    |             |             |           |             |             |             |         |               |               |             |            |            |             |               |             |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 1                  | Anerasi            | 363.338.311 | 130.828.800 | 1343.612  | 231.153.899 | 236.704.239 | 24.893.233  | 438.555 | 211.456.446   | 442.616.345   | 273.546.793 | 2.869.997  | 50.177.355 | 20.982.617  | 95.839.593    | 442.616.345 |
| 2                  | Pemasukan          | 554.143.894 | 357.266.751 | 2.301     | 196.874.242 | 213.441.574 | -           | -       | 213.441.574   | 410.315.815   | 321.473.911 | 921.892    | 3.422.844  | 5.273.534   | 79.219.391    | 410.315.815 |
| 3                  | Masudiri Inisialis | 32.321.288  | 19.585.125  | 1.871.439 | 10.858.663  | 27.830.372  | -           | -       | 27.830.372    | 38.689.635    | 38.499.439  | -          | -          | -           | -             | 38.689.635  |
| 4                  | Jasa Rikarja       | 142.318.072 | 21.190.785  | -         | 353.363     | 122.086.650 | 101.014.713 | -       | 101.014.713   | 223.101.363   | 223.101.363 | -          | -          | -           | -             | 223.101.363 |
| 5                  | BPJS Kesehatan     | *****       | 350.315.750 | 743.483   | 353.543.276 | 310.464.010 | -           | -       | 310.464.010   | 664.907.286   | 644.997.214 | -          | -          | -           | -             | 664.907.286 |
| Total Saldo        |                    |             |             |           |             |             |             |         | 1.778.730.444 | 1.520.816.578 | 2.591.868   | 53.605.339 | 26.258.151 | 175.058.968 | 1.778.730.444 |             |

Keterangan : Cut off 31 Mei 2026 sebesar Rp 1.778.730.444

#### 3.5.5.2 Klaim Pending

| NO          | MASALAH                                                                                                                                                            | DAMPAK        | TINDAK LANJUT               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| RAWAT JALAN |                                                                                                                                                                    |               |                             |
| 1.          | diagnosa non stroke rehab 6 bulan                                                                                                                                  | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 2           | indikasi kontrol ulang, pasien kunjungan sebelumnya sudah mendapatkan obat kronis                                                                                  | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 3           | pasien ada dx katarak masih kontrol terus, indikasi kontrol terus tanpa diopersai? Jika indikasi hanya karena memang visus blm memenuhi tdk perlu kontrol tiap bln | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 4           | konfirmasi dilakukan approval                                                                                                                                      | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 5           | konsul internal 1 tagihan dengan poli utama                                                                                                                        | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 6           | indikasi rujukan transit / rujukan numpang lewat untuk ke FKRTL lebih tinggi / self referral                                                                       | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 7           | kunjungan multipoli                                                                                                                                                | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |

|                   |                                                                                                                                                              |               |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 8                 | Kunjungan Kontrol Poli Jiwa DU Menggunakan Z09.3                                                                                                             | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 9                 | Potensi fragmentasi rajal                                                                                                                                    | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| <b>RAWAT INAP</b> |                                                                                                                                                              |               |                             |
| 1                 | Readmisi                                                                                                                                                     | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 2                 | Tindakan Pemasangan Ett Merupakan Bagian Dari Tindakan CPR / RJP dan dikode dengan 99.60, 9604 tidak perlu dikoding, tidak terbukti rawat gabung dengan SP.N | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 3                 | Prosedur hecing seharusnya menggunakan kode 86.59 BUKAN 83.65                                                                                                | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 4                 | N13.2 disertai infeksi N30, menggunakan kode gabung N13.6                                                                                                    | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 5                 | Pasien riwayat MRS dgn CVA, reseleksi kode I63 menjadi I69                                                                                                   | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 6                 | Tatalaksana RDS ridak sesuai ketentuan, hapus                                                                                                                | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 7                 | Hasil BGA yang dilampirkan belum memenuhi kriteria gagal nafas, kode J96 dihapus                                                                             | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 8                 | Pending tidak sesuai kaidah pengkodean : pasien mual muntah reseleksi DU R11                                                                                 | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 9                 | pasien dgn Liniair fractura ujung distal Os Radius dextra sisi medial, kode prosedur 79.42 tidak sesuai, gunakan 79.02                                       | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |
| 10                | Kode eksisi abses tidak sesuai, reseleksi kode                                                                                                               | Klaim Pending | Menjawab Konfirmasi Pending |

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

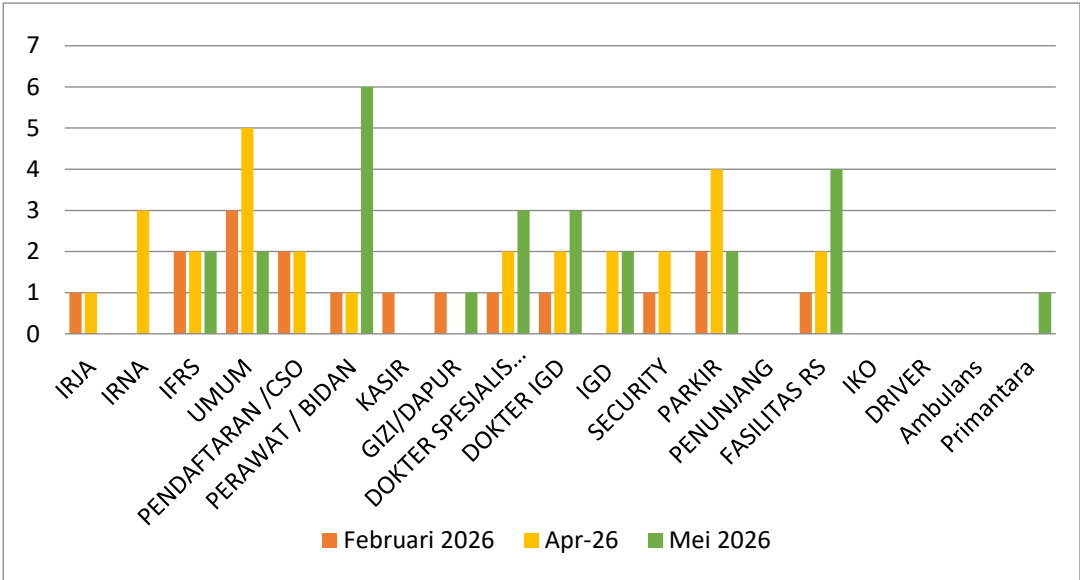
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2026

| NO | Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 |
|----|--------------------------------------|------------|------------|----------|
| 1. | IRJA                                 | 1          | 1          | 0        |
| 2. | IRNA                                 | 0          | 3          | 0        |
| 3. | IFRS                                 | 2          | 2          | 2        |
| 4. | UMUM                                 | 3          | 5          | 2        |
| 5. | PENDAFTARAN /CSO                     | 2          | 2          | 0        |
| 6. | PERAWAT / BIDAN                      | 1          | 1          | 6        |
| 7. | KASIR                                | 1          | 0          | 0        |
| 8. | GIZI/DAPUR                           | 1          | 0          | 1        |
| 9. | DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)      | 1          | 2          | 3        |

|       |              |    |    |    |
|-------|--------------|----|----|----|
| 10.   | DOKTER IGD   | 1  | 2  | 3  |
| 11.   | IGD          | 0  | 2  | 2  |
| 12.   | SECURITY     | 1  | 2  | 0  |
| 13.   | PARKIR       | 2  | 4  | 2  |
| 14.   | PENUNJANG    | 0  | 0  | 0  |
| 15.   | FASILITAS RS | 1  | 2  | 4  |
| 16.   | IKO          | 0  | 0  | 0  |
| 17.   | DRIVER       | 0  | 0  | 0  |
| 18.   | Ambulans     | 0  | 0  | 0  |
| 19.   | Primantara   | 0  | 0  | 1  |
| Total |              | 17 | 28 | 26 |

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Mei 2026



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Mei 2026 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- Jumlah complain Pada bulan Mei 2026 mengalami dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan maret 2026 sebanyak 17 pasien pada bulan April sebanyak 28 pasien Sedangkan pada bulan Mei sebanyak 26 pasien.
- Komplain terbanyak pada bulan Mei 2026 yaitu dari bagian perawat sebayak 6 kasus, failitas sebanyak 4 kasus, Dokter IGD sebanyak 3 kasus, DPJP sebanyak 3 kasus, Parkir, UMUM dan IFRS sebanyak masing-masing 2 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- Pada bulan Mei 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :
  - Parkir
 

Terdapat 2 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap
  - Fasilitas
 

Terdapat 4 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar perawatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait



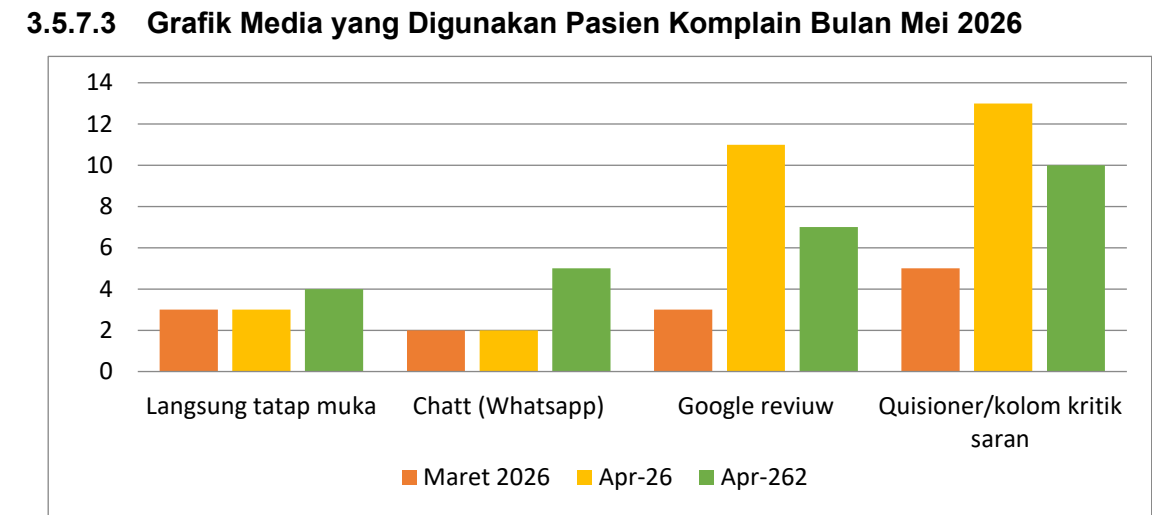
3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Mei 2026

| NO | JENIS PASIEN COMPLAIN        | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
|----|------------------------------|------------|------------|----------|
| 1. | Langsung tatap muka          | 3          | 3          | 4        |
| 2. | Tidak Langsung :             |            |            |          |
|    | a. Chatt (Whatsapp)          | 2          | 2          | 5        |
|    | b. Google reviuw             | 3          | 11         | 7        |
| 3. | Quisioner/kolom kritik saran | 5          | 13         | 10       |

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

|  | KESSAN BPJS | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |             | 2         | 0         | 4         | 245       | 703       |



Analisis :

Pada bulan Mei 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner sebanyak 10 kasus complain. Dari google reviuw swbanyak 7 kasus complain, dari chat/ telpon sebanyak 5 kasus, Sedangkan terbanyak dari tatap muka sebanyak 4 kasus complain.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Mei 2026

| No | Jenis pasien complain           | Waktu tanggap     |                                                                                        | Waktu penyelesaian |            | < 3 hr<br>Manajerial RS | 7 hr<br>ke PT |
|----|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|
|    |                                 | Standard<br>< 5 ' | Pencapaian (dari<br>waktu total dibagi<br>jml komplain atau<br>rata2 waktu<br>tanggap) | Standard <<br>60 ' | pencapaian |                         |               |
| 1. | Langsung tatap<br>muka          | 100%              | 100%                                                                                   | 100%               | 100%       | 0                       | 0             |
|    |                                 |                   |                                                                                        |                    |            |                         |               |
| 2. | Chatt<br>(WA/Tele/SMS/IG)       | 100%              | 100%                                                                                   | 100%               | 100%       | 0                       | 0             |
|    |                                 |                   |                                                                                        |                    |            |                         |               |
| 3. | Google review                   | 100%              | 100%                                                                                   | 100%               | 100%       | 0                       | 0             |
|    |                                 |                   |                                                                                        |                    |            |                         |               |
| 4. | Quisioner/kolom<br>kritik saran | 100%              | 100%                                                                                   | 100%               | 60%        | 40%                     | 0             |
|    |                                 |                   |                                                                                        |                    | 7          | 6                       |               |
| 5. | KESSAN                          | 100%              | 100%                                                                                   | 100%               | 100%       | 0                       | 0             |
|    |                                 |                   |                                                                                        |                    |            |                         |               |

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Mei 2026 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Pada bulan April 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya

- Parkir  
Terdapat 2 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap
- Fasilitas  
Terdapat 4 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar perawatan.

Rencana Tindak Lanjut :

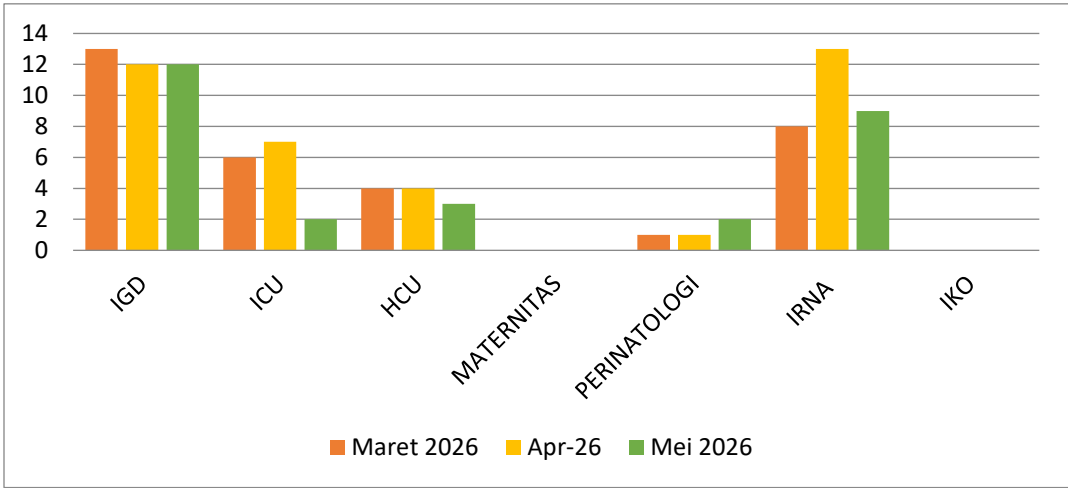
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Mei2026

| No    | Unit Perujuk | Maret<br>2026 | April<br>2026 | Mei<br>2026 |
|-------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.    | IGD          | 13            | 12            | 12          |
| 2.    | ICU          | 6             | 7             | 2           |
| 3.    | HCU          | 4             | 4             | 3           |
| 4.    | MATERNITAS   | 0             | 0             | 0           |
| 5.    | NEONATOLOGI  | 1             | 1             | 2           |
| 6     | IRNA         | 8             | 13            | 9           |
| 7     | IKO          | 0             | 0             | 0           |
| Total |              | 44            | 32            | 37          |

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Mei 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Mei 2026

| NO | NO RM  | Nama Pasien            | UNIT | DIAGNOSIS                                                                                   | DPJP                                   | RS TUJUAN   | ALASAN RUJUK                                              | PLAYON HABIS                                                  |
|----|--------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | 248640 | Warsidi                | 6A   | STEMI ANTEROSEPTAL, SYOK KARDIOGENIK, HF DT HHD DD CAD, RIWAYAT RUN VT                      | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | RSU UMM     | PRO PRIMARY PCI                                           | Tidak                                                         |
| 2  | 248634 | Alfian                 | HCU  | Cva Infark, LV trombus ,Nstemi,HF,Hemiparese S,Hiperurisemia                                | Dr Fahimma, Sp. N                      | RSSA        | PRO STROKE UNIT                                           | Plavon : 5.555.200<br>Tarif rs ; 6.478.339<br>Minus : 923.139 |
| 3  | 170481 | Ahmad Suwarno          | 4A   | fr thoracal 10 + spinal cord injury                                                         | Dr Arianto, Sp.Ot                      | RS SOETOMO  | PRO MRI Decompresi + Multitrauma                          | Tidak                                                         |
| 4  | 248723 | Sriati                 | IGD  | syock condition susp hipovolemik dd hemorrhagic                                             | Dr Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. Pd         | RSSA        | Perawatan lebih lanjut                                    | Tidak                                                         |
| 5  | 248718 | By Ny. Miratus Suaibah | NEO  | RDS ok HMD DD neonatal pneumonia                                                            | Dr Fiona Paramitha Sp.A                | RSSA        | pro subspesialis neonatologi                              | Tidak                                                         |
| 6  | 248855 | Khoirul Hidayah        | ICU  | CVA EMBOLI                                                                                  | Dr Fahimma, Sp. N                      | RSSA        | PRO SUBSPESIALI NEUROVASKULAR                             | Tidak                                                         |
| 7  | 248090 | Ainul Muttaqin         | 4A   | CKD ST 4+ ANEMIA+ HIPERKALEMIA                                                              | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | RSUD LAWANG | PRO HD                                                    | Tidak                                                         |
| 8  | 244036 | Dhorifah               | ICU  | TOTAL AV BLOCK, UAP                                                                         | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | RSSA        | PRO TPM/PPM                                               | Tidak                                                         |
| 9  | 249251 | Mariati                | IGD  | STEMI INFEROLATERAL POSTERIOR DAN RV INFARCT                                                | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | RSI Aisyah  | Rujuk pro PCI                                             | Tidak                                                         |
| 10 | 246614 | Ngateman               | IGD  | STEMI anteriorseptal                                                                        | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | RSU UMM     | Rujuk pro PCI                                             | Tidak                                                         |
| 11 |        | Aisyah Humaira         | 3C   | Syok Hipovolemik+ GEA + Dehidrasi berat                                                     | Dr Dicky Faturrachman,Spa,M, Biomed    | RSSA        | Rujuk pro subspesialis intensif anak + PICU               | Tidak                                                         |
| 12 | 90914  | Djamal                 | 7A   | ESRD                                                                                        | Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd                 | RSUD LAWANG | PRO HD                                                    | Tidak                                                         |
| 13 | 249256 | By Ny Hindun           | NEO  | congenital pneumonia ,bronchopulmonary dysplasia, achondroplasia , feeding difficulty, susp | Dr Ratih Kusumawardhani, Sp. A         | RSSA        | prosubspesialis anak kardiologi/neonatologi/endokrinologi | Tidak                                                         |

|    |        |                      |     |                                            |                                        |                 |                                          |       |
|----|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------|
|    |        |                      |     | PJB dd PPHN                                |                                        |                 |                                          |       |
| 14 | 248786 | Puji Astutik         | 7A  | ANEMIA GRAVIS                              | Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd            | RSSA            | PRO PERAWATAN KGEH                       | Tidak |
| 15 | 198094 | M Nadeo              | 3C  | ileus obstfuktif                           | Dr Dicky Faturrachman,Spa,M, Biomed    | RSSA            | Bedah anak                               | Tidak |
| 16 | 66355  | Ardi                 | IGD | STEMI anterior                             | Dr Ira Setya Waty Sp Jp                | RSSA            | Rujuk Fast Track pro PCI                 | Tidak |
| 17 | 247677 | Sulkin               | IGD | CKD                                        | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | RSUD LAWANG     | PRO HD                                   | Tidak |
| 18 | 249723 | Mudakir              | HCU | CVA ICH, ICH                               | Dr Fahimma, Sp. N                      | RSUD BANGIL     | PRO STROKE UNIT                          | Tidak |
| 19 | 197483 | Sukatno              | 2A  | nstemi dm tipe2 hiperglikemia dislipidemia | Dr Ira Setya Waty Sp Jp                | RS UMM          | PRO PCI                                  | Tidak |
| 20 | 246314 | Umi Saroh            | 6A  | CVA INFARK, SLIGHT HEMIPARESE (S)          | Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N             | RSUD BANGIL     | PRO STROKE UNIT                          | Tidak |
| 21 | 249744 | Nur Fadilah          | HCU | CVA ICAH Thalamus kiri                     | Dr Dewi Maharani Sp. S                 | RS Lavallate    | Pro Perawatan Subspesialis neurovascular | Tidak |
| 22 | 249709 | Astuti Wahyu Ningrum | IGD | abses mandibula D                          | Dr.Sigit,Sp.BS                         | RSSA            | PRO evaluasi retrofaring dan parafaring  | Tidak |
| 23 | 241691 | Hj. Luluk Cholikatin | IGD | Obs Joundice                               | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | RSSA            | PRO Sp.PD-KHOM/ Sp.PD-KGEH               | Tidak |
| 24 | 249907 | Mistani              | IGD | COR 356                                    | Dr.Fachry,Sp.BS                        | RSSA            | PRO Sp. BS                               | Tidak |
| 25 | 234652 | Siami                | IGD | CA Rectum, Hematoschezia                   | Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd            | RSSA            | Pro Sp KGEH                              | Tidak |
| 26 | 237427 | Yeni Puji Atmani     | IGD | CKD st V                                   | Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd            | RS Karsa Husada | Pro HD                                   | Tidak |
| 27 | 239880 | Fa'imah              | IGD | CKD                                        | Dr Yoga Waranugraha Sp Jp              | RSUD Bangil     | Pro HD                                   | Tidak |
| 28 | 237427 | Badratul Aini        | IGD | CVA ICH, ICH                               | Dr Akhmad Syahrir Sp N                 | RS Karsa Husada | PRO BEDAH SYARAF                         | Tidak |

**Analisis :**

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Mei 2026.
 Pada bulan Maret 2026 turun menjadi 32 pasien. Pada bulan April sebanyak 37 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 28 pasien.
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
  - Pro PCI
  - Pro CVCU
  - Pro stroke unit
  - Pro HD
  - MRI
  - Pro bedah saraf lanjutan
  - Membutuhkan alat khusus
  - Membutuhkan pengobatan ARV
- Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
 Pada bulan bulan April 2026 Tidak ada plavon habis yang dilakukan rujuk Sedangkan pada bulan Mei 2026 sebesar Rp. 923.139

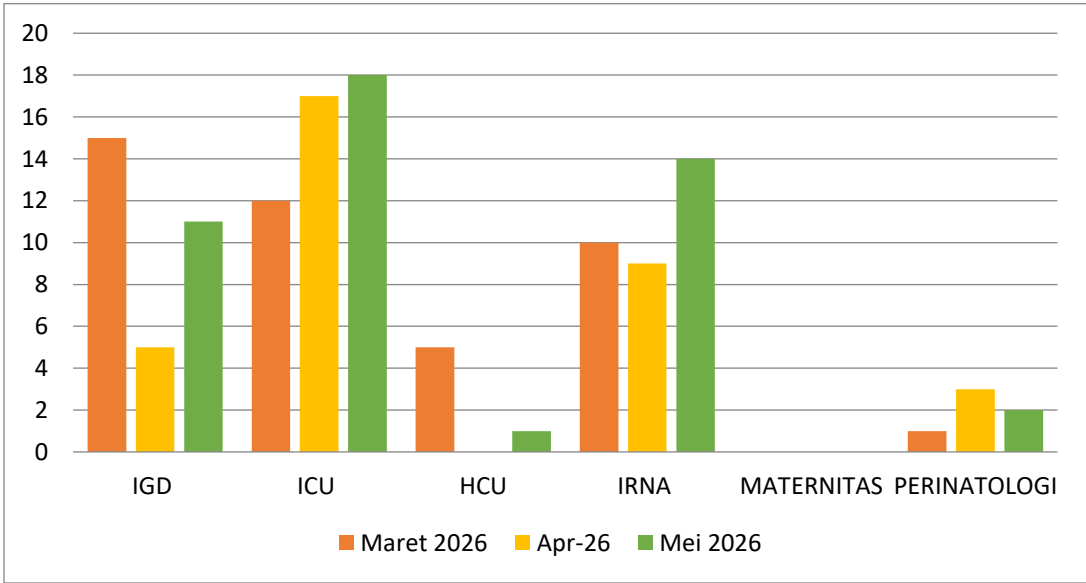
**Rencana Tindak Lanjut:**

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Mei 2026

| No    | Unit Asal Pasien Meninggal | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 |
|-------|----------------------------|------------|------------|----------|
| 1.    | IGD                        | 5          | 11         | 13       |
| 2.    | ICU                        | 17         | 18         | 15       |
| 3     | HCU                        | 0          | 1          | 3        |
| 4.    | IRNA                       | 9          | 14         | 11       |
| 5.    | MATERNITAS                 | 0          | 0          | 0        |
| 6     | NEONATOLOGI                | 3          | 2          | 0        |
| Total |                            | 43         | 34         | 46       |

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Mei 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal Mei 2026

| No | NO RM  | Nama Pasien    | Lama Rawat | Status         | Unit | Penyebab Kematian | Diagnosis                                                                            | DPJP                                   | EWS |
|----|--------|----------------|------------|----------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 1  | 210169 | GATOT SUSANTO  | 1          | umum           | IGD  | cardiac arrest    | DOA                                                                                  | Dr Endra                               | √   |
| 2  | 123819 | RUMAJI         | 1          | BPJS KESEHATAN | IGD  | cardiac arrest    | CHEST PAIN                                                                           | Dr Isrotul                             | √   |
| 3  | 195420 | HOTIMAH        | 2          | BPJS KESEHATAN | 7A   | cardiac arrest    | FATTT LIVER, NEFROLITHIASIS, HT, PNEUMOTHORAX                                        | Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes         | √   |
| 4  | 240408 | VIVI ANDRIANI  | 7          | BPJS Kesehatan | ICU  | cardiac arrest    | Gagal nafas dengan ventilator + TB on therapy +Sop cerebri,Hiv,Toxoplasmosis cerebri | Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N             | √   |
| 5  | 216246 | Jumroti        | 2          | BPJS Kesehatan | ICU  | cardiac arrest    | DM Hipergilekemia + ards + trombositopenia + syock hipovolemic                       | Dr. Andy Sp. P                         | √   |
| 6  | 218929 | YULEKHAH       | 3          | BPJS Kesehatan | IGD  | cardiac arrest    | DM HIPERGLIKEMIA, ARDS                                                               | Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes         | √   |
| 7  | 123910 | DINIYATI       | 4          | BPJS Kesehatan | ICU  | cardiac arrest    | Syock condition dd syoch hipovolemic                                                 | Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes         | √   |
| 8  | 177513 | SUKARTI        | 5          | BPJS Kesehatan | ICU  | cardiac arrest    | Ileus Obstruksi                                                                      | Dr Rossy Zaki, Sp.B                    | √   |
| 9  | 117049 | SOELALA        | 6          | BPJS Kesehatan | 5C   | cardiac arrest    | ARDS + COMA HIPOGLIKEMIA                                                             | Dr Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. Pd         | √   |
| 10 | 248954 | SITI JUWARIYAH | 1          | BPJS Kesehatan | ICU  | cardiac arrest    | Pneumonia, Nstemi                                                                    | Dr. Andy Sp. P                         | √   |
| 11 | 249031 | TUTI HANDAYANI |            | umum           | IGD  | cardiac arrest    | doc ec hipoglikemia + gagal nafas                                                    | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | √   |

|    |        |                        |   |                |     |                |                                                                                                                                                         |                                        |   |
|----|--------|------------------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|
| 12 | 64983  | SRIJANI                | 6 | BPJS Kesehatan | 4A  | cardiac arrest | MR+AF+HHD+HF, Acute DOC ec susp ensefalopati metabolik dd CVA emboli + CKD + hipoalbumin + hipokalsemi                                                  | Dr Yoga Waranugraha Sp Jp              | √ |
| 13 | 249072 | MISTIN                 | 2 | BPJS KESEHATAN | 8A  | cardiac arrest | DOC SUSP SEPSIS,AF,RVR                                                                                                                                  | Dr Yolanda                             | √ |
| 14 | 186900 | BUCHARI                | 7 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | Dx. Utama: STEMI INFERIOR<br>Dx. Sekunder: Tb paru on OAT,DM hiperglikemia ,Cardiogenic shock,Respiratory failure,Pneumonia,Syncope,C kd st 3 (eGFR 44) | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | √ |
| 15 | 248952 | NANIK MULYANI          | 4 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | Dx. Utama: STEMI Anterior<br>Dx. Sekunder: STROKE,Heart Failure,Dm Tipe 2                                                                               | Dr Yoga Waranugraha Sp Jp              | √ |
| 16 | 087662 | SUHARIYADI             | 5 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | Gradual DOC ec ensefalopati hipoksik dd hidrosefalus susp ALO cardiogenic + AF + Respi failure                                                          | Dr Akhmad Syahrir Sp N                 | √ |
| 17 | 173248 | RIRIN FEMMY TAKARIANTI | 2 | BPJS KESEHATAN | IGD | cardiac arrest | Hepatoma                                                                                                                                                | Dr Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. Pd         | √ |
| 18 | 249164 | MUTMAINAH              | 6 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | Dx. Utama: Cva IVH<br>Dx. Sekunder: Edema cerebri,Hydrocephalus,contusi o muscularum cruris dextra,vulnus appertum genu sinistra                        | Dr Fachry, <a href="#">Sp.Bs</a>       | √ |
| 19 | 249108 | Sdr. M. Bagus Yunianto | 5 | JR+BPJS        | ICU | cardiac arrest | COB+EDH                                                                                                                                                 | Dr Fachry, <a href="#">Sp.Bs</a>       | √ |
| 20 | 249312 | MANSUR                 | 3 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | Pneumonia Nstemi                                                                                                                                        | Dr. Andy Sp. P                         | √ |
| 21 | 185511 | SUDJILAH               | 4 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | ARDS,CKD                                                                                                                                                | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | √ |
| 22 | 249310 | SUGENG HARIYANTO       | 4 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | PNEUMONIA PSI 88, RESPIRATORY FAILURE                                                                                                                   | Dr. Andy Sp. P                         | √ |
| 23 | 247770 | ASPANDI                | 1 | BPJS KESEHATAN | IGD | cardiac arrest | CVA 2nd Attack susp. Supratentorial Hemorrhage                                                                                                          | Dr Endra                               | √ |
| 24 | 249441 | SUMI'AH                | 2 | BPJS KESEHATAN | 7A  | cardiac arrest | DSS DT MODS                                                                                                                                             | Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd                 | √ |
| 25 | 249453 | WAGISAN                | 2 | BPJS KESEHATAN | IGD | cardiac arrest | CVA ICH, SAH                                                                                                                                            | Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N             | √ |
| 26 | 94380  | SUDARSONO              | 1 | UMUM           | IGD | cardiac arrest | DOA                                                                                                                                                     | Dr Isrotul                             | √ |
| 27 | 249559 | NALIM                  | 1 | BPJS KESEHATAN | IGD | cardiac arrest | Syock condition ec cardiogenik dd non cardiogenik (hipovolemik)                                                                                         | Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp        | √ |
| 28 | 249022 | SUMARDJI SARSONO       | 1 | UMUM           |     | cardiac arrest | DOA                                                                                                                                                     | Dr Yeni                                | √ |
| 29 | 248226 | SUTONO                 | 1 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | KAD+SYOK SEPSIS                                                                                                                                         | Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes         | √ |
| 30 | 156773 | Tiajah Rubiajah        | 8 | BPJS KESEHATAN | 6A  | cardiac arrest | Ulcus Decubitus Coxae D/S post Debridement, Pneumonia, CKD st 3, Shock Hipovolemic                                                                      | Dr. Andi Abdillah,Sp.B                 | √ |
| 31 | 249501 | Arys Adyanto           | 5 | BPJS KESEHATAN | 6A  | cardiac arrest | Cholelithiasis, Fatty Liver, Jaundice                                                                                                                   | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | √ |
| 32 | 245111 | RIADI                  | 3 | BPJS KESEHATAN | 6A  | cardiac arrest | Nefrolitiasis, PAC, Asidosis                                                                                                                            | Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes         | √ |
| 33 | 248551 | SULIANI                | 3 | BPJS KESEHATAN | HCU | cardiac arrest | Krisis Hipergilemi, CVA Sequele                                                                                                                         | Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd                 | √ |
| 34 | 167079 | BAMBANG PURNOMO        | 2 | BPJS KESEHATAN | HCU | cardiac arrest | DOC ec susp sepsis dd uremic encephalopathy                                                                                                             | Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd                 | √ |
| 35 | 249866 | ERDIN HUSAENI          | 1 | UMUM           | IGD | cardiac arrest | Susp STEMI inferior                                                                                                                                     | Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N             | √ |
| 36 | 222838 | An. RATIH AQILA DEWATI | 1 | UMUM           | IGD | cardiac arrest | DOC ec multiple trauma                                                                                                                                  | Dr Yolanda                             | √ |
| 37 | 137221 | SUWARJI                | 1 | UMUM           | IGD | cardiac arrest | DOA                                                                                                                                                     | Dr Yolanda                             | √ |
| 38 | 249849 | MULYATIN               | 2 | BPJS KESEHATAN | HCU | cardiac arrest | CVA ICH Subcortex S IVH<br>Susp SOP Cerebri HT Emergency Leukositosis<br>Susp Pneumonia                                                                 | Dr Fahimma, Sp. N                      | √ |

|    |        |           |   |                |     |                |                                                                         |                                        |   |
|----|--------|-----------|---|----------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|
|    |        |           |   |                |     |                | Herniasi Cerebri                                                        |                                        |   |
| 39 | 226529 | WARSIAH   | 1 | BPJS KESEHATAN | 6A  | cardiac arrest | dm hiperglikemi                                                         | Dr Ardityo Rahmat Ardhany, Sp.Pd, K-Gh | √ |
| 40 | 249183 | MISNATI   | 4 | BPJS KESEHATAN | 8A  | cardiac arrest | DM tipe 2, Hiperglikemia post coma, Diabetic foot pedis dextra post DNN | Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd            | √ |
| 41 | 183152 | SUWANDI R | 3 | BPJS KESEHATAN | ICU | cardiac arrest | CVA, ARDS, DIC                                                          | Dr Akhmad Syahrir Sp N                 | √ |
| 42 | 035715 | SUWANDI   | 1 | BPJS KESEHATAN | 6A  | cardiac arrest | CVA Infark                                                              | Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N             | √ |

**Analisa :**

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Mei 2026 sebanyak 42 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 15 pasien IRNA : 13 pasien IGD : 12 pasien
3. Pada bulan Maret 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 4 kasus.
4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

**Rencana Tindak Lanjut**

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

**3.5.7.6 Laporan MPP**

**Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien**

| NO | IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN                                   | BULAN / JUMLAH |            |          |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|
|    |                                                                  | MARET 2026     | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Usia lanjut                                                      | 2              | 2          | 9        |
| 2  | Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik                     | 0              | 0          | 9        |
| 3  | Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll) | 0              | 0          | 0        |
| 4  | Perkiraan biaya tinggi                                           | 3              | 3          | 18       |
| 5  | Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)         | 0              | 0          | 0        |
| 6  | Pasien dengan fungsi kognitif rendah                             | 0              | 0          | 2        |
| 7  | Potensial komplain tinggi                                        | 1              | 1          | 7        |
| 8  | Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat                         | 0              | 0          | 1        |
| 9  | Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya                  | 0              | 0          | 2        |
| 10 | Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan                       | 0              | 0          | 3        |
| 11 | Berpotensi masalah hukum                                         | 0              | 0          | 1        |
| 12 | Naik kelas pelayanan                                             | 7              | 7          | 2        |
| 13 | Lain - lain                                                      | 10             | 10         | 27       |

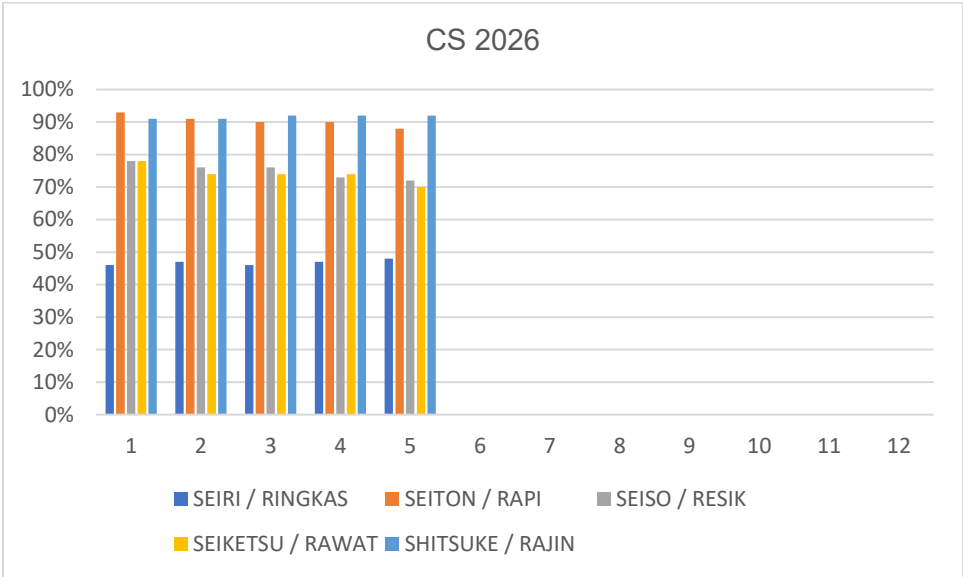
**3.5.8 Cleaning Service**

**3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service**

| KATEGORI | DESKRIPSI                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Seiri    | Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly                    |
|          | Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly                    |
| Seiton   | Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs              |
|          | Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS              |
| Seiso    | Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal               |
|          | Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal               |
| Seiketsu | Mematuhi Sop Kebersihan                                          |
|          | Mematuhi SOP Kebersihan                                          |
| Shiketsu | Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan |
|          | Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan |
|          | Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan |

3.5.8.2 Tabel Produktifitas *Cleaning Service*

| NO | JENIS SPV        | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|----|----|
| 1  | SEIRI / RINGKAS  | 46% | 47% | 46% | 47% | 48% |   |   |   |   |    |    |    |
| 2  | SEITON / RAPI    | 93% | 91% | 90% | 90% | 88% |   |   |   |   |    |    |    |
| 3  | SEISO / RESIK    | 78% | 76% | 76% | 73% | 72% |   |   |   |   |    |    |    |
| 4  | SEIKETSU / RAWAT | 78% | 74% | 74% | 74% | 70% |   |   |   |   |    |    |    |
| 5  | SHITSUKE / RAJIN | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% |   |   |   |   |    |    |    |



**Analisa :**  
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

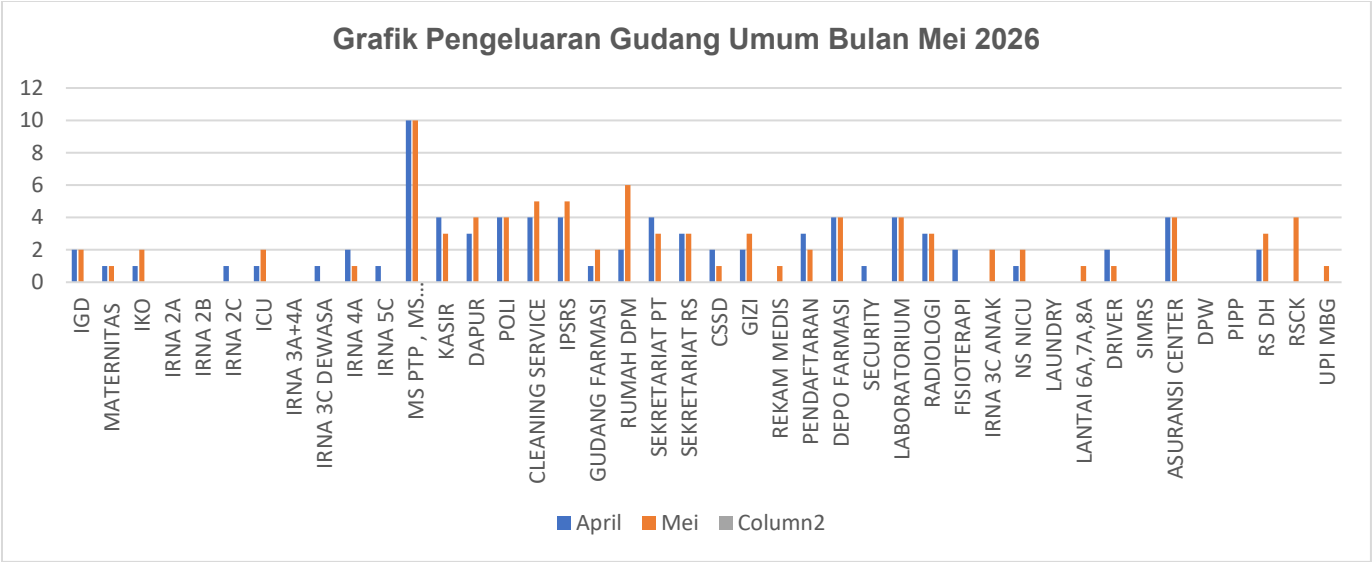
3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

| NO | UNIT ASAL                    | JUMLAH BARANG |     | PERSENTASE |
|----|------------------------------|---------------|-----|------------|
|    |                              | APRIL         | MEI |            |
| 1  | IGD                          | 2             | 2   | ↓0%        |
| 2  | MATERNITAS                   | 1             | 1   | ↓0%        |
| 3  | IKO                          | 1             | 2   | ↑50%       |
| 4  | IRNA 2A                      | 0             | 0   | ↓0%        |
| 5  | IRNA 2B                      | 0             | 0   | ↓0%        |
| 6  | IRNA 2C                      | 1             | 0   | ↓-100%     |
| 7  | ICU                          | 1             | 2   | ↑50%       |
| 8  | IRNA 3A+4A                   | 0             | 0   | ↓0%        |
| 9  | IRNA 3C DEWASA               | 1             | 0   | ↓0%        |
| 10 | IRNA 4A                      | 2             | 1   | ↓ -10 0%   |
| 11 | IRNA 5C                      | 1             | 0   | ↓0%        |
| 12 | MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS | 10            | 10  | ↑0%        |
| 13 | KASIR                        | 4             | 3   | ↓-33,33%   |
| 14 | DAPUR                        | 3             | 4   | ↑-33,33%   |
| 15 | POLI                         | 4             | 4   | ↑0%        |
| 16 | CLEANING SERVICE             | 4             | 5   | ↑20%       |



|    |                 |   |   |          |
|----|-----------------|---|---|----------|
| 17 | IPSRs           | 4 | 5 | ↑20%     |
| 18 | GUDANG FARMASI  | 1 | 2 | ↑50%     |
| 19 | RUMAH DPM       | 2 | 6 | ↑ 66,66% |
| 20 | SEKRETARIAT PT  | 4 | 3 | ↓-33,33% |
| 21 | SEKRETARIAT RS  | 3 | 3 | ↑0%      |
| 22 | CSSD            | 2 | 1 | ↓-100%   |
| 23 | GIZI            | 2 | 3 | ↑33,33%  |
| 24 | REKAM MEDIS     | 0 | 1 | ↓100%    |
| 25 | PENDAFTARAN     | 3 | 2 | ↓-50%    |
| 26 | DEPO FARMASI    | 4 | 4 | ↓0%      |
| 27 | SECURITY        | 1 | 0 | ↑100%    |
| 28 | LABORATORIUM    | 4 | 4 | ↑0%      |
| 29 | RADIOLOGI       | 3 | 3 | ↓0%      |
| 30 | FISIOTERAPI     | 2 | 0 | ↑100%    |
| 31 | IRNA 3C ANAK    | 0 | 2 | ↓0%      |
| 32 | NS NICU         | 1 | 2 | ↑50%     |
| 33 | LAUNDRY         | 0 | 0 | ↑0%      |
| 34 | LANTAI 6A,7A,8A | 0 | 1 | ↑100%    |
| 35 | DRIVER          | 2 | 1 | ↓-100%   |
| 36 | SIMRS           | 0 | 0 | ↓0%      |
| 37 | ASURANSI CENTER | 4 | 4 | ↑0%      |
| 38 | DPW             | 0 | 0 | ↓0%      |
| 39 | PIPP            | 0 | 0 | ↑0%      |
| 40 | RS DH           | 2 | 3 | ↑33,33%  |
| 41 | RSCK            | 0 | 4 | ↑100%    |
| 42 | UPI MBG         | 0 | 1 | ↑100%    |

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



**Analisis :**  
Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
  - 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
  - 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT - SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

| NO | BULAN     | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                                                                           | DOKUMENTASI                                                                         |
|----|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JANUARI   | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 30/01/2025          | server SIMRS 2, CCTV, INACBG, SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS |  |
|    | FEBRUARI  |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | MARET     |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | APRIL     | 4x/tahun | 1x        | 100%    | 30/01/2026          | Selesai                                                                              | Terlampir                                                                           |
|    | MEI       |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | JUNI      |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | JULI      | 4x/tahun |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | AGUSTUS   |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | SEPTEMBER |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | OKTOBER   | 4x/tahun |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | NOVEMBER  |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |
|    | DESEMBER  |          |           |         |                     |                                                                                      |                                                                                     |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

| NO | BULAN    | TARGET    | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                 | DOKUMENTASI                                                                           |
|----|----------|-----------|-----------|---------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JANUARI  | 62x/bulan | 62x       | 100%    | Setiap hari         | mikrotik IT (Ruang Server) |  |
|    | FEBRUARI | 56x/bulan | 56x       | 100%    | Setiap hari         | mikrotik IT (Ruang Server) |                                                                                       |
|    | MARET    | 62x/bulan | 62x       | 100%    | Setiap hari         | selesai                    |                                                                                       |
|    | APRIL    | 60x/bulan | 60x       | 100%    | Setiap hari         | selesai                    | Terlampir                                                                             |
|    | MEI      | 62x/bulan | 62x       | 100%    | Setiap hari         | selesai                    | Terlampir                                                                             |
|    | JUNI     |           |           |         |                     |                            |                                                                                       |

|  |           |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
|  | JULI      |  |  |  |  |  |  |
|  | AGUSTUS   |  |  |  |  |  |  |
|  | SEPTEMBER |  |  |  |  |  |  |
|  | OKTOBER   |  |  |  |  |  |  |
|  | NOVEMBER  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESEMBER  |  |  |  |  |  |  |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

| NO | BULAN     | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                                                                                                                                                             | DOKUMENTASI |
|----|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | JANUARI   | 1x/bulan | 1x        | 100%    | 16/01/2025          | Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Poli sentral It1, It2, Ruang Server IT, Parkiran Karyawan, Blok 3, Parkiran Belakang, Server IPCAM |             |
|    | FEBRUARI  | 1x/bulan | 1x        | 100%    | 14/02/2025          | Selesai                                                                                                                                                                |             |
|    | MARET     | 1x/bulan | 1x        | 100%    | 09/03/2026          | Selesai                                                                                                                                                                |             |
|    | APRIL     | 1x/bulan | 1x        | 100%    | 24/04/2026          | Selesai                                                                                                                                                                | Terlampir   |
|    | MEI       | 1x/bulan | 1x        | 100%    | 20/05/2026          | selesai                                                                                                                                                                | Terlampir   |
|    | JUNI      |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | JULI      |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | AGUSTUS   |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | SEPTEMBER |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | OKTOBER   |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | NOVEMBER  |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |
|    | DESEMBER  |          |           |         |                     |                                                                                                                                                                        |             |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

| NO | BULAN     | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                             | DOKUMENTASI                                                                         |
|----|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JANUARI   | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 30/01/2015          | Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome |  |
|    | FEBRUARI  |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | MARET     |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | APRIL     | 4x/tahun | 1x        | 100%    | 22/04/2026          | Selesai                                | Terlampir                                                                           |
|    | MEI       |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | JUNI      |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | JULI      | 4x/tahun |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | AGUSTUS   |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | SEPTEMBER |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | OKTOBER   | 4x/tahun |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | NOVEMBER  |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | DESEMBER  |          |           |         |                     |                                        |                                                                                     |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

1.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

| NO | BULAN    | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN  | KETERANGAN                                                    | DOKUMENTASI                                                                           |
|----|----------|------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JANUARI  | 15PC/Bulan | 4x        | 26%     | 26/01/2025           | Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A |  |
|    | FEBRUARI | 15PC/Bulan | 7x        | 47%     | 17/02/2026           | Belum selesai                                                 |                                                                                       |
|    | MARET    | 15PC/Bulan | 8x        | 54%     | 23 s/d 25 maret 2026 | PC all Farmasi                                                |                                                                                       |
|    | APRIL    | 15PC/Bulan | 21x       | 100%    | 19 s/d 26 april      | Verif,rm, manajemen selesai                                   | Terlampir                                                                             |

|  |           |            |            |     |      |               |           |
|--|-----------|------------|------------|-----|------|---------------|-----------|
|  | MEI       | 15PC/Bulan | 15PC/Bulan | 21x | 100% | 14 s/d 17 mei | Poli Irja |
|  | JUNI      | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | JULI      | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | AGUSTUS   | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | SEPTEMBER | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | OKTOBER   | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | NOVEMBER  | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |
|  | DESEMBER  | 15PC/Bulan |            |     |      |               |           |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target  
Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

### 3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

| NO | BULAN     | TARGET           | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                             | DOKUMENTASI                                                                         |
|----|-----------|------------------|-----------|---------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JANUARI   | 3 Printer /bulan | 3x        | 100%    | 1/01/2025           | PT, Rekam Medis (management), PDF IGD. |  |
|    | FEBRUARI  | 3 Printer /bulan | 3x        | 100%    | 16/02/2026          | Selesai                                |                                                                                     |
|    | MARET     | 3 Printer /bulan | 3x        | 100%    | 19/03/2026          | Selesai                                |                                                                                     |
|    | APRIL     | 3 Printer /bulan | 3x        | 100%    | 22/04/2026          | Selesai                                |                                                                                     |
|    | MEI       | 3 Printer /bulan | 3x        | 100%    | 22/04/2026          | Selesai                                | Terlampir                                                                           |
|    | JUNI      |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | JULI      |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | AGUSTUS   |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | SEPTEMBER |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | OKTOBER   |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |
|    | NOVEMBER  |                  |           |         |                     |                                        |                                                                                     |

Analisa :  
Sudah dilakukan maintenance sesuai target  
  
Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

### 3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

| NO | BULAN    | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                                 | DOKUMENTASI                                                                           |
|----|----------|----------|-----------|---------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JANUARI  | 4x/Tahun | 1x        | 25%     | 2/01/2025           | Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI |  |
| 2  | FEBRUARI |          |           |         |                     |                                            |                                                                                       |
| 3  | MARET    |          | 1x        | 50%     | 19/03/2026          |                                            |                                                                                       |
| 4  | APRIL    |          |           |         |                     |                                            |                                                                                       |

|    |           |          |    |     |  |         |           |
|----|-----------|----------|----|-----|--|---------|-----------|
| 5  | MEI       | 4x/Tahun | 1x | 50% |  | Selesai | Terlampir |
| 6  | JUNI      |          |    |     |  |         |           |
| 7  | JULI      |          |    |     |  |         |           |
| 8  | AGUSTUS   |          |    |     |  |         |           |
| 9  | SEPTEMBER |          |    |     |  |         |           |
| 10 | OKTOBER   |          |    |     |  |         |           |
| 11 | NOVEMBER  |          |    |     |  |         |           |
| 12 | DESEMBER  |          |    |     |  |         |           |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

### 3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

| NO | BULAN     | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN        | DOKUMENTASI                                                                           |
|----|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JANUARI   | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 31/01/2025          | Ruang Server PABX |  |
| 2  | FEBRUARI  |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 3  | MARET     |          | 1x        | 50%     | 19/03/2026          | Selesai           |                                                                                       |
| 4  | APRIL     |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 5  | MEI       |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 6  | JUNI      |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 7  | JULI      |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 8  | AGUSTUS   |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 9  | SEPTEMBER |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 10 | OKTOBER   |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 11 | NOVEMBER  |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |
| 12 | DESEMBER  |          |           |         |                     |                   |                                                                                       |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

### 3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

| NO | BULAN   | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                                               | DOKUMENTASI |
|----|---------|----------|-----------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | JANUARI | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 04/01/2025          | Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. |             |

|    |           |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
|----|-----------|----------|----|--|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |           |          |    |  |     |            | blok 3, Pdf<br>Paru, Lounge<br>loun dry,<br>Gudang<br>farmasi,<br>CSSD,<br>Farmasi depo,<br>Driver, DPM |           |
| 2  | FEBRUARI  |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 3  | MARET     |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 4  | APRIL     | 4x/tahun | 1x |  | 50% | 22/04/2026 | Selesai                                                                                                 | Terlampir |
| 5  | MEI       |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 6  | JUNI      |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 7  | JULI      |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 8  | AGUSTUS   |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 9  | SEPTEMBER |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 10 | OKTOBER   |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 11 | NOVEMBER  |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |
| 12 | DESEMBER  |          |    |  |     |            |                                                                                                         |           |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

### 3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

| NO | BULAN    | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                                                                                                                                                 | DOKUMENTASI |
|----|----------|----------|-----------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | JANUARI  |          |           |         |                     | Gedung A 1-8 PT,<br>Management,<br>Gedung C 1-5, Gedung D 1-4.<br>blok 3, Pdf Paru, Lounge loun dry,<br>Gudang farmasi, CSSD,<br>Farmasi depo, Driver, DPM |             |
|    |          | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 09/01/2025          |                                                                                                                                                            |             |
| 2  | FEBRUARI |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 3  | MARET    |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 4  | APRIL    | 4x/tahun | 1x        | 50%     | 09/04/2025          | Selesai                                                                                                                                                    | Terlampir   |
| 5  | MEI      |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 6  | JUNI     |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 7  | JULI     |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 8  | AGUSTUS  |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |
| 9  | SEPT     |          |           |         |                     |                                                                                                                                                            |             |

|    |          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 10 | OKTOBER  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NOVEMBER |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DESEMBER |  |  |  |  |  |  |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

| NO | BULAN     | TARGET   | REALISASI | CAPAIAN | TANGGAL PELAKSANAAN | KETERANGAN                       | DOKUMENTASI                                                                         |
|----|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JANUARI   | 4x/tahun | 1x        | 25%     | 30/01/2025          | Ruang Server PABX                |  |
| 2  | FEBRUARI  |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 3  | MARET     |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 4  | APRIL     | 4x/tahun | 1x        | 50%     | 7/04/2026           | 1. modem mati (perlu Ganti baru) | Terlampir                                                                           |
| 5  | MEI       |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 6  | JUNI      |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 7  | JULI      |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 8  | AGUSTUS   |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 9  | SEPTEMBER |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 10 | OKTOBER   |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 11 | NOVEMBER  |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |
| 12 | DESEMBER  |          |           |         |                     |                                  |                                                                                     |

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

| No | Bulan | Kegiatan                                                | Hasil  | Petugas  | Keterangan |
|----|-------|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1  | Mei   | Setting Bridging sim Khanza MS Klinik                   | Tuntas | Internal |            |
| 2  | Mei   | Setting Ip Public sim Khanza MS                         | Tuntas | Internal |            |
| 3  | Mei   | Setting IP public untuk kebutuhan virtual server APISIX | Tuntas | Internal |            |
| 4  | Mei   | Simulasi sursim akreditasi                              | Tuntas | Internal |            |
| 5  | Mei   | Pemasangan barcode kartu control pc / maintenance       | Tuntas | Internal |            |

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

| NO | Kegiatan                    | Target (Bulan) | Hasil          | Keterangan |
|----|-----------------------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | Penambahan kamera cctv area | Juni           | Tuntas / Tidak |            |



|   |                                             |      |                       |                              |
|---|---------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------|
|   | parker mobil depan igd                      |      | Tuntas                |                              |
| 2 | Instal aplikasi khanza di semua komputer PT | Juni | Tuntas / Tidak Tuntas | SIM Khanza ALL MS Klinik     |
| 3 | Penambahan kamera cctv                      | Juni | Tuntas / Tidak Tuntas | Area LAF farmasi di lantai 4 |

### 3.3.6 Penanganan Keluhan

#### 3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

| BULAN     | JUMLAH LAPORAN | JUMLAH TERSELESAIKAN | PROSENTASE (%) |
|-----------|----------------|----------------------|----------------|
| Januari   | 51             | 51                   | 100%           |
| Februari  | 32             | 32                   | 100%           |
| Maret     | 72             | 72                   | 100%           |
| April     | 77             | 77                   | 100%           |
| Mei       | 64             | 64                   | 100%           |
| Juni      |                |                      |                |
| Juli      |                |                      |                |
| Agustus   |                |                      |                |
| September |                |                      |                |
| Oktober   |                |                      |                |
| November  |                |                      |                |
| Desember  |                |                      |                |

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

#### 3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

| BULAN    | JUMLAH LAPORAN | JUMLAH TERSELESAIKAN | PROSENTASE (%) |
|----------|----------------|----------------------|----------------|
| Januari  | 69             | 69                   | 100%           |
| Februari | 107            | 107                  | 100%           |
| Maret    | 54             | 54                   | 100%           |
| April    | 43             | 43                   | 100%           |
| Mei      | 34             | 34                   | 100%           |
| Juni     |                |                      |                |
| Juli     |                |                      |                |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| Agustus   |  |  |  |
| September |  |  |  |
| Oktober   |  |  |  |
| November  |  |  |  |
| Desember  |  |  |  |

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

| SPESIFIK           | JUMLAH  |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
|--------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|                    | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| PC                 | 13      | 30       | 16    | 24    | 25  |      |      |         |           |         |          |          |
| PRINTER            | 17      | 28       | 19    | 15    | 9   |      |      |         |           |         |          |          |
| SIMRS              | 4       | 6        | 10    | 3     | 2   |      |      |         |           |         |          |          |
| JARINGAN INTERNET  | 60      | 57       | 61    | 58    | 43  |      |      |         |           |         |          |          |
| TELPON PABX        | 5       | 5        | 1     | 4     | 4   |      |      |         |           |         |          |          |
| CCTV               | 3       | 3        | 3     | 3     | 3   |      |      |         |           |         |          |          |
| UPS                | 1       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| HP / TAB           | 3       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| CAMERA             | 2       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| KEYBOARD DAN MOUSE | 3       | 0        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| LAINNYA            | 2       | 3        | 9     | 2     | 13  |      |      |         |           |         |          |          |
| TOTAL              | 113     | 132      | 119   | 109   | 99  | 0    | 0    | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        |

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

| No | Kegiatan                 | Jumlah | Hasil        | Petugas  | Keterangan |
|----|--------------------------|--------|--------------|----------|------------|
| 1  | Komputer pdf igd konslet | 1      | Belum Tuntas | Internal | Vga Mati   |

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

| NO | BULAN    | JUMLAH<br>TOTAL<br>PC RS | JUMLAH PC<br>YANG PERLU<br>PEREMAJAAN            | JUMLAH PC<br>YANG SUDAH<br>DILAKUKAN<br>PEREMAJAAN | PROSENTASE | KETERANGAN                                                |
|----|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Januari  | 188                      | - RM<br>- Verif                                  | IRNA 2A (pakai<br>pc ex pdf loket<br>6)            |            |                                                           |
| 2  | Februari | 188                      | - Verif<br>- PC poli ipd<br>perawat              | IGD p2<br>IRNA 2A                                  |            | Sudah<br>Dilakukan<br>peremajaan                          |
| 3  | Maret    | 188                      | - Verif<br>- PC poli ipd<br>perawat              |                                                    |            |                                                           |
| 4  | April    | 188                      | - Verif<br>- PC poli ipd<br>perawat<br>- irna 2a |                                                    |            |                                                           |
| 5  | Mei      | 198                      | -Pdf igd                                         | -admin mutu<br>-Irna 2a Dokter                     |            | Pdf igd mati<br>total karena<br>konslet<br>kesalahan user |

Tabel Data CCTV

| NO | BULAN    | JUMLAH<br>TOTAL<br>CCTV RS | JUMLAH CCTV<br>YANG PERLU<br>PEREMAJAAN  | JUMLAH CCTV<br>YANG SUDAH<br>DILAKUKAN<br>PEREMAJAAN        | PROSENTASE | KETERANGAN                              |
|----|----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 1  | Januari  | 100                        | 1 (DPM Depan<br>gerbang rumah<br>7b)     |                                                             |            | Pergantian<br>power dvr<br>yang konslet |
| 2  | Februari | 100                        |                                          |                                                             |            |                                         |
| 3  | Maret    | 100                        | Power supply<br>dvr cctv dpm             |                                                             |            | Pergantian<br>power dvr<br>yang konslet |
| 4  | April    | 101                        | Penambahan<br>kamera cctv di<br>area atm | Pindahan<br>chanel dvr<br>parkiran ke dvr<br>Gudang farmasi |            | Pemasangan<br>baru                      |
| 5  | Mei      | 101                        | 0                                        | 101                                                         | 100%       |                                         |

Tabel Data Printer

| NO | BULAN    | JUMLAH<br>TOTAL<br>PRINTER<br>RS | JUMLAH<br>PRINTER YANG<br>PERLU<br>PEREMAJAAN | JUMLAH PRINTER<br>YANG SUDAH<br>DILAKUKAN<br>PEREMAJAAN                         | PROSENTASE | KETERANGAN                                                          |
|----|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Januari  | 44                               |                                               | 1. Printer etiket parkir get in Jaminan                                         |            | Untuk printer belum dilakukan permajaan dikarenakan akan proses ERM |
| 2  | Februari | 44                               |                                               | 1. Admin Jaminan (Ganti sensor head dengan kanibal unit printer yg sudah rusak) |            |                                                                     |
| 3. | Maret    | 44                               | 2 (printer hasil & pengantar laborat)         |                                                                                 |            | Head printer lx 310 sudah mulai bergaris                            |
| 4. | April    | 44                               | 2 (printer cso dan radiologi)                 | Pdf igd                                                                         |            | Pergantian karet penarik kertas                                     |
| 5  | Mei      | 44                               | 3 (Poli jantung, cso, printer backup)         |                                                                                 |            | Pergantian karet penarik kertas                                     |

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

| NO | TANGGAL<br>KEJADIAN<br>DOWNTIME | JENIS DOWNTIME<br>(TERENCANA/TIDAK<br>TERENCANA) | LAMA<br>DOWNTIME | PENYEBAB<br>DOWNTIME | RTL |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----|
| -  | -                               | -                                                | -                | -                    | -   |

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

| KEPERLUAN               | JUMLAH  |          |       |       |     |      |      |         |           |         |          |          |
|-------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|                         | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
| RUJUK PASIEN KE RS LAIN | 47      | 44       | 31    | 36    | 35  |      |      |         |           |         |          |          |
| RUJUK PASIEN KE RSPHS   | 0       | 1        | 0     | 0     | 0   |      |      |         |           |         |          |          |
| JEMPUT RUMAH PASIEN     | 21      | 27       | 19    | 20    | 17  |      |      |         |           |         |          |          |
| ANTAR RUMAH PASIEN      | 22      | 21       | 15    | 25    | 18  |      |      |         |           |         |          |          |
| SAMPEL LAB              | 31      | 33       | 29    | 29    | 33  |      |      |         |           |         |          |          |
| SAMPEL SHK              | 3       | 4        | 3     | 2     | 1   |      |      |         |           |         |          |          |

|                                |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM | 8   | 4   | 3   | 6   | 2   |  |  |  |  |  |  |  |
| KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT   | 1   | 0   | 3   | 1   | 0   |  |  |  |  |  |  |  |
| PENGANTARAN JENAZAH            | 42  | 33  | 34  | 37  | 40  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUJUK CT SCAN                  | 0   | 5   | 0   | 12  | 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTAR MCU RSPHM                | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   |  |  |  |  |  |  |  |
| LAIN-LAIN                      | 16  | 17  | 18  | 11  | 28  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                          | 191 | 190 | 155 | 179 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |

**Analisa :**  
 Utilitas pada bulan Mei masih dalam tahap normal sehingga bisa tidak ada kendala

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

| BULAN     | JUMLAH | RATA-RATA / BULAN |
|-----------|--------|-------------------|
| JANUARI   | 1024   | 40                |
| FEBRUARI  | 1025   | 44                |
| MARET     | 907    | 39                |
| APRIL     | 1152   | 48                |
| MEI       | 1086   | 47                |
| JUNI      |        |                   |
| JULI      |        |                   |
| AGUSTUS   |        |                   |
| SEPTEMBER |        |                   |
| OKTOBER   |        |                   |
| NOVEMBER  |        |                   |
| DESEMBER  |        |                   |
| TOTAL     |        |                   |

**Analisa :**  
 Fluktuatif sesuai hari libur dan kenaikan pasien

**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

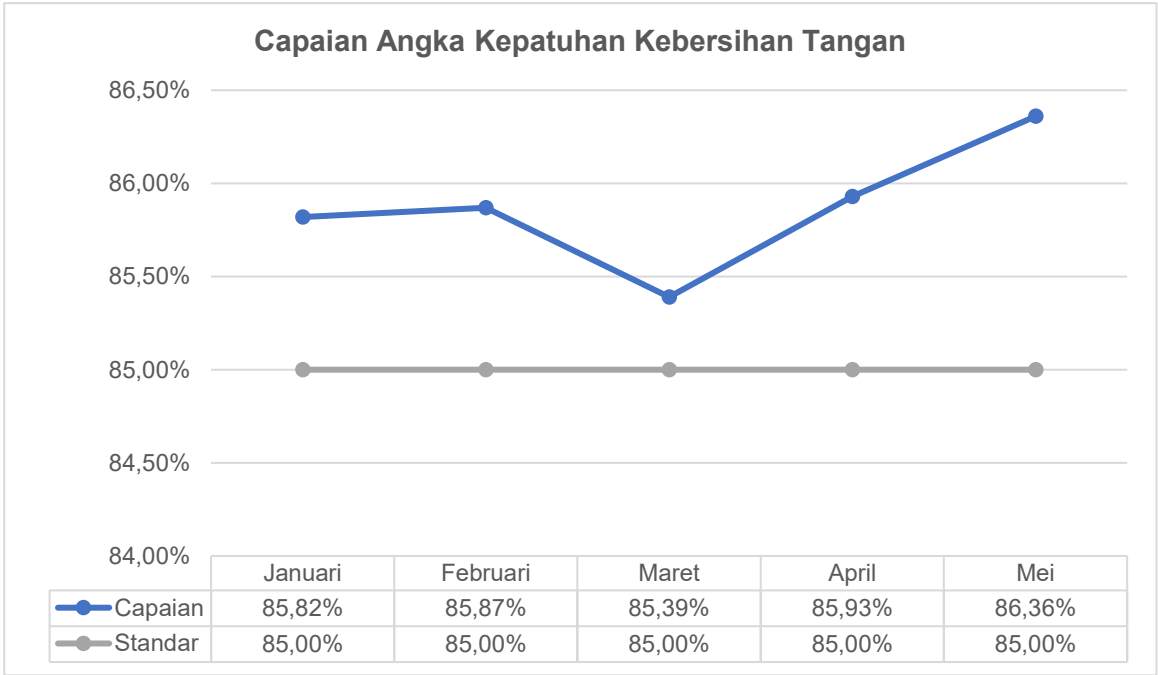
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

| NO  | Judul Indikator                                   | Bulan   |         |         |         |         |     |     |     |     |     |     |     | Stan-<br>dar | Rata-<br>Rata | Keterangan    |
|-----|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------|---------------|
|     |                                                   | Jan     | Feb     | Mar     | Apr     | Mei     | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |              |               |               |
| 1.  | Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan                 | 85,82%  | 85,87%  | 85,39%  | 85,93%  | 86,36%  |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 85%        | 86,87%        | Ditingkatkan  |
| 2.  | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)    | 96,82%  | 96,88%  | 96,40%  | 96,48%  | 97,13%  |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 96,74%        | PDSA          |
| 3.  | Kepatuhan Identifikasi Pasien                     | 99,96%  | 99,06%  | 99,89%  | 99,97%  | 99,85%  |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 99,75%        | PDSA          |
| 4.  | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi    | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 80%        | 100,00%       | Dipertahankan |
| 5.  | Waktu Tunggu Rawat Jalan                          | 89,90%  | 86,30%  | 89,20%  | 95,04%  | 95,98%  |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 80%        | 91,28%        | Dipertahankan |
| 6.  | Penundaan Operasi Elektif                         | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |     |     |     |     |     |     |     | ≤ 5%         | 0,00%         | Dipertahankan |
| 7.  | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                     | 66,75%  | 73,63%  | 68,35%  | 87,98%  | 88,55%  |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 80%        | 77.05%        | Ditingkatkan  |
| 8.  | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium               | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 100.00%       | Dipertahankan |
| 9.  | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional         | 86,13%  | 86,07%  | 86,45%  | 86,33%  | 85,81%  |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 80%        | 86,16%        | Dipertahankan |
| 10. | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | 30,51%  | 16,11%  | 18,75%  | 53,33%  | 65,22%  |     |     |     |     |     |     |     | ≥ 80%        | 36,78%        | PDSA          |
| 11. | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh    | 91.,4%  | 93.31%  | 95,60%  | 96,55%  | 91,99%  |     |     |     |     |     |     |     | 100%         | 93,80%        | PDSA          |

|     |                                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |         |         |               |
|-----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------------|
| 12. | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 80%   | 100,00% | Dipertahankan |
| 13. | Kepuasan Pasien                  | 99,70%  | 99,89%  | 99,79%  | 99,88%  | 99,41%  |  |  |  |  |  |  |  | ≥ 76,61 | 99,73%  | Dipertahankan |

### 3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



#### Analisis:

Pada bulan Mei, angka kepatuhan kebersihan tangan di RS Prima Husada Malang mencapai **86,36%**. Berdasarkan grafik pada Gambar 3.1, capaian ini mengalami peningkatan sebesar **0,43%** dibandingkan bulan April. Hasil tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu **≥85%**, serta menjadi capaian tertinggi dalam empat bulan terakhir.

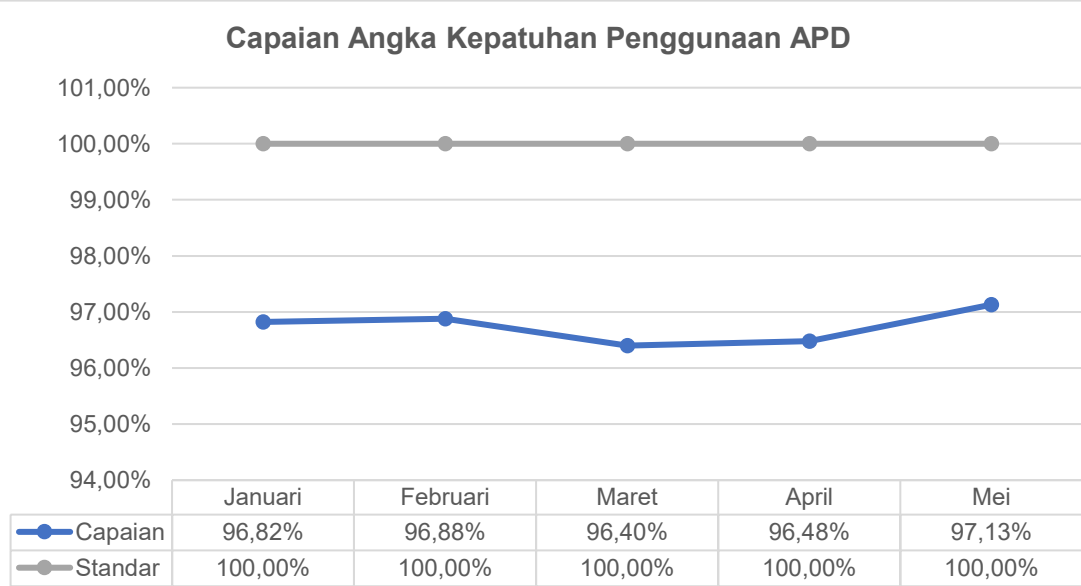
Berdasarkan capaian per unit, tingkat kepatuhan kebersihan tangan tertinggi diperoleh oleh **IRJA** dengan capaian **100%**, diikuti oleh **IKO** sebesar **94,80%** dan **ICU** sebesar **91,33%**. Capaian yang tinggi pada unit-unit tersebut menunjukkan konsistensi petugas dalam menerapkan praktik kebersihan tangan sesuai standar yang berlaku.

Sebaliknya, masih terdapat beberapa unit yang belum mencapai standar minimal kepatuhan kebersihan tangan. **Instalasi Gizi** merupakan unit dengan capaian terendah, yaitu **75,46%**. Selain itu, unit lain yang juga berada di bawah standar adalah **CS (84,72%)**, **IGD (83,55%)**, **Instalasi Laboratorium (83,89%)**, **IRNA 3C (83,20%)**, **IRNA 6A (82,76%)**, **IRNA 7A (83,24%)**, dan **IRNA 8A (84,45%)**. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan edukasi, pengawasan,

pemberian umpan balik hasil monitoring, serta penguatan budaya keselamatan pasien agar kepatuhan kebersihan tangan di seluruh unit dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan.

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



**Analisis:**  
Pada bulan Mei, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di RS Prima Husada Malang mencapai **97,13%**, mengalami peningkatan sebesar **0,65%** dibandingkan bulan April. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam empat bulan terakhir, menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan petugas terhadap penggunaan APD



sesuai standar. Namun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 2,87%**. Beberapa unit telah mencapai tingkat kepatuhan **100%**, yaitu **IGD, ICU, PICU, IKO, Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA**

**2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi**. Capaian ini menunjukkan konsistensi petugas dalam menerapkan penggunaan APD sesuai dengan ketentuan pencegahan dan pengendalian infeksi. Sementara itu, **CSSD** merupakan unit dengan capaian kepatuhan terendah, yaitu **79,03%**. Meskipun capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar **75,56%**, angka tersebut masih jauh di bawah standar yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian khusus melalui penguatan edukasi, supervisi, monitoring kepatuhan, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi petugas dalam penggunaan APD. Upaya perbaikan yang berkelanjutan diperlukan agar seluruh unit dapat mencapai target kepatuhan 100% dan mendukung keselamatan petugas maupun pasien.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Mei tahun 2026

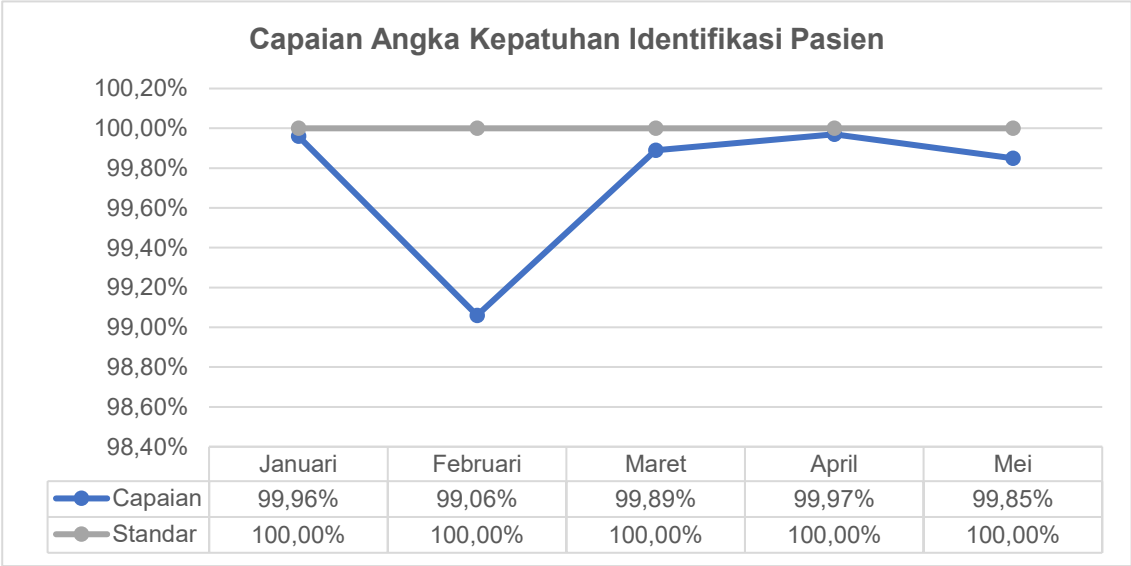
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problem</b> | Pada Bulan Mei, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di RS Prima Husada Malang mencapai 97,13%, mengalami peningkatan dari Bulan April sebesar 0.65%. Capaian ini merupakan yang paling tinggi dari 4 (empat) bulan sebelumnya, namun masih memiliki gap sebesar 2,87% dari standar minimal yang ditetapkan yakni 100%. Masalah yang ditemukan adalah masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD baik yang tidak lengkap maupun berlebihan, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata, kebiasaan kerja lama masih memengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten, dan monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata.                                              |
| <b>Plan</b>    | Mengupayakan peningkatan kepatuhan penggunaan APD sehingga mencapai standar minimal (100%) dengan mengingatkan petugas yang memakai APD berlebihan, mengevaluasi penggunaan stok APD, memberikan edukasi, dan melakukan supervisi terkait ketersediaan dan penggunaan APD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Do</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan penggunaan APD</li> <li>2. Edukasi pengunaan APD</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Study</b>   | Capaian target bulan ini masih belum memenuhi standar minimal (100%) sebesar 96.48%. Terjadinya penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau kurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Beberapa upaya yang dilakukan dari bulan sebelumnya yakni reminder kepada staf untuk memakai APD sesuai standar, peningkatan monitoring oleh kepala unit. Dari upaya tersebut didapatkan kenaikan kepatuhan penggunaan APD sebesar 0.08% dari bulan sebelumnya. Upaya ini bisa terus dilakukan untuk dapat semakin meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan APD sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. |
| <b>Action</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi.</li> <li>2. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM).</li> <li>3. Meningkatkan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai.</li> <li>4. Melakukan supervisi terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.</li> <li>5. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.</li> </ol>                                                                                        |

Tabel Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana Kegiatan                      |                       | Tujuan                                                          | Sasaran                     | Strategik                                                                    | Pelaksana                                                                               | Waktu         |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Peningkatan Kepatuhan APD             | Monitoring Penggunaan | Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan) | Unit pelayanan              | Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja         | <ul style="list-style-type: none"><li>Komite PPI, IPCN</li><li>Kepala Ruangan</li></ul> | Berkelanjutan |
| 2  | Peningkatan penggunaan APD yang benar | Konsistensi APD yang  | Meningkatkan konsistensi penggunaan APD                         | Seluruh staf unit pelayanan | Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback         | <ul style="list-style-type: none"><li>Komite PPI</li></ul>                              | Setiap bulan  |
| 3  | Kontroling APD                        | ketersediaan          | Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD                  | Unit pelayanan              | Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi | <ul style="list-style-type: none"><li>Komite PPI</li><li>Farmasi</li></ul>              | Setiap bulan  |

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



### Analisis:

Pada bulan Mei 2026, kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang mencapai **99,85%**, mengalami penurunan sebesar **0,12%** dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun capaian ini masih tergolong sangat tinggi, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga masih terdapat **gap sebesar 0,15%** yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan identifikasi pasien.

Beberapa unit telah mencapai 100% kepatuhan, yaitu **Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRJA, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, IRNA 8A, Neonatologi, dan Maternitas**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi pasien pada unit-unit tersebut telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku.

Di sisi lain, **IRNA 5C** menjadi unit dengan capaian terendah, yaitu **89,23%**. Capaian ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan identifikasi pasien yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan 161uper perbaikan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi

kepada petugas, peningkatan Supervisi dan monitoring kepatuhan, serta pemberian umpan balik secara berkala agar pelaksanaan identifikasi pasien dapat dilakukan secara konsisten dan mencapai target 100% di seluruh unit pelayanan.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Mei tahun 2026

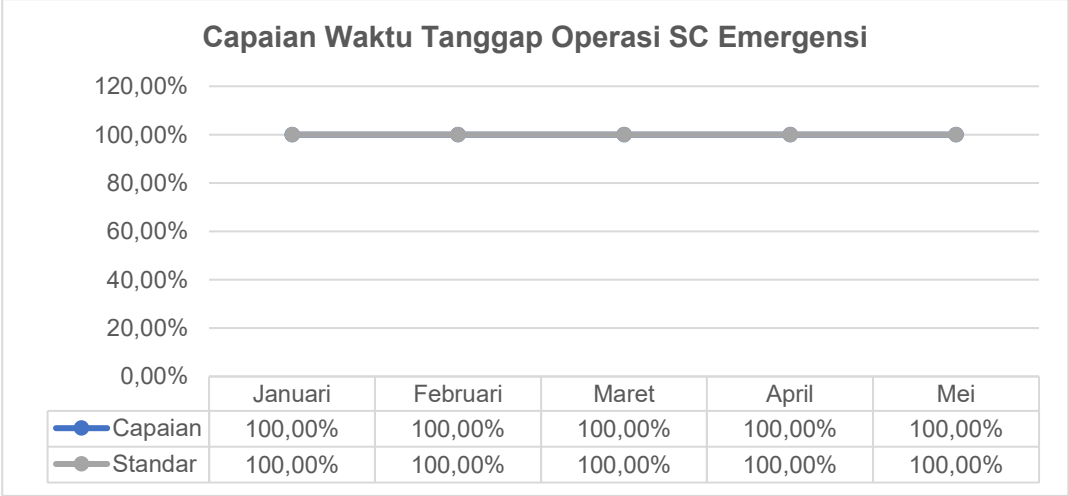
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problem</b> | Capaian kepatuhan identifikasi pasien bulan Mei 2026 sebesar 99,85% belum mencapai standar 100%, dengan masih ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan identifikasi pasien di beberapa unit, terutama di IRNA 5C yang memiliki capaian terendah sebesar 89,23%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plan</b>    | Berdasarkan hasil monitoring indikator mutu kepatuhan identifikasi pasien di unit pelayanan, ditemukan bahwa kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah. Beberapa temuan antara lain petugas tidak melakukan identifikasi menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir / nomor rekam medis) sebelum tindakan. Selain itu masih terdapat petugas yang tidak melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Oleh karena itu direncanakan upaya perbaikan berupa sosialisasi ulang SPO identifikasi pasien, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, serta penguatan budaya keselamatan pasien. |
| <b>Do</b>      | Komite Mutu bersama kepala unit dan ruangan melakukan sosialisasi kembali terkait standar identifikasi pasien kepada seluruh petugas pelayanan. Mengingatkan kembali mengenai pentingnya identifikasi pasien sebelum tindakan. Selain itu dilakukan monitoring dan audit kepatuhan identifikasi pasien secara berkala serta pengawasan langsung oleh kepala unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Study</b>   | Capaian bulan Mei mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang sudah sangat mendekati standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan supervisi dari kepala ruangan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diartikan bahwa pengingatan kembali kepada staf untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP dan pengawasan langsung oleh kepala unit mampu meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien. Masih ada petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi sesuai SOP terutama pada kondisi pelayanan yang sibuk atau pada pasien yang sudah dikenal oleh petugas.                                                                                               |
| <b>Action</b>  | Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabel Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana Kegiatan                                 | Tujuan                                                                           | Sasaran                  | Strategik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pelaksana                                                      | Waktu   |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan | Meningkatkan kewaspadaaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP | Seluruh tenaga kesehatan | Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. | <ul style="list-style-type: none"><li>Kepala ruangan</li></ul> | 1 bulan |

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

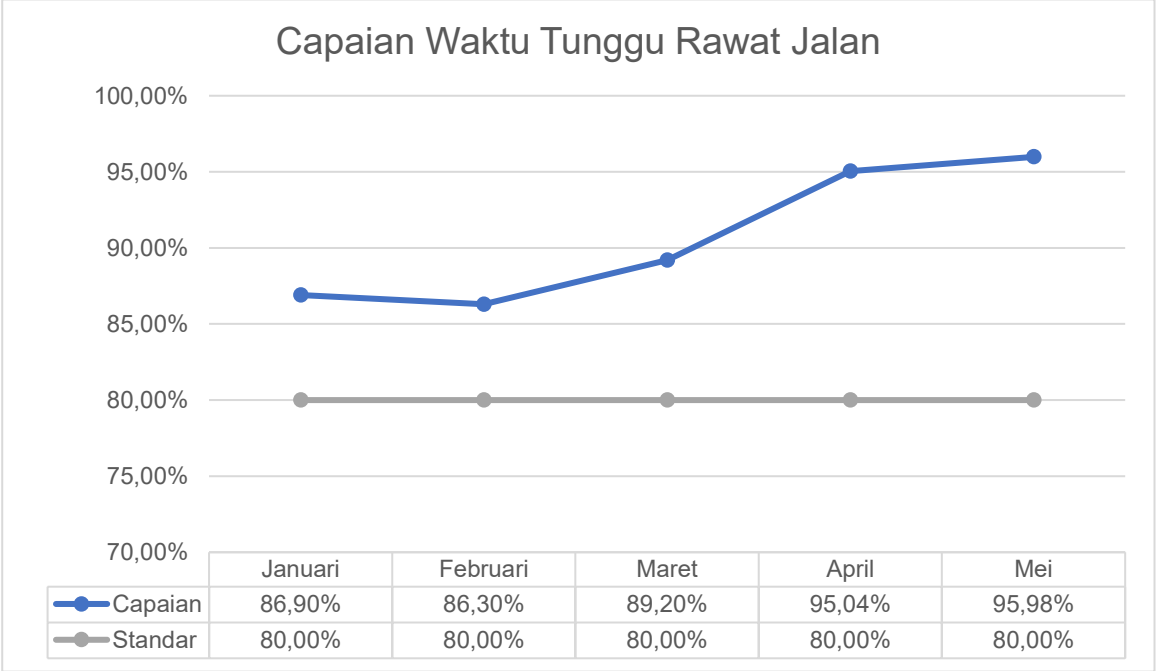


Analisis:

Pada bulan Mei 2026, capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi  $\leq 30$  menit mencapai **100%**. Capaian ini telah memenuhi standar yang ditetapkan dan berhasil dipertahankan selama **lima bulan berturut-turut**, menunjukkan konsistensi rumah sakit dalam memberikan respons yang cepat dan tepat pada kasus seksio sesarea emergensi. Hasil ini mencerminkan koordinasi yang baik antar unit terkait, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap prosedur penanganan kegawatdaruratan obstetri. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan mutu pelayanan tetap optimal dan keselamatan ibu serta bayi tetap terjamin.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Analisis:

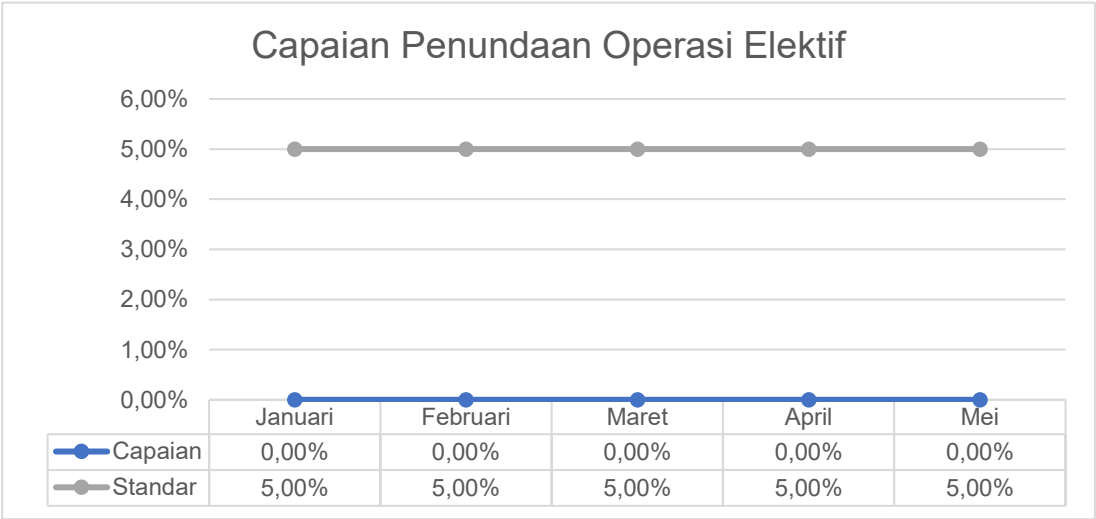
Pada bulan Mei 2026, capaian indikator waktu tunggu pelayanan rawat jalan  $\leq 60$  menit di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 95,98%. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu  $\geq 80\%$  serta mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan

capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam efektivitas alur pelayanan rawat jalan, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan awal, hingga pelayanan oleh dokter di poliklinik. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar unit pelayanan, optimalisasi jadwal pelayanan, serta monitoring waktu tunggu secara berkala

oleh manajemen dan unit terkait. Dengan capaian yang tinggi ini, diharapkan mutu pelayanan rawat jalan, kepuasan pasien, dan efisiensi pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



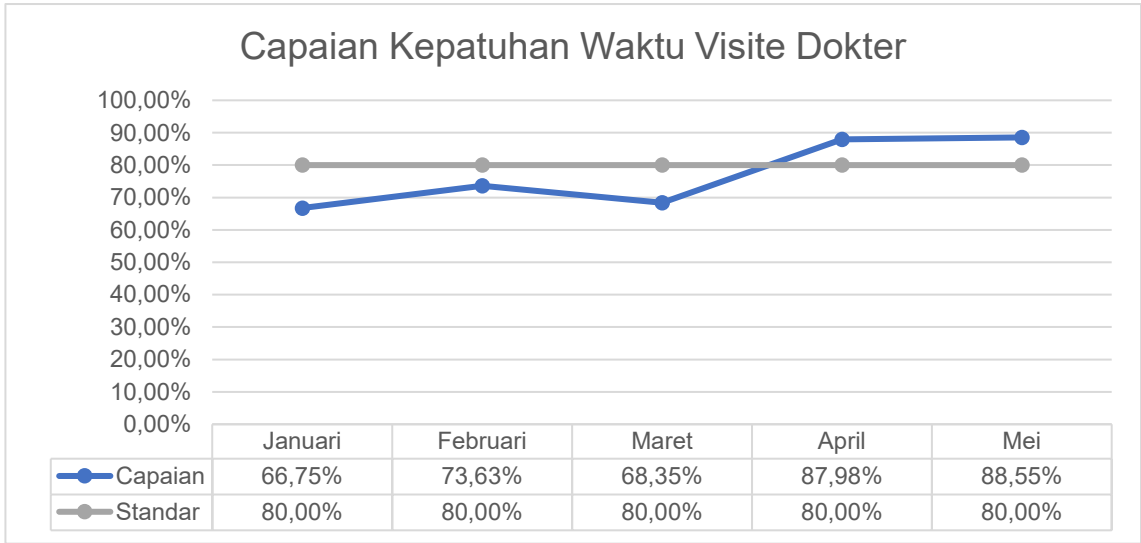
Analisis:

Pada bulan Mei 2026, capaian indikator penundaan operasi elektif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 0%, sehingga telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu  $\leq 5\%$ . Capaian ini berhasil dipertahankan selama 5 bulan berturut-turut. Tidak adanya kejadian penundaan operasi elektif menunjukkan bahwa proses pelayanan operatif berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi yang baik antara Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar Operasi, serta dukungan manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan. Selain itu, perencanaan yang efektif

terkait kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan alat, dan pengaturan ruang operasi turut berkontribusi dalam mencegah terjadinya penundaan operasi elektif.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

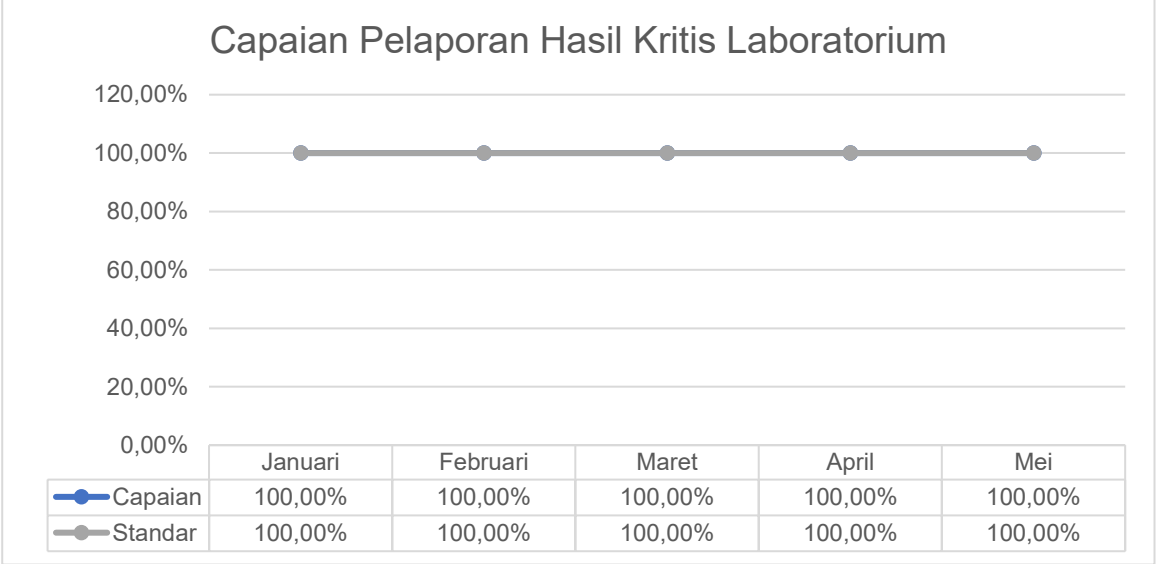


Analisis:

Pada Bulan Mei 2026, capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 88,55%, mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar minimal yang ditetapkan yaitu  $\geq 80\%$ , sehingga menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan dokter dalam melaksanakan visite tepat waktu. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan secara berkesinambungan, antara lain penguatan komunikasi dan komitmen dengan DPJP terkait pelaksanaan visite sesuai jadwal yang telah disepakati, koordinasi aktif antara perawat dengan DPJP mengenai jadwal visite pasien, serta monitoring rutin oleh manajemen dan unit terkait terhadap pelaksanaan visite dokter.

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



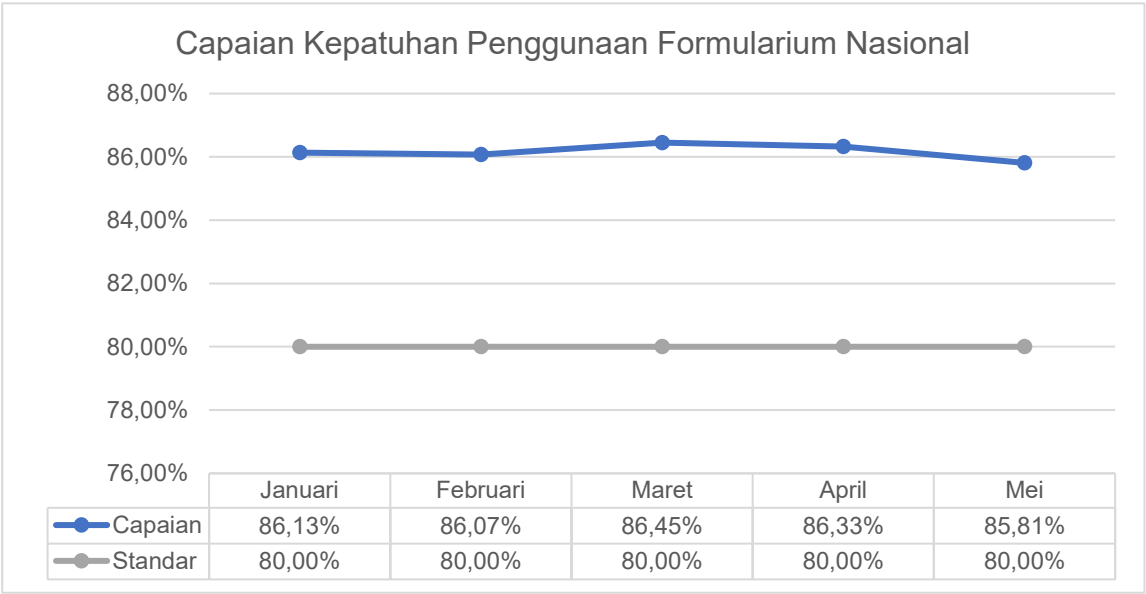
Analisis:

Pada bulan Mei 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian tersebut juga berhasil dipertahankan selama lima bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi petugas dalam melaksanakan pelaporan hasil kritis secara tepat dan sesuai prosedur. Keberhasilan ini mencerminkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar petugas laboratorium dengan unit pelayanan terkait dalam mendukung keselamatan pasien. Upaya yang terus dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut meliputi sosialisasi kebijakan dan SPO pelaporan hasil kritis, penguatan alur komunikasi hasil kritis antar unit, serta peningkatan kesadaran seluruh petugas untuk menjadikan pelaporan hasil kritis sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien di rumah sakit.



3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

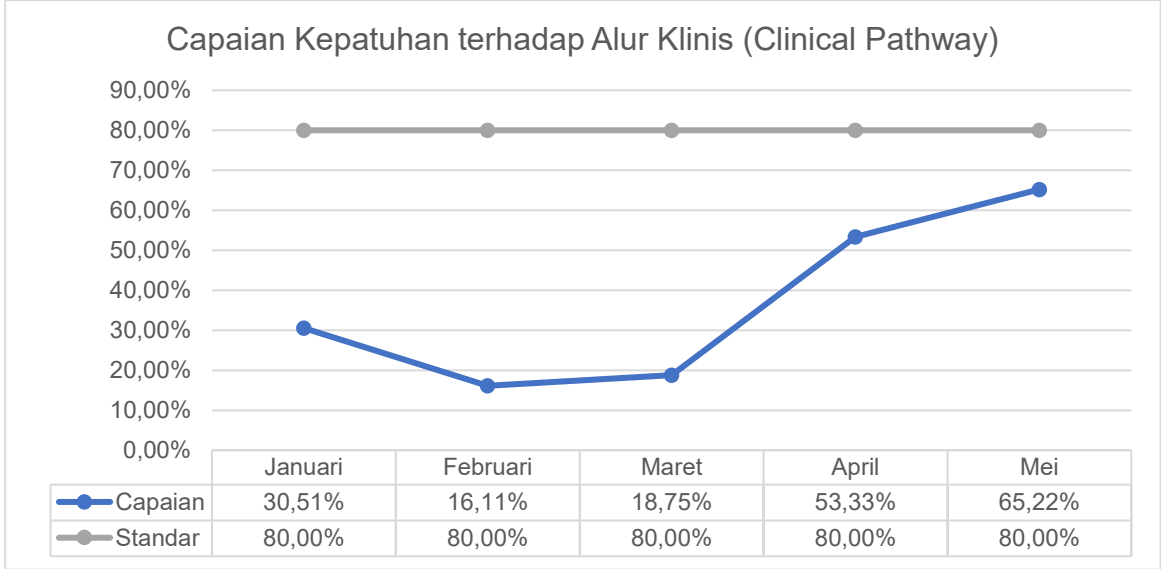


Analisis:

Pada bulan Mei 2026, capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 85,81%. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 0,52% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh masih berada di atas standar minimal yang ditetapkan yaitu  $\geq 80\%$ , sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan hasil kritis laboratorium secara umum telah berjalan dengan baik. Penurunan capaian ini perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dalam proses pelaporan hasil kritis, baik dari aspek komunikasi, ketepatan waktu, maupun kepatuhan petugas terhadap prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan agar capaian indikator dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan secara optimal sesuai standar yang telah ditetapkan.

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Jumlah pasien dan kepatuhan terhadap CP sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

| No | Diagnosis             | Jumlah Pasien | Kepatuhan CP |             |
|----|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
|    |                       |               | Patuh        | Tidak patuh |
| 1  | Hipertensi            | 1             | 1            | 0           |
| 2  | DM (DM Ulkus)         | 13            | 11           | 2           |
| 3  | Tuberkulosis          | 9             | 3            | 6           |
| 4  | HIV                   | 0             | -            | -           |
| 5  | Keganasan (Ca Mammae) | 0             | -            | -           |

Tabel Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana Kegiatan                                                              | Tujuan                                                                                                           | Sasaran                        | Strategik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                   | Waktu     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis ( <i>clinical pathway</i> ) | Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis                                                             | Seluruh tenaga medis pelayanan | Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite Mutu akan melakukan penguatan implementasi <i>clinical pathway</i> kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Medik</li> <li>• Komite Mutu</li> <li>• Kabid Pelayanan Medis</li> </ul>                                                                                                    | 1 bulan   |
| 2  | Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan                   | Mendapatkan alur klinis yang telah disepakai oleh semua PPA sehingga PPA akan memberikan perawatan yang seragam. | Seluruh PPA                    | Rumah sakit akan melakukan penyamaan persepsi antar PPA mengenai alur pelayanan dan tahapan tindakan klinis sesuai SPO atau <i>clinical pathway</i> yang berlaku dan penguatan koordinasi dan komunikasi efektif antar PPA untuk memastikan kesinambungan pelayanan pasien                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Medik</li> <li>• Komite Mutu</li> <li>• Kabid Pelayanan Medis</li> <li>• Komite Keperawatan</li> <li>• Kepala Instalasi Gizi</li> <li>• Kepala Instalasi Farmasi</li> </ul> | 1-2 bulan |

Pada bulan Mei 2026, monitoring kepatuhan terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*) dilakukan pada lima diagnosis prioritas, yaitu hipertensi, DM dengan ulkus, tuberculosis, HIV, dan Ca Mammae. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat **23 kasus** yang menjadi sampel penilaian, dengan **15 kasus patuh** dan **8 kasus tidak patuh** terhadap *Clinical Pathway*.

Pada diagnosis **hipertensi**, terdapat **1 pasien** dan seluruhnya telah memenuhi kepatuhan terhadap *Clinical Pathway*, sehingga tingkat kepatuhan mencapai **100%**. Pada diagnosis **DM dengan ulkus**, dari **13 pasien** yang dievaluasi, terdapat **11 pasien patuh** dan **2 pasien tidak patuh**, sehingga tingkat kepatuhan mencapai **84,62%**.

Sementara itu, pada diagnosis **tuberkulosis** terdapat **9 kasus** yang dievaluasi, dengan **3 kasus patuh** dan **6 kasus tidak patuh**, sehingga tingkat kepatuhan hanya mencapai **33,33%**. Capaian ini merupakan yang terendah dibandingkan diagnosis lainnya dan menunjukkan bahwa implementasi *Clinical Pathway* pada pasien

tuberkulosis masih belum optimal.  
Untuk diagnosis **HIV** dan **keganasan (Ca Mammae)** tidak terdapat kasus yang memenuhi kriteria pengukuran pada bulan Mei 2026, sehingga tidak dilakukan penilaian kepatuhan terhadap *Clinical Pathway*.  
Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap *Clinical Pathway* pada bulan Mei 2026 sebesar **65,22%** (15 kasus patuh dari 23 kasus yang dievaluasi). Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penerapan *Clinical Pathway* masih perlu ditingkatkan, terutama pada kasus tuberkulosis dan DM dengan ulkus.  
Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada DPJP dan tenaga kesehatan, peningkatan monitoring kelengkapan pengisian *Clinical Pathway*, serta evaluasi

Tabel PDSA Kepatuhan terhadap Alur Klinis

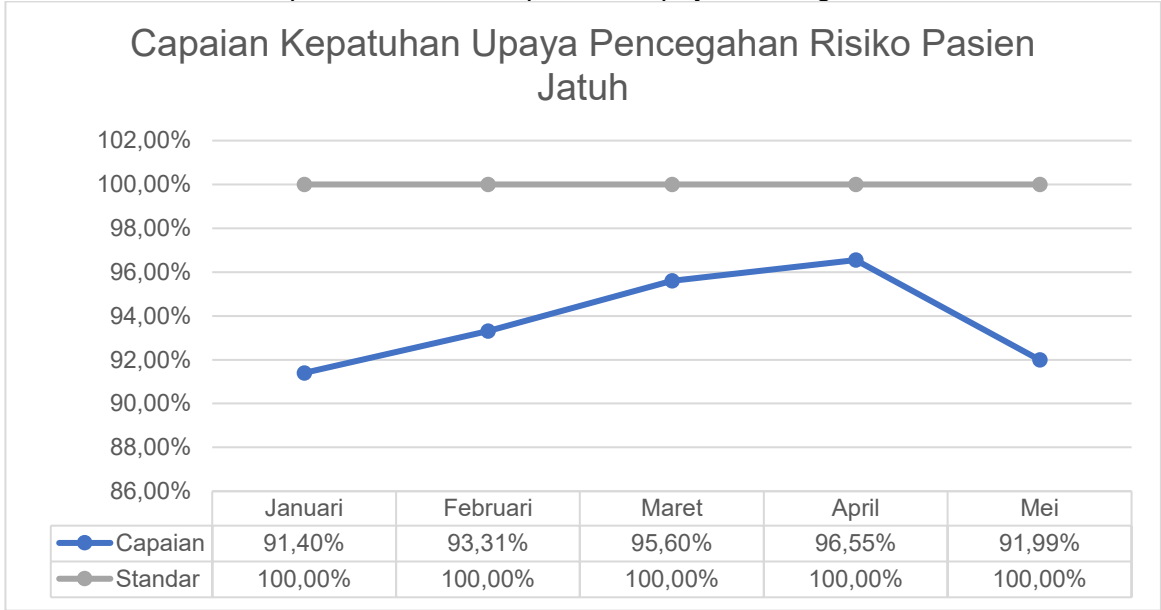
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problem</b> | Capaian kepatuhan terhadap alur klinis ( <i>Clinical Pathway</i> ) pada bulan Mei 2026 sebesar <b>65,22%</b> , meningkat <b>11,89%</b> dibandingkan bulan April yang mencapai <b>53,33%</b> . Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah standar <b>80%</b> , dengan gap sebesar <b>14,78%</b> .<br>Belum tercapainya standar disebabkan masih adanya ketidakpatuhan dalam pengisian dan penggunaan <i>Clinical Pathway</i> , terutama pada kasus tuberkulosis yang hanya mencapai kepatuhan <b>33,33%</b> . Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain kurangnya pemahaman petugas, keterbatasan waktu dalam pengisian dokumen, serta monitoring dan evaluasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan terhadap <i>Clinical Pathway</i> . |
| <b>Plan</b>    | Meningkatkan capaian kepatuhan terhadap alur klinis agar memenuhi standar yang ditetapkan (80%) dengan sosialisasi kembali mengenai penggunaan alur klinis, peningkatan monitoring kepatuhan pengisian oleh kepala ruangan atau PJ Mutu Unit, serta koordinasi dengan Komite Medik dan DPJP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Do</b>      | Komite Mutu bersama Komite Medik melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan alur klinis dalam pelayanan pasien. Selain itu dilakukan pengingat kepada DPJP dan petugas terkait untuk mengisi alur klinis sesuai diagnosis yang telah ditentukan. Kepala unit rawat inap juga diminta melakukan monitoring kelengkapan pengisian alur klinis pada rekam medis pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Study</b>   | Capaian kepatuhan terhadap alur klinis ( <i>Clinical Pathway</i> ) pada bulan Mei 2026 sebesar <b>65,22%</b> , meningkat <b>11,89%</b> dibandingkan bulan April yang mencapai <b>53,33%</b> . Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah standar <b>80%</b> , dengan gap sebesar <b>14,78%</b> . Upaya yang dilakukan untuk menaikkan capaian tersebut adalah meningkatkan monitoring oleh kepala ruangan dan kabid pelayanan medis. Selanjutnya, upaya tersebut dapat terus ditingkatkan agar semakin mendorong tercapainya kepatuhan terhadap alur klinis untuk dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Action</b>  | 1. Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis (clinical pathway)<br>2. Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabel Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana Kegiatan                                                              | Tujuan                                                                                                           | Sasaran                        | Strategik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                   | Waktu     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Sosialisasi terkait pengisian dokumen alur klinis ( <i>clinical pathway</i> ) | Meningkatkan kepatuhan pengisian dokumen alur klinis                                                             | Seluruh tenaga medis pelayanan | Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan penggunaan alur klinis. Komite Medik bersama Komite Mutu akan melakukan penguatan implementasi clinical pathway kepada DPJP serta melakukan supervisi terhadap pengisian dokumen alur klinis dalam rekam medis pasien. Selain itu, akan dilakukan evaluasi berkala serta pemberian umpan balik kepada unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap alur klinis sehingga capaian indikator dapat mencapai standar yang ditetapkan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Medik</li> <li>• Komite Mutu</li> <li>• Kabid Pelayanan Medis</li> </ul>                                                                                                    | 1 bulan   |
| 2  | Diskusi dengan PPA dalam fiksasi alur klinis yang dilakukan                   | Mendapatkan alur klinis yang telah disepakai oleh semua PPA sehingga PPA akan memberikan perawatan yang seragam. | Seluruh PPA                    | Rumah sakit akan melakukan penyamaan persepsi antar PPA mengenai alur pelayanan dan tahapan tindakan klinis sesuai SPO atau clinical pathway yang berlaku dan penguatan koordinasi dan komunikasi efektif antar PPA untuk memastikan kesinambungan pelayanan pasien                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Medik</li> <li>• Komite Mutu</li> <li>• Kabid Pelayanan Medis</li> <li>• Komite Keperawatan</li> <li>• Kepala Instalasi Gizi</li> <li>• Kepala Instalasi Farmasi</li> </ul> | 1-2 bulan |

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Pada bulan Mei 2026, capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebesar **91,99%**. Berdasarkan hasil monitoring, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar **4,56%** dibandingkan bulan April. Meskipun masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, hasil ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu **100%**. Penurunan capaian tersebut menyebabkan kesenjangan (gap) terhadap standar semakin besar, yaitu mencapai **8,01%**. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kepatuhan melalui penguatan supervisi, sosialisasi ulang terkait pencegahan risiko pasien jatuh, pemberian umpan balik hasil monitoring kepada unit terkait, serta evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Unit yang telah memenuhi standar (100%) antara lain IRNA 2C, IRNA 6A, IRNA 7A, IRNA 8A, dan Neonatologi. Sementara itu, unit yang memiliki capaian terendah berasal dari unit IRNA 2A.

| Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                           | Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Mei 2026 sebesar <b>91,99%</b> . Capaian ini mengalami penurunan sebesar <b>4,56%</b> dibandingkan bulan April yang mencapai <b>96,55%</b> . Meskipun angka kepatuhan masih tergolong tinggi, capaian tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu <b>100%</b> , sehingga terdapat <b>gap sebesar 8,01%</b> terhadap target. Penurunan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan risiko pasien jatuh masih belum optimal. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi antara lain |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | kepatuhan petugas dalam menerapkan intervensi pencegahan risiko jatuh yang belum konsisten, edukasi kepada pasien dan keluarga yang belum dilakukan secara optimal, serta monitoring dan dokumentasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh yang belum lengkap. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi berkelanjutan, serta evaluasi rutin untuk memastikan seluruh tindakan pencegahan risiko jatuh dilaksanakan sesuai standar.                                                                                                                                   |
| Plan   | Meningkatkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh agar memenuhi standar 100% dengan sosialisasi ulang SOP pencegahan risiko jatuh dan audit kepatuhan pencegahan risiko jatuh secara rutin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Do     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pengkajian risiko jatuh pada pasien saat masuk dan berkala</li> <li>- Pemberian tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)</li> <li>- Penerapan intervensi pencegahan sesuai tingkat risiko</li> <li>- Edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Study  | Capaian bulan Mei mengalami penurunan sebesar 4,56% dari bulan sebelumnya. Pada bulan April, capaian mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi berupa edukasi pasien dan keluarga tentang pencegahan jatuh dan monitoring pemasangan pemberian tanda risiko jatuh dari bulan Maret. Adanya peningkatan capaian pada bulan April menunjukkan bahwa upaya intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh. Upaya tersebut dapat terus dilakukan untuk semakin meningkatkan capaian sehingga mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. |
| Action | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh</li> <li>2. Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabel Rencana Tindak Lanjut

| No | Rencana Kegiatan                                                                       | Tujuan                                                                                             | Sasaran                                          | Strategik                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pelaksana                                                                                                            | Waktu         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh | Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan | Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap</li> <li>• Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster</li> <li>• Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh</li> <li>• Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat ruangan</li> <li>• Kepala ruangan</li> <li>• Komite Mutu</li> </ul> | Berkelanjutan |
| 2  | Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)                         | Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh                                | Perawat dan tenaga kesehatan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat ruangan</li> <li>• Kepala ruangan</li> <li>• Komite Mutu</li> </ul> | Berkelanjutan |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit kepatuhan secara berkala</li> <li>• Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian</li> <li>• Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



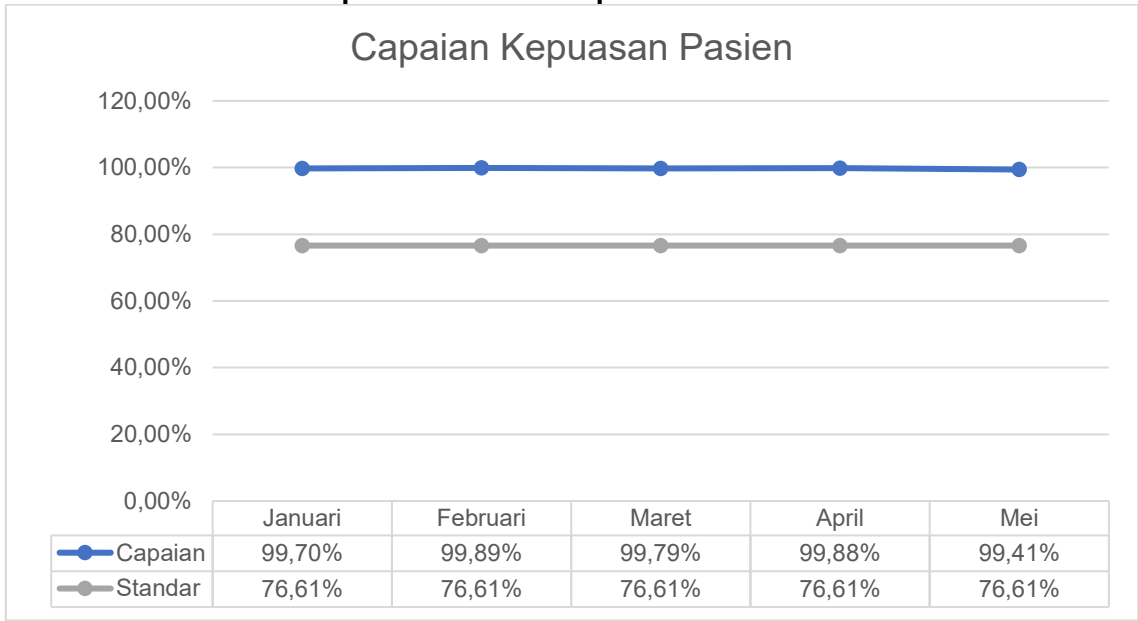
**Analisis:**

Pada bulan Mei 2026, capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain di Rumah Sakit Prima Husada Malang mencapai 100% dan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Capaian ini juga berhasil dipertahankan selama empat bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi rumah sakit dalam memberikan respons cepat terhadap setiap komplain yang diterima. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara PIPP dengan manajemen rumah sakit dalam melakukan tindak lanjut komplain secara cepat dan tepat. Selain itu, tersedianya mekanisme pelaporan komplain yang mudah diakses melalui PIPP, telepon, WhatsApp, maupun formulir online turut meningkatkan efektivitas penerimaan dan penanganan komplain pasien. Dukungan sumber daya manusia yang telah terlatih dalam manajemen komplain serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam tercapainya indikator ini. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien.



3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



**Analisis:**  
Pada bulan Mei 2026, capaian indikator kepuasan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang sebesar 99,41%, mengalami penurunan sebesar 0,47% dibandingkan bulan sebelumnya. Hasil tersebut telah melampaui standar yang ditetapkan yaitu  $\geq 76,61\%$ , sehingga menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik.

### 3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

| No. | Judul Indikator                                                                           | Bulan  |        |        |        |        |     |     |     |     |     |     |     | Standar | Rata-Rata | Keterangan    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|---------------|
|     |                                                                                           | Jan    | Feb    | Mar    | Apr    | Mei    | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |         |           |               |
| 1.  | Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi) | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 100%      | Dipertahankan |
| 2.  | Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)                                    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 100%      | Dipertahankan |
| 3.  | Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap              | 92,42% | 92,14% | 92,90% | 92,83% | 93,06% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 92,67%    | PDSA          |
| 4.  | Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)                                                  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 97.78% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 100%      | Dipertahankan |
| 5.  | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)                         | 85,05% | 85,70% | 85,91% | 86,59% | 83,10% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 85,27%    | PDSA          |
| 6.  | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)                | -      | 87,11% | 92,08% | 98,42% | 90,16% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 91,94%    | PDSA          |

### Analisis:

Berdasarkan Tabel 3.10, terdapat enam indikator sasaran keselamatan pasien yang dimonitor. Dari keenam indikator tersebut, dua indikator berhasil mencapai dan mempertahankan standar 100%, sedangkan empat indikator lainnya masih memerlukan upaya perbaikan melalui siklus PDSA.

1. **Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (Farmasi)** mencapai **100%** pada bulan Mei 2026. Capaian ini konsisten dipertahankan sejak Januari hingga Mei dan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten oleh petugas farmasi.
2. **Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi** juga mencapai **100%** dan berhasil dipertahankan selama lima bulan berturut-turut. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan hasil kritis radiologi telah berjalan sesuai prosedur sehingga mendukung keselamatan pasien melalui penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
3. **Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di rawat inap** mencapai **93,06%**, mengalami peningkatan dibandingkan bulan April yang sebesar 92,83%. Meskipun menunjukkan tren perbaikan, capaian tersebut masih berada di bawah standar 100%, dengan rata-rata capaian sebesar **92,67%**. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelabelan obat LASA dan High Alert yang berpotensi meningkatkan risiko medication error, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut melalui PDSA.
4. **Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)** pada bulan Mei mencapai **97,78%**, mengalami sedikit penurunan dibandingkan empat bulan sebelumnya yang konsisten mencapai 100%. Meskipun capaian bulan Mei belum memenuhi standar, rata-rata capaian tetap mencapai **100%** sehingga indikator ini masih dikategorikan dipertahankan. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyebab ketidakpatuhan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
5. **Kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan** mencapai **83,10%** pada bulan Mei, mengalami penurunan dibandingkan bulan April yang mencapai 86,59%. Capaian ini berada di bawah standar minimal 100% dengan rata-rata capaian sebesar **85,27%**. Penurunan tersebut menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan petugas dalam melaksanakan kebersihan tangan sesuai prosedur, sehingga diperlukan penguatan edukasi, supervisi, dan monitoring secara berkelanjutan melalui siklus PDSA.
6. **Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, dan IKO)** mencapai **90,16%** pada bulan Mei, mengalami penurunan dibandingkan bulan April yang mencapai 98,42%. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan bulan-bulan awal pengukuran, capaian tersebut masih belum memenuhi standar 100% dengan rata-rata capaian sebesar **91,94%**. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ketidakpatuhan dalam penerapan upaya pencegahan risiko jatuh pasien, sehingga diperlukan tindak lanjut melalui PDSA untuk meningkatkan kepatuhan petugas.

Secara keseluruhan, terdapat **dua indikator yang berhasil dipertahankan** karena konsisten mencapai standar, yaitu kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan dan kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi. Sementara itu, **empat indikator lainnya masih memerlukan perbaikan melalui siklus PDSA**, terutama pada aspek pelabelan obat LASA dan High Alert, kepatuhan cuci tangan, serta pencegahan risiko jatuh pasien, agar seluruh indikator

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

| No. | Judul Indikator                                                                | Bulan |       |        |        |       |     |     |     |     |     |     |     | Standar | Rata-Rata | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|------------|
|     |                                                                                | Jan   | Feb   | Mar    | Apr    | Mei   | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |         |           |            |
| 1.  | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap) | -     | 7,08% | 12,50% | 11,9%  | 3,53% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 8,75%     | PDSA       |
| 2.  | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)      | -     | 12,1% | 21,48% | 12,34% | 3,5%  |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 12,36%    | PDSA       |
| 3.  | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)                                    | -     | 8,31% | 12,05% | 17,94% | 4,94% |     |     |     |     |     |     |     | 100%    | 10,81%    | PDSA       |

Analisis:

Berdasarkan Tabel 3.11, seluruh indikator mutu pelayanan klinis prioritas pada pasien Diabetes Melitus (DM) dengan ulkus masih belum mencapai standar yang ditetapkan sebesar **100%**. Bahkan pada bulan Mei 2026 seluruh indikator mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga memerlukan tindak lanjut melalui siklus **PDSA**.

- 1. **Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planning Pasien DM dengan Ulkus (Rawat Inap)** pada bulan Mei mencapai **3,53%**, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan bulan April yang sebesar **11,90%**. Rata-rata capaian selama periode pengukuran sebesar **8,75%**, masih jauh di bawah standar yang ditetapkan. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa dokumentasi discharge planning pada pasien DM dengan ulkus belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi kesinambungan pelayanan dan edukasi pasien setelah pulang dari rumah sakit.
- 2. **Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada Pasien DM dengan Ulkus (Rawat Inap)** mencapai **3,50%** pada bulan Mei, menurun dibandingkan bulan April yang sebesar **12,34%**. Dengan rata-rata capaian sebesar **12,36%**, indikator ini juga masih jauh dari target 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses dokumentasi edukasi kepada pasien DM dengan ulkus belum dilaksanakan secara konsisten, sehingga perlu dilakukan penguatan kepatuhan petugas dalam memberikan dan mendokumentasikan edukasi pasien.
- 3. **Kepatuhan PPK dan Clinical Pathway (CP) Pasien DM (Rawat Inap)** pada bulan Mei mencapai **4,94%**, mengalami penurunan dibandingkan bulan April yang mencapai **17,94%**. Rata-rata capaian indikator ini sebesar **10,81%**, masih jauh di bawah standar yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi serta kelengkapan dokumentasi PPK dan Clinical Pathway pasien DM belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan petugas.

Secara keseluruhan, ketiga indikator mutu pelayanan klinis prioritas menunjukkan capaian yang masih sangat rendah dan belum memenuhi standar. Selain itu, seluruh indikator mengalami penurunan pada bulan Mei dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya perbaikan yang lebih intensif melalui sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan, penguatan monitoring dan supervisi, penyederhanaan proses dokumentasi apabila diperlukan, serta pemberian umpan balik hasil evaluasi secara berkala agar kepatuhan terhadap standar pelayanan klinis pada pasien DM dengan ulkus dapat meningkat.

3.4 Tujuan Strategis

| NO | Judul Indikator                                             | Bulan   |         |         |         |         |         |          |           |          |         |         |         | Standar | Rata-Rata | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
|    |                                                             | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | Mei '26 | Jun '26 | Juli '26 | Agust '26 | Sept '26 | Okt '26 | Nov '26 | Des '26 |         |           |            |
| 1. | Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i> | 5       | 1       | 3       | 11      | 7       |         |          |           |          |         |         |         | 0       | 5,4       | PDSA       |

Analisis:

Pada bulan Mei 2026, jumlah kejadian komplain pasien/keluarga yang disampaikan melalui Google Review tercatat sebanyak **7 komplain**. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan bulan April yang mencapai **11 komplain**, namun masih berada di atas standar yang ditetapkan yaitu **0 komplain**. Dengan demikian, target indikator belum tercapai dan masih diperlukan upaya perbaikan melalui siklus **PDSA**.

Selama periode Januari hingga Mei 2026, jumlah komplain yang diterima bersifat fluktuatif, yaitu 5 komplain pada Januari, 1 komplain pada Februari, 3 komplain pada Maret, meningkat menjadi 11 komplain pada April, dan menurun menjadi 7 komplain pada Mei. Rata-rata jumlah komplain selama periode tersebut adalah **5,4 komplain per bulan**.

Meskipun terjadi penurunan jumlah komplain pada bulan Mei, masih adanya komplain yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga menunjukkan bahwa terdapat aspek pelayanan yang belum memenuhi harapan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap isi dan penyebab komplain untuk mengidentifikasi area pelayanan yang perlu diperbaiki. Tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain melakukan evaluasi terhadap jenis komplain yang paling sering muncul, meningkatkan respons terhadap keluhan pelanggan, memperkuat komunikasi dan edukasi kepada pasien serta keluarga, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas perbaikan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan kepuasan pasien dan menurunkan jumlah komplain di masa mendatang.

3.5 Perbaikan Sistem

| No | Judul Indikator                                | Bulan   |         |         |         |         |         |         |           |          |         |         |         | Standar | Rata-Rata | Keterangan    |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
|    |                                                | Jan '26 | Feb '26 | Mar '26 | Apr '26 | Mei '26 | Jun '26 | Jul '26 | Agust '26 | Sept '26 | Okt '26 | Nov '26 | Des '26 |         |           |               |
| 1. | Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |         |         |           |          |         |         |         | 100%    | 100%      | Dipertahankan |
| 2. | Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit | 89,62%  | 82,66%  | 83,15%  | 86,44%  | 90,75%  |         |         |           |          |         |         |         | 100%    | 86.52%    | PDSA          |

Analisis:

Berdasarkan data pada tabel, terdapat dua indikator mutu yang dimonitor, yaitu kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat dan waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit.

- 1. **Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat** pada bulan Mei 2026 mencapai **100%**. Capaian ini berhasil dipertahankan secara konsisten sejak Januari hingga Mei 2026 dan telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa petugas telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan alat sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat mendukung ketersediaan serta keandalan alat dalam pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, indikator ini termasuk dalam kategori **dipertahankan**.
- 2. **Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit** pada bulan Mei 2026 mencapai **90,75%**, mengalami peningkatan dibandingkan bulan April yang sebesar **86,44%**. Capaian ini merupakan yang tertinggi selama periode Januari–Mei 2026, menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelayanan farmasi. Namun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu **100%**, sehingga masih terdapat gap sebesar **9,25%**. Rata-rata capaian indikator selama periode pengukuran sebesar **86,52%**. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasien yang menerima obat racikan dengan waktu tunggu melebihi 60 menit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan, seperti beban kerja petugas, jumlah resep racikan, alur pelayanan, maupun ketersediaan sumber daya, sehingga dapat dilakukan perbaikan melalui siklus **PDSA**.

Secara keseluruhan, terdapat **satu indikator yang berhasil dipertahankan**, yaitu kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat, dan **satu indikator yang masih memerlukan tindak lanjut melalui PDSA**, yaitu waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit, agar dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

### 3.6 Hasil Kegiatan Mutu Prioritas Unit

#### 3.6.1 Instalasi Gawat Darurat

Tabel 3.1 Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gawat Darurat bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                       | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                           | 83,55% | ≥ 85%      | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                        | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                         | 97,16% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit             | 100%   | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                        | 97,16% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)   | 87,95% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)     | 77,86% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                           | Ketidaklengkapan e-rm pengkajian awal IGD dan SPRI                    | 1,27%  | 0%         | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD                            | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

#### 3.6.2 IRNA 2A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                     | Mei    | Standar | Keterangan             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                         | 86,28% | ≥ 85%   | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                      | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                       | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                       | 100%   | ≥ 80%   | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                      | 29,89% | 100%    | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 84,62% | 100%    | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda                   | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |

|                                      |                                                                                                |        |            |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
|                                      | brankar (SKP 6)                                                                                |        |            |                        |
| 3                                    | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | 7,07%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                    | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | 7,07%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| 5                                    | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | 9,24%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                    | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 0%     | 0%         | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 48,91% | 0%         | Belum mencapai standar |

### 3.6.3 IRNA 2C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2C bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei                 | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                    | 86,94%              | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | 87,59%              | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                            | 87,04%              | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 4                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 5                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0                   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 0%                  | 0%         | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 0%                  | 0%         | Sudah mencapai standar |



### 3.6.4 IRNA 3A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei              | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |                  |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 100%             | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| 3                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | Tidak ada pasien | ≥ 80%      | -                      |
| 4                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |                  |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| 2                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| 4                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | Tidak ada pasien | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |                  |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | Tidak ada pasien | 0 kejadian | -                      |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | Tidak ada pasien | 0%         | -                      |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | Tidak ada pasien | 0%         | -                      |

### 3.6.5 IRNA 3C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3C bulan Mei Tahun 2026

| No                             | Judul Indikator                                | Mei    | Standar | Keterangan             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b> |                                                |        |         |                        |
| 1                              | Kepatuhan kebersihan tangan                    | 83,20% | ≥ 85%   | Belum mencapai standar |
| 2                              | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 3                              | Kepatuhan identifikasi pasien                  | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 4                              | Kepatuhan waktu visite dokter                  | 100%   | ≥ 80%   | Sudah mencapai standar |

|                                             |                                                                     |        |            |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                      | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 78,43% | 100%       |                        |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)   | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                     | 0%     | 0%         | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap            | 0%     | 0%         | Sudah mencapai standar |

### 3.6.6 IRNA 4A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 4A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                    | 85,00% | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | 90,27% | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | 51,14% | 100%       |                        |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                            | 88,89% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 72,67% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | 0,86%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | 0,85%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | 0,85%  | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 0%     | 0%         | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 9,58%  | 0%         | Belum mencapai standar |

3.6.7 IRNA 5C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 5C bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei                 | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                    | 86,23%              | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 90,97%              | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | 89,23%              | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | 82,68%              | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | 96,09%              | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                            | 92,59%              | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 4                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 5                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0                   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 10,62%              | 0%         | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 4,27%               | 0%         | Belum mencapai standar |

3.6.8 IRNA 6A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 6A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                      | Mei    | Standar | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                      |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                          | 82,76% | ≥ 85%   | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)       | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                        | 89,23% | 100%    | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                        | 82,68% | ≥ 80%   | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh       | 96,09% | 100%    | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                      |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci | 85,37% | 100%    | Belum mencapai standar |

|                                      |                                                                                                |                     |            |                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|
|                                      | tangan (SKP 5)                                                                                 |                     |            |                        |
| 2                                    | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 100%                | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 4                                    | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| 5                                    | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | Tidak ada pasien DM | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                                                                |                     |            |                        |
| 1                                    | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0                   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 21,67%              | 0%         | Belum mencapai standar |
| 3                                    | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 0%                  | 0%         | Sudah mencapai standar |

### 3.6.9 IRNA 7A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 7A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                    | 83,24% | ≥ 85%      | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | 79,49% | ≥ 80%      | Belum mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                            | 86,76% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | 75%    | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | 75%    | 100%       | Belum mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | 83,33% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |        |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

|   |                                                          |        |    |                        |
|---|----------------------------------------------------------|--------|----|------------------------|
| 2 | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite          | 24,89% | 0% | Belum mencapai standar |
| 3 | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap | 26%    | 0% | Belum mencapai standar |

### 3.6.10 IRNA 8A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 8A bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                | Mei                              | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                |                                  |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                    | 84,45%                           | ≥ 85%      | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                 | 89,52%                           | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                  | 100%                             | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                                                  | 88,73%                           | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                                 | 100%                             | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                |                                  |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                            | 87,27%                           | 100%       | Belum mencapai standar |
| 1                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                              | 100%                             | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas) | 100%                             | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)      | Tidak ada pasien DM dengan ulkus | 100%       | -                      |
| 4                                           | Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)                                    | Tidak ada pasien DM dengan ulkus | 100%       | -                      |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                |                                  |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                                                           | 0                                | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                                                | 11,27%                           | 0%         | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap                                       | 12,37%                           | 0%         | Belum mencapai standar |

3.6.11 ICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit ICU bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                            | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                            |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                | 91,33% | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                             | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                              | 94,44% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                              | 100%   | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                             | 94,44% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                            |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)        | 88,76% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)          | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                            |        |            |                        |
| 1                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU                  | 1,82%  | 0%         | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kejadian kesalahan saat hand over (serah terima)                           | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pasien                          | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam | 0%     | <3%        | Sudah mencapai standar |

3.6.12 PICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PICU bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                   | Mei  | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                   |      |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                    | 100% | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                     | 100% | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan waktu visite dokter                                     | 100% | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                    | 100% | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                   |      |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6) | 100% | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                   |      |            |                        |
| 1                                           | Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP                              | 0    | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

|   |                                                          |    |    |                        |
|---|----------------------------------------------------------|----|----|------------------------|
| 2 | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite          | 0% | 0% | Sudah mencapai standar |
| 3 | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap | 0% | 0% | Sudah mencapai standar |

### 3.6.13 Instalasi Rawat Jalan

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRJA bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                                  | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                                  |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                                      | 100%   | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                                   | 97,51% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                                    | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Waktu tunggu rawat jalan                                                                         | 95,98% | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                                  |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                              | 82,98% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                                  |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan DPJP terhadap jadwal Praktek                                                           | 85,66% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja                                               | 2,46%  | 0%         | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Target Pasien PRB dan iterasi                                                                    | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

### 3.6.14 Fisioterapi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Fisioterapi bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                                   | Mei | Standar    | Keterangan             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                                                   |     |            |                        |
| 1                                    | Kegagalan pelaksanaan layanan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Pelayanan tidak sesuai program terapi                                             | 0%  | 0 %        | Sudah mencapai standar |

### 3.6.15 Maternitas

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Maternitas bulan Mei Tahun 2026

| No                             | Judul Indikator                                | Mei    | Standar | Keterangan             |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b> |                                                |        |         |                        |
| 1                              | Kepatuhan kebersihan tangan                    | 91,20% | ≥ 85%   | Sudah mencapai standar |
| 2                              | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |

|                                             |                                                                     |        |            |                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                       | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit           | 100%   | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                       | 87,27% | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| 6                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                      | 95,45% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 87,32% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)   | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas            | 17,27% | 0%         | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Angka kematian ibu                                                  | 0%     | 0%         | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kejadian perdarahan post partum                                     | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Angka kejadian partus macet                                         | 4,7%   | < 10%      | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kejadian eklamsi                                                    | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 6                                           | Kejadian pre eklamsi                                                | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 7                                           | Kejadian infeksi nifas                                              | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 8                                           | Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite                     | 12,73% | 0%         | Belum mencapai standar |

### 3.6.16 Neonatologi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Neonatologi bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                     | Mei    | Standar | Keterangan             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                         | 90,77% | ≥ 85%   | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                      | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                       | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan Waktu Visite Dokter                                       | 89,36% | ≥ 80%   | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                      | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 98,08% | 100%    | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)   | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Angka Kematian Bayi                                                 | 1,18%  | 0%      | Sudah mencapai standar |



|   |                                                                        |   |            |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------|
| 2 | Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi | 0 | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 3 | Kejadian SHK yang di tolak Dinkes                                      | 0 | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

3.6.17 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IKO bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                                          | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Nasional              |                                                                                          |        |            |                        |
| 1                                    | Kepatuhan kebersihan tangan                                                              | 94,80% | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                           | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Kepatuhan identifikasi pasien                                                            | 97,78% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                    | Penundaan operasi elektif                                                                | 0%     | ≤ 5%       | Sudah mencapai standar |
| 5                                    | Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh                                           | 97,78% | 100%       | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit |                                                                                          |        |            |                        |
| 1                                    | Kepatuhan penandaan lokasi operasi (SKP 4)                                               | 97,78% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                      | 90,24% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                    | Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)                        | 97,78% | 100%       | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Unit        |                                                                                          |        |            |                        |
| 1                                    | Kejadian re operasi                                                                      | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO | 2,52%  | 0%         | Belum mencapai standar |
| 3                                    | Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA       | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

3.6.18 Instalasi Laboratorium

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Laboratorium bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                      | Mei    | Standar | Keterangan             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| Indikator Mutu Nasional              |                                                      |        |         |                        |
| 1                                    | Kepatuhan kebersihan tangan                          | 83,00% | ≥ 85%   | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)       | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Kepatuhan identifikasi pasien                        | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| 4                                    | Pelaporan hasil kritis laboratorium                  | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit |                                                      |        |         |                        |
| 1                                    | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci | 77,50% | 100%    | Belum mencapai standar |

|                                      |                                                             |        |            |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
|                                      | tangan (SKP 5)                                              |        |            |                        |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                             |        |            |                        |
| 1                                    | Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi | 69     | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi" | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah            | 93,94% | 100%       | Belum mencapai standar |

### 3.6.19 Instalasi Radiologi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Radiologi bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                     | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                         | 83,89% | ≥ 85%      | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                      | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                       | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (SKP 2)                  | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 90,74% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                     |        |            |                        |
| 1                                           | Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien | 9      | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi       | 32     | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.20 Instalasi Gizi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gizi bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                     | Mei    | Standar | Keterangan             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                         | 75,46% | ≥ 85%   | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                      | 95,57% | 100%    | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                       | 100%   | 100%    | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 33,33% | 100%    | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                     |        |         |                        |

|   |                                                                        |       |            |                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|
| 1 | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan | 66,7% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2 | Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji                             | 100%  | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3 | Angka kelengkapan pengkajian gizi                                      | 99,7% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4 | Kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap               | 1     | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 5 | Kejadian adanya benda asing dalam makanan                              | 1     | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 6 | Kejadian makanan basi                                                  | 0     | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.21 Instalasi Farmasi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Farmasi bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                                                         | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Nasional</b>              |                                                                                         |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan kebersihan tangan                                                             | 86,20% | ≥ 85%      | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                                          | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan identifikasi pasien                                                           | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 4                                           | Kepatuhan penggunaan formularium nasional                                               | 85,81% | ≥ 80%      | Sudah mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                                                         |        |            |                        |
| 1                                           | Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (SKP 1) | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 2                                           | Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert di rawat inap (SKP 3)   | 93,06% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 3                                           | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)                     | 81,82% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Waktu tunggu obat racikan < 60 menit (Perbaikan Sistem)                                 | 90,75% | 100%       | Belum mencapai standar |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                                                         |        |            |                        |
| 1                                           | Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit                          | 41,14% | 0%         | Belum mencapai standar |
| 2                                           | Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap                                           | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 3                                           | Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat                                                       | 1      | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 4                                           | Kejadian Kesalahan Pemberian Obat                                                       | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 5                                           | Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat                                                | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 6                                           | Kejadian Kesalahan Input E-Resep                                                        | 1      | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

3.6.22 Pengadaaan Farmasi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Pengadaaan Farmasi bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                    | Mei   | Standar | Keterangan             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                    |       |         |                        |
| 1                             | Keterlambatan sediaan farmasi datang               | 0%    | 0%      | Sudah mencapai standar |
| 2                             | Kesalahan pembelian sediaan farmasi                | 0%    | 0%      | Sudah mencapai standar |
| 3                             | Angka selisih stok opname                          | 0,64% | 0%      | Belum mencapai standar |
| 4                             | Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam | 100%  | 100%    | Sudah mencapai standar |

3.6.23 Komite PPI

Tabel Capaian Indikator Mutu Komite PPI bulan Mei Tahun 2026

| No                              | Judul Indikator                                        | Mei   | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Komite |                                                        |       |            |                        |
| 1                               | IDO (Infeksi Daerah Operasi)                           | 0%    | ≤ 2 %      | Sudah mencapai standar |
| 2                               | IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)                     | 0%    | ≤ 3,5‰     | Sudah mencapai standar |
| 3                               | VAP (Ventilation Associated Pneumonia)                 | 0%    | ≤ 5,8 ‰    | Sudah mencapai standar |
| 4                               | ISK (Infeksi Saluran Kencing)                          | 0%    | ≤ 4,7 ‰    | Sudah mencapai standar |
| 5                               | Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)          | 0,32% | ≤ 5 %      | Sudah mencapai standar |
| 6                               | Angka Decubitus                                        | 2,5%  | 0%         | Belum mencapai standar |
| 7                               | Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan) | 0     | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

3.6.24 SDM

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit SDM bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                           | Mei   | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                           |       |            |                        |
| 1                             | Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK | 0     | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                             | Angka turn over staf                      | 1,38% | 0%         | Belum mencapai standar |

3.6.25 Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran)

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran) bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                       | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                       |     |            |                        |
| 1                             | Kesalahan pendaftaran pasien                          | 32  | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 2                             | Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

|   |                                                                     |   |            |                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------|
|   | E-PLKK                                                              |   |            |                        |
| 3 | Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI | 0 | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

### 3.6.26 K3RS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit K3RS bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator               | Mei | Standar | Keterangan |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                               |     |         |            |
| 1                                    | Ketidakpatuhan pembuatan PCRA |     | 0%      |            |

### 3.6.27 IPSRS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IPSRS bulan Mei Tahun 2026

| No                                          | Judul Indikator                                              | Mei | Standar    | Keterangan |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit</b> |                                                              |     |            |            |
| 1                                           | Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat (Manajemen Risiko) |     | 100%       |            |
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b>        |                                                              |     |            |            |
| 1                                           | Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit |     | 100%       |            |
| 2                                           | Kejadian kerusakan sarana prasarana                          |     | 0 kejadian |            |

### 3.6.28 Asuransi Center

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Asuransi Center bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                         | Mei       | Standar              | Keterangan             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                         |           |                      |                        |
| 1                                    | Waktu Pengajuan Klaim                   | Tanggal 5 | Tanggal 5 awal bulan | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Klaim pending RJTL                      | 11,4%     | <0,1%                | Belum mencapai standar |
| 3                                    | Klaim pending RITL                      | 6,6%      | <1%                  | Belum mencapai standar |
| 4                                    | Klaim tidak layak                       |           | 0%                   |                        |
| 5                                    | Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL     |           | < Rp1.000.000        |                        |
| 6                                    | Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL     |           | < Rp5.000.000        |                        |
| 7                                    | Nilai selisih negatif klaim RJTL        |           | < Rp50.000.000       |                        |
| 8                                    | Nilai selisih negatif klaim RITL        |           | < Rp100.000.000      |                        |
| 9                                    | Persentase readmisi pasien rawat inap   | 2,4%      | 0%                   | Belum mencapai standar |
| 10                                   | Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS | 67%       | 100%                 | Belum mencapai standar |

3.6.29 PIPP

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PIPP bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                       | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Nasional              |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                    | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain                                      | 100%   | 80%        | Sudah mencapai standar |
| 2                                    | Kepuasan Pasien                                                       | 99,41% | ≥ 76,61%   | Sudah mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                    | Kejadian komplain pasien/keluarga di google review (Tujuan Strategis) | 7      | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Unit        |                                                                       |        |            |                        |
| 1                                    | Angka Kepuasan Pasien Peserta BPJS                                    | 99,91% | 100%       | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN                       | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |
| 3                                    | Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN                          | 100%   | 100%       | Sudah mencapai standar |

3.6.30 Cleaning Service

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Cleaning Service bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                     | Mei    | Standar | Keterangan             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| Indikator Mutu Nasional              |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                    | Kepatuhan kebersihan tangan                                         | 84,72% | ≥ 85%   | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)                      | 92,42% | 100%    | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                    | Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5) | 66,67% | 100%    | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Unit        |                                                                     |        |         |                        |
| 1                                    | Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit                       | 92,39% | ≥ 90%   | Sudah mencapai standar |

3.6.31 Kesekretariatan

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kesekretariatan bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                                          | Mei             | Standar | Keterangan |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                                          |                 |         |            |
| 1                             | Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS (saat akhir rapat) | Tidak ada rapat | 0%      | -          |

3.6.32 CSSD & Laundry

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit CSSD & Laundry bulan Mei Tahun 2026

| No                                    | Judul Indikator                                     | Mei    | Standar    | Keterangan             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Nasional               |                                                     |        |            |                        |
| 1                                     | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)      | 79,03% | 100%       | Belum mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry |                                                     |        |            |                        |
| 1                                     | Kejadian linen ruang perawatan hilang               | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                                     | Kejadian tercampur benda asing                      | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD    |                                                     |        |            |                        |
| 1                                     | Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril       | 1      | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 2                                     | Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang | 0      | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |

3.6.33 IT

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IT bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                      | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                      |     |            |                        |
| 1                             | Kejadian CCTV tidak terecord         | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                             | Kejadian komputer dan internet lemot | 22  | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

3.6.34 Kamar Jenazah

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kamar Jenazah bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                | Mei | Standar | Keterangan             |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|---------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                |     |         |                        |
| 1                             | Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah | 0%  | 0%      | Sudah mencapai standar |

3.6.35 Driver

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kamar Driver bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                           | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                           |     |            |                        |
| 1                             | Kejadian permintaan driver yang bersamaan | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                             | Kejadian oncall driver                    | 3   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 3                             | Penggunaan ambulance luar RS              | 2   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.36 Security

Tabel Capaian Indikator Mutu Security bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                |     |            |                        |
| 1                             | Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 2                             | Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap | 29  | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.37 Gudang Umum

Tabel Capaian Indikator Mutu Gudang Umum bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                             | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                             |     |            |                        |
| 1                             | Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit | 3   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.38 Kasir

Tabel Capaian Indikator Mutu Kasir bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                           | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                           |     |            |                        |
| 1                             | Kesalahan pelunasan yang dilakukan                        | 1   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |
| 2                             | Keterlambatan pelunasan pembayaran                        | 0   | 0 kejadian | Sudah mencapai standar |
| 3                             | Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit | 10  | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.39 Humas

Tabel Capaian Indikator Mutu Humas bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                  | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                  |     |            |                        |
| 1                             | Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama | 1   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |

### 3.6.40 Primantara

Tabel Capaian Indikator Mutu Primantara bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                  | Mei | Standar    | Keterangan             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                  |     |            |                        |
| 1                             | Kejadian komplain keterlambatan pengantaran obat | 2   | 0 kejadian | Belum mencapai standar |



### 3.6.41 PKRS

Tabel Capaian Indikator Mutu PKRS bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                                            | Mei    | Standar | Keterangan             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                                                            |        |         |                        |
| 1                                    | Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi                                      | 66,67% | 100%    | Belum mencapai standar |
| 2                                    | Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi “Read Back” pada Instruksi Verbal | 83,3%  | 100%    | Belum mencapai standar |
| 3                                    | Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok                                  | 47,06% | 100%    | Belum mencapai standar |

### 3.6.42 PROGNAS KB

Tabel Capaian Indikator Mutu PROGNAS KB bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                                                                                                        | Mei | Standar | Keterangan |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                                                                                                        |     |         |            |
| 1                                    | Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP          |     | 100%    |            |
| 2                                    | Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran                                                        |     | 70%     |            |
| 3                                    | Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran |     | 0       |            |

### 3.6.43 PROGNAS TB

Tabel Capaian Indikator Mutu PROGNAS TB bulan Mei Tahun 2026

| No                                   | Judul Indikator                          | Mei | Standar | Keterangan |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----|---------|------------|
| <b>Indikator Mutu Prioritas Unit</b> |                                          |     |         |            |
| 1                                    | Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis |     | 100%    |            |

3.6.44 PROGNAS HIV

Tabel Capaian Indikator Mutu PROGNAS HIV bulan Mei Tahun 2026

| No                            | Judul Indikator                                                                            | Mei | Standar | Keterangan |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                                                            |     |         |            |
| 1                             | Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS |     | 100%    |            |

3.6.45 PROGNAS STUNTING

Tabel Capaian Indikator Mutu STUNTING HIV bulan Mei Tahun 2026

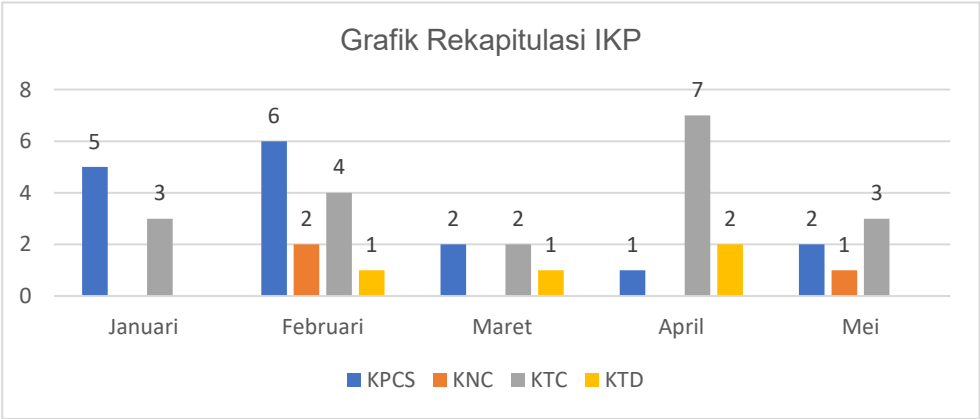
| No                            | Judul Indikator                                                                                                | Mei  | Standar | Keterangan             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|
| Indikator Mutu Prioritas Unit |                                                                                                                |      |         |                        |
| 1                             | Angka pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting                                            | 0%   | 100%    | Belum mencapai standar |
| 2                             | Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln) | 100% | 100%    | Sudah mencapai standar |

3.7 LAPORAN KEJADIAN IKP

Tabel Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

|           | KPC | KNC | KTC | KTD | SENTINEL | JUMLAH |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----------|--------|
| JANUARI   | 5   |     | 3   |     |          | 8      |
| FEBRUARI  | 6   | 2   | 4   | 1   |          | 13     |
| MARET     | 2   |     | 2   | 1   |          | 5      |
| APRIL     | 2   |     | 6   | 2   |          | 10     |
| MEI       | 2   | 1   | 3   |     |          | 6      |
| JUNI      |     |     |     |     |          |        |
| JULI      |     |     |     |     |          |        |
| AGUSTUS   |     |     |     |     |          |        |
| SEPTEMBER |     |     |     |     |          |        |
| OKTOBER   |     |     |     |     |          |        |
| NOVEMBER  |     |     |     |     |          |        |
| DESEMBER  |     |     |     |     |          |        |
| JUMLAH    | 16  | 3   | 19  | 4   |          | 41     |

Grafik Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden



### Laporan IKP Bulan Mei

| NO. | TGL KEJADIAN | STAF YG TERLIBAT |         | JENIS IKP | KRONOLOGI                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------|------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              | NAMA             | UNIT    |           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 6 Mei        |                  | IRNA 5C | KPCS      | Sonde pasien tidak ber-etiket karena adanya perubahan diit mendadak sehingga petugas gizi memberikan sediaan sonde yang dibawa dan belum diberikan label.                | 1. Larangan menaruh sonde tanpa etiket di nurse station meskipun untuk sementara                                                                                                                                                    |
| 2   | 7 Mei        |                  | IPSRS   | KPCS      | Lantai basah di depan UPS CT Scan bersumber dari tetesan sisa genangan air di ember alat AC yang ada di atas troli alat AC setelah melakukan pencucian di ruang operasi. | 1. Menghubungi CS untuk segera mengepel genangan air<br>2. Melakukan double check setiap selesai melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana                                                                                        |
| 3   | 9 Mei        |                  | Farmasi | KTC       | Kesalahan Input E-Resep oleh DPJP dan Kesalahan Penulisan Etiket Obat racikan puyer tertera rute topikal dan cara penggunaan dioleskan.                                  | 1. Koordinasi dengan komite medis<br>2. Menegur staf yang bersangkutan dan sosialisasi kembali SPO pengkajian resep.<br>3. Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum di serahkan kepada pasien (Double check). |
| 4   | 16 Mei       |                  | IRNA 5C | KTC       | Terjadi kesalahan interpretasi instruksi dokter terkait pemeriksaan laboratorium ulang, sehingga terdapat pemeriksaan yang dilakukan kembali di ruang rawat              | 1. Penggantian biaya laboratorium oleh perawat                                                                                                                                                                                      |

|   |        |  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--------|--|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |  |                |     | inap padahal instruksi tersebut telah ditujukan untuk pelaksanaan di IGD.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 | 24 Mei |  | Instalasi Gizi | KNC | Terjadi kesalahan pemberian diet pada pasien, di mana instruksi diet cair Diabetasol oleh DPJP pada pagi hari tidak sesuai dengan pesanan diet yang dibuat oleh ahli gizi menjelang siang, sehingga pasien hampir menerima diet cair sonde yang tidak sesuai saat makan siang. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli gizi bisa melihat operan pasien atau cppt untuk mengetahui diet yang di advice kan dpjp</li> <li>2. Ahli gizi bisa lebih teliti lagi dalam meberikan jenis Diet kepada pasien</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| 6 | 29 Mei |  | Instalasi Gizi | KTC | Ditemukan benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu)                                                                                                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemorsian snack dilakukan minimal 1 jam sebelum di bagikan tidak boleh H-1 sebelum di bagikan</li> <li>2. Setelah sudah diporsi dan di beri plastic wrap disimpan/diletakkan di tempat yang aman agar tidak ada benda asing yang masuk</li> <li>3. Seperti makan pasien, snack juga harus di QC oleh ahli gizi sebelum di bagikan oleh penyaji</li> </ol> |

3.8 Indikator Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi Kesehatan

| NO | INDIKATOR MUTU                   | STANDAR          | MARET                   | APRIL        | MEI          |
|----|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Waktu pengajuan klaim            | < 5 Setiap Bulan | 05/03/2026              | 5/5/2026     | 5/6/2026     |
| 2  | % Klaim pending RJTL             | < 0,5%           | 1,87%                   |              |              |
| 3  | % Klaim pending RITL             | < 0,1%           | 8,32%                   |              |              |
| 4  | Klaim tidak layak RJTL           | 0 (Nol)          | 3                       |              |              |
| 5  | Klaim tidak layak RITL           | 0 (Nol)          | 0                       |              |              |
| 6  | Audit pasca klaim RJTL           | < 1.000.000      | 0                       |              |              |
| 7  | Audit pasca klaim RITL           | < 5.000.000      | 0                       |              |              |
| 8  | Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA | < 50.000.000     | 153.296.445             | 250.986.654  | 209.944.648  |
| 9  | Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA | <100.000.000     | -<br>777.985.662,0<br>0 | -964.163.400 | -170.866.338 |

3.8 Indikator Mutu Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

| NO. | INDIKATOR MUTU                                         | STANDAR                                                                                                | MARET | APRIL | MEI |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1   | Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan | Jadwal praktik 100% sesuai = 100                                                                       | 75    | 75    | 75  |
|     |                                                        | Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75                                                                   |       |       |     |
|     |                                                        | Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50                                                                   |       |       |     |
|     |                                                        | Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25                                                                   |       |       |     |
|     |                                                        | Jadwal praktik <20% sesuai = 0                                                                         |       |       |     |
|     |                                                        | Tidak ada kunjungan = 100                                                                              |       |       |     |
| 2   | Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan               | Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100                                                         | 50    | 50    | 50  |
|     |                                                        | Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75 |       |       |     |
|     |                                                        | Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50       |       |       |     |
|     |                                                        | Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0                                    |       |       |     |
| 3   | Umpan Balik Peserta (Customer Feedback)                | Σ responden 100% target = 100                                                                          | 100   | 100   | 100 |
|     |                                                        | Σ responden 75 - 99% target = 75                                                                       |       |       |     |
|     |                                                        | Σ responden 50 - 74% target = 50                                                                       |       |       |     |
|     |                                                        | Σ responden 25 - 49% target = 25                                                                       |       |       |     |
|     |                                                        | Σ responden <25% target = 0                                                                            |       |       |     |
| 4   | Update Data Ketersediaan Tempat Tidur                  | Σ update ≥ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100                 | 100   | 100   | 100 |
|     |                                                        | Σ update ≥ 25 hari = 75                                                                                |       |       |     |
|     |                                                        | Σ update 15 - 24 hari = 50                                                                             |       |       |     |
|     |                                                        | Σ update 10 - 14 hari = 25                                                                             |       |       |     |
|     |                                                        | Σ update < 10 hari = 0                                                                                 |       |       |     |
| 5   | Update Jadwal Tindakan Medis Operatif                  | Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100            | 100   | 100   | 100 |
|     |                                                        | Tidak menginput jadwal TMO = 0                                                                         |       |       |     |
| 6   | Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN           | Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100                                                    | 100   | 75    | 75  |

|    |                                          |                                                                                                                                           |        |        |        |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | dan Waktu Tunggu Rawat Jalan             |                                                                                                                                           |        |        |        |
|    |                                          | Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75                                                                                                    |        |        |        |
|    |                                          | Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50                                                                                                    |        |        |        |
|    |                                          | Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25                                                                                                    |        |        |        |
|    |                                          | Pemanfaatan MJKN ≤ 70% target = 0                                                                                                         |        |        |        |
| 7  | Penerbitan Surat Kontrol                 | Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100                                                                                                    | 100    | 100    | 100    |
|    |                                          | Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75                                                                                                |        |        |        |
|    |                                          | Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50                                                                                                |        |        |        |
|    |                                          | Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25                                                                                                |        |        |        |
|    |                                          | Surat Kontrol terbit ≤50% sesuai = 0                                                                                                      |        |        |        |
| 8  | Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik | RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100 | 50     | 50     | 50     |
|    |                                          | RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75                                                                              |        |        |        |
|    |                                          | RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50                                                               |        |        |        |
| 9  | % Approval SEP                           | <1%                                                                                                                                       | 0      |        | 0,3%   |
| 10 | Angka Capaian Iterasi                    | 1854                                                                                                                                      | 44%    | 47,90% | 63,00% |
| 11 | Angka Capaian PRB                        | 1370                                                                                                                                      | 85,30% | 86,86% | 90,68% |

### 3.9 Aspek Analisis Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi

#### 3.9.1 Klaim Pending Rawat Jalan

| NO | ASPEK        | DEFINISI                                                                                                                                                | MASALAH YANG DITEMUKAN                                                                                                                                                  | TINDAK LANJUT (TL)                                                                                                                                                                        | WAKTU TL                                                                                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem       | Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis                                                                                      | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                       |
| 2  | Administrasi | Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan                                | -                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                       |
| 3  | Klinis       | Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku | 1. Indikasi numpang rujukan dan self referral (top 5 poli perujuk)<br>2. Kunjungan multipoli<br>3. Kunjungan Pre OP<br>4. Pasien dengan dx katarak masih kontrol terus. | Dilakukan sosialisasi kepada 5 SMF terbanyak (untuk penekanan rujuk antar Rumah Sakit) dan koordinasi dengan dpjp terkait kunjungan pasien pre op dan evaluasi dan koordinasi dengan dpjp | Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala |

|   |        |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                   |             |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |        |                                                                                                                                      |                                                  | terkait indikasi kunjungan berulang post op katarak                               |             |
| 4 | Koding | Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku | Kunjungan kontrol poli jiwa DU menggunakan Z09.3 | Evaluasi ulang untuk kode kontrol dengan kesesuaian tindakan yang telah dilakukan | Setiap hari |

**3.9.2 Klaim Pending Rawat Inap**

| NO | ASPEK        | DEFINISI                                                                                                                                                | MASALAH YANG DITEMUKAN                                                                                                                                                               | TINDAK LANJUT (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WAKTU TL     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Sistem       | Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis                                                                                      | Belum Mendapatkan Status Respon Final Dari PT.Jasa Raharja                                                                                                                           | Komunikasi dengan Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Setiap bulan |
| 2  | Administrasi | Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan                                | Readmisi                                                                                                                                                                             | Melakukan konfirmasi pada DPJP terkait indikasi pasien dilakukan rawat inap kembali dan mengkaji kembali terkait penyebab terjadinya readmisi.                                                                                                                                                                          | Setiap hari  |
| 3  | Klinis       | Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku | 1. Indikasi Pasien Rawat inap<br>2. Pasien Dirujuk ditagihkan rawat inap => meminta tagihan menjadi Rawat Jalan<br>3. Hasil BGA yang dilampirkan belum memenuhi kriteria gagal nafas | 1. Melakukan konfirmasi pada DPJP dan dilakukan monitoring oleh dokter casemix<br>2. Dilakukan sosialisasi dengan DPJP terkait dengan rujukan antar Rumah Sakit, koordinasi dengan Kabid Pelayanan apabila pasien tidak mendapatkan RS rujukan secara cepat dan apabila pasien dengan advice rujuk dari IGD maka pasien | Setiap hari  |



|   |        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ditagihkan<br>Raeat Jalan                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   |        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. evaluasi<br>diagnosa<br>gagal nafas<br>sesuai<br>dengan BA<br>kesepakatan                                                                                                                                                              |              |
| 4 | Koding | Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku | 1. luka terbuka pada kepala dengan tindakan muscle suturing (83.65) gunakan kode prosedur 86.5 (suture or other closure of skin and subcutaneous tissue)<br>2. pasien riwayat mrs dengan cva, reseleksi kode I63 menjadi I69<br>3. pasien dengan tindakan close reduction of epipisis kode prosedur 79.42 tidak sesuai, gunakan 79.02 | 1. koordinasi dengan dpjp terkait kesesuaian laporan operasi dan tindakan yang dilakukan.<br>2. konfirmasi kepada dpjp terkait penegakan diagnosa cva dan cva sequele<br>3. mengkaji ulang diskripsi laporan operasi dengan kode tindakan | Setiap bulan |

3.9.3
 Klaim Tidak Layak Rawat Jalan

| NO | ASPEK        | DEFINISI                                                                                                                                                | MASALAH YANG DITEMUKAN                                                                                                           | TINDAK LANJUT (TL)                                                                                                          | WAKTU TL                                                                                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem       | Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis                                                                                      | -                                                                                                                                | -                                                                                                                           | -                                                                                                       |
| 2  | Administrasi | Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan                                | -                                                                                                                                | -                                                                                                                           | -                                                                                                       |
| 3  | Klinis       | Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku | 1. kunjungan rawat jalan dan rawat inap di hari yang sama<br>2. kunjungan pre op<br>3. kunjungan berulang igd dan indikasi gadar | 1. koordinasi dengan staf pelayanan terkait kunjungan dihari yang sama<br>2. sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait | Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala |

|   |        |                                                                                                                                      |   |                                               |   |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|
|   |        |                                                                                                                                      |   | kunjungan pre op                              |   |
|   |        |                                                                                                                                      |   | 3. evaluasi kriteria gawat darurat pasien igd |   |
| 4 | Koding | Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku | - | -                                             | - |

**3.9.4 Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA**

| NO | ASPEK        | DEFINISI                                                                                                                                                | MASALAH YANG DITEMUKAN                                                                                                                                     | TINDAK LANJUT (TL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WAKTU TL     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Sistem       | Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis                                                                                      | 1. Tarif tindakan Fisioterapi dan Rawat luka, angkat jahitan yang lebih besar dari pada Inacbg's<br><br>2. Pasien DM dengan penunjang dan persepan Insulin | 1. Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan dan koordinasi dengan DPJP terkait pasien dengan rawat luka tatalaksana apabila sudah bisa dilanjutkan di FKTP bisa dikembalikan ke FKTP dan pembatasan pemberian obatnya<br><br>2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait kriteria pemberian insulin | Setiap bulan |
| 2  | Administrasi | Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan                                |                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            |
| 3  | Klinis       | Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            |
| 4  | Koding       | Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku                    | -                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            |

3.9.5 Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA

| NO | ASPEK        | DEFINISI                                                                                                                                                | MASALAH YANG DITEMUKAN                             | TINDAK LANJUT (TL)                                                                                                                                                                                                                                      | WAKTU TL   |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Sistem       | Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis                                                                                      | Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's | Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan, sudah ada perubahan terkait dengan pengelompokan tarif tindakan sehingga hasilnya turun tetapi terlihat menjadi selisih negatif yang sangat besar untuk tindakan naik kelas | Bulan juni |
| 2  | Administrasi | Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan                                |                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |
| 3  | Klinis       | Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |
| 4  | Koding       | Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku                    | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -          |

3.10 Evaluasi Mutu APM

| Tanggal  | Jml. Kunjungan | Jml. Mobile JKN | Jml. APM | Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan | Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan MJKN |
|----------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Januari  | 10.955         | 7.477           | 4.418    | 40%                                   | 59%                                        |
| Februari | 9.712          | 6.453           | 4.456    | 46%                                   | 69%                                        |
| Maret    | 8.665          | 5.660           | 3.709    | 43%                                   | 66%                                        |
| April    | 10.819         | 6.884           | 5.165    | 48%                                   | 75%                                        |
| Mei      | 10.246         | 6.637           | 4.996    | 49%                                   | 75%                                        |

| No.    | Keterangan | Januari | Februari | Maret | April | Mei  |
|--------|------------|---------|----------|-------|-------|------|
| 1      | APM        | 40%     | 46%      | 43%   | 48%   | 49%  |
| 2      | Petugas    | 60%     | 54%      | 57%   | 52%   | 51%  |
| Jumlah |            | 100%    | 100%     | 100%  | 100%  | 100% |

1.6.1 Komite PPI

1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAI<sup>s</sup> Kemenkes)

| SSI 2026                | Bedah Orthopedi | Seksio Sesaria | Apendiktomi | Herniotomi | Katarak | CABG | Tumor Payudara |
|-------------------------|-----------------|----------------|-------------|------------|---------|------|----------------|
| Januari                 |                 |                |             |            |         |      |                |
| Jumlah Kasus            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0       | -    | 0              |
| Jumlah Tindakan operasi | 88              | 73             | 6           | 15         | 46      | -    | 13             |
| Insiden (%)             | 0%              | 0%             | 0%          | 0%         | 0%      | -    | 0%             |
| Februari                |                 |                |             |            |         |      |                |
| Jumlah Kasus            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0       | -    | 0              |
| Jumlah Tindakan operasi | 66              | 67             | 16          | 8          | 51      | -    | 15             |
| Insiden (%)             | 0%              | 0%             | 0%          | 0%         | 0%      | -    | 0%             |
| Maret                   |                 |                |             |            |         |      |                |
| Jumlah Kasus            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0       | -    | 0              |
| Jumlah Tindakan operasi | 80              | 76             | 14          | 7          | 23      | -    | 8              |
| Insiden (%)             | 0%              | 0%             | 0%          | 0%         | 0%      | -    | 0%             |
| April                   |                 |                |             |            |         |      |                |
| Jumlah Kasus            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0       | -    | 0              |
| Jumlah Tindakan operasi | 87              | 69             | 10          | 11         | 52      |      | 21             |
| Insiden (%)             | 0%              | 0%             | 0%          | 0%         | 0%      | -    | 0%             |
| Mei                     |                 |                |             |            |         |      |                |
| Jumlah Kasus            | 0               | 0              | 0           | 0          | 0       | -    | 0              |
| Jumlah Tindakan operasi | 59              | 76             | 6           | 11         | 36      | -    | 26             |
| Insiden (%)             | 0%              | 0%             | 0%          | 0%         | 0%      | -    | 0%             |

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                                                                 | Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting. |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                        |
| Masalah saat ini                                                                                                        | Tidak ditemukan kasus IDO.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                        |
| Permasalahan sebelumnya                                                                                                 | Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                        |
| Tindakan yang dilakukan                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI.</li> <li>• Monitoring kepatuhan Hand hygiene.</li> <li>• Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.</li> </ul>                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                        |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                                                   | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | SASARAN                                                                                                      | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PELAKSANA                                                                                                                  | WAKTU                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).</li> <li>• Menjalankan audit bundle SSI dengan baik.</li> <li>• Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis.</li> <li>• Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring bulanan</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahanan bundle IDO berjalan dengan baik.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien operasi</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual.</li> <li>• Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik)</li> <li>• Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi risiko infeksi.</li> <li>• Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat /Bidan</li> <li>• Dokter</li> <li>• Karu</li> <li>• IPCLN/IPCN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring bulanan</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahanan evaluasi pemahaman pemberian edukasi</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien post operasi.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah.</li> <li>• Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat /Bidan</li> <li>• Karu</li> <li>• IPCLN/IPCN</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring bulanan</li> </ul> |

---

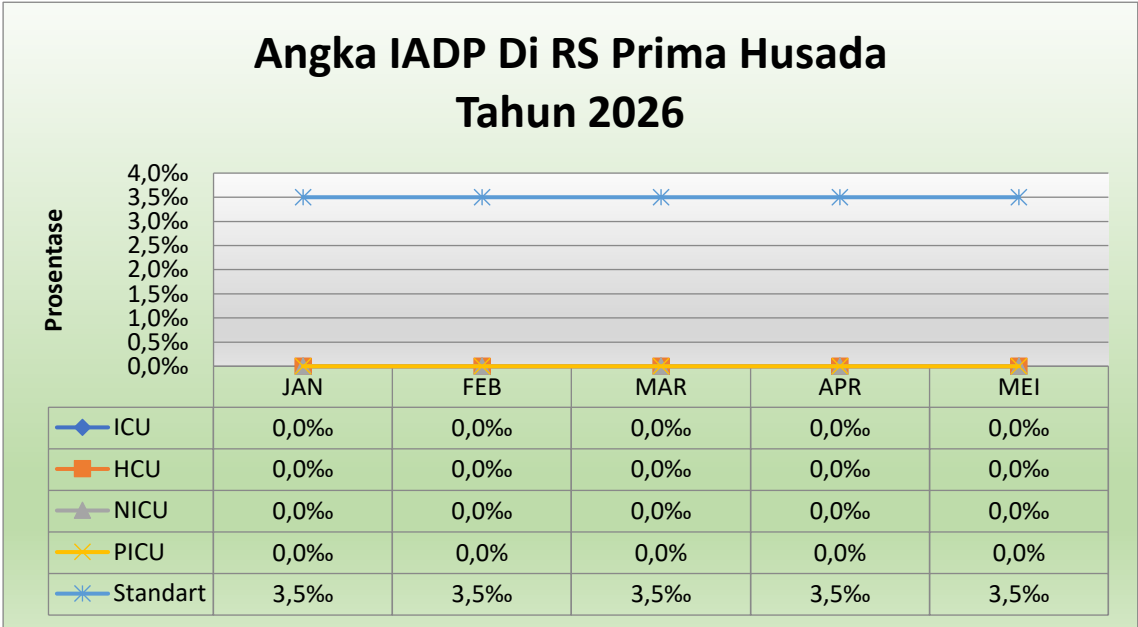
|                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| perawatan pasien pasca operasi |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka.</li><li>• Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien.</li><li>• Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.</li></ul> |  |  |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

| IADP 2026                      | ICU | HCU | NICU | PICU |
|--------------------------------|-----|-----|------|------|
| Januari                        |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian CVC | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Februari                       |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian CVC | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Maret                          |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian CVC | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| April                          |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian CVC | 15  | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
|                                |     |     |      |      |
| Mei                            |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian CVC | 15  | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |

3.7.8 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                                | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 21 hari total lama pemasangan CVC terhadap 1 pasien, 15 hari lama pemasangan CVC pasien dan dilanjutkan 6 hari lama pemasangan di unit 7A.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                |
| Masalah saat ini                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi IADP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                |
| Permasalahan sebelumnya                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi IADP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                |
| Tindakan yang dilakukan                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC.</li> <li>• Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC.</li> <li>• Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat.</li> <li>• Melakukan monitoring</li> <li>• perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.</li> </ul> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                  | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SASARAN                                                                          | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PELAKSANA                                                                                                                  | WAKTU                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahankan kepatuhan bundle IADP.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien dengan pemakaian CVC.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas.</li> <li>• Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC.</li> <li>• Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat.</li> <li>• Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat /Bidan</li> <li>• Dokter</li> <li>• Karu</li> <li>• IPCLN/IPC�</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu bulan</li> </ul> |

1.6.1.1.3 VAP

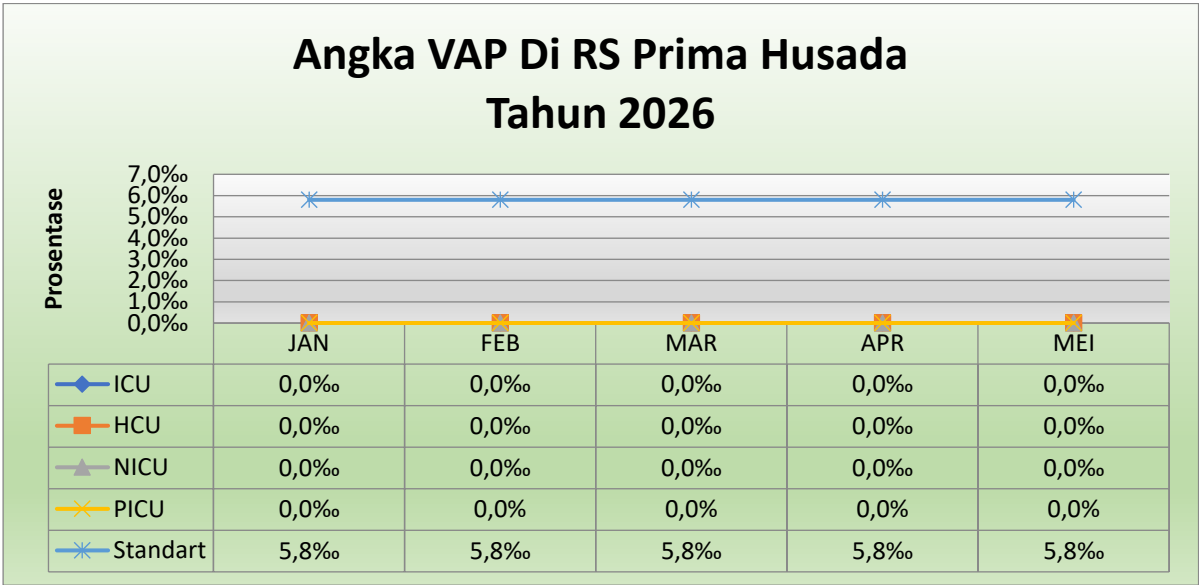
1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

| VAP 2026                                       | ICU | HCU | PICU | NICU |
|------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| Januari                                        |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi | 86  | 0   | 0    | 0    |
| Insiden (%)                                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Februari                                       |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi | 78  | 0   | 12   | 0    |
| Insiden (%)                                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Maret                                          |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                                   | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi | 98  | 0   | 60   | 0    |
| Insiden (%)                                    | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| April                                          |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                                   | 0   | 0   | 0    | 0    |



|                                                |     |    |    |    |
|------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi | 160 | 0  | 0  | 0  |
| Insiden (%)                                    | 0‰  | 0‰ | 0‰ | 0‰ |
| Mei                                            |     |    |    |    |
| Jumlah Kasus                                   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi | 170 | 0  | 0  | 0  |
| Insiden (%)                                    | 0‰  | 0‰ | 0‰ | 0‰ |

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Analisa                                                                | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 170 hari total lama pemasangan ventilator pada 14 pasien di ICU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |
| Masalah saat ini                                                       | • Tidak terjadi VAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |
| Permasalahan sebelumnya                                                | • Tidak terjadi VAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |
| Tindakan yang dilakukan                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik.</li><li>• Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator.</li><li>• Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator.</li><li>• Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction.</li><li>• Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.</li></ul> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |
| Rencana Tindak Lanjut                                                  | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SASARAN                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PELAKSANA                                                                                                             | WAKTU        |
| • Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene. | • Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • Pasien yang terpasang ventilator mekanik | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas.</li><li>• Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator.</li><li>• Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> &gt;30°-45°.</li><li>• Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator.</li><li>• Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM.</li><li>• Pemberian tindakan oral hygiene dengan chlorhexidine dan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perawat /Bidan</li><li>• Dokter</li><li>• Karu</li><li>• IPCLN/IPCN</li></ul> | • Satu bulan |

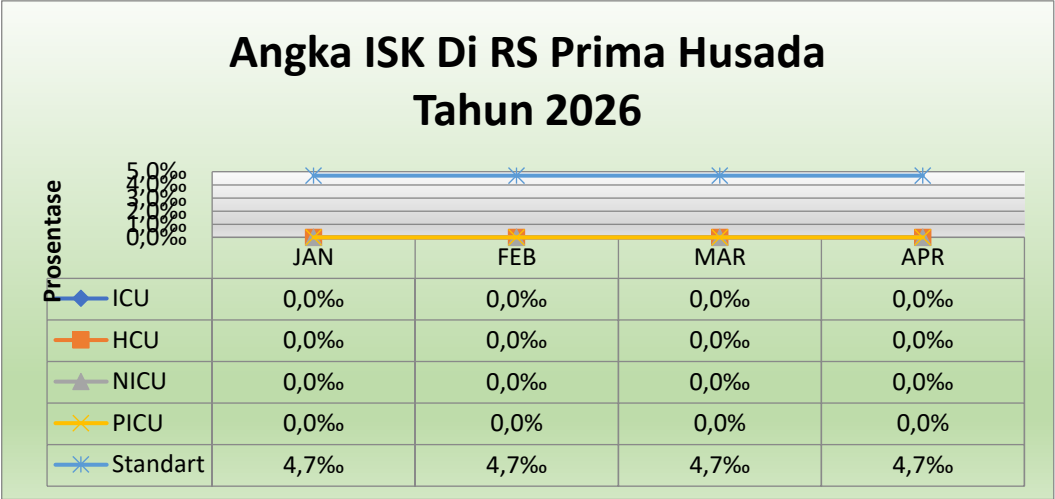
|  |  |  |                                            |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | petugas untuk melakukan tindakan tersebut. |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR  
(Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

| ISK 2026                            | ICU | HCU | PICU | NICU |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------|
| Januari                             |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                        | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter | 188 | 40  | 0    | 0    |
| Insiden (%)                         | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Februari                            |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                        | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter | 168 | 78  | 6    | 0    |
| Insiden (%)                         | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Maret                               |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                        | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter | 180 | 45  | 3    | 0    |
| Insiden (%)                         | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| April                               |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                        | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter | 246 | 89  | 10   | 0    |
| Insiden (%)                         | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |
| Mei                                 |     |     |      |      |
| Jumlah Kasus                        | 0   | 0   | 0    | 0    |
| Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter | 293 | 61  | 0    | 0    |
| Insiden (%)                         | 0‰  | 0‰  | 0‰   | 0‰   |

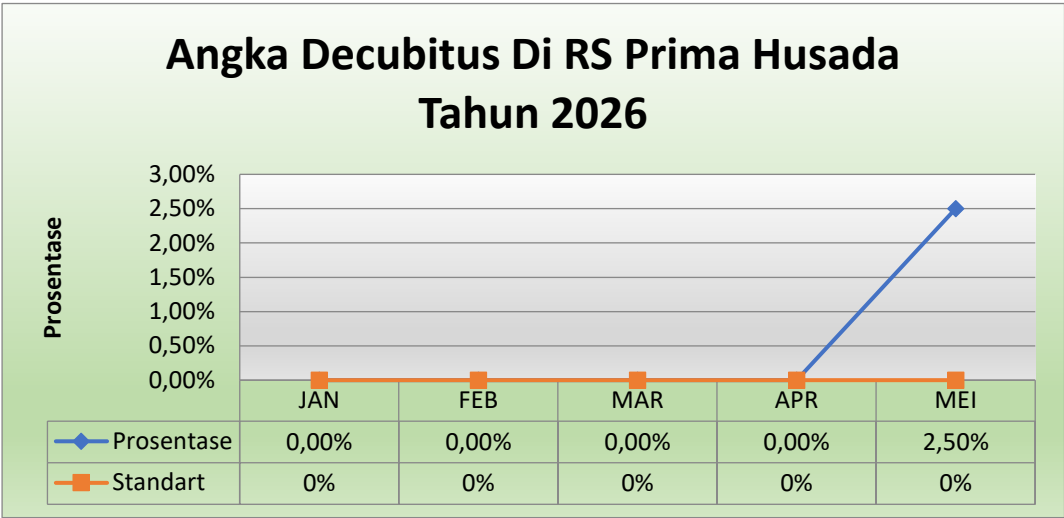
3.7.9 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                             | Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1416 hari lama pemakaian kateter pasien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                              |
| Masalah saat ini                                                                    | • Tidak terjadi ISK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                              |
| Permasalahan sebelumnya                                                             | • Tidak terjadi ISK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                              |
| Tindakan yang dilakukan                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien.</li><li>• Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter.</li><li>• Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter.</li><li>• Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.</li></ul> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                              |
| Rencana Tindak Lanjut                                                               | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SASARAN                                                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PELAKSANA                                                                                                            | WAKTU                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertahankan kepatuhan bundle ISK.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasien yang terpasang kateter</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas.</li><li>• Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter.</li><li>• Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter.</li><li>• Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perawat /Bidan</li><li>• Dokter</li><li>• Karu</li><li>• IPCLN/PCN</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Satu bulan</li></ul> |

1.6.1.1.5 Decubitus

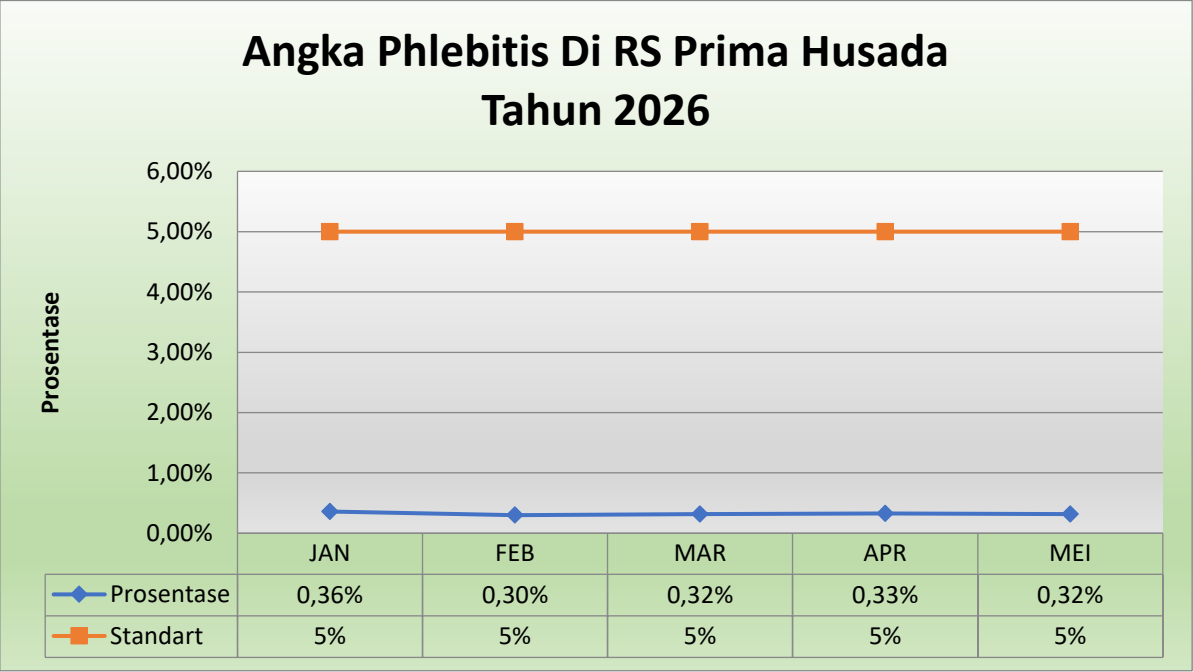
1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                                     | Pada bulan ini ditemukan 1 kasus decubitus pada 40 pasien tirah baring lama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
| Masalah saat ini                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Pasien mengalami decubitus (lecet pada area pantat) pada hari ke 5 perawatan di ruang ICU. Pencegahan decubitus kurang dijalankan dengan baik.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
| Permasalahan sebelumnya                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Penggunaan diapers dapat memperburuk kondisi kulit pada pasien yang tirah baring lama.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
| Tindakan yang dilakukan                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien.</li><li>Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki).</li><li>Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.</li><li>Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas.</li><li>Memastikan pemenuhan nutrisi yang tepat.</li></ul> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                       | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SASARAN                                                                                       | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PELAKSANA                                                                                                    | WAKTU                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Pasien yang tirah baring lama (&gt; 3x24 jam)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas.</li><li>Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki).</li><li>Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain</li><li>Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin.</li><li>Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Perawat /Bidan</li><li>Dokter</li><li>Karu</li><li>IPCLN/PCN</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Satu bulan</li></ul> |

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.10 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

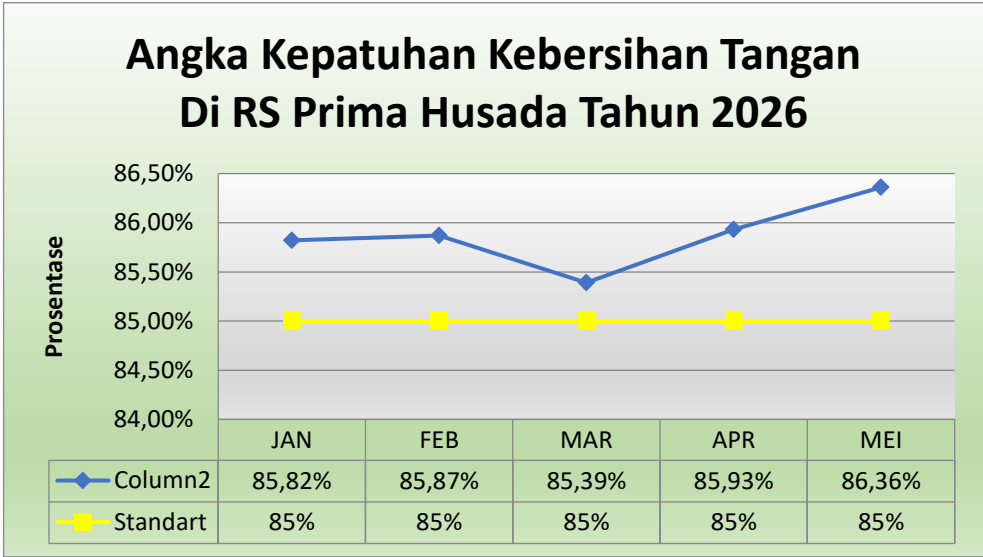


|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                                 | <p>Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 3085 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,32%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pasien pada bulan ini mengalami penurunan dan upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Mei berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis pada perawatan infus karena adanya pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif.</p> <p>Dari data yang diperoleh terdapat 10 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah.</p> <p>Dari 10 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).</p> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                              |
| Masalah saat ini                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan cairan pekat, antibiotik masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                              |
| Permasalahan sebelumnya                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.</li> <li>Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                              |
| Tindakan yang dilakukan                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis.</li> <li>Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal.</li> <li>Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi.</li> <li>Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal.</li> <li>Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                              |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                   | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SASARAN                                                                       | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PELAKSANA                                                                                                          | WAKTU                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasien yang terpasang infus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan.</li> <li>Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman.</li> <li>Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi.</li> <li>Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis.</li> <li>Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan.</li> <li>Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan.</li> <li>Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus.</li> <li>Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perawat /Bidan</li> <li>Dokter</li> <li>Karu</li> <li>IPCLN/IPCN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Satu bulan</li> </ul> |

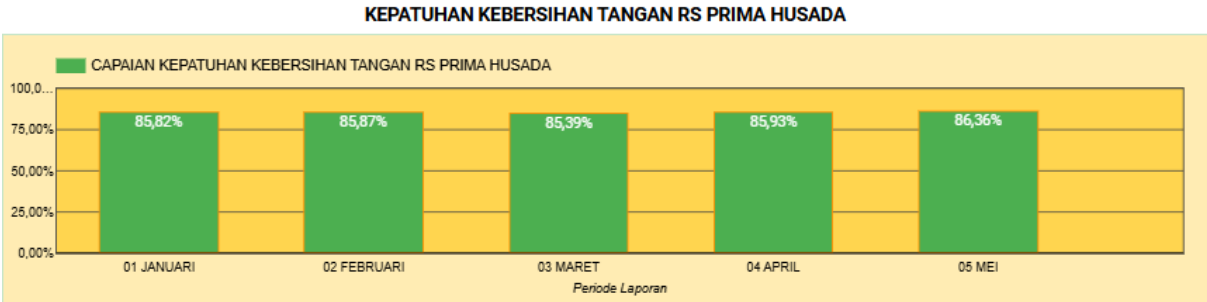
|                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat/bidan</li> <li>• Apoteker</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi.</li> <li>• Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat.</li> <li>• Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat /Bidan</li> <li>• Apoteker</li> <li>• Karu</li> <li>• IPCLN/IPCN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu bulan</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Proses Pemasangan &amp; Perawatan Infus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat/bidan</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi).</li> <li>• Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus.</li> <li>• Audit kepatuhan perawatan VAP &amp; manajemen infus setiap bulan.</li> <li>• Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat /Bidan</li> <li>• Dokter</li> <li>• Karu</li> <li>• IPCLN/IPCN</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiga bulan</li> </ul> |

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

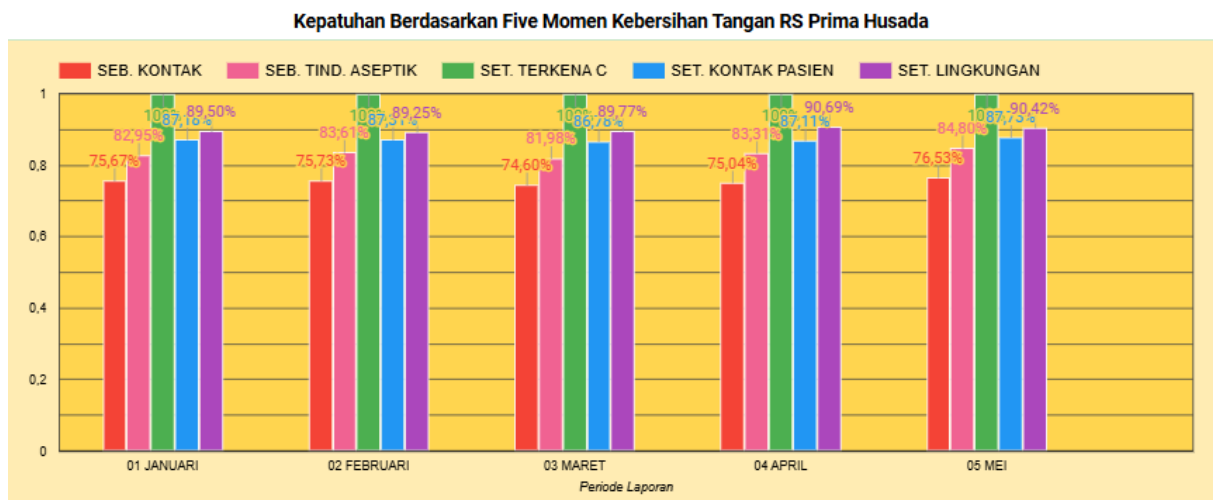
3.7.11 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan



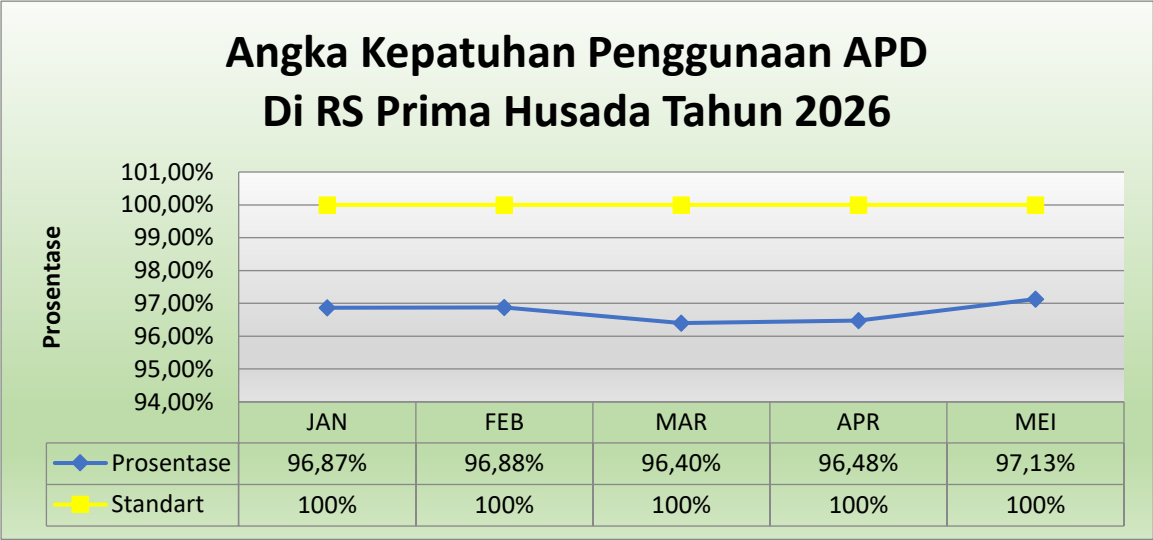


|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Analisa                                                                                       | <p>Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Mei 2026 berada sedikit di atas standar (selisih 0,43%).</p> <p>Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan, yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat.</p> <p>Nilai kepatuhan terhdap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 83,10%. Nilai ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya (April 2026: 86,59%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Penurunan ini bisa mencerminkan penurunan perhatian terhadap teknik yang benar dan penurunan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, seharusnya sudah menjadi kebiasaan untuk budaya cuci tangan dengan 5 momen dan 6 langkah yang tepat, bukan hanya frekuensi mencuci tangan saja.</p> <p>Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan.</p> <p>Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.</p> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                             |
| Masalah saat ini                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna.</li> <li>• Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect).</li> <li>• Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                             |
| Permasalahan sebelumnya                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan.</li> <li>• Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.</li> <li>• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna.</li> <li>• Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect).</li> <li>• Edukasi dan reminder visual belum optimal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                             |
| Tindakan yang dilakukan                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin.</li> <li>• Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan.</li> <li>• Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan.</li> <li>• Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.</li> <li>• Meningkatkan penerapan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                             |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                         | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SASARAN                                                                                                    | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                    | PELAKSANA                                                                      | WAKTU                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kepatuhan 5 momen cuci tangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kepatuhan 5 momen cuci tangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh perawat dan tenaga kesehatan di unit pelayanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi ulang 5 momen cuci tangan</li> <li>• Edukasi teknik 6 langkah melalui refresh training</li> <li>• Pemasangan poster &amp; reminder visual di area strategis</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> <li>• Karu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bulan</li> </ul> |

|                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konsistensi praktik cuci tangan</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konsistensi praktik kebersihan tangan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh staf unit pelayanan</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kepatuhan mingguan</li> <li>• Feedback langsung hasil observasi</li> <li>• Monitoring ketersediaan sarana (handrub, wastafel, sabun)</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> <li>• IPCN</li> <li>• Karu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mingguan</li> </ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kepatuhan 6 langkah cuci tangan</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketepatan teknik 6 langkah cuci tangan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat</li> <li>• Tenaga Kesehatan lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulasi praktik langsung saat supervisi</li> <li>• Supervisi saat jam pelayanan</li> <li>• Evaluasi melalui checklist observasi</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPCN</li> <li>• IPCLN</li> <li>• Karu</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mingguan</li> </ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kepatuhan kebersihan tangan saat tidak diamati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi kepatuhan semu karena observer effect</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh staf</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi acak tanpa pemberitahuan</li> <li>• Penguatan budaya keselamatan pasien koordinasi dengan komite PMKP</li> <li>• Kampanye internal "Hand Hygiene is Safety" jika diperlukan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> <li>• Komite PMKP</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkala</li> </ul>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan program kebersihan tangan</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keberlanjutan program kebersihan tangan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pelayanan</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi rutin program "PPI Quick Tips"</li> <li>• Reward bagi unit dengan kepatuhan terbaik</li> <li>• Rapat evaluasi bulanan</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> <li>• Manajemen RS</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap bulan</li> </ul> |

2.6.1.1.8 Kepatuhan APD

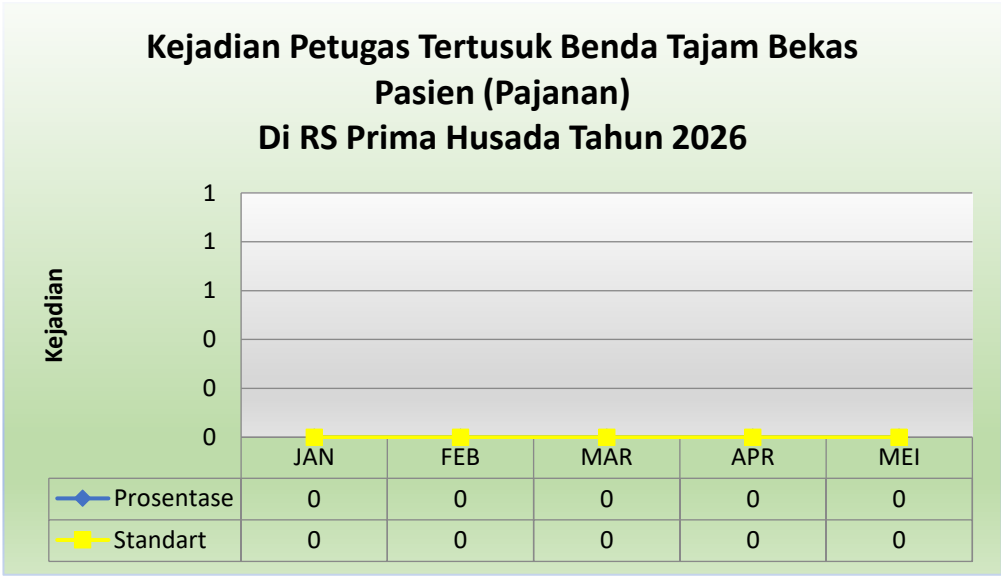
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisa                 | Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 97,13%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak tepat atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi peningkatan sedikit pada bulan ini, menunjukkan adanya: peningkatan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau bertambahnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga pemakaian APD yang berlebihan sehingga dianggap tetap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat. |
| Masalah saat ini        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi.</li><li>• Pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata.</li><li>• Kebiasaan kerja lama masih mempengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten.</li><li>• Monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh unit.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Permasalahan sebelumnya | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”.</li><li>• Audit belum merata.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tindakan yang dilakukan                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya.</li> <li>• Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi.</li> <li>• Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM).</li> <li>• Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.</li> <li>• Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai.</li> <li>• Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD.</li> <li>• Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.</li> </ul> |                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                   |
| Rencana Tindak Lanjut                                                                                     | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SASARAN                                                                                | STRATEGI                                                                                                                         | PELAKSANA                                                                                                 | WAKTU                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh tenaga kesehatan</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI, IPCN</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bulan</li> </ul>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman staf terkait APD</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perawat dan tenaga kesehatan</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPCN</li> <li>• Kepala Ruangan</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1–2 bulan</li> </ul>     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan konsistensi penggunaan APD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh staf unit pelayanan</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap bulan</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga kesehatan di unit pelayanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Ruangan</li> <li>• IPCN</li> <li>• Komite PMKP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkelanjutan</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroling ketersediaan APD</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pelayanan</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite PPI</li> <li>• Farmasi</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap bulan</li> </ul>  |

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam  
3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |           |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------|
| Analisa                 | Tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |           |       |
| Masalah saat ini        | • Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           |       |
| Permasalahan sebelumnya | • Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           |       |
| Tindakan yang dilakukan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar.</li><li>• Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja.</li><li>• Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan.</li><li>• Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam.</li><li>• Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.</li></ul> |         |          |           |       |
| Rencana Tindak Lanjut   | TUJUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SASARAN | STRATEGI | PELAKSANA | WAKTU |

---

|                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh petugas pelayanan pasien</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan.</li> <li>• Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan.</li> <li>• Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya.</li> <li>• Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan.</li> <li>• Monitoring teknik recapping tutup jarum.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh petugas pelayanan di RS.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu bulan</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

| Unit          | Target   | Mar  | Apr  | Mei  | %              | MANDOK     | Keterangan                    |
|---------------|----------|------|------|------|----------------|------------|-------------------------------|
| IRNA 2C       | 4x/Bulan | 100% | 100% | 50%  | Tidak Tercapai | Lampiran B | IRNA 2C Tidak Mencapai Target |
| ICU\HCU       | 4x/Bulan | 0%   | 0%   | 0%   | Tidak Tercapai | Lampiran B | ICU/HCU Tidak mencapai target |
| IRNA 3C       | 4x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Lampiran B | IRNA 3C Mencapai target       |
| MATERNITAS    | 4x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Lampiran B | MATERNITAS Mencapai Target    |
| PERINATOLOGI  | 4x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Lampiran B | PERINATOLOGI Mencapai Target  |
| IRNA 5C       | 4x/Bulan | 0%   | 0%   | 0%   | Tidak Tercapai | Lampiran B | IRNA 5C Tidak Mencapai Target |
| IRNA 2A,3A,4A | 4x/Bulan | 100% | 50%  | 100% | Tercapai       | Lampiran B | IRNA 2A,3A,4A Mencapai Target |
| IRNA 6A,7A,8A | 4x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Lampiran B | IRNA 6A,7A,8A Mencapai target |
| IGD           | 4x/Bulan | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Lampiran B | IGD Mencapai Target           |
| FARMASI       | 4x/Bulan | 25%  | 100% | 75%  | Tidak Tercapai | Lampiran B | FARMASI Tidak Mencapai target |
| GIZI          | 4x/Bulan | 0%   | 50%  | 100% | Tercapai       | Lampiran B | Gizi Mencapai Target          |
| IRJA          | 4x/Bulan | 100% | 100% | 75%  | Tidak Tercapai | Lampiran B | IRJA Tidak Mencapai Target    |

**ANALISIS** : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Mei Tahun 2026, Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target, beberapa Unit belum mencapai target dan perlu ditingkatkan, berikut: ICU/HCU, IRNA 5C, FARMASI dan IRJA

**RTL** : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Mei.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

| UNIT                                                   | TARGET   | KEGIATAN         | MAR  | APR  | MEI  | %              | MANDOK | KET              |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------|------|----------------|--------|------------------|
| Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri | 2X/Bulan | Senam            | 0%   | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |                  |
|                                                        |          | Hypnoterapi      |      |      |      |                |        |                  |
|                                                        |          | KIE              |      |      |      |                |        |                  |
| Komunitas Ibu Hamil                                    | 2X/Bulan | Senam            | 0%   | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |                  |
|                                                        |          | Hypnoterapi      |      |      |      |                |        |                  |
|                                                        |          | KIE              |      |      |      |                |        |                  |
| Yoga Lansia                                            | 2xBulan  | Yoga             | 25%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |                  |
|                                                        |          | Hynoterapi       |      |      |      |                |        |                  |
|                                                        |          | KIE              |      |      |      |                |        |                  |
| Komunitas Shirothul Jannah Perempuan                   | 2X/Bulan | Pengajian        | 50%  | 100% | 50%  | Tidak Tercapai | Ada    | Libur Idhul Adha |
|                                                        |          | Karya wisata     |      |      |      |                |        |                  |
| Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki                   | 2X/Bulan | Pengajian        | 50%  | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |                  |
| Bimbingan Doa                                          | 8X/Bulan | Mendoakan Pasien | 100% | 100% | 100% | Tercapai       | Ada    |                  |

|                          |           |  |    |    |    |                |   |  |
|--------------------------|-----------|--|----|----|----|----------------|---|--|
| General Meeting Karyawan | 1x/2Bulan |  | 0% | 0% | 0% | Tidak Tercapai | - |  |
| Pembinaan Fatayat        | 1X/Tahun  |  |    |    |    |                |   |  |

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

| Unit                                      | Target   | Mar  | Apr | Mei  | %              | Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi | Ket |
|-------------------------------------------|----------|------|-----|------|----------------|----------------------------------------------------|-----|
| PONEK                                     | 4X/Bulan | 100% | 25% | 100% | Tercapai       | √                                                  |     |
| HIV                                       | 4X/Bulan | 0%   | 0%  | 0%   | Tidak Tercapai | -                                                  |     |
| STUNTING dan WASTING                      | 4X/Bulan | 0%   | 0%  | 50 % | Tidak Tercapai | √                                                  |     |
| KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA) | 4X/Bulan | 0%   | 0%  | 0%   | Tidak Tercapai | -                                                  |     |
| TB DOTS                                   | 4X/Bulan | 0%   | 0%  | 0%   | Tidak Tercapai | -                                                  |     |

**ANALISIS** : Bulan Mei PROGNAS belum tercapai  
**RTL** : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

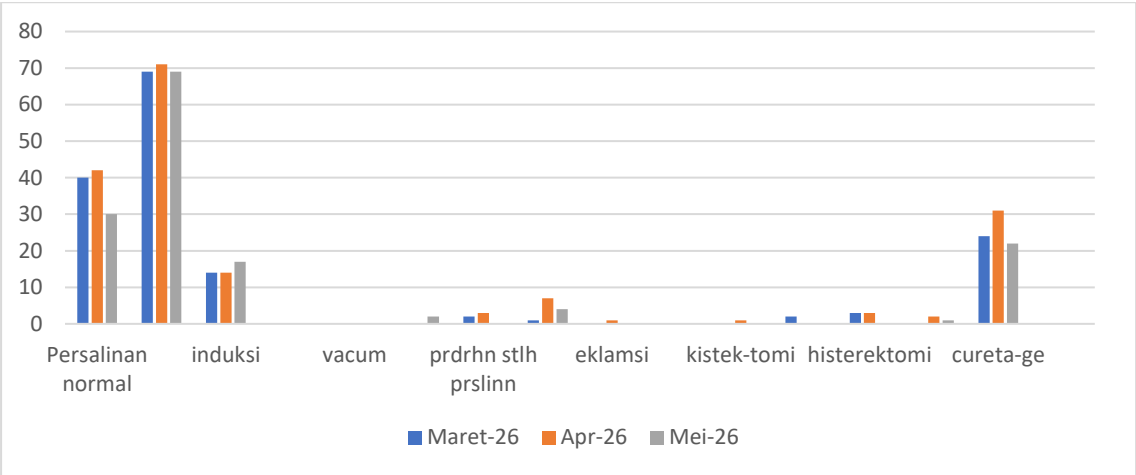
3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Mei 2026

| No | Jenis Pelayanan                  | Jumlah Pasien    |                  |                |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                                  | Bulan Maret 2026 | Bulan April 2026 | Bulan Mei 2026 |
| 1  | <b>Persalinan</b>                |                  |                  |                |
|    | a. Persalinan Normal             | 40               | 42               | 30             |
|    | b. <i>SectioCaesaria</i>         | 69               | 71               | 69             |
| 2  |                                  |                  |                  |                |
|    | a. Induksi / Drip                | 14               | 14               | 17             |
|    | b. Sungsang                      | 0                | 0                | 0              |
|    | c. Vacum                         | 0                | 0                | 0              |
| 3  |                                  |                  |                  |                |
|    | a. Perdarahan sebelum Persalinan | 0                | 0                | 2              |
|    | b. Perdarahan setelah Persalinan | 2                | 3                | 0              |
|    | c. Pre Eklamsi                   | 1                | 7                | 4              |
|    | d. Eklamsi                       | 0                | 1                | 0              |
|    | e. Infeksi                       | 0                | 0                | 0              |
| 4  |                                  |                  |                  |                |
|    | a. Curretage                     | 24               | 31               | 22             |



|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| b. Kistektomi   | 0 | 1 | 0 |
| c. Miomektomi   | 2 | 0 | 0 |
| d. Histerectomy | 3 | 3 | 0 |
| e. KET          | 0 | 2 | 1 |

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

1. Pada jenis persalinan normal pada bulan Mei 2026 yaitu 30 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 42 pasien , sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 40 pasien.
2. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Mei 2026 yaitu 69 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 71 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 69 pasien,.
3. Pasien terbanyak yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya,CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
4. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Mei 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Mei 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
5. Induksi/ Drip pada bulan Mei sebanyak 17 pasien, meningkat dibandingkan bulan April dan Maret 2026 yaitu 14 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
6. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Mei 2026 yaitu 4, menurun dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 7, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 1 kasus.
7. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan Mei 2026 yaitu 0 kasus, menurun dibandingkan dengan bulan April 1 kasus, sedangkan Maret 2026 yaitu 0 kasus.
8. Jenis pelayanan curretage di bulan Mei 2026 yaitu 22 kasus, menurun jika dibandingkan dengan April 2026 yaitu 31 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 24 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum,

sis plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**

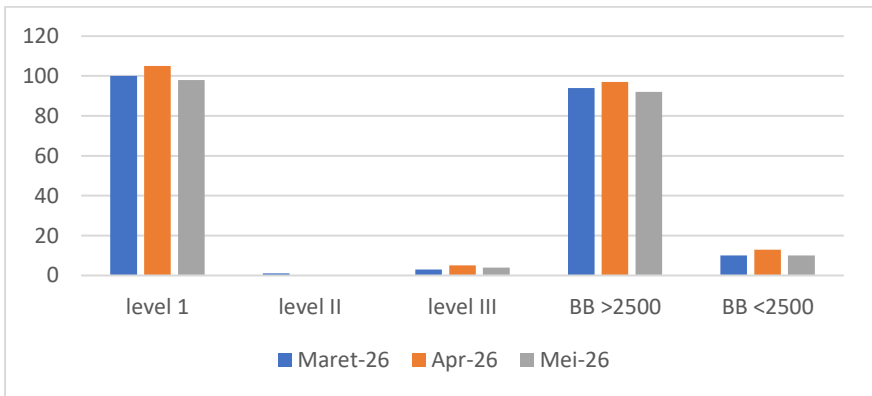
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

**3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal**

**3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek April 2026**

| NO | JENIS PELAYANAN                | JUMLAH PASIEN    |                  |                |
|----|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                                | BULAN MARET 2026 | BULAN APRIL 2026 | BULAN MEI 2026 |
| 1  |                                |                  |                  |                |
|    | a. Level 1/ rawat gabung       | 100              | 105              | 98             |
|    | b. Level II/ rujukan dari luar | 1                | 0                | 0              |
|    | c. Level III/NICU              | 3                | 5                | 4              |
| 2  |                                |                  |                  |                |
|    | a. BB ≥ 2500 gram              | 94               | 97               | 92             |
|    | b. BB ≤ 2500 gram              | 10               | 13               | 10             |

**3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Mei 2026**



**Analisis :**

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Mei 2026 yaitu 98 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 105 pasien , sedangkan Maret 2026 yaitu 100 pasien
2. Pada pelayanan level 2/ rujukan dari luar pada bulan Mei dan April 2026 yaitu 0 pasien , menurun dibandingkan pada bulan Maret 2026 yaitu 1 pasien.
3. Pada pelayanan level 3 pada bulan Mei yaitu 4 pasien, menurun jika dibandingkan dengan April yaitu 5 pasien, sedangkan bulan Maret yaitu 3 pasien.

- 4. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Mei 2026 yaitu 92 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 97 pasien, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 94 pasien.
- 5. Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Mei 2026 yaitu 10 pasien, menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 13 pasien, dan Maret 2026 yaitu 10 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

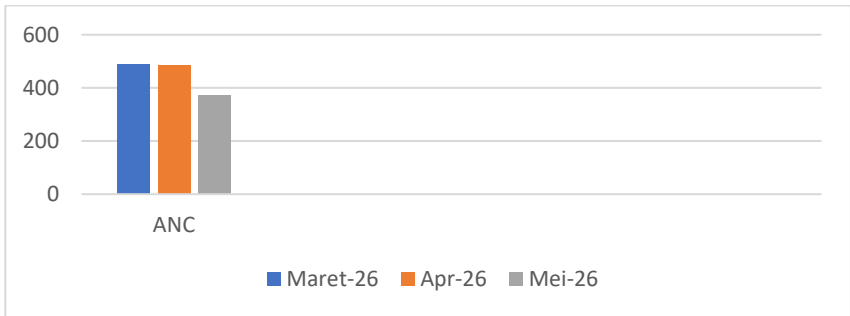
**Rencana dan Tindak Lanjut**

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

**3.7.12 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)**  
**Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek April 2026**

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah                 |                        |                      |
|----|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|    |                 | Bulan<br>Maret<br>2026 | Bulan<br>April<br>2026 | Bulan<br>Mei<br>2026 |
| 1  | ANC             | 491                    | 485                    | 371                  |

**Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Mei 2026**



**Analisis :**

- 1) Berdasarkan data kunjungan Ante Natal Care (ANC), Pada bulan Mei, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 371 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan April, terjadi penurunan sebanyak 114 kunjungan atau sekitar 23,5%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan berkurangnya pemanfaatan layanan ANC oleh ibu hamil. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi kondisi tersebut antara lain Faktor yang mungkin memengaruhi penurunan ini antara lain jadwal kontrol pasien yang bergeser ke bulan berikutnya, variasi jumlah pasien baru, atau faktor eksternal seperti hari libur dan kondisi akses pelayanan atau faktor sistem dan Kebijakan terkait perubahan regulasi JKN

- 2) Secara keseluruhan, tren kunjungan ANC pada periode Maret-Mei 2026 menunjukkan kecenderungan menurun, terutama pada bulan Mei. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab penurunan kunjungan serta penguatan upaya promosi kesehatan, pemantauan ibu hamil berisiko, dan peningkatan edukasi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin agar cakupan pelayanan ANC tetap optimal

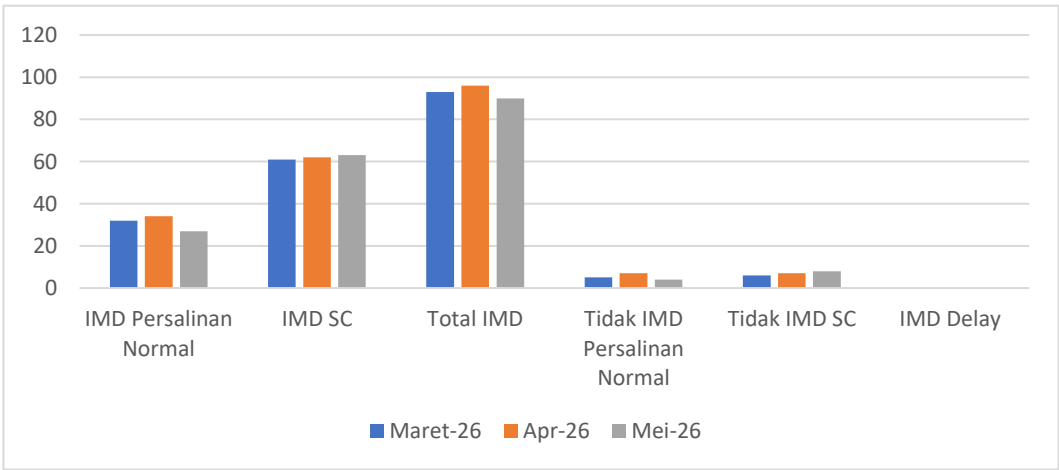
**Rencana dan Tindak Lanjut :**

- 1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3. Melakukan Program kelas ibu hamil

**3.7.13 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)**  
**Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Mei 2026**

| No | Uraian                      | Jumlah Pasien    |       |                  |       |                |       |
|----|-----------------------------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
|    |                             | Bulan Maret 2026 | %     | Bulan April 2026 | %     | Bulan Mei 2026 | %     |
| 1  | IMD Persalinan Normal       | 32               | 86,5% | 34               | 82,9% | 27             | 87%   |
| 2  | IMD SC                      | 61               | 91,0% | 62               | 89,9% | 63             | 88,7% |
| 3  | Total IMD                   | 93               | 89,4% | 96               | 87,3% | 90             | 88,2% |
| 4  | Tidak IMD Persalinan Normal | 5                | 13,5% | 7                | 17,1% | 4              | 12,9% |
| 5  | Tidak IMD SC                | 6                | 9,0%  | 7                | 10,1% | 8              | 11,2% |
| 6  | IMD Delay                   | 0                | 0%    | 0                | 0%    | 0              | 0%    |
|    | Total Kelahiran Normal      | 37               |       | 41               |       | 31             |       |
|    | Total Kelahiran SC          | 67               |       | 69               |       | 71             |       |
|    | Total kelahiran             | 104              |       | 110              |       | 102            |       |

**Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Mei 2026**



**Analisis :**

- 1. Pada bulan Mei 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 27 (87%) pasien, menurun di dibandingkan bulan April yaitu 34 (82,9%) pasien sedangkan bulan Maret yaitu 32 (86,5%) pasien Bayi.

2. Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Mei yaitu 63 (88,7%) pasien, meningkat sedikit dibanding dengan bulan April 62 (89,9%) pasien, dan bulan Maret yaitu 61 (91%) pasien.
3. Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Mei yaitu 4 (12,9%) pasien, menurun dibandingkan bulan April yaitu 7 (17,1%) sedangkan bulan Maret yaitu 5 pasien (13,5%)
4. Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Mei 2026 yaitu 8 (11,2%) pasien, meningkat dibandingkan bulan April 2026 yaitu 7 (10,1%), sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 6 (9,0%) pasien
5. Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti bayi BBL dengan perawatan infant warmer, bayi dengan pemakaian CPEP.
6. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2026

| No                | Nama Bayi          | Diagnosa                                                                                              | Perawatan BBL    |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Persalinan Normal |                    |                                                                                                       |                  |
|                   | Ny Firnanda        | NKB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny miftakhul       | NCB + BBLR                                                                                            | Infarn Warmer    |
|                   | Ny Yulis           | NKB + BBLR                                                                                            | Infarn Warmer    |
|                   | Ny Fitri Nadhila   | Pneumonia                                                                                             | CPEP + inkubator |
| SC                |                    |                                                                                                       |                  |
|                   | Ny Nuhda Akmalia   | NKB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Miratus Suaibah | NKB + BBLR                                                                                            | CPEP + inkubator |
|                   | Ny Elma kania      | NCB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Ziadatul Azizah | NKB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Siti Kholifah   | NKB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Mei Ria         | NCB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Alfiah          | NKB + BBLR                                                                                            | Cuvis            |
|                   | Ny Hindun          | Obs distres nafas ok<br>Neonatal Pneumonia<br>dd MAS, susp<br>congenital anomaly dd<br>achondroplasia | CPEP + inkubator |

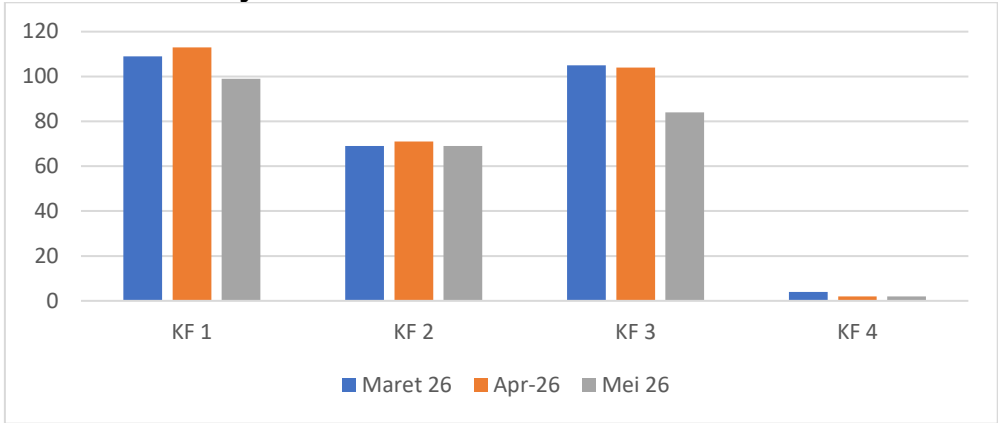
**Rencana dan Tindak Lanjut :**

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.7.14 Pelayanan Post Natal Care (PNC)  
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Mei 2026

| No | Jenis Pelayanan    | Jumlah           |       |                  |      |                |        |
|----|--------------------|------------------|-------|------------------|------|----------------|--------|
|    |                    | Bulan Maret 2026 | %     | Bulan April 2026 | %    | Bulan Mei 2026 | %      |
| 1  | KF 1 (6-4 jam)     | 109              | 100%  | 113              | 100% | 99             | 100%   |
| 2  | KF2: 3–7 hari      | 69               | 63,3% | 71               | 62,% | 69             | 69,6%  |
| 3  | KF 3 (8- 28 hari)  | 105              | 96,2% | 104              | 92%  | 84             | 84,8 % |
| 4  | KF4: 29–42 hari)   | 4                | 3,67% | 2                | 2,1% | 2              | 2%     |
|    | Σ kelahiran Normal | 40               |       | 42               |      | 30             |        |
|    | Σ kelahiran SC     | 69               |       | 71               |      | 69             |        |
|    | Total kelahiran    | 109              |       | 113              |      | 99             |        |

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

1. Dari tabel dan grafik 3.3.6 Kunjungan PNC KF 1 pada bulan Mei yaitu 99 pasien (100%), pada bulan April yaitu 113 pasien (100%), sedangkan pada bulan Maret 109 pasien (100%), ini artinya semua pasien post partum melakukan kunjungan pada KF1
2. Pada kunjungan KF 2 pada bulan Mei yaitu 69 pasien ( 69,6%), pada bulan April yaitu 67 pasien ( 71,2%), sedangkan pada bulan Maret 69 pasien (63,3%), capaian KF 2 belum 100% di karenakan pasien post partum normal hari ke 2 sudah diijinkan pulang dan jadwal kontrol ulang hari ke 8 pasca rawat inap.
3. Pada kunjungan KF 3 pada bulan Mei yaitu 84 pasien ( 84,8%) pada bulan April yaitu 104 pasien ( 92%) sedangkan pada bulan Maret yaitu 105 pasien ( 96,2%), capaian KF 3 belum 100% di karenakan masuk laporan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya.
4. Pada kunjungan KF 4 pada bulan Mei dan April yaitu 2 pasien (2,1%), sedangkan pada bulan Maret 4 pasien (3,67%), pada KF 4 cakupan hanya sedikit di karenakan pasien post partum dan post SC setelah kunjungan KF 3 pasien tidak ada komplikasi untuk pemantauan di kembalikan ke faskes 1, pasien KF 4 yang masih bias di layani di faskes 2 dikarenakan ada masalah seperti infeksi luka operasi atau infeksi jahitan perenium, Tekanan Darah pasien tinggi, evaluasi sisa selaput ketuban

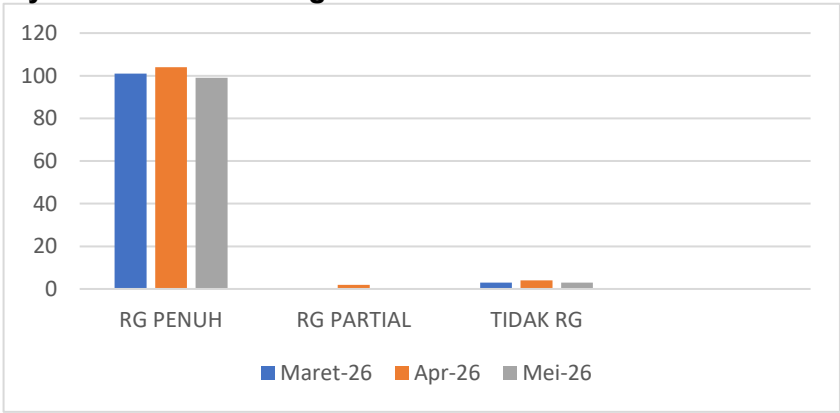
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas sesuai jadwal
2. Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
3. Melakukan eduaksi pentingnya KB pasca salin
4. Melakukan edukasi pemantauan nifas KF 4 di faskes 1

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung  
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponok April 2026

| No          | Uraian               | Jumlah Pasien    |       |                  |        |                |      |
|-------------|----------------------|------------------|-------|------------------|--------|----------------|------|
|             |                      | Bulan Maret 2026 | %     | Bulan April 2026 | %      | Bulan Mei 2026 | %    |
| 1           | Rawat gabung penuh   | 101              | 97,2% | 104              | 94,5 % | 99             | 97%  |
| 2           | Rawat gabung partial | 0                | 0%    | 2                | 1,8%   | 0              | 0%   |
| 3           | Tidak Rawat gabung   | 3                | 2,9%  | 4                | 3,6 %  | 3              | 2,9% |
| Σ Kelahiran |                      | 104              | -     | 110              | -      | 102            | -    |

Grafik Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2026 yaitu 99 (97%) bayi menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 104 (94,5%) bayi, sedangkan bulan Maret 2026 yaitu 101 (97,2% ) bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi, menurun jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 4 (3,6%) bayi, dan Maret 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi.
- Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

| Nama                | Diagnosa                                                                                              | Perawatan BBL    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| By Ny Miratus       | NKB + BBLR +RDS                                                                                       | CPEP + Inkubator |
| Ny Ny Fitri Nadhila | Pneumonia                                                                                             | CPEP + inkubator |
| By Ny Hindun        | Obs distres nafas ok<br>Neonatal Pneumonia dd<br>MAS, susp congenital<br>anomaly dd<br>achondroplasia | CPEP + inkubator |

- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

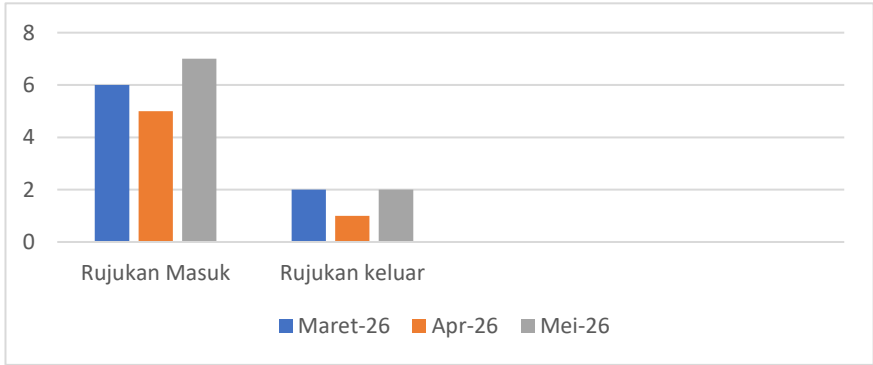
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2. Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3. Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4. Pelaksanaan **Kangaroo Mother Care (KMC)** pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan  
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponpek April 2026

| Rujukan        | Bulan<br>Maret<br>2026 | Bulan<br>April<br>2026 | Bulan<br>Mei<br>2026 |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Rujukan Masuk  | 6                      | 5                      | 7                    |
| Rujukan keluar | 2                      | 1                      | 2                    |

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Evaluasi :

- 1. Jumlah rujukan masuk pada bulan Mei 2026 menurun yaitu 7 rujukan, sedangkan pada bulan April 2026 menurun yaitu 5 rujukan, dan bulan Maret 2026 sebanyak 6 rujukan.
- 2. Jumlah rujukan keluar pada bulan Mei 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 2 rujukan, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 1 rujukan, dan Maret 2026 sebanyak 2 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2. Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk  
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Mei 2026

| Bulan Maret 2026 |                 |                                                         |                      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                | Ny Wiwik Puji A | G5 P2002 Ab200 UK 39-40 minggu dengan KPD + letak Obliq | PMB Munawaroh        |
| 2                | Ny Heny S       | Anemia + AUB                                            | Dr.Rifatul           |
| 3                | Ny Rika S       | G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KIFA              | Klinik Mutiara Sehat |
| 4                | Ny Irma S       | G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KPD + susp CPD    | PMB Titik S          |
| 5                | Ny Lelly Priga  | G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD               | PMB Titik S          |



|                         |                     |                                                                                     |                      |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6                       | Ny Cello velinda    | G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KPD + HT gestasional+ letak Obliq             | PMB Lilik A          |
| <b>Bulan April 2026</b> |                     |                                                                                     |                      |
| 1                       | Ny Chusna W         | G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA                                          | PKM Singosari        |
| 2                       | NY Dwi Oktavianti   | G4 P0000 Ab300 UK 38-39 minggu dengan KET                                           | RSUD Lawang          |
| 3                       | Ny Siti fatonah     | G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Kala 2 + letsu                                | PMB Lilik            |
| 4                       | Ny Darwati          | Syok hipovolemik ec AUB ec Mioma uteri                                              | PKM Lawang           |
| 5                       | Ny Nina             | G1 P0000 Ab000 UK 41-42 minggu dengan Kala 2                                        | PKM Jabung           |
| <b>Bulan Mei 2026</b>   |                     |                                                                                     |                      |
| 1                       | Ny Muspita Sari     | G4 P2002 Ab100 UK 18-20 minggu dengan IUFD                                          | KRI Putra Husada     |
| 2                       | Ny Sari Kurnia      | G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA                                          | Klinik Mutiara Sehat |
| 3                       | Ny Vio Eka          | G1 P0000 Ab000 UK 40 minggu dengan impending ekamsia                                | Klinik Mutiara Sehat |
| 4                       | Ny Siti Muyassyaroh | G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD                                           | PMB Munawaroh        |
| 5                       | Ny Alfiah           | G1 P0000 Ab000 UK 36-37 minggu dengan letsu + partus prematurus + KIFA + IUGR + PER | PMB Titik S          |
| 6                       | Ny Sofi Andini      | G3 P1001 Ab100 UK 38-39 minggu dengan KPD + KIFA                                    | PMB Lilik Agustina   |
| 7                       | Ny Anita            | G5 P4004 Ab000 UK 10-12 minggu dengan abortus inkomplit                             | PMB Titik Idmawanti  |

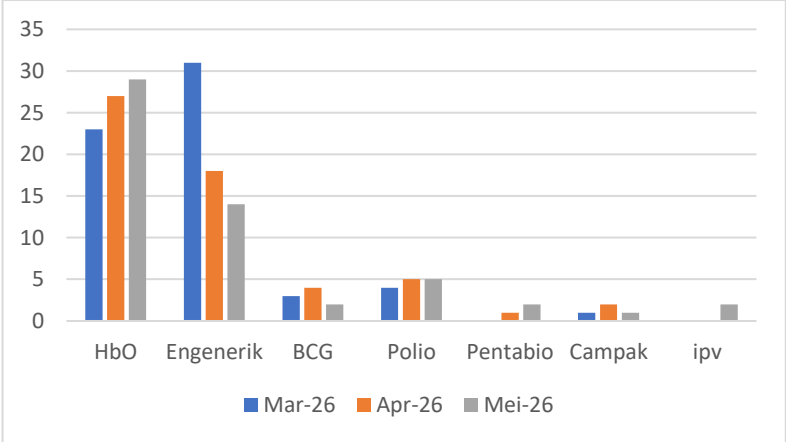
3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar  
Tabel Rujukan Keluar Ponpek Mei 2026

| No                      | Nama            | Usia   | Unit  | Diagnosa                                                                                  | Alasan Rujukan                                   | Tujuan Rujukan  |
|-------------------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bulan Maret 2026</b> |                 |        |       |                                                                                           |                                                  |                 |
| 1                       | By Ny Savira    | 1 hari | NICU  | RDS ok Neonatal pneumonia dd MAS                                                          | Pro Sub Spesialistik Neonatologi                 | RS Soepraoen    |
| 2                       | NY Aisyah Kayla | 30 th  | Ponek | G1 P0000 Ab000 Uk 32-34 minggu dengan PEB                                                 | Penatalaksanaan lebih lanjut                     | RS Saiful Anwar |
| <b>Bulan April 2026</b> |                 |        |       |                                                                                           |                                                  |                 |
| 1                       | By Ny sufiati   | 1 hari | NICU  | RDS ok HMD DD neonatal Pneumonia, BBLASR                                                  | Pro Sub Spesialistik Neonatologi                 | RS Saiful Anwar |
| <b>Bulan Mei 2026</b>   |                 |        |       |                                                                                           |                                                  |                 |
| 1                       | By Ny Miratus   | 0 hari | NICU  | NKB + BBLR + RDS                                                                          | Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfaktan | RS Saiful Anwar |
| 2                       | By Ny Hindun    | 4 hari | NICU  | Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia | Pro Sub Spesialistik Neonatologi                 | RS Saiful Anwar |

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi  
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponpek Mei 2026

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah           |        |                  |       |                |       |
|----|-----------------|------------------|--------|------------------|-------|----------------|-------|
|    |                 | Bulan Maret 2026 | %      | Bulan April 2026 | %     | Bulan Mei 2026 | %     |
| 1  | HbO             | 23               | 21,1%  | 27               | 23,9% | 29             | 28,4% |
| 2  | Engerix Junior  | 31               | 21,1%) | 18               | 15,9% | 14             | 13,7% |
| 3  | BCG             | 3                | -      | 4                | -     | 2              | -     |
| 3  | Polio           | 4                | -      | 5                | -     | 5              | -     |
| 4  | Pentabio        | 0                | -      | 1                | -     | 2              | -     |
| 5  | Campak          | 1                | -      | 2                | -     | 1              | -     |
| 6  | IPV             | 0                | -      | 0                | -     | 2              | -     |
|    | Σ Kelahiran     | 109              |        | 113              |       | 102            |       |

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

1. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Mei 2026 yaitu 29 (28,4%) pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yaitu 27 (23,9%) pasien, sedangkan pada bulan Maret 2026 yaitu 23 (21,1%) pasien, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
2. Pada bulan Mei ada 14 (13,7%) bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, menurun dibandingkan pada bulan April ada 18 (15,9%) bayi, sedangkan bulan Maret ada 31 (28%) bayi, Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
3. Bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Mei sebanyak 2, sedangkan bulan April 2026 dan Maret tidak ada.
4. Ada 2 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Mei 2026, dan menurun dibandingkan dengan April yaitu 4 bayi, sedangkan bulan Maret 3 bayi.
5. Ada 1 bayi yang Imunisasi Campak bulan Mei 2026, sedangkan bulan April ada 2 bayi, dan di bulan Maret ada 1 bayi.
6. Ada 5 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Mei dan April 2026, sedangkan bulan Maret ada 4 bayi.
7. Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Mei 2026, sedangkan pada bulan April ada 1 bayi, dan pada bulan Maret tidak ada. Imunisasi pentabio

diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

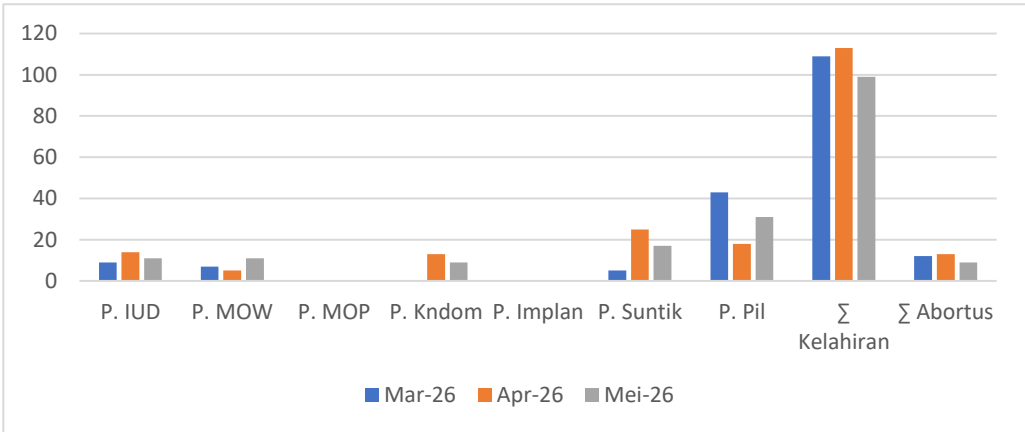
**Rencana dan Tindak Lanjut**

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

**3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)**  
**Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponpek Mei 2026**

| No | Jenis       | Jumlah Pasang    |       |                  |       |                |       |
|----|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
|    |             | Bulan Maret 2026 | %     | Bulan April 2026 | %     | Bulan Mei 2026 | %     |
| 1  | IUD         | 9                | 20,9% | 14               | 12,4% | 11             | 11,1% |
| 2  | MOW         | 7                | 17,3% | 5                | 4,4%  | 11             | 11,1% |
| 3  | MOP         | 0                | -     | 0                | -     | 0              | -     |
| 4  | Kondom      | 15               | 100%  | 13               | 100%  | 9              | 100%  |
| 5  | Implant     | 0                | -     | 0                | -     | 0              | -     |
| 6  | Suntikan    | 5                | -     | 25               | -     | 17             | -     |
| 7  | Pil         | 43               |       | 18               |       | 31             |       |
| 8  | Σ Kelahiran | 109              |       | 113              |       | 99             |       |
| 9  | Σ Abortus   | 15               |       | 13               |       | 9              |       |

**Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026**



**Aanalisis :**

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Mei 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 ( 11,1%) akseptor, pada bulan April 14 (12,4%) sedangkan pada bulan maret 9 (20,9%) Pemakaian IUD pasca salin dengan cakupan sedikit dikarenakan ada biaya jasa dokter 400.000 untuk IUD coper T, dan biaya IUD nova T 850.000.
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Mei 2026 sebanyak 11 (11,1%) pasien, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 5 (4,4%), dan bulan Maret sebanyak 7 (16,3%) pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 9 pasien, sedangkan pada bulan April 2025 sebanyak 13 pasien, dan pada bulan Maret sebanyak 15 pasien.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Mei 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 31 pengguna, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 18 pengguna, dan bulan Maret sebanyak 43 pengguna.

- Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Mei menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 pengguna, sedangkan bulan April 2026 sebanyak 25 pengguna, dan bulan Maret 2026 sebanyak 5 pengguna.

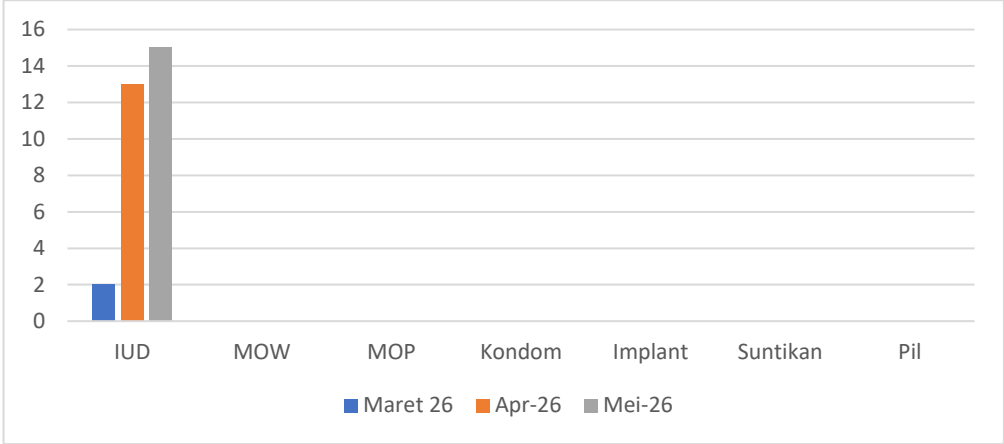
**Rencana dan Tindak Lanjut :**

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

**Pelayanan Pelepasan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026**

| No | Jenis    | Jumlah Lepas |            |          |
|----|----------|--------------|------------|----------|
|    |          | Maret 2026   | April 2026 | Mei 2026 |
| 1  | IUD      | 2            | 13         | 15       |
| 2  | MOW      | 0            | 0          | 0        |
| 3  | MOP      | 0            | 0          | 0        |
| 4  | Kondom   | 0            | 0          | 0        |
| 5  | Implant  | 0            | 0          | 0        |
| 6  | Suntikan | 0            | 0          | 0        |
| 7  | Pil      | 0            | 0          | 0        |

**Grafik Pelayanan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026**



**Analisis :**

- Pelepasan KB IUD pada bulan Mei 2026 meningkat yaitu 15 Akseptor, sedangkan pada bulan April 2026 yaitu 13 Akseptor, dan bulan Maret 2026 yaitu 2 Akseptor,
- Pelepasan KB Implan pada bulan April 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

**Rencana dan Tindak Lanjut :**

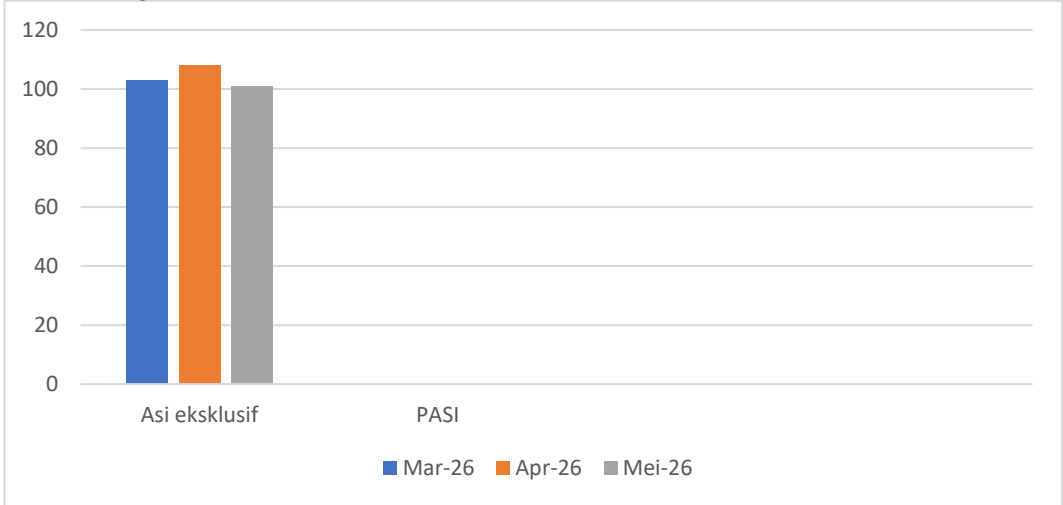
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

**3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif**

**Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Mei 2026**

| No          | Pemberian Asi | Jumlah Pasien    |      |                  |      |                |      |
|-------------|---------------|------------------|------|------------------|------|----------------|------|
|             |               | Bulan Maret 2026 | %    | Bulan April 2026 | %    | Bulan Mei 2026 | %    |
| 1           | Asi eksklusif | 103              | 100% | 108              | 100% | 101            | 100% |
| 2           | PASI          | 0                | 0%   | 0                | 0%   | 0              | 0%   |
| 3           | Puasa         | 1                |      | 2                |      | 1              |      |
| Σ kelahiran |               | 104              | -    | 110              | -    | 102            | -    |

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Mei yaitu 101 (100%) bayi, pada bulan April 2026 yaitu 108 (100%) bayi, sedangkan Maret sebanyak 103 (100%) bayi. Pemberian ASI sudah memenuhi target yaitu 100% Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

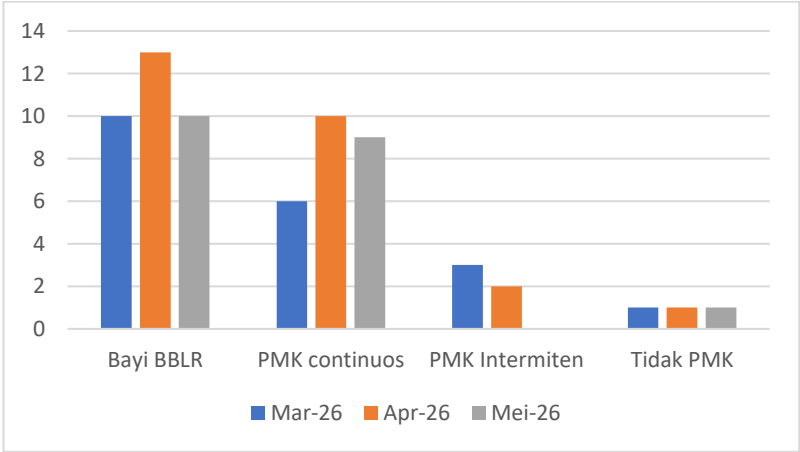
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal
- 2. Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR  
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Mei 2026

| No | Uraian         | Jumlah Pasien    |                  |                |
|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                | Bulan Maret 2026 | Bulan April 2026 | Bulan Mei 2026 |
| 1  | Bayi BBLR      | 10               | 13               | 10             |
| 2  | PMK continuos  | 6                | 10               | 9              |
| 3  | PMK Intermiten | 3                | 2                | 0              |
| 4  | Tidak PMK      | 1                | 1                | 1              |

Grafik Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Mei 2026



**Analisis :**

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2. Tidak ada pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Mei 2026, sedangkan pada bulan April 2026 ada 2 bayi, dan bulan Maret ada 3 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan April 2026 sebanyak 9 bayi, sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 10 bayi , dan Maret sebanyak 6 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4. Ada 1 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Mei dan 2 bulan sebelumnya, Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa NCB, BBLR dan RDS dan bayi di rujuk ke RS lain.

**Rencana dan Tindak Lanjut**

- 1. Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
- 2. Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

**1.1.2.2. TB DOT’S**

**3.1.2.2.2 Skrining Pasien**

| NO | JENIS SKRINING                                                              | JUMLAH PASIEN |     |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|-----|
|    |                                                                             | APRIL         | MEI | JUNI |     |
| 1. | Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB                              | 0             | 0   |      |     |
| 2  | Pemberian Masker pada Keluarga TB+                                          | 0             | 0   |      |     |
| 3  | Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah | 0             | 0   |      |     |

**Evaluasi :**

- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

**Rencana dan Tindak Lanjut:**

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

**3.1.2.2.1 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi**

**3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis Bulan Maret 2026**

| No | Pelaksanaan | Usia | Px Mantoux | TCM Bakteriologis | Foto X Ray | Hasil PA |
|----|-------------|------|------------|-------------------|------------|----------|
| 1. | 02/03/2026  | 49TH | -          | Negatif           | Positif    | -        |
| 2  | 03/03/2026  | 46TH | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 3  | 04/03/2026  | 68TH | -          | Positif           | Positif    | -        |

|    |              |      |          |          |          |          |
|----|--------------|------|----------|----------|----------|----------|
| 4  | 16/03/2026   | 24TH | -        | Negatif  | Negatif  | Positif  |
| 5  | 16/03/2026   | 26TH | -        | Negatif  | Positif  | -        |
| 6  | 07/03/2026   | 71TH | -        | Positif  | Negatif  | -        |
| 7  |              |      |          |          |          |          |
| 8  |              |      |          |          |          |          |
| 9  |              |      |          |          |          |          |
| 10 |              |      |          |          |          |          |
|    | <b>Total</b> |      | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>1</b> |

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis  
Bulan April 2026

| No | Pelaksanaan  | Usia  | Px Mantoux | TCM Bacteriologis | Foto X Ray | Hasil PA |
|----|--------------|-------|------------|-------------------|------------|----------|
| 1. | 01/04/2026   | 36 th | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 2  | 07/04/2026   | 24 th | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 3  | 08/04/2026   | 49th  | -          | Negatif           | Positif    | -        |
| 4  | 10/04/2026   | 71th  | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 5  | 13/04/2026   | 76th  | -          | Negatif           | Positif    | -        |
| 6  | 14/04/2026   | 74th  | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 7  | 25/04/2026   | 2th   | Negatif    | -                 | Negatif    | Positif  |
| 8  | 29/04/2026   | 61th  | -          | Negatif           | Positif    | -        |
| 9  |              |       |            |                   |            |          |
| 10 |              |       |            |                   |            |          |
| 11 |              |       |            |                   |            |          |
| 12 |              |       |            |                   |            |          |
| 13 |              |       |            |                   |            |          |
|    | <b>Total</b> |       | <b>1</b>   | <b>4</b>          | <b>7</b>   | <b>1</b> |

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis  
Bulan Mei 2026

| No | Pelaksanaan  | Usia | Px Mantoux | TCM Bacteriologis | Foto X Ray | Hasil PA |
|----|--------------|------|------------|-------------------|------------|----------|
| 1. | 04/05/2026   | 28th | -          | Negatif           | Negatif    | Positif  |
| 2  | 06/05/2026   | 42th | -          | Negatif           | Positif    | -        |
| 3  | 07/05/2026   | 74th | -          | Positif           | Positif    | -        |
| 4  | 14/05/2026   | 1th  | Negatif    | -                 | Negatif    | Positif  |
| 5  | 28/05/2026   | 20th | -          | Positif           | Negatif    | -        |
| 6  |              |      |            |                   |            |          |
| 7  |              |      |            |                   |            |          |
| 8  |              |      |            |                   |            |          |
| 9  |              |      |            |                   |            |          |
| 10 |              |      |            |                   |            |          |
|    | <b>Total</b> |      |            | <b>2</b>          | <b>2</b>   | <b>2</b> |

**Analisis :**

1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

**Rencana dan Tindak Lanjut :**

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

**3.1.2.2.1 Penemuan Kasus TB**

| No | Unit          | Jumlah Pasien |          |      |
|----|---------------|---------------|----------|------|
|    |               | April         | Mei      | Juni |
| 1. | Poli Paru     | 5             | 2        |      |
| 2  | Poli Bedah    |               |          |      |
| 3  | Poli IPD      |               |          |      |
| 4  | Poli Anak     | 1             | 1        |      |
| 5  | Irna 2C       |               |          |      |
| 6  | ICU           |               | 1        |      |
| 7  | IGD           |               |          |      |
| 8  | Irna 2A       |               |          |      |
| 9  | Irna 3C anak  |               |          |      |
| 10 | Irna 3A       |               |          |      |
| 11 | Irna 4A       |               |          |      |
| 12 | Maternitas 4C |               |          |      |
| 13 | Irna 5C       | 2             | 1        |      |
| 14 | Irna 6A       |               |          |      |
| 15 | Irna 7A       |               |          |      |
| 16 | Irna 8A       |               |          |      |
|    | <b>Total</b>  | <b>8</b>      | <b>5</b> |      |

**Analisis :**

1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 0 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 0 pasien dan pasien negative 0 pasien

**Rencana dan Tindak Lanjut:**

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.



### 3.1.2.2.2 Jumlah Kunjungan pasien TB

| No | Kegiatan                        | Jumlah Pasien |     |      | Jumlah Total Pasien TB |
|----|---------------------------------|---------------|-----|------|------------------------|
|    |                                 | April         | Mei | Juni | Total                  |
| 1. | Pasien TB kunjungan keseluruhan | 63            | 49  |      |                        |
| 2  | Pasien RFC (OAT Protolan)       | 0             | 4   |      |                        |
| 3  | Pasien RFT                      | 8             | 5   |      |                        |

#### Analisis:

1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan April mencapai 63 pasien, di bulan Mei 49 pasien, dan di bulan Juni 0 pasien.
2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan April 0 pasien, di bulan Mei 4 pasien dan di bulan Juni 0 pasien.
3. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFT di bulan April 8 pasien, di bulan Mei 5 pasien dan di bulan Juni 0 pasien.

#### Rencana dan Tindak Lanjut :

Meningkatkan kunjungan pasien

### 3.1.2.2.3 Pemberian Obat Pencegahan

| No | Pemberian Obat Pencegahan                            | Jumlah Pasien |     |      |
|----|------------------------------------------------------|---------------|-----|------|
|    |                                                      | April         | Mei | Juni |
| 1. | Sasaran keluarga pasien yang kontak dengan pasien TB | 8             | 5   |      |

#### Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

#### Rencana dan Tindak Lanjut

1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

### 3.1.2.2.4 Pemberian Imunisasi BCG

| NO | KEGIATAN                | JUMLAH PASIEN |     |      |
|----|-------------------------|---------------|-----|------|
|    |                         | APRIL         | MEI | JUNI |
| 1. | Pemberian imunisasi BCG | 4             | 2   |      |

#### Evakuasi :

1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan April
2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 0 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.5 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan April 2026

| No | Kegiatan                     | Nama Pasien | Patuh | Tidak Patuh | Alasan |
|----|------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|
| 1. | dr. Andy, Sp. P(K)           | Ny.I        | V     |             |        |
|    |                              | Ny.H        | V     |             |        |
|    |                              | Tn. R       | V     |             |        |
|    |                              | Tn. I       | V     |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
| 2. | dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK | Ny. S       | V     |             |        |
|    |                              | Ny.K        | V     |             |        |
|    |                              | Tn.D        | V     |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
| 3. | dr. Fiona Paramitha. Sp.A    |             |       |             |        |
| 3. | dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed      | An. A       | V     |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |

3.1.2.2.6 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Mei 2026

| No | Kegiatan                     | Nama Pasien | Patuh | Tidak Patuh | Alasan                                 |
|----|------------------------------|-------------|-------|-------------|----------------------------------------|
| 1. | dr. Andy, Sp. P(K)           | Ny.D        | V     |             |                                        |
|    |                              | Tn. A       | V     |             |                                        |
|    |                              |             |       |             |                                        |
| 2. | dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK | Tn. NP      | V     |             |                                        |
|    |                              | Tn. B       | V     |             | MENINGGAL<br>SEBELUM<br>PENGOBATA<br>N |
|    |                              |             |       |             |                                        |
| 3. | dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed      |             |       |             |                                        |
| 4. | dr. Ratih.Sp.A.M.Biomed      | An. A       | V     |             |                                        |

3.1.2.2.7 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juni 2026

| No | Kegiatan                     | Nama Pasien | Patuh | Tidak Patuh | Alasan |
|----|------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|
| 1. | dr. Andy, Sp. P(K)           |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
| 2. | dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |
|    |                              |             |       |             |        |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 3 |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

**Analisis :**  
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

**3.1.2.2.7 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD**

| No | Kegiatan                                              | Jumlah Pasien |      |      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|------|------|
|    |                                                       | April         | Mei  | Juni |
| 1. | Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95   | 100%          | 100% |      |
| 2  | Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah | 100%          | 100% |      |
| 3  | Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort             | 100%          | 100% |      |

**Analisis:**  
 Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

**3.1.2.2.8 Penempatan Pasien TB**

| No | Penempatan Paien TB             | Jumlah Pasien |      |      |
|----|---------------------------------|---------------|------|------|
|    |                                 | April         | Mei  | Juni |
| 1. | Penempatan pasien TB IGD        | 100%          | 100% |      |
| 2  | Penempatan pasien TB Poli Paru  | 100%          | 100% |      |
| 3  | Penempatan pasien TB di IRNA 5c | 100%          | 100% |      |

**Analisis:**  
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
 Mempertahankan penempatan dengan benar

**3.1.2.2.9 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan April 2026**

| No | Unit      | Nama Pasien | Baru | Lama | Bulan April | Tempat Rujukan  | Alasan                                     |
|----|-----------|-------------|------|------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1. | Poli Paru | Ny.S        | V    | -    | 1           | PKM Karangploso | Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya |

|    |               |      |   |   |   |               |                                            |
|----|---------------|------|---|---|---|---------------|--------------------------------------------|
|    | Poli Paru     | Tn.D | V | - | 1 | PKM Singosari | Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya |
| 2  | Poli Bedah    |      |   |   |   |               |                                            |
| 3  | Poli IPD      |      |   |   |   |               |                                            |
| 4  | Poli Anak     |      |   |   |   |               |                                            |
| 5  | Irna 2C       |      |   |   |   |               |                                            |
| 6  | ICU           |      |   |   |   |               |                                            |
| 7  | IGD           |      |   |   |   |               |                                            |
| 8  | Irna 2A       |      |   |   |   |               |                                            |
| 9  | Irna 3C anak  |      |   |   |   |               |                                            |
| 10 | Irna 3A       |      |   |   |   |               |                                            |
| 11 | Irna 4A       |      |   |   |   |               |                                            |
| 12 | Maternitas 4C |      |   |   |   |               |                                            |
| 13 | Irna 5C       |      |   |   |   |               |                                            |
| 14 | Irna 6A       |      |   |   |   |               |                                            |
| 15 | Irna 7A       |      |   |   |   |               |                                            |
| 16 | Irna 8A       |      |   |   |   |               |                                            |
|    | <b>Total</b>  |      |   |   |   |               |                                            |

3.1.2.2.10 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Mei 2026

| No | Unit          | Nama Pasien | Baru | Lama | Bulan Mei | Tempat Rujukan | Alasan |
|----|---------------|-------------|------|------|-----------|----------------|--------|
| 1. | Poli Paru     |             |      |      |           |                |        |
|    | Poli Paru     |             |      |      |           |                |        |
| 2  | Poli Bedah    |             |      |      |           |                |        |
| 3  | Poli IPD      |             |      |      |           |                |        |
| 4  | Poli Anak     |             |      |      |           |                |        |
| 5  | Irna 2C       |             |      |      |           |                |        |
| 6  | ICU           |             |      |      |           |                |        |
| 7  | IGD           |             |      |      |           |                |        |
| 8  | Irna 2A       |             |      |      |           |                |        |
| 9  | Irna 3C anak  |             |      |      |           |                |        |
| 10 | Irna 3A       |             |      |      |           |                |        |
| 11 | Irna 4A       |             |      |      |           |                |        |
| 12 | Maternitas 4C |             |      |      |           |                |        |
| 13 | Irna 5C       |             |      |      |           |                |        |
| 14 | Irna 6A       |             |      |      |           |                |        |
| 15 | Irna 7A       |             |      |      |           |                |        |
| 16 | Irna 8A       |             |      |      |           |                |        |
|    | <b>Total</b>  |             |      |      |           |                |        |

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Juni 2026

| No | Unit          | Nama Pasien | Baru | Lama | Bulan Juni | Tempat Rujukan | Alasan |
|----|---------------|-------------|------|------|------------|----------------|--------|
| 1. | Poli Paru     |             |      |      |            |                |        |
| 2  | Poli Bedah    |             |      |      |            |                |        |
| 3  | Poli IPD      |             |      |      |            |                |        |
| 4  | Poli Anak     |             |      |      |            |                |        |
| 5  | Irna 2C       |             |      |      |            |                |        |
| 6  | ICU           |             |      |      |            |                |        |
| 7  | IGD           |             |      |      |            |                |        |
| 8  | Irna 2A       |             |      |      |            |                |        |
| 9  | Irna 3C anak  |             |      |      |            |                |        |
| 10 | Irna 3A       |             |      |      |            |                |        |
| 11 | Irna 4A       |             |      |      |            |                |        |
| 12 | Maternitas 4C |             |      |      |            |                |        |
| 13 | Irna 5C       |             |      |      |            |                |        |
| 14 | Irna 6A       |             |      |      |            |                |        |
| 15 | Irna 7A       |             |      |      |            |                |        |
| 16 | Irna 8A       |             |      |      |            |                |        |
|    | Total         |             |      |      |            |                |        |

Analisis :

- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 2 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP karena memilih lebih dekat dengan rumahnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

| No | Kegiatan           | Jumlah Pasien |      |      | ED    |
|----|--------------------|---------------|------|------|-------|
|    |                    | April         | Mei  | Juni |       |
| 1. | OAT Anak           | 3             | 2    |      | 01/27 |
| 2. | OAT Harian Dewasa  | 10            | 4    |      | 11/26 |
| 3. | Ethambutol 250 mg  | 0             | 0    |      | 0     |
| 4. | Ethambutol 400 mg  | 0             | 0    |      | 0     |
| 5. | Pirazinamid 500 mg | 632           | 632  |      | 05/27 |
| 6. | Isoniazid 300 mg   | 404           | 304  |      | 08/26 |
| 7. | Rimfapicin 450 mg  | 1082          | 1082 |      | 03/28 |
| 8. | Rimfapicin 300 mg  | 0             | 0    |      | 0     |

**Analisis :**  
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

| No | Unit | Jenis TB           | Jumlah Pasien |        |      |      |        |      |
|----|------|--------------------|---------------|--------|------|------|--------|------|
|    |      |                    | April         |        | Mei  |      | Juni   |      |
|    |      |                    | Anak          | Dewasa | Anak | Anak | Dewasa | Anak |
| 1. |      | Pasien paru        | 0             | 7      | 0    | 3    |        |      |
| 2. |      | Pasien Ekstra paru | 1             | 0      | 1    | 1    |        |      |

- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru
  - 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 3 pasien paru
  - 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien ekstra paru dan 0 pasien paru

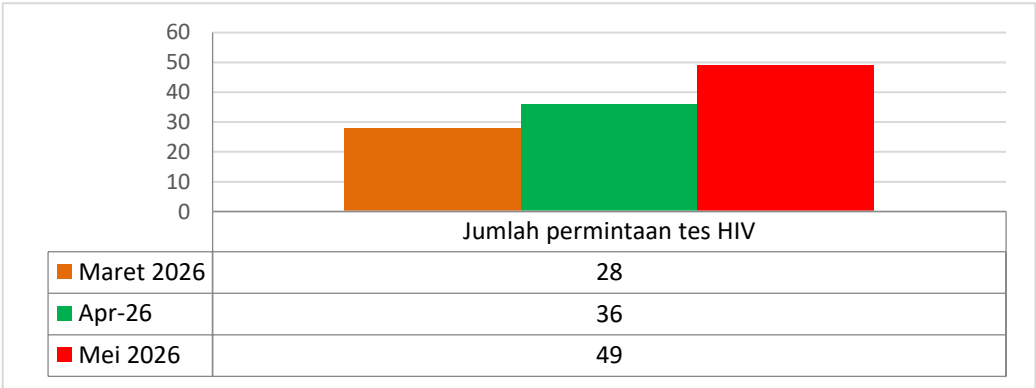
**Rencana dan Tindak Lanjut :**  
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

| No | URAIAN              | BULAN      |            |          |
|----|---------------------|------------|------------|----------|
|    |                     | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Permintaan Test HIV | 28         | 36         | 49       |

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2026



**Analisis :**  
Jumlah permintaan pelayanan HIV mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Bulan Maret 2026 sebanyak 28 pemeriksaan, pada bulan April 2026 sebanyak 36 pemeriksaan sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 49 pemeriksaan yang berasal dari Asal permintaan test diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.

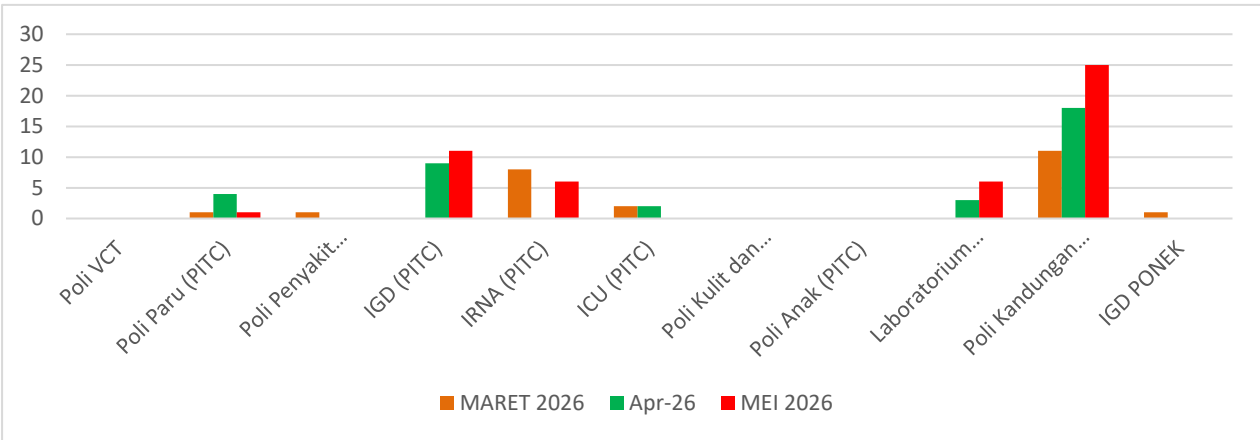
**Rencana Tindak Lanjut :**  
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan

HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.15 Asal Permintaan Tes HIV

| NO | UNIT / KLINIK ASAL PERMINTAAN | BULAN      |            |           |
|----|-------------------------------|------------|------------|-----------|
|    |                               | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026  |
| 1  | Poli VCT                      | 0          | 0          | 0         |
| 2  | Poli Paru (PITC)              | 1          | 4          | 1         |
| 3  | Poli Penyakit Dalam (PITC)    | 1          | 0          | 0         |
| 4  | IGD (PITC)                    | 0          | 9          | 11        |
| 7  | IRNA (PITC)                   | 8          | 0          | 6         |
| 8  | ICU (PITC)                    | 2          | 2          | 0         |
| 9  | Poli Kulit dan kelamin (PITC) | 0          | 0          | 0         |
| 10 | Poli Anak (PITC)              | 0          | 0          | 0         |
| 11 | Laboratorium (PITC)           | 0          | 3          | 6         |
|    | <b>Total PITC</b>             | <b>12</b>  | <b>18</b>  | <b>24</b> |
| 12 | Poli Obgyn (PMTCT)            | 11         | 18         | 25        |
| 13 | IGD PONEK                     | 1          | 0          | 0         |
|    | <b>Total PMTCT</b>            | <b>12</b>  | <b>18</b>  | <b>25</b> |
|    | <b>Total PITC + PMTCT</b>     | <b>24</b>  | <b>36</b>  | <b>49</b> |

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Mei 2026



Analisis :

- 1) Unit Asal permintaan Yang meminta pelayanan HIV di bulan Mei 2026 diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.
- 2) Jumlah tertinggi permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di bulan Mei 2026 yaitu dari poli Kandungan sebanyak 25 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV dan pemeriksaan triple eliminasi.
- 3) Jumlah terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di bulan Mei 2026 yaitu dari poli VCT yaitu 0 tidak ada permintaan. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS
- 4) Poli terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV yaitu dari poli VCT bisa dilakukan peningkatan permintaan pemeriksaan pelayanan HIV dengan dilakukanya edukasi terkait pentingnya screening HIV
- 5) Unit yang masuk PITC diantaranya, poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, IGD, IRNA dan ICU dengan jumlah total di di bulan Mei 2026 sebanyak 24 pasien. Sedangkan yang masuk PMTCT diantaranya poli kandungan dan IGD PONEK dengan jumlah total di di bulan Mei 2026 sebanyak 25 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

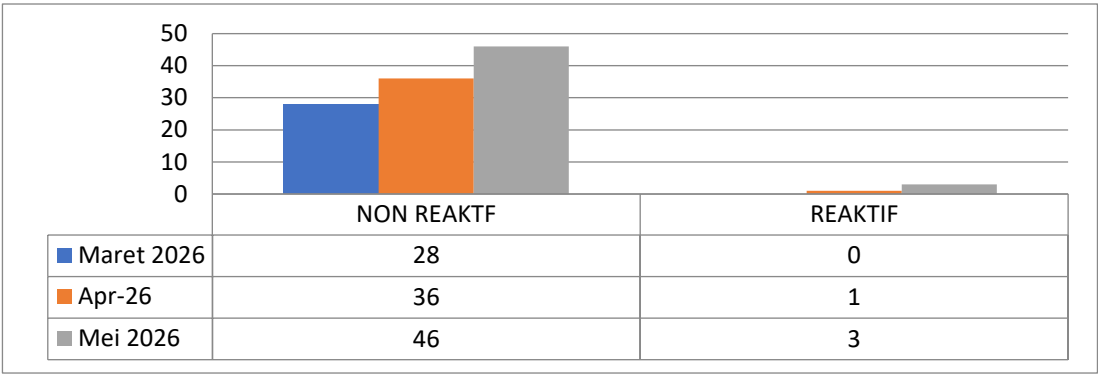
Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD,

rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

| No | URAIAN      | BULAN      |            |          |
|----|-------------|------------|------------|----------|
|    |             | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Non Reaktif | 28         | 36         | 46       |
| 2  | Reaktif     | 0          | 1          | 3        |

Grafik Status HIV Mei 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada bulan Maret 2026 tidak ditemukan pasien yang reaktif HIV, pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari ICU isolasi. Sedangkan pada bulan Mei terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari

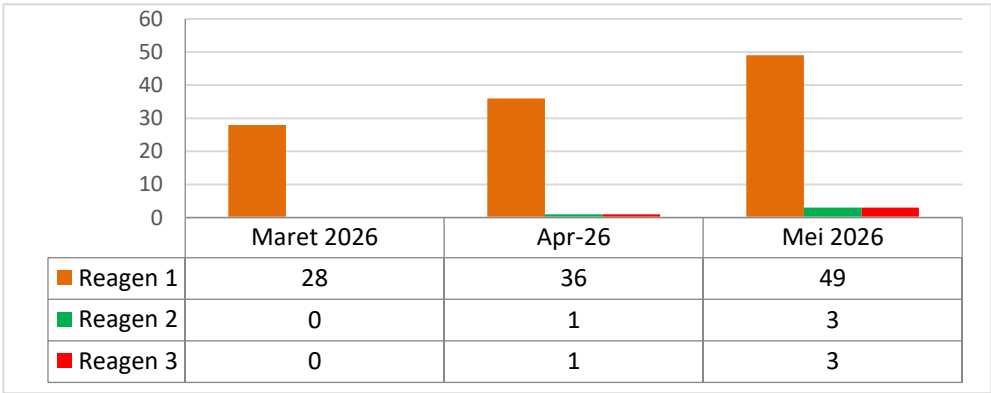
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.16 Jumlah Pemakaian Reagen

| No | URAIAN   | BULAN      |            |          |
|----|----------|------------|------------|----------|
|    |          | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Reagen 1 | 28         | 36         | 49       |
| 2  | Reagen 2 | 0          | 1          | 3        |
| 3  | Reagen 3 | 0          | 1          | 3        |

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Mei 2026





**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Maret 2026 hanya memakai reagen 1 saja sebanyak 28 reagen. pada bulan April 2026 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2026 memakai 3 reagen dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 3 pasien.

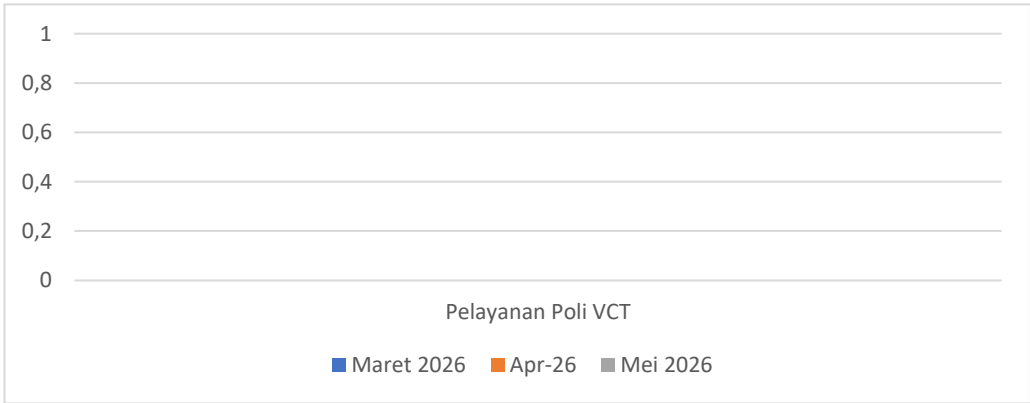
**Rencana Tindak Lanjut :**

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.  
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

**3.7.17 Pelayanan Poli VCT ( Voluntary Conseling And Testing )**

| No | URAIAN             | BULAN      |            |          |
|----|--------------------|------------|------------|----------|
|    |                    | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Pelayanan Poli VCT | 0          | 0          | 0        |

**Grafik Pelayanan Poli VCT April 2026**



**Analisis pelayanan Poli VCT**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

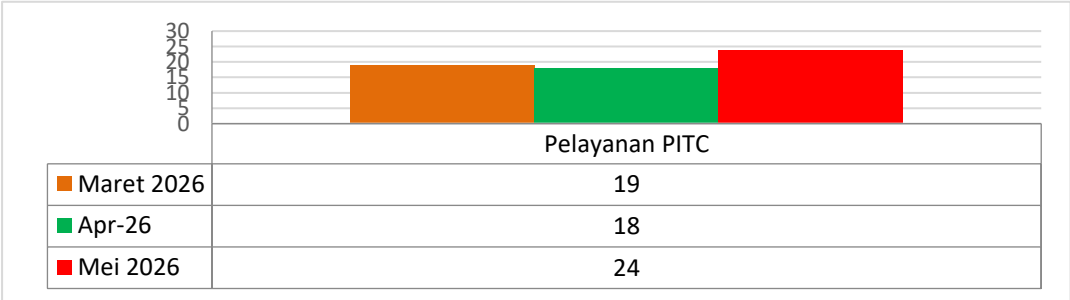
**Rencana Tindak Lanjut**

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

**3.7.18 Pelayanan PITC ( Provider Initiated Testing and Counseling )**

| No | URAIAN         | BULAN      |            |          |
|----|----------------|------------|------------|----------|
|    |                | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Pelayanan PITC | 19         | 18         | 24       |

**Grafik Pelayanan PITC Mei 2026**



**Analisis :**

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan february 2026 sebanyak 22 pasien, pada bulan Maret 2026 sebanyak 19 pasien. Sedangkan pada bulan April 2026 sebanyak 18 pasien.

Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

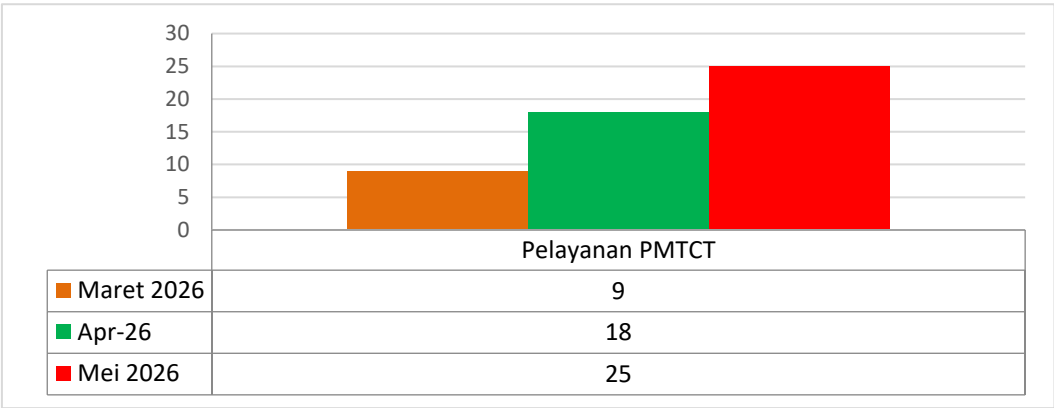
**Rencana Tindak Lanjut :**

Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

**3.7.19 Pelayanan PMTCT ( Prevention to Mother Of Child Transmision )**

| No | URAIAN          | BULAN         |               |             |
|----|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|    |                 | MARET<br>2026 | APRIL<br>2026 | MEI<br>2026 |
| 1  | Pelayanan PMTCT | 9             | 18            | 25          |

**Grafik Pelayanan PMTCT Mei 2026**



**Analisis :**

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien. pada bulan April 2026 naik menjadi 18 pasien. Sedangkan pada bulan mei 2026 sebanyak 25 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

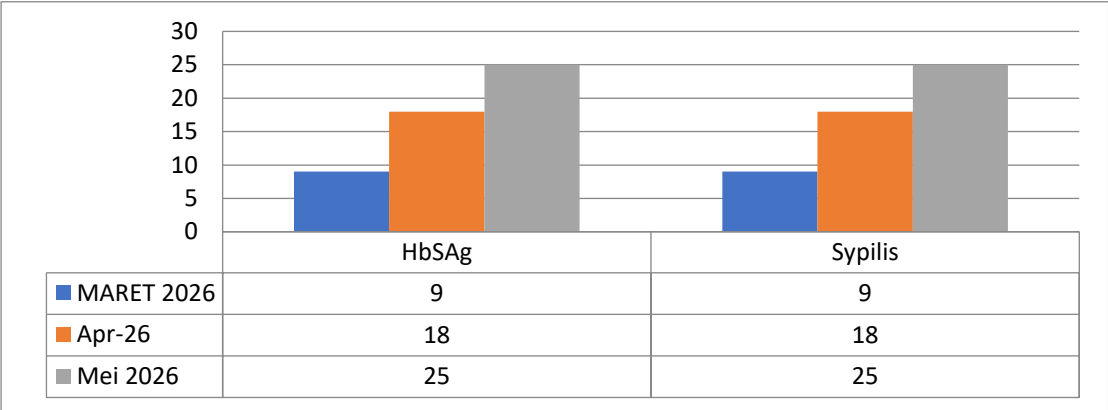
**Rencana Tindak Lanjut :**

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

**3.7.20 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil**

| No | URAIAN  | BULAN         |               |             |
|----|---------|---------------|---------------|-------------|
|    |         | MARET<br>2026 | APRIL<br>2026 | MEI<br>2026 |
| 1  | HbSAg   | 9             | 18            | 25          |
| 2  | Sypilis | 9             | 18            | 25          |

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil  
Mei 2026



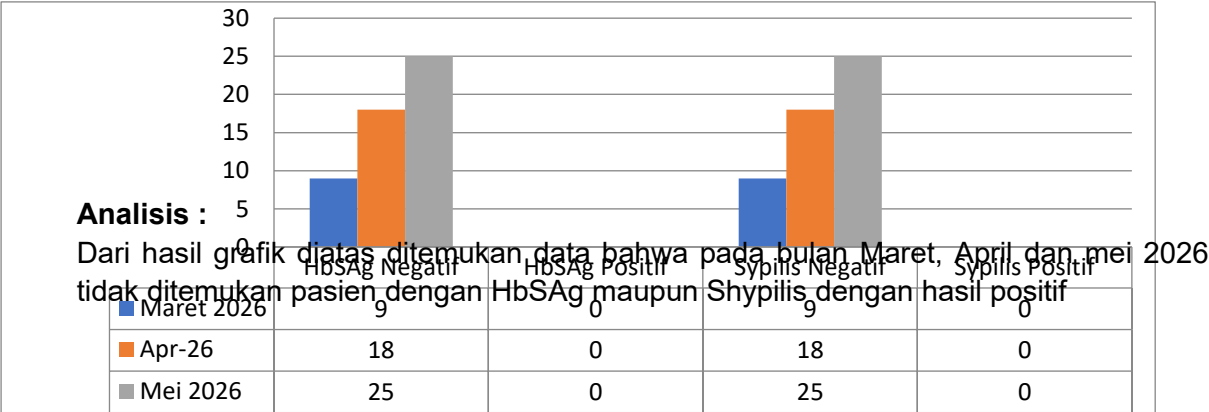
**Analisis :**  
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan Maret 2026 sebanyak 9 pasien yang dilakukan pemeriksaan. pada bulan April 2026 sebanyak 18 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 25 pasien  
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

**Rencana Tindak lanjut :**  
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.21 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

| No | URAIAN  | BULAN      |            |          |
|----|---------|------------|------------|----------|
|    |         | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | HbSAg   |            |            |          |
|    | Negatif | 9          | 18         | 25       |
|    | Positif | 0          | 0          | 0        |
| 2  | Sypilis |            |            |          |
|    | Negatif | 9          | 18         | 25       |
|    | Positif | 0          | 0          | 0        |

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Mei 2026



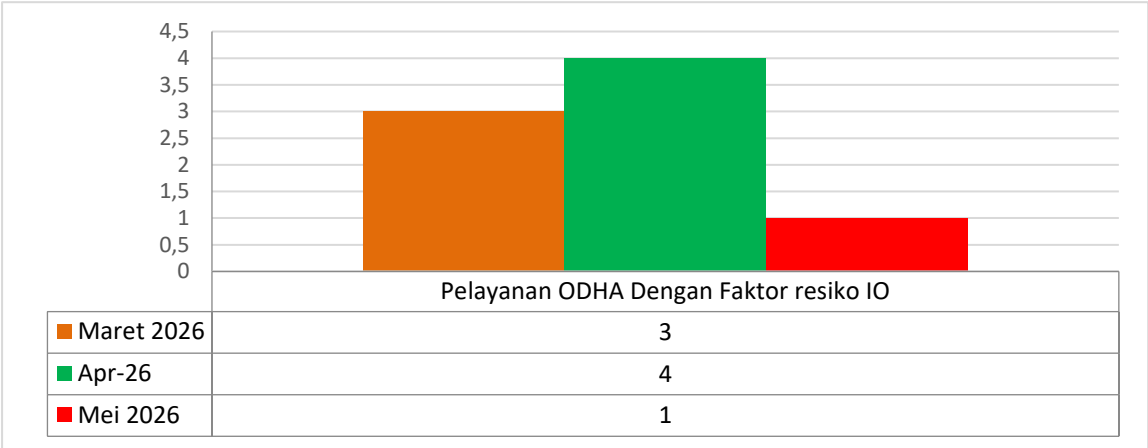
**Rencana Tindak Lanjut :**

1. Pada pasien HbSAg  
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis  
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

**3.7.22 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik**

| NO | URAIAN                                                                   | BULAN      |            |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|    |                                                                          | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
| 1  | Jumlah Pelayanan ODHA dg IO (Pasien TB Positif dilakukan pemeriksaan HIV | 3          | 4          | 1        |
| 2  | Pasien TB Positif dengan HIV positif                                     | 0          | 0          | 0        |

**Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Mei 2026**



**Analisis :**

1. Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien TB yang dilakukan pemeriksaan HIV pada bulan Maret 2026 sebanyak 4 pasien. pada bulan April 2026 sebanyak 4 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 1 pasien.
2. Hasil pemeriksaan HIV pasien TB Pada bulan Maret s/d bulan Mei 2026 tidak ada yang positif HIV.

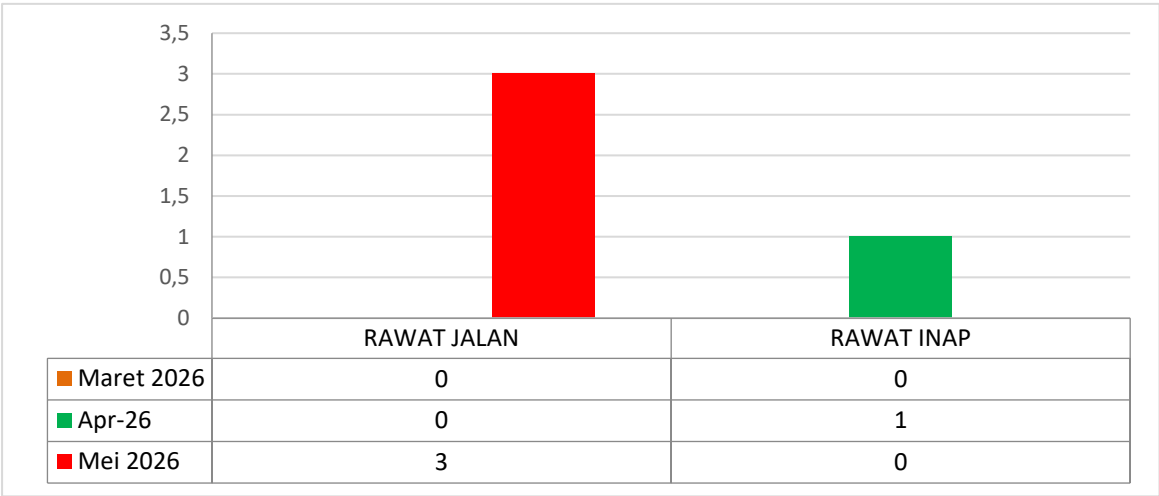
**Rencana Tindak Lanjut :**

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.7.23 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

| No | URAIAN      | BULAN         |               |             |
|----|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    |             | MARET<br>2026 | APRIL<br>2026 | MEI<br>2026 |
| 1  | Rawat Jalan | 0             | 0             | 3           |
| 2  | Rawat Inap  | 0             | 1             | 0           |

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Mei 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Maret 2026 tidak terdapat pasien yang dilakukan rujuk, baik dari rawat jalan maupun rawat inap. pada bulan April 2026 terapat 1 pasien yang dilakukan rujuk dari ICU isolasi Sedangkan pada bulan Mei 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk dari IRNA  
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Mei 2026

| NO | KEGIATAN POKOK                                                                                               | RINCIAN KEGIATAN                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting | Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting. |
| 2  | Program 1000 HPK                                                                                             | Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien                                |
| 3  | Suplementasi Folat Pada Ibu hamil                                                                            | Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang                                                                              |
| 4  | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil                                                              | Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang                                                                      |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif                  | 1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan<br>2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas<br>3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan |
| 6  | Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)                    | Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada                                                                                                                                                                               |
| 7  | Pemberian imunisasi                                                                  | Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.                                                                                                                                |
| 8  | Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang                                        | Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi                                                | 1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal.<br>2. Konseling pemberian ASI eksklusif.<br>3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif                                                                                                                      |
| 10 | Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting                         | 1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita<br>2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak.<br>3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.  |
| 11 | Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan | Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | Program Pemantauan dan Evaluasi                                                      | Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.                                                                                                                                                                                          |

**Analisis**

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2
Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

| Program          | Kegiatan                                        | Sasaran                           | Lokasi                  | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| Program 1000 HPK | Penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan | Pengunjung RS Prima Husada Malang | IRJA anak dan Kandungan | 1x         | 1x         | 1x       |

|                                                                     |                                                                                        |                                               |                                                         |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Suplementasi Asam folat pada ibu hamil                              | 1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil                    | Ibu Hamil                                     | Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5 | 1x         | 1x         | 1x         |
|                                                                     | 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat                                        | Ibu Hamil                                     | Poli kandungan                                          | 491 pasien | 485 pasien | 371 pasien |
| Pemberian PMT Ibu Hamil                                             | 1.Pemberian PMT pemulihan dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK | Ibu Hamil                                     | Senam hamil                                             | 2x         | 2x         | 2x         |
|                                                                     | 2.Pemberian PMT penyuluhan pada ibu hamil                                              | Ibu Hamil                                     | Senam hamil                                             | 1x         | 1x         | 1x         |
| Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif | Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif           | Ibu hamil                                     | IRJA anak dan kandungan, irna maternitas                | 105 pasien | 108 pasien | 103 pasien |
| Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)                              | 1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita                     | Pasien poli anak dan IRNA Anak                | IRJA                                                    | 2x         | 1x         | 1x         |
|                                                                     | 2. Pemberian makanan Bayi dan Anak                                                     | Pasien IRNA Anak                              | IRNA                                                    | 164 pasien | 198 pasien | 224 pasien |
| Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)   | Melakukan pencatatan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak terdeteksi       | Pasien IRNA Anak terdeteksi wasting/ stunting | IRJA anak                                               | 4          | 6          | 4          |

|                                               |                                                                                                                       |                                 |                            |          |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|
|                                               | stunting/<br>wasting                                                                                                  |                                 |                            |          |           |           |
| Pemberian Imunisasi                           | Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak                                                   | Pasien anak dan Bayi baru lahir | IRJA anak                  | 6 pasien | 14 pasien | 15 pasien |
| Pemberian vitamin A                           | Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian vitamin A pada anak-anak                                                     | Pasien anak                     | IRJA anak                  | 2x       | 0x        | 0x        |
| Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang | Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan | Pasien anak                     | Rawat Inap                 | 4 pasien | 6 pasien  | 4 pasien  |
| Pemberian Taburia pada Baduta                 | Penyuluhan mengenai pemberian bubuk taburia                                                                           | Pasien anak                     | Rawat Inap dan Rawat Jalan | 1x       | 0x        | 0x        |
| Pemberian Obat cacing pada ibu hamil          | Penyuluhan mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil                                                              | Ibu Hamil                       | Rawat Inap dan Rawat Jalan | 1x       | 0x        | 1x        |

**Analisis :**  
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas, Rumah Sakit hanya memberikan dalam bentuk PMT penyuluhan.

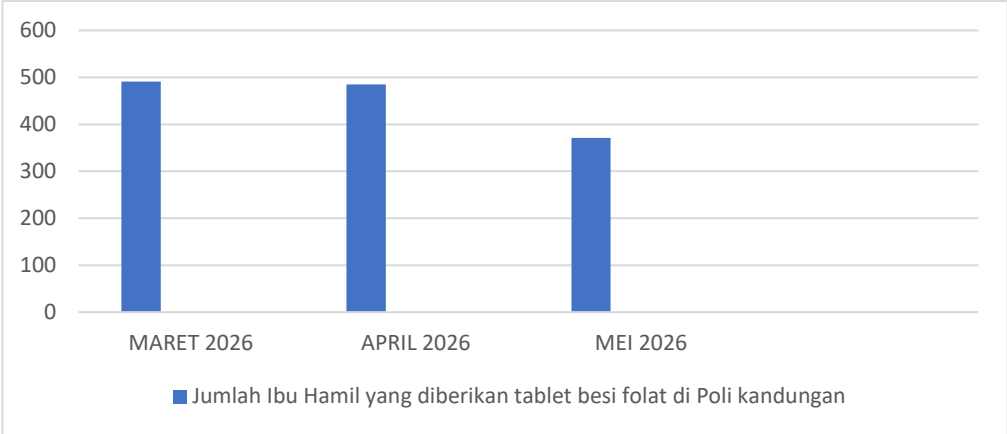
**Rencana Tindak Lanjut :**  
 Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

**3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil**  
**Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang**

| BULAN                                                               | MARET<br>2026 | APRIL<br>2026 | MEI<br>2026 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan | 491           | 485           | 371         |



Grafik Jumlah Pemberian Tablet Besi Folat Pada Ibu Hamil Mei 2026



**Analisis :**  
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 485 di bulan April menjadi 371 pada bulan Mei yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

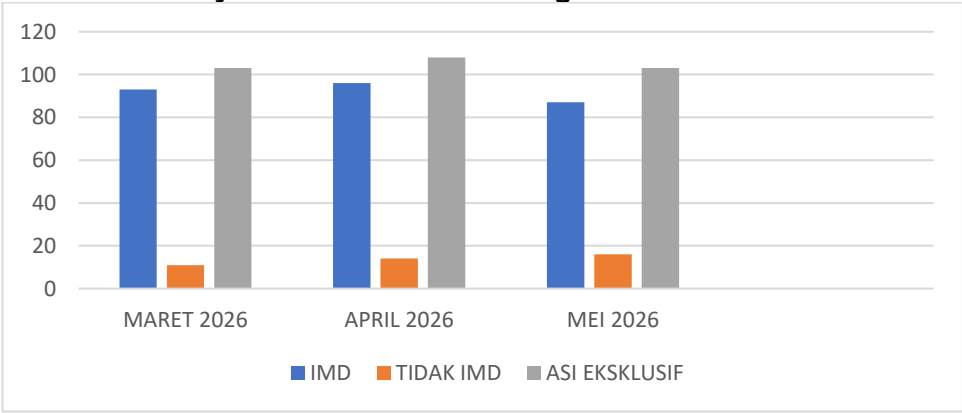
- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
  - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

| NO | URAIAN                           | JUMLAH PASIEN    |                  |                |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                                  | BULAN MARET 2026 | BULAN APRIL 2026 | BULAN MEI 2026 |
| 1  | IMD                              | 93               | 96               | 87             |
| 2  | Tidak IMD                        | 11               | 14               | 16             |
| 3  | Mendapat Konseling ASI Eksklusif | 103              | 108              | 103            |

Grafik Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif Mei 2026



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Mei sebanyak 87 bayi.

2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 16 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan penurunan jumlah pasien
3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan Mei 2026 yaitu sebanyak 103 pasien.

**Rencana Tindak Lanjut:**

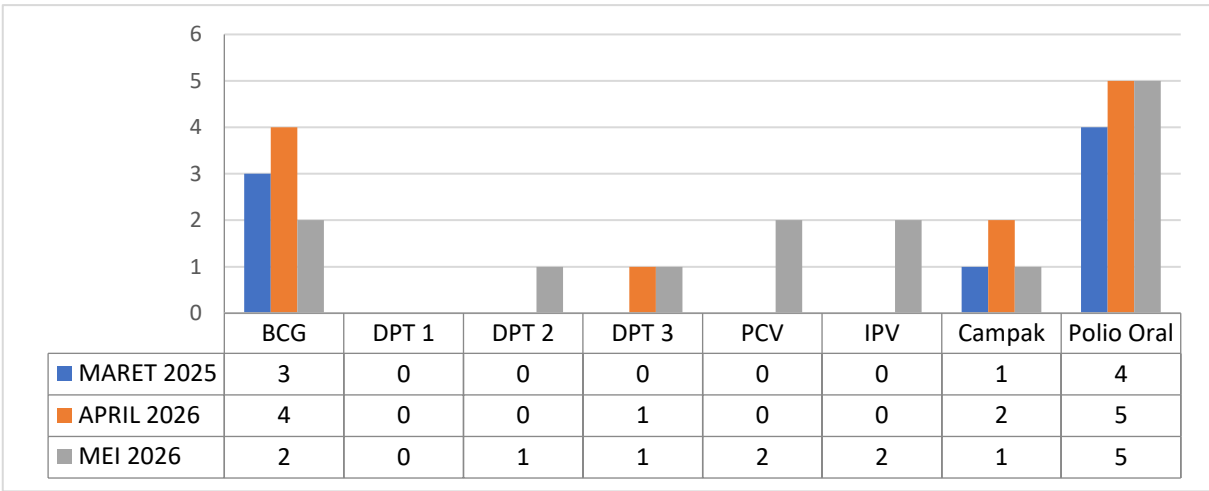
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

**3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi**

**Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi**

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah           |                  |                |
|----|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|    |                 | Bulan Maret 2026 | Bulan April 2026 | Bulan Mei 2026 |
| 1  | BCG             | 3                | 4                | 2              |
| 2  | DPT 1           | 0                | 0                | 0              |
| 3  | DPT 2           | 0                | 0                | 1              |
| 4  | DPT 3           | 0                | 1                | 1              |
| 5  | PCV             | 0                | 0                | 2              |
| 5  | IPV             | 0                | 0                | 2              |
| 6  | Campak          | 1                | 2                | 1              |
| 7  | Polio Oral      | 4                | 5                | 5              |
| 8  | Rotavirus       | 0                | 0                | 1              |

**Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Mei 2026**



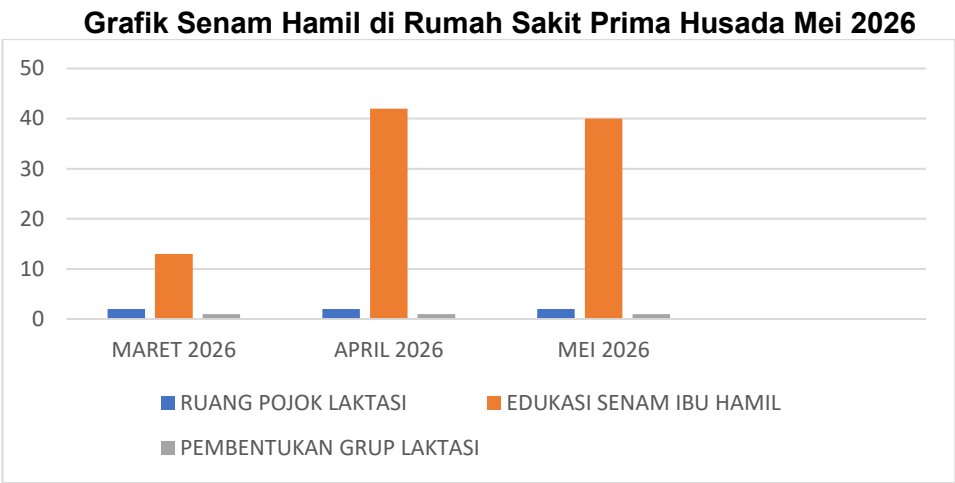
**Analisis:**

1. Pada bulan Mei sebanyak 2 balita melakukan imunisasi BCG.
2. Sebanyak 1 balita melakukan imunisasi DPT 2, DPT 3, campak, dan rotavirus di Prima Husada Malang pada bulan Mei.
3. Pada bulan Mei tidak ada yang melakukan imunisasi DPT 1.
4. Terdapat 2 pasien melakukan imunisasi PCV dan IPV pada bulan Mei 2026.
5. Terdapat 5 pasien melakukan imunisasi polio oral di Prima Husada Malang

**Rencana Tindak Lanjut :**  
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

**3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**  
**Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

| KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Ruang Pojok Laktasi                                | 2          | 2          | 2        |
| Senam Hamil                                        | 13         | 42         | 40       |
| Pembentukan Grup Laktasi                           | 1          | 1          | 1        |



- Analisis :**
- Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
  - Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
  - Pada bulan Mei edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan obat cacing pada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan (PMT) pada Ibu Hamil sebanyak 40 peserta, penyuluhan dilakukan di senam hamil.

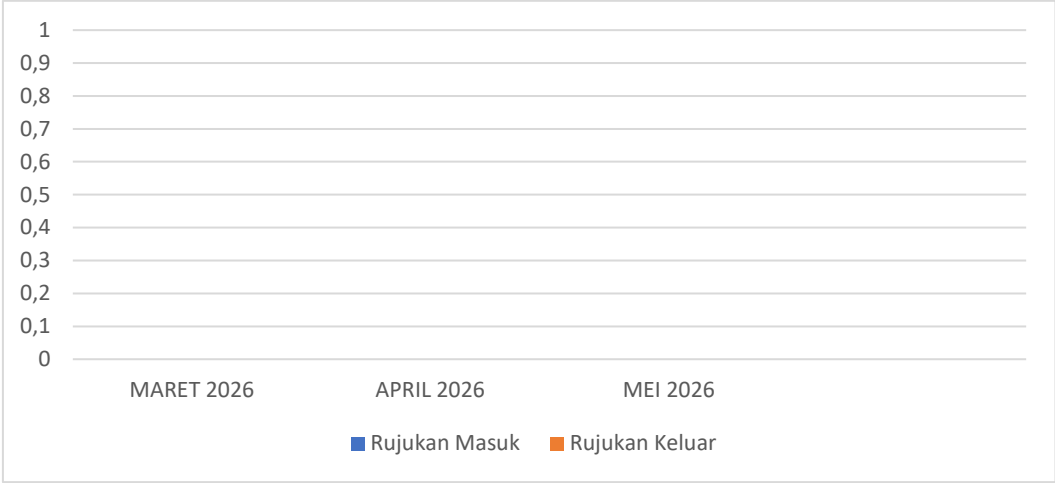
- Rencana Tindak Lanjut :**
- Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
  - Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting**  
**Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

| Rujukan Masuk  |         |      |          |                |
|----------------|---------|------|----------|----------------|
| Bulan          | Nama PX | Usia | Diagnosa | Asal Rujukan   |
| Maret          | -       | -    | -        | -              |
| April          | -       | -    | -        | -              |
| Mei            | -       | -    | -        | -              |
| Rujukan Keluar |         |      |          |                |
| Bulan          | Nama PX | Usia | Diagnosa | Tujuan Rujukan |

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| Maret | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - |
| Mei   | - | - | - | - |

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Mei 2026



**Analisis :**  
 Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan April

**Rencana Tindak Lanjut:**  
 Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan  
 Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

| BULAN                  | MARET 2026 | APRIL 2026 | MEI 2026 |
|------------------------|------------|------------|----------|
| Jumlah Pasien Stunting | 2          | 6          | 3        |
| Jumlah Pasien Wasting  | 3          | 6          | 4        |

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



**Analisis :**

Pada bulan Mei 2026 ditemukan sebanyak 3 balita berat badan kurang dengan stunting, dan 1 balita berat badan kurang. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan

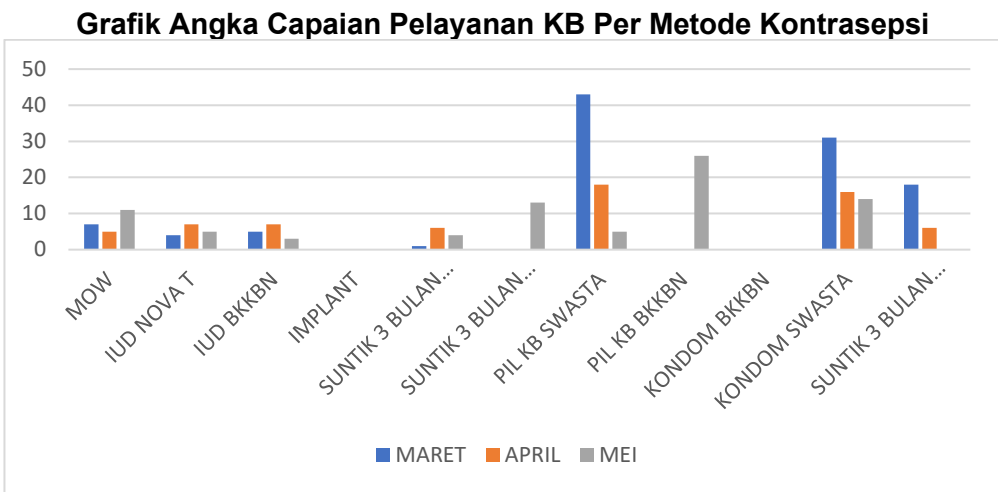
**Rencana Tindak Lanjut :**

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan. Penginputan pasien stunting dan wasting di aplikasi eppgbm. Pemberian diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP). Kolaborasi antar ahli gizi, DPJP, serta Ahli gizi puskesmas balita.

3.1.2.5 KBRS

3.7.24 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

| No | Jenis Pelayanan                 | Jumlah Pasien    |                  |                | Target sasaran per metode kontrasepsi dalam satu tahun |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                 | Bulan Maret 2026 | Bulan April 2026 | Bulan Mei 2026 |                                                        |
| 1  | MOW                             | 7                | 5                | 11             | 26                                                     |
| 2  | IUD Nova T                      | 4                | 7                | 5              | 49                                                     |
| 3  | IUD BKKBN                       | 5                | 7                | 3              |                                                        |
| 4  | IMPLANT                         | 0                | 0                | 0              | 111                                                    |
| 5  | SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI        | 1                | 6                | 4              | 187                                                    |
| 6  | SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN BKKBN  | 0                | 13               | 13             |                                                        |
| 7  | SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN SWASTA | 18               | 6                | 0              |                                                        |
| 8  | PIL KB BKKBN                    | 0                | 0                | 26             | 135                                                    |
| 9  | PIL KB SWASTA                   | 43               | 18               | 5              |                                                        |
| 10 | KONDOM BKKBN                    | 0                | 0                | 0              | 30                                                     |
| 11 | KONDOM SWASTA                   | 31               | 16               | 14             |                                                        |



**Evaluasi :**

1. Peserta MOW pada bulan Maret turun (7) April turun (5) Mei naik (11)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Maret naik (4) April naik (7) Mei turun (5)
3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Maret naik (5) April naik (7) Mei turun (3)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Maret turun(1) April naik (6) Mei turun (4)
5. Peserta KB suntik progestin bkkbn pada bulan Maret tetap (0) April naik (13) Mei tetap (13)
6. Karena stok suntik 3 bulan progestin BKKBN kosong,maka Peserta KB menggunakan Suntik 3 bulan progestin swasta Maret (18) April turun (6) dan Mei (0) karena stok dari BKKBN sudah ada
7. Peserta KB pil kombinasi karena stok habis pada bulan Maret (0) karena barang masing kosong dari BKKBN,April tetap (0) Mei naik (26) karena sudah mendapat stok dari BKKBN
8. Karena stok pil kombinasi BKKBN kosong,Maka peserta KB menggunakan pil kombinasi swasta Maret (43) peserta April turun (18) Mei turun (5) karena sudah ada stok dari BKKBN
9. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan karena stok habis Maret (0) April (0) Mei (0) karena kosong dari BKKBN
10. Peserta KB Kondom swasta Maret naik (31) April (16) Mei turun (14) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

**Analisis :**

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn dan poli KB salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin tentang pentingnya KB

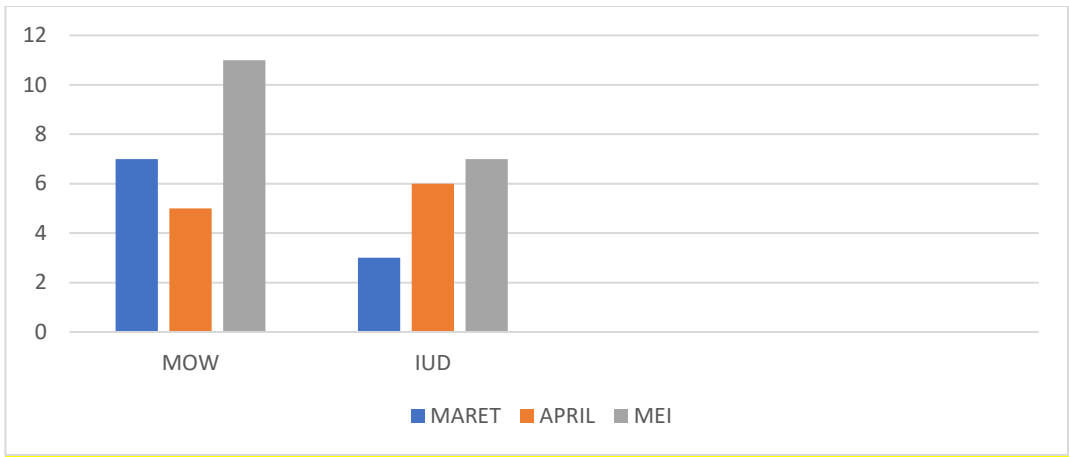
**Rencana Tindak Lanjut :**

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD,Implan serta pemasangan IUD pasca plasenta,dan diadakan Pelayanan KB oleh bidan setiap hari Senin-Jumat

**Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan**

| No | Jenis Pelayanan pasca persalinan | Jumlah Pasien KB Bulan Maret 2026 | Jumlah pasien bersalin bulan Maret 2026 | Jumlah Pasien KB Bulan April 2026 | Jumlah pasien bersalin bulan April 2026 | Jumlah Pasien KB Bulan Mei 2026 | Jumlah pasien bersalin bulan Mei 2026 |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | MOW                              | 7                                 | 93                                      | 5                                 | 101                                     | 11                              | 92                                    |
| 2  | IUD                              | 3                                 | 93                                      | 6                                 | 101                                     | 7                               | 92                                    |

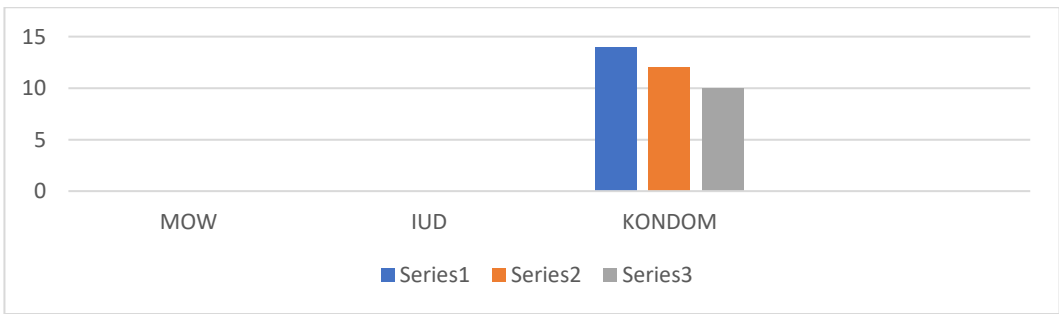
Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

| No | Jenis Pelayanan pasca keguguran | Jumlah Pasien kb Bulan Maret 2026 | Jumlah pasien abortus Bulan Maret 2026 | Jumlah Pasien kb Bulan April 2026 | Jumlah pasien abortus Bulan April 2026 | Jumlah Pasien kb Bulan Mei 2026 | Jumlah pasien abortus Bulan Mei 2026 |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | MOW                             | 0                                 | 14                                     | 0                                 | 12                                     | 0                               | 10                                   |
| 2  | IUD                             | 0                                 |                                        | 0                                 |                                        | 0                               |                                      |
| 3  | KONDOM                          | 14                                |                                        | 12                                |                                        | 10                              |                                      |

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Maret-April-Mei meningkat tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Maret-April-Mei menetap tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Analisis :

- 1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
- 2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai

---

alasan ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

**Rencana dan Tindak Lanjut :**

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin diruang maternitas tentang pentingnya berKB



### 3.2.3 Tim PPRA

#### 3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2026

| No. | Nama             | Jenis Kelamin /umur | Dokter              | No. RM | Diagnosis KRS                    | Tgl MRS    | Tgl KRS    | LOS (Hari) | Antibiotik  | Jumlah Antibiotik | Dosis (gram) | Total Dosis (gram) | ATC | DDD  |
|-----|------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 1   | Dian Kodrat      | P/31                | dr. Aida, Sp.OG     | 142487 | Mio – adenomyoma                 | 01/03/2026 | 04/03/2026 | 4          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Ceftriaxone |                   | 2x1          | 4                  | 2   | 2    |
| 2   | Silva Yuli       | P/31                | dr. Aida, Sp.OG     | 177196 | Post SC + BSC                    | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,75 |
| 3   | Ayu Fidya        | P/25                | dr. Humaira, Sp.OG  | 224081 | Gravida SC                       | 14/03/2026 | 16/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1,5                | 2   | 0,75 |
| 4   | Puput Murniati   | P/28                | dr. Humaira, Sp.OG  | 246431 | Post Curetage + Misseda Abortion | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 2          | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2   | 0,5  |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Amoxicillin |                   | 3x0,5        | 1                  | 1,5 | 0,67 |
| 5   | Uswatun Chasanah | P/35                | dr. Humaira, Sp.OG  | 176626 | Post SC + Plasenta Previa        | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 6   | Aristianti A     | P/30                | dr. Aida, Sp.OG     | 240863 | Post SC + KPD                    | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 7   | Irma Setyowati   | P/22                | dr. Aida, Sp.OG     | 246537 | Post SC + KPD                    | 18/03/2026 | 20/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1,5                | 2   | 0,75 |
| 8   | Laili Nisfi      | P/30                | dr. Humaira, Sp.OG  | 223910 | Post SC + Oligohidramnion        | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 9   | Sunarti          | P/40                | dr. Humaira, Sp.OG  | 239363 | Post Curetage Menometroragia     | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 2          | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2   | 0,5  |
|     |                  |                     |                     |        |                                  |            |            |            | Amoxicillin |                   | 3x0,5        | 1,5                | 1,5 | 1    |
| 10  | Lia Setianingrum | P/32                | dr. Humaira, Sp. OG | 113940 | Post Partum                      | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 2          | Amoxicillin | 1                 | 3x0,5        | 1,5                | 1,5 | 1    |
| 11  | Budi Winarto     | L/60                | dr. Arianto, Sp.OT. | 075676 |                                  | 05/03/2026 | 07/03/2026 | 3          | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2   | 0,2  |

|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   |                    |   |        |      |     |      |
|----|--------------------|------|----------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|---|--------------------|---|--------|------|-----|------|
|    |                    |      |                      |        | Cruss injury manus (S) digiti 1                    |            |            |   | Ceftriaxone        |   | 2x1    | 2    | 2   | 1    |
| 12 | Supingah           | P/57 | dr. Andi, Sp.B       | 246148 | Peritonitis generalisata ec appendicitis perforasi | 09/03/2026 | 11/03/2026 | 3 | Ceftriaxone        | 1 | 1x2    | 2    | 2   | 2    |
| 13 | Suriadi            | L/51 | dr. Pradana, Sp. U   | 229693 | BPH                                                | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 3 | Ceftizoxime        | 1 | 1x2    | 2    | 4   | 0,5  |
| 14 | Ahmad Taufiq       | L/24 | dr. Oka,Sp.OT.       | 246282 | Partial ruptur tendon extensor                     | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 15 | Dani Abednego      | L/21 | dr. Oka,Sp.OT.       | 229394 | Union radius fracture of lower end of radius       | 13/03/2026 | 15/03/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 16 | Andry Muji A       | L/44 | Dr. Edi, Sp. U       | 110993 | Batu Ureter                                        | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 3 | Ceftizoxime        | 1 | 1x2    | 2    | 4   | 0,5  |
| 17 | Ediyanto           | L/48 | dr. Oka,Sp.OT.       | 192204 | Ruptur quadriceps tendon                           | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 18 | Suparti            | P/63 | dr. Anton,Sp.B.      | 061659 | Necrotizing fascitis S + DM Hiperglikemi           | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Picyn              | 3 | 1x1,5  | 1,5  | 6   | 0,25 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Picyn              |   | 3x1,5  | 4,5  | 6   | 0,75 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Metronidazole (PO) |   | 3x0,25 | 1,25 | 2   | 0,63 |
| 19 | Wiyung Krisbantoro | L/26 | dr. Oka,Sp.OT.       | 230940 | Traumatic amputation manus                         | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 20 | Sungkono           | L/44 | dr. Fachriy,Sp.BS.   | 246913 | Multiple open wound parietal                       | 28/03/2026 | 30/03/2026 | 3 | Ceftriaxone        | 2 | 1x2    | 2    | 2   | 1    |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Ceftriaxone        |   | 2x1    | 4    | 2   | 2    |
| 21 | Moeljadi           | L/86 | dr. Andy, Sp. P      | 146401 | Pneumonia + Takikardi + Sepsis                     | 02/03/2026 | 05/03/2026 | 4 | Meropenem          | 1 | 2x1    | 6    | 3   | 2    |
| 22 | Atim               | P/89 | dr. Miryanti, Sp. JP | 245949 | HF + ISK                                           | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 5 | Ceftriaxone        | 1 | 2x1    | 4    | 2   | 2    |
| 23 | Jamiah             | P/59 | dr. Zora, Sp. Pd     | 229778 | DM Hiperglikemi + UTI                              | 04/03/2026 | 07/03/2026 | 4 | Ciprofloxacin      | 1 | 2x0,5  | 2,5  | 1   | 2,5  |
| 24 | Djoko Utomo        | L/53 | dr. Ardhi, Sp.Pd     | 037689 | Selulitis regio cruris dextra et sisnista          | 08/03/2026 | 11/03/2026 | 4 | Ceftriaxone        | 2 | 2x1    | 6    | 2   | 3    |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Levofloxacin PO    |   | 1x0,5  | 1,5  | 0,8 | 3,5  |
| 25 | Kasan              | L/77 | dr. Farid, Sp.N      | 240824 | CVA Infark + Parkinson'S Disease + Pneumonia       | 10/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | Ceftriaxone        | 2 | 2x1    | 2    | 2   | 1    |
|    |                    |      |                      |        |                                                    |            |            |   | Azitromycin        |   | 1x0,5  | 1,5  | 0,3 | 5    |
| 26 | Suyono             | L/56 |                      | 218744 |                                                    | 10/03/2026 | 13/03/2026 | 4 | Ceftriaxone        | 2 | 2x1    | 5    | 2   | 2,5  |

|    |          |      |                        |        |                                  |            |            |   |                   |   |       |     |     |     |
|----|----------|------|------------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|---|-------------------|---|-------|-----|-----|-----|
|    |          |      | dr. Ard hany,<br>Sp.Pd |        | Fatty liver +<br>Nephrolithiasis |            |            |   | Asam<br>Pipemidat |   | 2x0,4 | 1,6 | 0,8 | 2   |
| 27 | Mujiono  | L/58 | dr. Heri, Sp. Pd       | 208041 | DM Type 2 + Cystitis             | 12/03/2026 | 15/03/2026 | 4 | Asam<br>Pipemidat | 1 | 2x0,4 | 1,6 | 0,8 | 2   |
| 28 | Kastomo  | L/70 | dr. Andy, Sp. P        | 065312 | COPD eksaserbasim<br>akut + AF   | 17/03/2026 | 19/03/2026 | 3 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 5   | 2   | 2,5 |
| 29 | Farhan B | L/23 | dr. Ardhi, Sp. Pd      | 105814 | GEA + Diarrhea                   | 23/03/2026 | 26/02/2026 | 4 | Ciprofloxacin     | 1 | 2x0,5 | 3   | 1   | 3   |
| 30 | Buari    | L/73 | dr. Elvi, Sp. P        | 246785 | COPD AE                          | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 5   | 2   | 2,5 |

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2026

| No. | Nama            | Jenis Kelamin /umur | Dokter              | No. RM | Diagnosis KRS                         | Tgl MRS    | Tgl KRS    | LOS (Hari)  | Antibiotik  | Jumlah Antibiotik | Dosis (gram) | Total Dosis (gram) | ATC  | DDD  |
|-----|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|------|------|
| 1   | Dita Andriyani  | P/33                | dr. Aida, Sp. OG    | 231521 | Multiple mioma uteri                  | 31/03/2026 | 03/04/2026 | 4           | Cefazoline  | 1                 | 1x2          | 2                  | 3    | 0,67 |
| 2   | Qurotu Ngainina | P/18                | dr. Aida, Sp. OG    | 246780 | Colic abdomen ec ovrial cyst          | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2           | Ceftriaxone | 1                 | 2x1          | 3                  | 2    | 1,5  |
| 3   | Dian Astutik    | P/26                | dr. Humaira, Sp.OG  | 008496 | Gravida SC                            | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 3           | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3    | 0,67 |
|     |                 |                     |                     |        |                                       |            |            | Cefadroxile | 2x0,5       |                   | 1,5          | 2                  | 0,75 |      |
| 4   | Fanny Kartika   | P/35                | dr. Aida, Sp.OG     | 132363 | Post SC + BSC                         | 02/04/2026 | 04/04/2026 | 3           | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3    | 0,67 |
|     |                 |                     |                     |        |                                       |            |            | Cefadroxile | 2x0,5       |                   | 1,5          | 2                  | 0,75 |      |
| 5   | Poppy Annisa    | P/32                | dr. Humaira, Sp. OG | 214099 | Abortus incomplete post curet         | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 2           | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2    | 0,5  |
|     |                 |                     |                     |        |                                       |            |            | Cefadroxile | 2x0,5       |                   | 1            | 2                  | 0,5  |      |
| 6   | Sufiati Ulfa    | P/32                | dr. Humaira, Sp. OG | 073950 | Gravida partus normal + post curetage | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 2           | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2    | 0,5  |
|     |                 |                     |                     |        |                                       |            |            | Cefadroxile | 2x0,5       |                   | 1            | 2                  | 0,5  |      |
| 7   | Siti Lutfiah    | P/21                | dr. Humaira, Sp.OG  | 236450 | Post SC + KPD                         | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 3           | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3    | 0,67 |
|     |                 |                     |                     |        |                                       |            |            | Cefadroxile | 2x0,5       |                   | 1,5          | 2                  | 0,75 |      |
| 8   | Siti Arba'yah   | P/33                | dr. Aida, Sp. OG    | 127022 | Post Partum Normal                    | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 2           | Amoxicillin | 1                 | 3x0,5        | 1,5                | 1,5  | 1    |

|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   |                    |   |        |      |     |      |
|----|-----------------|-------|---------------------|--------|------------------------------------------------------|------------|------------|---|--------------------|---|--------|------|-----|------|
| 9  | Richa Damayanti | P/320 | dr. Humaira, Sp. OG | 199190 | Post Curetage + Misseda Abortion                     | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Ceftriaxone        | 2 | 1x1    | 1    | 2   | 0,5  |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Amoxicillin        |   | 3x0,5  | 1    | 1,5 | 0,67 |
| 10 | Qurrotul Aini   | P/32  | dr. Humaira, Sp. OG | 130109 | Post Curetage + Misseda Abortion                     | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Ceftriaxone        | 2 | 1x1    | 1    | 2   | 0,5  |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Amoxicillin        |   | 3x0,5  | 1    | 1,5 | 0,67 |
| 11 | Dendy hutama    | L/32  | dr. Oka,Sp.OT.      | 226731 | Union Humerus Proximal Dextra                        | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 12 | Ferry K         | L/45  | dr. Oka,Sp.OT.      | 247577 | Finger tip injury digiti 4 manus dextra              | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 2x1    | 6    | 3   | 2    |
| 13 | Hadi kurniawan  | L/42  | dr. Pradana,Sp.U.   | 073780 | Bt Ureter D                                          | 10/04/2026 | 12/04/2026 | 3 | Ceftizoxime        | 1 | 1x2    | 2    | 4   | 0,5  |
| 14 | Wahyu nanang    | L/32  | dr. Oka,Sp.OT.      | 247653 | Crush injury dengan bone expose digit 4 pedis dextra | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 1    | 3   | 0,33 |
| 15 | Hartono         | L/64  | dr. Pradana,Sp.U.   | 157710 | BPH                                                  | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Ceftizoxime        | 1 | 1x2    | 2    | 4   | 0,5  |
| 16 | Farida Maimunah | P/652 | dr. Anton,Sp.B.     | 151192 | Necrotizing fascitis pedis dextra                    | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 3 | Picyn              | 3 | 1x1,5  | 1,5  | 6   | 0,25 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Picyn              |   | 3x1,5  | 4,5  | 6   | 0,75 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Metronidazole (PO) |   | 3x0,25 | 1,25 | 2   | 0,63 |
| 17 | Sumarmi         | P/76  | dr. Oka,Sp.OT.      | 011074 | Fracture Humerus                                     | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Cefazolin          | 2 | 1x2    | 2    | 3   | 0,67 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Cefazolin          |   | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 18 | Suparman        | L/75  | dr. Edi,Sp.OT.      | 181099 | BPH                                                  | 20/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Ceftizoxime        | 1 | 1x2    | 2    | 4   | 0,5  |
| 19 | Supardi         | P/54  | dr. Oka,Sp.OT.      | 141301 | Finger tip injury digiti 3 manus dextra              | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Cefazolin          | 2 | 2x1    | 2    | 3   | 0,67 |
| 20 | Rosyidatul M    | P/28  | dr. Anton,Sp.B      | 144748 | Appendicitis acute                                   | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 3 | Picyn              | 2 | 1x1,5  | 1,5  | 6   | 0,25 |
|    |                 |       |                     |        |                                                      |            |            |   | Picyn              |   | 3x1,5  | 3    | 6   | 0,5  |
| 21 | Nabila Aprilia  | P/18  | dr. Ardhany, Sp. Pd | 234237 | Nephrolithiasis                                      | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Asam pipemidat     | 1 | 2x0,4  | 3,2  | 0,8 | 4    |
| 22 | Ahlul Fadli     | L/45  | dr. Ardhi, Sp. Pd   | 247243 | Chronic diare + Anemia                               | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Ciprofloxacina po  | 1 | 2x0,5  | 1,5  | 1   | 1,5  |
| 23 | Ahlul Fadl      | L/45  | dr. Elvi, Sp. P     | 050074 | COPD AE                                              | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 3 | Ceftriaxone        | 1 | 2x1    | 6    | 2   | 3    |
| 24 | Okta Miliani    |       | dr. Zora, Sp. Pd    | 247272 | GEA dehidras sedang diare                            | 04/04/2026 | 06/04/2026 | 3 | Ciprofioxacin po   | 1 | 2x0,5  | 2    | 1   | 2    |
| 25 | Hartawan Hari   | L/45  | dr. Heri, Sp. Pd    | 247408 | DF                                                   | 07/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Cefixime           | 1 | 2x0,1  | 0,5  | 0,4 | 1,25 |

|    |              |      |                   |        |                            |            |            |   |                   |   |       |   |   |     |
|----|--------------|------|-------------------|--------|----------------------------|------------|------------|---|-------------------|---|-------|---|---|-----|
| 26 | Mualifin     | L/58 | dr. Mira, Sp. JP  | 247502 | Chest Pain unspecified     | 09/04/2026 | 11/04/2026 | 3 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 5 | 2 | 2,5 |
| 27 | Sulastri     | P/61 | dr. Andy, Sp. P   | 056285 | Pneumonia + CVA            | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 3 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 5 | 2 | 2,5 |
| 28 | R. Noeriwan  | L/53 | Dr. Zora, Sp. Pd  | 245787 | GEA + Vomiting             | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Ciprofoloxacin po | 1 | 2x0,5 | 3 | 1 | 3   |
| 29 | Sutrisnowati | P/31 | dr. Ardhi, Sp. Pd | 248189 | Cholelithiasis             | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 7 | 2 | 3,5 |
| 30 | Supadmi      | P/71 | dr. Andy, Sp. P   | 248372 | Pneumonia psi 91 + COPD AE | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 6 | 2 | 3   |

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2026

| No. | Nama              | Jenis Kelamin /umur | Dokter              | No. RM | Diagnosis KRS             | Tgl MRS    | Tgl KRS    | LOS (Hari) | Antibiotik  | Jumlah Antibiotik | Dosis (gram) | Total Dosis (gram) | ATC | DDD  |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-----|------|
| 1   | Wilda Nurmala     | P/24                | dr. Humaira, Sp. OG | 201062 | Post Partum Normal        | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 2          | Amoxicillin | 1                 | 3x0,5        | 1,5                | 1,5 | 1    |
| 2   | Tri Lindah M      | P/33                | dr. Aida, Sp. OG    | 152777 | Gravida SC + KPD          | 03/05/2026 | 05/05/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 3   | Karlina           | P/38                | dr. Aida, Sp. OG    | 237457 | Makrosomia + Gravida SC   | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 4          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 4   | Siska Nurkhoiriya | P/30                | dr. Puti F, Sp. OG  | 063844 | Kista Ovari               | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 4          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 5   | Sekar Mastiti     | P/30                | dr. Humaira, Sp. OG | 241444 | Gravida SC + Mioma Uteri  | 15/05/2026 | 17/05/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1,5                | 2   | 0,75 |
| 6   | Agustina Dwi      | P/38                | dr. Humaira, Sp. OG | 248958 | Kista Bartolini           | 18/05/2026 | 19/05/2026 | 2          | Ceftriaxone | 2                 | 1x1          | 1                  | 2   | 0,5  |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |
| 7   | Virsa Novita      | P/22                | dr. Humaira, Sp. OG | 240348 | Gravida SC                | 20/05/2026 | 23/05/2026 | 4          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1,5                | 2   | 0,75 |
| 8   | Paisri            | P/39                | dr. Humaira, Sp. OG | 247736 | Post SC + Oligohidramnion | 21/05/2026 | 23/05/2026 | 3          | Cefazoline  | 2                 | 1x2          | 2                  | 3   | 0,67 |
|     |                   |                     |                     |        |                           |            |            |            | Cefadroxile |                   | 2x0,5        | 1                  | 2   | 0,5  |

|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   |               |   |       |     |     |      |
|----|----------------|------|---------------------|--------|---------------------------------------------|------------|------------|---|---------------|---|-------|-----|-----|------|
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   |               |   |       |     |     |      |
| 9  | Mauliddya Sari | P/25 | dr. Puti F, Sp. OG  | 139820 | Post SC + BSC                               | 22/05/2026 | 24/05/2026 | 3 | Cefazoline    | 2 | 1x2   | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Cefadroxile   |   | 2x0,5 | 1   | 2   | 0,5  |
| 10 | Tarisa Adinda  | P/25 | dr. Humaira, Sp. OG | 247721 | Post Partum Normal                          | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 2 | Amoxicillin   | 1 | 3x0,5 | 1,5 | 1,5 | 1    |
| 11 | M Afrizal Dwi  | L/20 | dr. Oka, Sp.OT.     | 246289 | Union Phalank                               | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Cefazolin     | 2 | 1x2   | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Cefazolin     |   | 2x1   | 2   | 3   | 0,67 |
| 12 | Iwan           | L/44 | dr. Oka, Sp.OT.     | 248995 | Vulnus laceratum regio antebrachia sinistra | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Cefazolin     | 2 | 1x2   | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Cefazolin     |   | 2x1   | 4   | 3   | 1,33 |
| 13 | Junaidi        | L/33 | dr. Zaki,Sp.B.      | 221724 | Stt Temporo A                               | 05/05/2026 | 07/5/2026  | 3 | Cefoperazone  | 2 | 1x2   | 2   | 4   | 0,5  |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Ceftriaxone   |   | 2x1   | 2   | 2   | 1    |
| 14 | M Sururi       | L/47 | dr. Anton,Sp.OB     | 103822 | Necrotizing Fascitis Frontalis              | 07/05/2026 | 09/05/2026 | 3 | Picyn         | 2 | 1x1,5 | 1,5 | 6   | 0,25 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Picyn         |   | 3x1,5 | 4,5 | 6   | 0,75 |
| 15 | Misnati        | P/49 | dr. Anton,Sp.OB     | 249183 | Necrotizing Fascitis Pedis D                | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | Picyn         | 2 | 1x1,5 | 1,5 | 6   | 0,25 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Picyn         |   | 3x1,5 | 7,5 | 6   | 1,25 |
| 16 | Adi Wiyono     | L/45 | dr. Arianto,Sp.OT.  | 066470 | Crush Injury Digits 1 Manus Sinistra        | 22/05/2026 | 24/05/2026 | 3 | Ceftriaxone   | 2 | 1x2   | 2   | 2   | 1    |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Ceftriaxone   |   | 2x1   | 3   | 2   | 1,5  |
| 17 | Karsi'in       | L/69 | dr. Pradana, Sp. U  | 216168 | Bt buli                                     | 19/05/2026 | 21/05/2026 | 3 | Ceftizoxime   | 1 | 1x2   | 2   | 4   | 0,5  |
| 18 | Elok Kusuma N  | P/19 | dr. Oka,Sp.OT.      | 249330 | CF Clavicula Dextra                         | 22/05/2026 | 24/05/2026 | 3 | Cefazolin     | 2 | 1x2   | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Cefazolin     |   | 2x1   | 2   | 3   | 0,67 |
| 19 | Adinda N       | P/20 | dr. Oka,Sp.OT.      | 247674 | Schopoid dislocation                        | 22/05/2026 | 24/05/2026 | 3 | Cefazolin     | 2 | 1x2   | 2   | 3   | 0,67 |
|    |                |      |                     |        |                                             |            |            |   | Cefazolin     |   | 2x1   | 2   | 3   | 0,67 |
| 20 | Atim           | L/71 | dr. Edi, Sp. U      | 249539 | BPH                                         | 25/05/2026 | 27/05/2026 | 3 | Ceftizoxime   | 1 | 1x2   | 2   | 4   | 0,5  |
| 21 | Sariani        | P/80 | dr. Andy, Sp. JP    | 248668 | Pneumonia                                   | 02/05/2026 | 05/05/2026 | 4 | Ceftriaxone   | 1 | 2x1   | 5   | 2   | 2.5  |
| 22 | Umi Prihatin T | P/50 | dr. Zora, Sp. Pd    | 076079 | GEA + Volume Depletion                      | 04/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Ciprofloxacin | 1 | 2x0,5 | 2   | 1   | 2    |
| 23 | Widarto        | L/64 | dr. Mira, Sp. JP    | 248736 | NSTEMI + Lung edema                         | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 4 | Ceftriaxone   | 1 | 2x1   | 6   | 3   | 2    |
| 24 | Tabri          | L/57 | dr. Andy, Sp. P     | 236852 | COPD AE + ALO                               | 05/05/2026 | 08/05/2026 | 4 | Ceftriaxone   | 1 | 2x1   | 6   | 3   | 2    |
| 25 | Misdi          | L/66 | dr. Elvi, Sp. P     | 249047 | Sepsis + Pneumonia                          | 11/05/2026 | 14/05/2026 | 4 | Meropenem     | 1 | 3x1   | 9   | 3   | 3    |

---

|    |             |      |                   |        |                                  |            |            |   |                   |   |       |     |     |     |
|----|-------------|------|-------------------|--------|----------------------------------|------------|------------|---|-------------------|---|-------|-----|-----|-----|
| 26 | Fransiska C | P/86 | dr. Heri, Sp. Pd  | 146544 | Hematemesis + Cystitis           | 12/05/2026 | 14/05/2026 | 3 | Asam<br>Pipemidat | 1 | 2x0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,5 |
| 27 | Asri        | P/67 | dr. Ira, Sp. JP   | 237276 | NSTEMI + ALO + Tumor<br>Abdomen  | 13/05/2026 | 16/05/2026 | 4 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 6   | 2   | 3   |
| 28 | Rokayatin   | P/60 | dr. Farid, Sp.N   | 101720 | CVA Infark + Bronkitis           | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 4 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 5   | 2   | 2.5 |
| 29 | Suhartono   | L/42 | dr. Ardhi, Sp. Pd | 248749 | Cholelithiasis multiple          | 23/05/2026 | 26/05/2026 | 4 | Ceftriaxone       | 1 | 2x1   | 6   | 2   | 3   |
| 30 | Ngatiman    | L/65 | dr. Ardhi, Sp. Pd | 249910 | Colic Abdomen +<br>Hydronefrosis | 28/05/2026 | 30/05/2026 | 3 | Ciprofloxacin     | 1 | 2x0,5 | 1   | 1   | 1   |

### 3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

#### 3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap 2026

| KELENGKAPAN |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
|-------------|------------------------|-----|------|---|-----------------------|-------|------|------|------|-------|------|------|------------------|-------|------|------|
| DPJP        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| BULAN       | Ringkasan Keluar Masuk |     |      |   | Pengkajian Awal Medis |       |      |      | CPPT |       |      |      | Ringkasan Pulang |       |      |      |
|             | Σ L                    | %   | Σ TL | % | Σ L                   | %     | Σ TL | %    | Σ L  | %     | Σ TL | %    | Σ L              | %     | Σ TL | %    |
| Januari     | -                      | -   | -    | - | 1090                  | 93,70 | 61   | 6,30 | 1080 | 93,37 | 69   | 5,16 | 1147             | 99,66 | 4    | 0,34 |
| Februari    | -                      | -   | -    | - | 920                   | 84    | 119  | 16%  | 929  | 86,4  | 110  | 13,6 | 1005             | 97    | 34   | 3    |
| Maret       | -                      | -   | -    | - | 1001                  | 95,30 | 54   | 16   | 1000 | 94,93 | 55   | 5,07 | 1031             | 96,67 | 24   | ,33  |
| April       | 1244                   | 99  | 12   | 1 | 1070                  | 88    | 149  | 12   | 1113 | 89    | 142  | 11   | 1162             | 93    | 94   | 7    |
| Mei         | 14                     | 100 | 0    | 0 | 996                   | 85    | 179  | 15   | 1039 | 87    | 157  | 13   | 1087             | 93    | 81   | 7    |
| Juni        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Juli        |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Agustus     |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| September   |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |
| Oktober     |                        |     |      |   |                       |       |      |      |      |       |      |      |                  |       |      |      |

| KELENGKAPAN |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
|-------------|------------------------|-------|------|------|------|----|------|---|--------------------|-----|------|-----|---------------------------|-----|------|----|
| PERAWAT     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| BULAN       | Pengkajian Keperawatan |       |      |      | CPPT |    |      |   | Asuhan Keperawatan |     |      |     | Resume Keperawatan / SBAR |     |      |    |
|             | Σ L                    | %     | Σ TL | %    | Σ L  | %  | Σ TL | % | Σ L                | %   | Σ TL | %   | Σ L                       | %   | Σ TL | %  |
| Januari     | 1013                   | 97,18 | 38   | 2,82 | -    | -  | -    | - | 1051               | 100 | 0    | 0   | 1051                      | 100 | 0    | 0  |
| Februari    | 1008                   | 98    | 27   | 2    | -    | -  | -    | - | 1034               | 100 | 2    | 0,3 | 1036                      | 100 | 0    | 0  |
| Maret       | 1047                   | 100   | 7    | 0    | -    | -  | -    | - | 1043               | 100 | 11   | 0   | 1054                      | 100 | 0    | 0  |
| April       | 1148                   | 91    | 107  | 9    | 1203 | 96 | 52   | 4 | 1203               | 96  | 52   | 4   | 1220                      | 97  | 35   | 3  |
| Mei         | 1112                   | 93    | 84   | 8    | 1154 | 96 | 42   | 4 | 1171               | 98  | 25   | 2   | 1080                      | 90  | 116  | 10 |
| Juni        |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Juli        |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Agustus     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| September   |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |
| Oktober     |                        |       |      |      |      |    |      |   |                    |     |      |     |                           |     |      |    |



| KELENGKAPAN |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
|-------------|----------------------|----|------|----|------|-----|------|------|---------------------|-----|------|----|------|----|------|----|
| BULAN       | AHLI GIZI            |    |      |    |      |     |      |      | APOTEKER            |     |      |    |      |    |      |    |
|             | Pengkajian Awal Gizi |    |      |    | CPPT |     |      |      | Rekonsialisasi Obat |     |      |    | CPPT |    |      |    |
|             | Σ L                  | %  | Σ TL | %  | Σ L  | %   | Σ TL | %    | Σ L                 | %   | Σ TL | %  | Σ L  | %  | Σ TL | %  |
| Januari     | 556                  | 52 | 484  | 48 | 1040 | 100 | 0    | 0    | 1133                | 100 | 0    | 0  | 1010 | 91 | 123  | 9  |
| Februari    | 528                  | 61 | 398  | 39 | 926  | 100 | 0    | 0    | 1027                | 100 | 0    | 0  | 965  | 94 | 62   | 6  |
| Maret       | 587                  | 65 | 341  | 35 | 927  | 100 | 1    | 0,07 | 1034                | 90  | 13   | 10 | 291  | 33 | 756  | 67 |
| April       | 564                  | 99 | 99   | 3  | 1130 | 99  | 11   | 1    | 1206                | 97  | 42   | 3  | 1171 | 99 | 13   | 1  |
| Mei         | 517                  | 98 | 8    | 2  | 1061 | 99  | 14   | 1    | 1121                | 94  | 72   | 6  | 1067 | 98 | 21   | 2  |
| Juni        |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Juli        |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Agustus     |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| September   |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |
| Oktober     |                      |    |      |    |      |     |      |      |                     |     |      |    |      |    |      |    |

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada bulan Mei 2026, kelengkapan dokumentasi oleh DPJP menunjukkan bahwa Ringkasan Keluar Masuk mencapai 100%, sehingga seluruh dokumen yang diperiksa telah terisi lengkap. Namun masih ditemukan ketidaklengkapan pada Pengkajian Awal Medis sebesar 15% (179 dokumen), CPPT sebesar 13% (157 dokumen), dan Ringkasan Pulang sebesar 7% (81 dokumen). Dibandingkan bulan April, capaian Pengkajian Awal Medis dan CPPT mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan DPJP dalam melengkapi dokumentasi medis secara tepat waktu karena berpengaruh terhadap kesinambungan pelayanan, mutu rekam medis, dan pemenuhan standar akreditasi.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

Pada bulan Mei 2026, kelengkapan dokumentasi keperawatan menunjukkan hasil yang cukup baik. **Asuhan Keperawatan mencapai 96%, CPPT Keperawatan 98%, dan Pengkajian Keperawatan 93%.** Namun demikian, **Resume Keperawatan/SBAR masih memiliki ketidaklengkapan sebesar 10% (116 dokumen),** yang merupakan angka ketidaklengkapan tertinggi pada dokumentasi keperawatan. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas komunikasi saat transfer pasien dan kesinambungan pelayanan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Pada bulan Mei 2026, dokumentasi oleh Ahli Gizi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Pengkajian Awal Gizi sebesar 98% dan CPPT sebesar 99%. Sementara itu, dokumentasi oleh Apoteker juga menunjukkan capaian yang baik, dengan Rekonsiliasi Obat sebesar 94% dan CPPT sebesar 98%. Meskipun capaian sudah tinggi, masih ditemukan ketidaklengkapan pada rekonsiliasi obat sebanyak 72 dokumen (6%), sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mendukung keselamatan pasien terutama pada transisi pelayanan

---

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:

- 1) Melakukan monitoring kelengkapan rekam medis DPJP setiap minggu.
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi kepada masing-masing DPJP sebagai umpan balik.
- 3) Mengoptimalkan peran Kepala SMF dan Komite Medik dalam pengawasan kepatuhan dokumentasi.
- 4) Melakukan reminder kepada DPJP untuk melengkapi rekam medis sebelum pasien pulang.
- 5) Melakukan audit rekam medis secara berkala dan membahas hasilnya dalam rapat mutu.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

- 1) Melakukan supervisi pengisian Resume Keperawatan/SBAR oleh kepala ruang.
- 2) Mengingatkan perawat penanggung jawab pasien untuk melengkapi dokumen sebelum pasien pulang.
- 3) Melakukan audit dokumentasi keperawatan secara rutin.
- 4) Memberikan edukasi dan refreshment terkait pentingnya dokumentasi keperawatan yang lengkap.
- 5) Menjadikan kelengkapan rekam medis sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja ruangan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:

- 1) Meningkatkan monitoring kepatuhan rekonsiliasi obat pada pasien masuk, pindah ruang, dan pulang.
- 2) Melakukan audit dokumentasi farmasi dan gizi secara berkala.
- 3) Memberikan umpan balik kepada petugas yang belum melengkapi dokumentasi sesuai standar.
- 4) Memastikan dokumentasi dilakukan secara real time pada saat pelayanan diberikan.
- 5) Mempertahankan capaian CPPT Gizi dan Farmasi yang telah mencapai  $\geq 98\%$ .

### 3.7 Permasalahan Rumah Sakit

#### 1.7.1 Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

| NO                        | MASALAH                                                                                                  | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Permasalahan Dari Unit |                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                              |
| 1                         | Suction IKO rusak , harus ada 3 yang stanby                                                              | P             | Suction di IKO 2 rusak, masih perbaikan ke IPSRS                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                          | D             | Sudah pengajuan ke pengadaan sambil menunggu suction perbaikan                                                                                                                               |
|                           |                                                                                                          | S             | Koordinasi dengan MFK untuk maintenance alat suction karena load operasi tinggi                                                                                                              |
|                           |                                                                                                          | A             | Follow up pengajuan alat sampai barang ready                                                                                                                                                 |
| 2                         | Meja IKO 3 tidak bisa naik sehingga operasi hemoroid terkendala                                          | P             | Meja IKO 3 tidak bisa naik karena trouble sehingga jika ada operasi hemoroid harus menunduk dan kesusahan dalam tindakan terutama posisi litotomi                                            |
|                           |                                                                                                          | D             | Lapor atem untuk ditindaklanjuti → proses service                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                          | S             | Proses service ditarget kurang dari satu minggu untuk pengadaan atau penggantian sparepart                                                                                                   |
|                           |                                                                                                          | A             | <del>Follow up pengajuan alat sampai barang bisa digunakan</del>                                                                                                                             |
| 3                         | Harus Input ulang laporan operasi karena ubah penjamin dari Umum ke JKK, sehingga semua inputan terhapus | P             | Pasien dengan penjamin sebelumnya UMUM, berubah menjadi JKK, di simrs di batalkan kunjungan sehingga form ERM pengkajian awal medis, laporan operasi. CPPT dan inputan yang lain ikut hilang |
|                           |                                                                                                          | D             | Review kembali akses untuk pembatalan simrs agar sesuai dan tidak disalahgunakan                                                                                                             |
|                           |                                                                                                          | S             | Pengubahan penjamin tidak perlu menghapus kunjungan, tetapi koordinasi dengan programmer untuk pengubahan data                                                                               |
|                           |                                                                                                          | A             | Sosialisasi pada unit pelayanan, kasir, pendaftaran untuk case ubah penjamin yang masih nyantol                                                                                              |

#### 1.7.2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

| NO                                               | MASALAH                                                           | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit |                                                                   |               |                                                                                                                                              |
| 1                                                | Kunjungan di IGD dengan proporsi rawat jalan dan rawat inap 60:40 | P             | Kunjungan rawat jalan di IGD bulan mei 2026 sebanyak 1.880 kunjungan. Dengan kunjungan rawat jalan 1048, dan rawat inap 832. Proporsi 60:40. |
|                                                  |                                                                   | D             | Identifikasi kasus abu-abu yang bisa berpotensi dirawat inapkan                                                                              |
|                                                  |                                                                   | S             | Koordinasi dengan dokter IGD, casemix dan direktur untuk membahas kasus pasien yang potensi rawat inap                                       |
|                                                  |                                                                   | A             | Koordinasi dengan PIPP untuk memantau kondisi pasien                                                                                         |
| 2                                                | Respon time di IGD lama                                           | P             | Salah satu penyebab respon time di IGD lama adalah pasien dengan diagnosa kompleks seperti sesak, bisa mengarah ke jantung atau paru.        |
|                                                  |                                                                   | D             | Membutuhkan observasi dan konsul untuk                                                                                                       |

|   |                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                               |   | memastikan leader dpjp yang merawat pasien tersebut                                                                                                                                                                              |
|   |                                                               | S | DPJP lebih selektif dalam MRS pasien terutama untuk pasien BPJS Kesehatan harus memenuhi kriteria rawat inap sesuai dengan kompetensi/SMF nya                                                                                    |
|   |                                                               | A | Apabila ada pasien yang terlalu lama observasi, bisa dikonsulkan ke yanmed (jam kerja), MOD (lur jam kerja) untuk mitigasi resiko agar pasien dan keluarga tidak komplain dan paham jika masih di observasi perbaikan K/U di igd |
| 3 | Pasien rencana rujuk yang tidak diperkenankan menunggu di IGD | P | Pasien advice rujuk dari awal dan DPJP minta untuk tidak boleh pindah ruangan karena takut klaim menjadi rawat jalan                                                                                                             |
|   |                                                               | D | Koordinasi antara dokter casemix dan DPJP agar pasien diidentifikasi permasalahan yang bisa diatasi oleh RS                                                                                                                      |
|   |                                                               | S | Koordinasi agar pasien distabilkan dan tidak terburu-buru rujuk karena pertimbangan tidak langsung diterima atau bisa dirujuk penuh per poli                                                                                     |
|   |                                                               | A | Koordinasi dengan Dokter casemix dan PIPP dilibatkan karena pasien termasuk dalam kriteria kompleks                                                                                                                              |

### 3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

| NO | MASALAH                                                               | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pasien ada yang tidak di visite dokter                                | P             | Ada pasien rawat inap yang tidak di visite oleh DPJP dikarenakan berhalangan hadir dan dokter dalam satu SMF tidak bisa visite                                                            |
|    |                                                                       | D             | Apabila dalam kondisi khusus dan pasien perlu dilakukan visite, boleh dilakukan oleh dokter IGD dengan syarat delegasi dan harus lapor keadaan ke DPJP, bukan berarti menggantikan visite |
|    |                                                                       | S             | Apabila ada pasien yang belum di visite oleh DPJP, lapor dokter ruangan untuk diperiksa pasiennya                                                                                         |
|    |                                                                       | A             | Jika dokter ruangan libu, bisa di delegasikan oleh dokter IGD dengan kondisi emergency, lapor PIPP untuk pengondisian mitigasi resiko komplain dari keluarga dan pasien                   |
| 2. | Discharge planning                                                    | P             | Saat dilakukan penyimpanan, ada beberapa bagian yang hilang sehingga tidak muncul di review cetakan                                                                                       |
|    |                                                                       | D             | Kendala sudah dilporkan ke programmer                                                                                                                                                     |
|    |                                                                       | S             | Dari programmer segera ditindaklanjuti                                                                                                                                                    |
|    |                                                                       | A             | Untuk saat ini sudah bisa digunakan, tingkatkan monitoring dan evaluasi dengan programmer                                                                                                 |
| 3. | Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk | P             | Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk                                                                                                                     |
|    |                                                                       | D             | Koordinasi dengan security untuk penertiban secara halus pada keluarga pasien yang besuk di                                                                                               |

|  |  |   |                                                                                                                                 |
|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   | rawat inap                                                                                                                      |
|  |  | S | Ada warning atau himbauan yang terdengar di rawat inap                                                                          |
|  |  | A | KIE pada pasien yang akan istirahat, bahwa kondisi kamar akan steril sesuai jam minum obat dan istirahat malam jam 19.00 keatas |

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

| NO | MASALAH                                                                        | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Form perencanaan operasi masih ada kendala sehingga masih menggunakan hardcopy | P             | Form perencanaan operasi belum bisa terinput tanggal real time, di review cetak, pemeriksaan yang tidak tercentang otomatis sudah terisi sehingga menjadi rancu                                                                                                   |
|    |                                                                                | D             | Form perencana tidak link dengan rawat inap, sehingga rawat inap kesulitan membaca operan/ noted dari poli                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                | S             | Lapor dan koordinasi dengan programmer, rencana perbaikan dan ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                | A             | Untuk layanan pasien lodingan, memakai hardcopy dan masih order ke RM untuk di print kan                                                                                                                                                                          |
| 2  | Kebijakan konsul internal                                                      | P             | Pasien poli yang mempunyai rujukan lebih dari satu, untuk kunjungan selanjutnya harus dilakukan konsul internal                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                | D             | Potensi fragmentasi jika diidentifikasi pasien menggunakan 2 rujukan untuk kontrol ke RSPHM                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                | S             | Jika pasien kronis, maka salah satu harus di PRB, jika pasien membutuhkan 2 DPJP sekaligus diberlakukan konsul internal (kecuali rujukan poli gigi), dan monitoring target untuk PRB atau stabilnya kapan                                                         |
|    |                                                                                | A             | Pasien yang mempunyai 2 rujukan, di list di grup pelayanan yang isinya PDF, Poli , farmasi dan Asce. Diharapkan jika ada pasien dengan 2 rujukan, salah satu harus ditarget dan di warning ke DPJP untuk PRB. Jika tidak bisa di PRB, harus disertakan alasannya. |
| 3  | Angka rujukan rawat jalan bulan Mei 2026 masih tinggi sebanyak 212 pasien      | P             | Angka rujukan rawat jalan bulan Mei 2026 masih tinggi sebanyak 212 pasien                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                | D             | Rujukan rawat jalan diantaranya pro MRI, Pro EEG, pro Audiotimpanometri, pro sub spesialis onkologi, spesialis spine dan lain-lain                                                                                                                                |
|    |                                                                                | S             | Asce koordinasi dengan rawat jalan dan pendaftaran untuk mengkaji rujukan transit (perpanjangan rujukan)                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                | A             | Identifikasi pasien yang bisa ditujuk tanpa harus berkunjung di poli RSPHM agar tidak terjadi pe                                                                                                                                                                  |

3.7.5 Permasalahan Unit Laboratorium

| NO | MASALAH                                                                                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alat URIT/5160, dimana kontrol (DL) sudah tersedia selama bulan Mei, tetapi tidak masuk (out of range). Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian hasil kontrol yang dapat mempengaruhi validitas hasil pemeriksaan. | P             | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem KSO alat URIT/5160 terkait ketidaksesuaian kontrol mutu, ketersediaan bahan kontrol yang kompatibel, dukungan teknis vendor, serta dampaknya terhadap mutu hasil pemeriksaan laboratorium.                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                           | D             | Telah dilakukan evaluasi KSO bersama vendor dan identifikasi permasalahan meliputi keterlambatan penyediaan kontrol mutu, bahan kontrol yang tidak kompatibel, kesulitan komunikasi teknis, serta belum tersedianya alat backup.                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                           | S             | Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kontrol mutu tidak berjalan sesuai standar, terjadi error sistemik pada >50% parameter, dan terdapat risiko terhadap validitas hasil pemeriksaan, keselamatan pasien, serta keberlangsungan pelayanan laboratorium.                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                           | A             | Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengusulkan renegotiasi/addendum kontrak KSO yang mencakup kewajiban penyediaan bahan kontrol standar, SLA teknis, alat backup, sistem penagihan yang jelas, dan mekanisme penalti. Apabila vendor tidak dapat memenuhi perbaikan yang dipersyaratkan, rumah sakit akan mempertimbangkan penggantian vendor KSO untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. |

### 3.7.6 Permasalahan Unit Gizi

| NO | MASALAH                                                                                                  | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana                                                        | P             | Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT                                                                     |
|    |                                                                                                          | D             | Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi                                            |
|    |                                                                                                          | S             | Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis |
|    |                                                                                                          | A             | Tim gizi, programmer, dan pihak manajemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi                                                                      |
| 2  | Suhu Freezer daging meningkat sehingga daging di dalam freezer tidak beku dan mengeluarkan bau menyengat | P             | Menurunkan suhu freezer daging sehingga memperpanjang masa simpan daging dan menjaga kualitas daging agar tidak busuk                                |
|    |                                                                                                          | D             | Melakukan koordinasi dengan tim IPSRS untuk mengatur settingan freezer agar suhu freezer sesuai dengan standar yaitu $\leq -5^{\circ}\text{C}$       |
|    |                                                                                                          | S             | Risiko daging sapi mengalami pembusukan                                                                                                              |
|    |                                                                                                          | A             | Tim gizi, IPSRS, yang bekerjasama dalam                                                                                                              |

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
|  |  |  | mengontrol suhu penyimpanan daging |
|--|--|--|------------------------------------|

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis dan Pendaftaran

| NO | MASALAH                                                                                                                                                           | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA                                                                                                              | P             | Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                   | D             | Karu koordinasi dengan KABID                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                   | S             | Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                   | A             | Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Belum optimalnya penggunaan APM (Anjungan Pasien Mandiri): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minim penggunaan aplikasi JKN mobile pasien.</li> </ul> | P             | Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan APM dan aplikasi Mobile JKN untuk mempercepat proses pendaftaran pasien, mengurangi antrean loket, serta mendukung transformasi digital pelayanan rumah sakit.                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                                                   | D             | Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN melalui petugas pendaftaran, media informasi, banner, serta pendampingan langsung bagi pasien yang mengalami kesulitan saat registrasi.                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                   | S             | Hasil monitoring menunjukkan penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN masih belum optimal karena sebagian pasien belum memahami cara penggunaan aplikasi, belum mengaktifkan akun Mobile JKN, serta lebih memilih melakukan pendaftaran secara langsung melalui loket.                                                       |
|    |                                                                                                                                                                   | A             | Meningkatkan sosialisasi penggunaan Mobile JKN dan APM secara berkelanjutan, menyediakan petugas pendamping pada jam sibuk, memasang petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, serta melakukan monitoring jumlah pendaftaran melalui APM dan Mobile JKN sebagai indikator keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan. |

3.7.8 Permasalahan Radiologi

| NO | MASALAH                | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kerusakan part CT Scan | P             | Melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional CT Scan yang sering mengalami error mengingat usia alat telah mencapai 6 tahun dan frekuensi penggunaan yang tinggi. Menyusun rencana perbaikan bersama vendor untuk menjaga kontinuitas pelayanan radiologi.      |
|    |                        | D             | Melaporkan kerusakan kepada vendor Philips dan melakukan koordinasi dengan teknisi. Pada tanggal 30 Mei 2026 dilakukan penggantian spare part oleh teknisi Philips (Bapak Rozy) sebagai tindakan perbaikan terhadap gangguan yang terjadi selama periode 1–30 Mei 2026. |
|    |                        | S             | Setelah dilakukan penggantian spare part, dilakukan                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        |   | pengujian fungsi dan monitoring operasional alat. Hasil evaluasi menunjukkan CT Scan dapat kembali beroperasi normal dan pelayanan pemeriksaan CT Scan dapat berjalan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                      |
|   |                                        | A | Melakukan monitoring performa CT Scan pasca perbaikan, meningkatkan pelaksanaan preventive maintenance sesuai rekomendasi vendor, menyusun rencana pengadaan atau penggantian komponen kritis berdasarkan usia alat, serta mengusulkan kajian penggantian alat dalam perencanaan investasi apabila frekuensi kerusakan meningkat seiring bertambahnya usia alat. |
| 2 | Respon Time Pelayanan Radiologi >3 jam | P | Melakukan evaluasi terhadap respon time pembacaan hasil radiologi yang melebihi 3 jam, terutama pada pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi. Menyusun mekanisme percepatan pelaporan hasil untuk mendukung pelayanan pasien.                                                                                                            |
|   |                                        | D | Melakukan tindak lanjut (follow up) kepada dokter radiologi melalui media WhatsApp untuk mengingatkan dan mempercepat proses pembacaan hasil pemeriksaan yang belum tervalidasi, khususnya pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari atau di luar jam praktik.                                                                                                  |
|   |                                        | S | Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keterlambatan pembacaan sebagian besar terjadi pada pemeriksaan yang selesai setelah pukul 22.00, sehingga waktu pembacaan menyesuaikan ketersediaan dokter radiologi. Follow up melalui WhatsApp membantu mempercepat proses validasi hasil pada beberapa kasus prioritas.                                                     |
|   |                                        | A | Melanjutkan mekanisme follow up kepada dokter radiologi untuk pemeriksaan yang belum terbaca sesuai standar waktu pelayanan, menyusun kesepakatan respon time pembacaan hasil radiologi di luar jam praktik, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan respon time dokter radiologi.                                                    |

3.7.9 Permasalahan Farmasi

| NO | MASALAH                                                                                                | TINDAK LANJUT |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2025 dan belum mencapai target selisih 0. | P             | Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                        | D             | Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO)                                                                                                        |
|    |                                                                                                        | S             | Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                        | A             | Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO) :<br>Terhitung mulai Januari 2026, setiap selisih stok opname (SO), baik positif maupun negatif, wajib |



|   |                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                       |   | dianalisis penyebabnya. Apabila terbukti melibatkan unit lain, maka pembebanan selisih ditanggung oleh unit terkait bersama PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang. Jika tidak ditemukan keterlibatan unit lain, maka selisih SO langsung dibebankan kepada PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Obat tertinggal rawat 2x24 jam dan obat RF rawat inap | P | Perbaiki kebijakan obat tertinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                       | D | Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                       | S | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat tertinggal bulan Mei mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam.</li> <li>2. Menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.</li> <li>3. RF banyak yang menumpuk tidak diambil oleh pasien krs</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                       | A | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.</li> <li>2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.</li> <li>3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.</li> <li>4. PJ shift irna dan apoteker irna mengecek resep RF jika ada pasien yang belum mengambil RF, konfirmasi ruangan pasien tsb kenapa belum mengambil resep RF melalui WA, bias diambil atau meggunakan primantara</li> </ol> |
| 3 | Penambahan daftar obat near ED                        | P | Mempercepat pengeluaran barang near ED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                       | D | Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                       | S | Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                       | A | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED.</li> <li>2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3.8 Profil SDM

3.8.3 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

| NO | UNIT                  | PENDIDIKAN                             | TOTAL | JUMLAH | TETAP | TIDAK TETAP | RESIGN |
|----|-----------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|--------|
| 1  | Direktur              | Dokter Umum                            | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 2  | Kabid Pelayanan Medis | D3 Kebidanan                           | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 3  | Kabid Penunjang Medis | Profesi Ners                           | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 4  | Kabid Keperawatan     | Profesi Ners                           | 0     | 0      | 0     | 0           | 0      |
| 5  | Kabid Umum            | Dokter Gigi Umum                       | 1     | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 6  | Casemix Manager       | SMK                                    | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 7  | Farmasi               | Profesi Apoteker                       | 39    | 12     | 6     | 6           | 0      |
|    |                       | S1 Farmasi                             |       | 3      | 2     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Analis Farmasi dan Makanan          |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Farmasi                             |       | 22     | 14    | 8           | 1      |
|    |                       | SMK                                    |       | 0      | 0     | 0           | 0      |
|    |                       | S1 Manajemen                           |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 8  | Asuransi Center       | D3 Asuransi Kesehatan                  | 10    | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |       | 8      | 7     | 1           | 0      |
|    |                       | SMK                                    |       | 0      | 0     | 0           | 0      |
|    |                       | SMA                                    |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 9  | CSSD                  | D3 Keperawatan                         | 3     | 2      | 1     | 1           | 0      |
|    |                       | SMA                                    |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                                    |       | 0      | 0     | 0           | 0      |
| 10 | Fisioterapi           | S1 Fisioterapi                         | 5     | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Fisioterapi                         |       | 3      | 2     | 1           | 0      |
|    |                       | D3 Terapi Wicara                       |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 11 | Gizi                  | S1 Ilmu Gizi                           | 16    | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D4 Gizi dan Dietetika                  |       | 2      | 2     | 0           | 1      |
|    |                       | D3 Ahli Gizi                           |       | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | SMK                                    |       | 6      | 0     | 6           | 0      |
|    |                       | SMA                                    |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | SMP                                    |       | 3      | 2     | 1           | 0      |
| 12 | Humas & Marketng      | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2     | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | S1 Teknik Informatika                  |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
| 13 | ICU dan HCU           | Profesi Ners                           | 10    | 5      | 5     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Keperawatan                         |       | 4      | 2     | 2           | 0      |
|    |                       | D3 Kebidanan                           |       | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 14 | IGD                   | Profesi Ners                           | 23    | 10     | 8     | 2           | 0      |
|    |                       | D3 Keperawatan                         |       | 9      | 7     | 2           | 0      |
|    |                       | D4 Kebidanan                           |       | 2      | 2     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kebidanan                           |       | 2      | 2     | 0           | 0      |
| 15 | IKO                   | Profesi Ners                           | 11    | 7      | 7     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Keperawatan                         |       | 4      | 4     | 0           | 0      |
|    |                       | D3 Kebidanan                           |       | 0      | 0     | 0           | 0      |
| 16 | IPCN                  | Profesi Ners                           | 1     | 1      | 1     | 0           | 0      |
| 17 | IPSRs                 | S1 Tenik Elektro                       | 6     | 1      | 1     | 0           | 0      |
|    |                       | S1 Kesehatan Masyarakat                |       | 1      | 1     | 0           | 1      |
|    |                       | D3 Teknik Elektromedis                 |       | 1      | 0     | 1           | 0      |
|    |                       | SMK                                    |       | 3      | 3     | 0           | 0      |

|    |                      |                                        |    |    |    |   |   |
|----|----------------------|----------------------------------------|----|----|----|---|---|
| 18 | IRJA                 | Profesi Ners                           | 28 | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 15 | 14 | 1 | 0 |
|    |                      | D4 Keperawatan Gigi                    |    | 1  | 0  | 1 | 1 |
|    |                      | Profesi Kebidanan                      |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 19 | IRNA 2C              | Profesi Ners                           | 7  | 5  | 4  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 20 | IRNA 2A, 3A, & 4A    | Profesi Ners                           | 17 | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 9  | 6  | 3 | 0 |
| 21 | IRNA 3C Anak         | Profesi Ners                           | 12 | 4  | 2  | 2 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 8  | 7  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 0  | 0  | 0 | 0 |
| 22 | IRNA 5C              | Profesi Ners                           | 9  | 3  | 1  | 2 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 6  | 4  | 2 | 0 |
| 23 | IRNA 6A, 7A, & 8A    | Profesi Ners                           | 22 | 9  | 4  | 5 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 24 | Maternitas           | Profesi Kebidanan                      | 10 | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D4 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 7  | 7  | 0 | 0 |
| 25 | Neonatologi          | Profesi Ners                           | 8  | 3  | 2  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 4  | 4  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 26 | Keuangan & Akuntansi | S1 Ekonomi                             | 8  | 2  | 2  | 0 | 1 |
|    |                      | S1 Akuntansi                           |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | S1 Manajemen                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMK                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 27 | Laboratorium         | D4 Analis Kesehatan                    | 9  | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Analis Kesehatan                    |    | 8  | 6  | 2 | 0 |
| 28 | Laundry              | SMK                                    | 5  | 2  | 1  | 1 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 2  | 1  | 1 | 0 |
|    |                      | SMP                                    |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
| 29 | Rekam Medis          | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 8  | 8  | 8  | 0 | 0 |
| 30 | Pendaftaran          | S1 Sastra Inggris                      | 13 | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                      | S1 Kesehatan Masyarakat                |    | 1  | 1  | 0 | 1 |
|    |                      | D3 Asuransi Kesehatan                  |    | 1  | 0  | 1 | 0 |
|    |                      | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |    | 6  | 5  | 1 | 0 |
|    |                      | D1 Administrasi Perkantoran            |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMK                                    |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | SMA                                    |    | 3  | 3  | 0 | 0 |
| 31 | PIPP & MPP           | Profesi Ners                           | 4  | 0  | 0  | 0 | 0 |
|    |                      | D4 Kebidanan                           |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Keperawatan                         |    | 1  | 1  | 0 | 0 |
|    |                      | D3 Kebidanan                           |    | 2  | 2  | 0 | 0 |
| 32 | PMKP                 | Profesi Ners                           | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 33 | Radiologi            | D3 Radiodiagnostik & Radioterapi       | 6  | 6  | 4  | 2 | 0 |
| 34 | SDM                  | S1 Sosial                              | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |
| 35 | Sekretaris           | S1 Administrasi Publik                 | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 |

|                |                                                    |                             |     |     |     |    |   |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|----|---|
| 36             | SIMRS & IT                                         | S1 Teknik Informatika       | 3   | 3   | 3   | 0  | 0 |
| 37             | Umum & Rumah Tangga                                | S1 Ekonomi                  | 1   | 1   | 1   | 0  | 0 |
| 38             | Cleaning Service                                   | SMK                         | 39  | 12  | 7   | 5  | 0 |
|                |                                                    | SMA                         |     | 22  | 18  | 4  | 0 |
|                |                                                    | SMP                         |     | 5   | 5   | 0  | 0 |
| 39             | Security                                           | SMK                         | 10  | 4   | 2   | 2  | 0 |
|                |                                                    | SMA                         |     | 6   | 6   | 0  | 0 |
| 40             | Driver                                             | D1 Administrasi Perkantoran | 6   | 1   | 1   | 0  | 0 |
|                |                                                    | SMA                         |     | 4   | 3   | 1  | 0 |
|                |                                                    | SMP                         |     | 1   | 1   | 0  | 0 |
| 41             | Gudang Umum                                        | SMP                         | 1   | 1   | 1   | 0  | 0 |
| 42             | Staf Orientasi                                     | Profesi Ners                | 3   | 0   | 0   | 0  | 0 |
|                |                                                    | D3 TVF                      |     | 1   | 0   | 1  | 0 |
|                |                                                    | D3 Analis Kesehatan         |     | 1   | 0   | 1  | 0 |
|                |                                                    | SMK                         |     | 1   | 0   | 1  | 0 |
|                |                                                    |                             |     |     |     |    |   |
| Total Karyawan |                                                    |                             | 363 | 363 | 273 | 90 | 6 |
| 43             | Dokter IGD                                         | Dokter Umum                 | 9   | 9   | 0   | 9  | 1 |
| 44             | Dokter Casemix                                     | Dokter Umum                 | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 45             | Dokter Spesialis Penyakit Dalam                    | Pendidikan Dokter Spesialis | 5   | 5   | 1   | 4  | 0 |
| 46             | Dokter Spesialis Anak                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3  | 0 |
| 47             | Dokter Spesialis Bedah Umum                        | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4  | 0 |
| 48             | Dokter Spesialis Bedah Plastik                     | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 49             | Dokter Spesialis Bedah Saraf                       | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 50             | Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi          | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4  | 0 |
| 51             | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa                    | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 52             | Dokter Spesialis Mata                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3  | 0 |
| 53             | Dokter Spesialis THT                               | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 54             | Dokter Spesialis Paru                              | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3  | 0 |
| 55             | Dokter Spesialis Saraf                             | Pendidikan Dokter Spesialis | 4   | 4   | 0   | 4  | 0 |
| 56             | Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah        | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3  | 0 |
| 57             | Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology        | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 0   | 3  | 0 |
| 58             | Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin                 | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 59             | Dokter Spesialis Urologi                           | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 60             | Dokter Spesialis Anestesi                          | Pendidikan Dokter Spesialis | 3   | 3   | 1   | 2  | 0 |
| 61             | Dokter Spesialis Radiologi                         | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 62             | Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Pendidikan Dokter Spesialis | 2   | 2   | 0   | 2  | 0 |
| 63             | Dokter Spesialis Patologi Klinik                   | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 64             | Dokter Spesialis Patologi Anatomi                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 65             | Dokter Spesialis Gigi Periodontis                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 66             | Dokter Spesialis Gigi Pedodontis                   | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |
| 67             | Dokter Spesialis Gigi Orthodontis                  | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1  | 0 |

---

|                   |                                  |                             |     |     |     |     |   |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| 68                | Dokter Spesialis Konservasi Gigi | Pendidikan Dokter Spesialis | 1   | 1   | 0   | 1   | 0 |
| Total Dokter      |                                  |                             | 66  | 66  | 2   | 64  | 1 |
| Total Keseluruhan |                                  |                             | 429 | 429 | 275 | 154 | 7 |

Keterangan :  
Pada bulan Mei terdapat 5 staf dan 1 dokter resign.

---

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

#### **B. SARAN**

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian laporan bulan Mei 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Juni 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Junii 2026  
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



**dr. Resti Lestantini, M. Kes**





**LAMPIRAN**

| NO | NAMA PKS                                             | JENIS INSTANSI     | MULAI BERLAKU    | TANGGAL EXPIRED  | KETERANGAN                       | NOMOR PKS RUMAH SAKIT         | NOMOR PKS INSTANSI        |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | ASURANSI DAYIN MITRA                                 | ASURANSI           | 05 Februari 2015 | 05 Desember 2017 | PELAYANAN KESEHATAN              | PH/IKS/269/XII/2014           | 003/MKT/HLT/PKS/I/2015    |
| 2  | Batas Media 99                                       | PERUSAHAAN         | 05 Juni 2024     | 05 Juni 2027     | Pelayanan Kesehatan              | 158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024     | -                         |
| 3  | BPJS KESEHATAN                                       | ASURANSI           | 01 Januari 2025  | 31 Desember 2025 | Pelayanan Kesehatan              | 2035/E-PKS/DIR/XII/2024       | 651/KTR/VII-05/1224       |
| 4  | CV AUMERTA ANGGUN                                    | PERUSAHAAN         | 28 Agustus 2023  | 28 Agustus 2026  | PELAYANAN KESEHATAN              | 164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023 | -                         |
| 5  | ESWEJE Aesthetic Center                              | INSTANSI KESEHATAN | 01 Maret 2024    | 01 Maret 2027    | Sterilisasi alat kesehatan       | 079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024    | 9,1202E+12                |
| 6  | Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu           | AKRE               | 05 Desember 2022 | 04 Desember 2025 | Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu | 1754/E-PKS/DIR/XII/2022       | -                         |
| 7  | Indonesia Smelting Technology                        | PERUSAHAAN         | 01 Juni 2024     | 01 Juni 2026     | Rujukan Pelayanan                | 194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024     | 005/HRGA-IST/V/2024       |
| 8  | Instruktur Zumba                                     | AKRE               | 23 Februari 2024 | 23 Februari 2025 | Instruktur Zumba                 | 067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024     | -                         |
| 9  | Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso) | INSTANSI KESEHATAN | 02 Agustus 2021  | 02 Agustus 2026  | Pelayanan Laboratorium           | 429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021    | 069/PKS/PDP/VIII/2021     |
| 10 | Klinik Endisa Husada                                 | INSTANSI KESEHATAN | 01 Agustus 2023  | 01 Agustus 2026  | Rujukan Pelayanan                | 148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023  | PK/01/VII/2023-KEH        |
| 11 | Klinik Losari Medika                                 | INSTANSI KESEHATAN | 06 Februari 2024 | 06 Februari 2027 | Rujukan Pelayanan                | -                             | 021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024 |
| 12 | Klinik Pratama Beauty Medika Singosari               | INSTANSI KESEHATAN | 25 Mei 2024      | 25 Mei 2027      | Rujukan Pelayanan                | 145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024      | 001/PKS/12/2024           |
| 13 | Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care                  | INSTANSI KESEHATAN | 02 Desember 2024 | 02 Desember 2027 | Pelayanan Kesehatan              | 346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024    | 025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024 |
| 14 | Klinik Utama Medika                                  | INSTANSI           | 24               | 24 September     | Rujukan Pasien                   | 299/DPM/E-                    | -                         |

|    |                                             |                    |                   |                       |                                         |                                   |                                 |
|----|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|    |                                             | KESEHATAN          | September 2024    | 2027                  |                                         | PKS/DIR/IX/2024                   |                                 |
| 14 | Klinik Utama Rawat Jalan Akasia             | INSTANSI KESEHATAN | 25 April 2024     | 25 April 2027         | Pelayanan Kesehatan                     | 116/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2024     | 011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024      |
| 15 | Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel     | AKRE               | 14 September 2022 | 13 September 2025     | Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel | 1378/E-<br>PKS/DIR/X/2022         | -                               |
| 16 | Penerjemah Bahasa Madura                    | AKRE               | 01 Agustus 2022   | 02 Agustus 2025       | Penerjemah Bahasa Madura                | 1305/E-<br>PKS/DIR/IX/2022        | -                               |
| 17 | Penerjemah Bahasa Asing                     | AKRE               | 01 Agustus 2022   | 01 Agustus 2025       | Penerjemah Bahasa Inggris               | 1288/E-<br>PKS/DIR/IX/2022        | -                               |
| 18 | Persada Hospital                            | INSTANSI KESEHATAN | 10 Oktober 2022   | 10 Oktober 2027       | Pelayanan Kesehatan                     | 152.45//DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2022 | 1083.b.HS/MOU/X/PH-2022         |
| 19 | PMI Kabupaten Malang                        | INSTANSI KESEHATAN | 19 Agustus 2024   | 19 Agustus 2026       | Penyediaan Darah                        | 246/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2024   | 0904/02.06.28/UTD/VIII/2024     |
| 20 | PMI Kabupaten Malang                        | INSTANSI KESEHATAN | 01 Juni 2023      | 30 Juni 2023          | Rujukan Pelayanan                       | -                                 | 768/E-PKS/DIR/V/2023            |
| 21 | PMI Kota Malang                             | INSTANSI KESEHATAN | 01 Desember 2023  | 01 Desember 2025      | Penyediaan Darah                        | 1790/E-<br>PKS/DIR/XI/2023        | 2214/02.06.27/UTD/XI/2023       |
| 22 | PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB | INSTANSI KESEHATAN | 07 Februari 2024  | 26 Februari 2027      | Rujukan dan Pelayanan Penunjang         | 081/DPM/E-<br>PKS/DIR/III/2024    | -                               |
| 23 | PT AA International Indonesia               | ASURANSI           | 02 September 2019 | 02 September 2020     | Pelayanan Kesehatan Grab                | -                                 | -                               |
| 24 | PT Administrasi Medika                      | ASURANSI           | 01 Juli 2024      | 01 Juli 2027          | Asuransi                                |                                   | 071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024 |
| 25 | PT AIA Financial                            | ASURANSI           | 04 November 2020  | Perpanjangan Otomatis | Asuransi                                | No.069/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2020   | No. 639/AIA/-DPM/XI/2020        |
| 26 | PT AJ Central Asia Raya                     | ASURANSI           | 02 Juni 2017      | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan                     | 277/RSPH/E-<br>IKS/DIR/VI/2017    | DIR/PKS-RS/1455/VI/2017         |
| 27 | PT AJINOMOTO SALES                          | PERUSAHAAN         | 01 Mei            | 30 APRIL 2013         | PELAYANAN KESEHATAN                     |                                   |                                 |

|    |                                                            |                       |                         |                                         |                     |                                    |                                  |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|    | INDONESIA                                                  |                       | 2012                    | (selanjutnya<br>perpanjang<br>otomatis) |                     |                                    |                                  |
| 28 | PT Alfiza Medika Utama                                     | INSTANSI<br>KESEHATAN | 07 Maret<br>2024        | 07 Maret 2028                           | Pelayanan Kesehatan | 090/DPM/E-<br>PKS/DIR/III/2024     | 018/MOU/KAMU/07/III/2024         |
| 29 | PT Aloita Prima (Harris<br>Hotel Malang)                   | PERUSAHAAN            | 29 Juli<br>2024         | 29 Juli 2026                            | Pelayanan Kesehatan | 221/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024     | -                                |
| 30 | PT ANTARMITRA<br>SEMBADA CAB. MALANG                       | PERUSAHAAN            | 01<br>Desember<br>2024  | 01 Desember<br>2017                     | PELAYANAN KESEHATAN | 304.1.DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2024     | 344/MLG/AMS/XII/2024             |
| 31 | PT APLIKANUSA<br>LINTASARTA                                | ASURANSI              | 25<br>Februari<br>2015  | Perpanjangan<br>Otomatis                | PELAYANAN KESEHATAN | PH/IKS/100/II/2015                 | 095/LA/MOU/00300/2015            |
| 32 | PT ASABRI                                                  | ASURANSI              | 13<br>Desember<br>2023  | 12 Desember<br>2026                     | PELAYANAN KESEHATAN | 1902/E-<br>PKS/DIR/XII/2023        | PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023 |
| 33 | PT ASURANSI ADIRA<br>DINAMIKA                              | ASURANSI              | 12<br>Oktober<br>2023   | Perpanjangan<br>Otomatis                | PELAYANAN KESEHATAN | PH/E-<br>PKS/171/X/2013            | 499B/AAD-LEG-AGR/X/2013          |
| 34 | PT Asuransi Allianz Life<br>Indonesia                      | ASURANSI              | 12<br>Desember<br>2017  | Perpanjangan<br>Otomatis                | Asuransi            | -                                  | 729/AZLI-LGL/AG/XII/2017         |
| 35 | PT ASURANSI ALLIANZ<br>LIFE SYARIAH INDONESIA              | ASURANSI              | 18<br>November<br>2024  | Perpanjangan<br>Otomatis                | PELAYANAN KESEHATAN | 698.21/DPM/I-<br>PKS/DIR/IX/2024   | 391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024       |
| 36 | PT ASURANSI ASTRA<br>BUANA                                 | ASURANSI              | 01<br>September<br>2020 | 31 Agustus<br>2023                      | PELAYANAN KESEHATAN | 1033/RSPHS/E-<br>PKS/DIR/VIII/2020 | 26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020  |
| 37 | PT ASURANSI DAYIN<br>MITRA                                 | ASURANSI              | 05<br>Februari<br>2015  | 05 Desember<br>2017                     | PELAYANAN KESEHATAN | PH/IKS/269/XII/2014                | 003/MKT/HLT/PKS/II/2015          |
| 38 | PT Asuransi Jiwa Generali<br>Indonesia                     | ASURANSI              | 01<br>Oktober<br>2023   | 01 Oktober<br>2028                      | Asuransi            | 183.3/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2023     | 157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023       |
| 39 | PT Asuransi Jiwa In Health<br>Indonesia (Mandiri Inhealth) | ASURANSI              | 01<br>Februari<br>2023  | 31 Januari<br>2025                      | Asuransi            | 028.2/DPM/E-<br>PKS/DIRR/11/2023   | 0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123       |
| 40 | PT ASURANSI JIWA<br>MANULIFE INDONESIA                     | ASURANSI              | 01<br>Desember          | 01 Desember<br>2025                     | PELAYANAN KESEHATAN | 361/DPM/E-<br>PKS/DIR/XII/2024     | 331-11/EB-CONT/2024              |

|    |                                                       |            |                         |                          |                                        |                                  |                                |
|----|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|    |                                                       |            | 2024                    |                          |                                        |                                  |                                |
| 41 | PT ASURANSI MULTI<br>ARTHA GUNA TBK<br>(ASURANSI MAG) | ASURANSI   | 28 Januari<br>2020      | 27 Januari<br>2024       | RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN             | 015/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2019    | PKS-0097/XI/2019/MAG-R2        |
| 42 | PT Asuransi Reliance<br>Indonesia                     | ASURANSI   | 06<br>November<br>2024  | 06 November<br>2027      | Asuransi                               | 338/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2024    | 024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024  |
| 43 | PT ASURANSI RELIANCE<br>INDONESIA                     | ASURANSI   | 07<br>September<br>2020 | 07 September<br>2025     | PELAYANAN KESEHATAN                    | 368/DPM/I-<br>PKS/DIR/VIII/2020  | 163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020 |
| 44 | PT ASURANSI SINARMAS                                  | ASURANSI   | 01<br>September<br>2019 | Perpanjangan<br>Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                    | 010/DPM/E-<br>PKS/DIR/IX/2019    | 364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019   |
| 45 | PT ASURANSI SINARMAS<br>MSIG                          | ASURANSI   | 10<br>September<br>2012 | Perpanjangan<br>Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                    |                                  | 063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012     |
| 46 | PT ASURANSI TAFAKUL<br>KELUARGA                       | ASURANSI   | 02 Januari<br>2017      | 01 Januari<br>2020       | PELAYANAN KESEHATAN                    | 508/RSPH/E-<br>IKS/DIR/XI/2016   | 0642/PKS-RS-01/I/2017          |
| 47 | PT ASURANSI TUGU<br>KRESNA PRATAMA                    | ASURANSI   | 30<br>Oktober<br>2021   | Perpanjangan<br>Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                    | 612/RSPHS/E-<br>PKS/DIR/X/2019   | 300/PKS/DIR/TKP/X/2019         |
| 48 | PT AXA SERVICES<br>INDONESIA ( ADMEDIKA)              | ASURANSI   | 15<br>Agustus<br>2013   | Perpanjangan<br>Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                    |                                  | 067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013      |
| 49 | PT Bestari Murni Anugrah                              | PERUSAHAAN | 04 Juni<br>2024         | 04 Juni 2027             | rujukan pelayanan                      | 159/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024    | -                              |
| 50 | PT BNI LIFE INSURANCE                                 | ASURANSI   | 25 Juli<br>2016         | Perpanjangan<br>Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                    | 082/RSPH/E-<br>IKS/DIR/II/2016   | 274.PKS.BL.DIR.0716            |
| 51 | PT CAKRA SURYA<br>HUSADA                              | PERUSAHAAN | 02<br>Agustus<br>2022   | 02 Agustus<br>2025       | ASUHAN PASIEN & PELAYANAN<br>PENUNJANG | 112.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2022 | 138/MOU/VIII/CSH/2022          |
| 52 | PT Citra Karsa Dinamika                               | PERUSAHAAN | 01 Juli<br>2024         | 01 Juli 2026             | Pelayanan Kesehatan                    | 196/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024    | -                              |
| 53 | PT Docdoc Healthcare<br>Indonesia                     | ASURANSI   | 12<br>Desember<br>2024  | Perpanjangan<br>Otomatis | Asuransi                               | -                                | -                              |
| 54 | PT Equity Life Indonesia                              | ASURANSI   | 14<br>Oktober           | Perpanjangan<br>Otomatis | Pelayanan Kesehatan                    | -                                | 091/ELI/LGL/X/19               |

|    |                                           |            |                   |                       |                                                                                                    |                                 |                                        |
|----|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|    |                                           |            | 2019              |                       |                                                                                                    |                                 |                                        |
| 55 | PT EQUITY LIFE INDONESIA                  | ASURANSI   | 14 Oktober 2019   | Perpanjangan Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                                                                                |                                 | 090/ELI/LGL/X/19                       |
| 56 | PT Fullerton Health Indonesia             | ASURANSI   | 26 Agustus 2019   | Perpanjangan Otomatis |                                                                                                    | -                               | 640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019            |
| 57 | PT Global Assistance & Healthcare         | ASURANSI   | 26 Agustus 2019   | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan                                                                                | -                               | 640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019            |
| 58 | PT Green Mountains Natural Food           | PERUSAHAAN | 07 Agustus 2024   | 07 Agustus 2027       | Pelayanan Kesehatan                                                                                | 225/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024  | 01/GMN/KS/VI/2024                      |
| 59 | PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA         | ASURANSI   | 16 Maret 2015     | 15 Maret 2016         | PELAYANAN KESEHATAN                                                                                |                                 | 0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015             |
| 60 | PT Indo Aneka Atsiri                      | PERUSAHAAN | 07 Agustus 2024   | 06 Agustus 2027       | Pelayanan Kesehatan                                                                                | 222/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024  | 066/IAA/HRGA/VI/2024                   |
| 61 | PT INDOLAKTO PANDAAN                      | PERUSAHAAN | 10 Januari 2014   | Perpanjangan Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                                                                                |                                 |                                        |
| 62 | PT Indonesia Marine                       | PERUSAHAAN | 10 September 2024 | 10 September 2027     | Pelayanan Kesehatan                                                                                | -                               | -                                      |
| 63 | PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS   | VENDOR     | 03 Oktober 2022   | Perpanjangan Otomatis | PELAYANAN KESEHATAN                                                                                | 150/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2022    | 953/ISPC/PKS/X/2022                    |
| 64 | PT JASA RAHARJA                           | ASURANSI   | 04 Juli 2022      | 04 Juli 2027          | PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN | 912.1/E-<br>PKS/DIR/VII/2022    | P/13/SP/2022                           |
| 65 | PT Java Smartindo                         | PERUSAHAAN | 01 Agustus 2020   | Perpanjangan Otomatis | Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan                                                            | 364/DPM/I-<br>PKS/DIR/VIII/2020 | PKS.TPA-<br>JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C |
| 66 | PT JAYA OBAYASI                           | PERUSAHAAN | 01 Juli 2020      | 01 Juli 2025          | PELAYANAN KESEHATAN                                                                                | 360/DPM/I-<br>PKS/DIR/VIII/2020 |                                        |
| 67 | PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza) | ASURANSI   | 17 Juli 2020      | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan                                                                                | 034/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020  | 092/KBM-DPM/PKS/VII/2020               |
| 68 | PT LABBIOGEN ARTHA                        | INSTANSI   | 02                | 01 September          |                                                                                                    | 262/DPM/E-                      | B-MKT 01/001/623/VII/2024              |

|    |                                     |            |                   |                       |                                    |                                               |                                              |
|----|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | MEGA                                | KESEHATAN  | September 2024    | 2027                  |                                    | PKS/DIR/VIII/2024                             |                                              |
| 69 | PT MALANG INTERMEDIA PERS           | PERUSAHAAN | 01 Juli 2020      | 01 Juli 2025          | PELAYANAN KESEHATAN                | 025/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020                | 103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020                 |
| 70 | PT Medilink Digital Media           | ASURANSI   | 22 Maret 2024     | 22 Maret 2027         | Pelayanan Kesehatan                | 09/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2024                  | 229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024                   |
| 71 | PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI           | ASURANSI   | 28 November 2016  | Perpanjangan Otomatis | APLIKASI LAYANAN KESEHATAN         | 150/PKS-<br>RSPRIMAHUSADA-<br>MAT/DIR/XI/2016 |                                              |
| 72 | PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL        | ASURANSI   | 08 Juli 2024      | 08 Juli 2027          | PELAYANAN KESEHATAN                | 200/DPM/E-<br>PKS/DIR/2024                    | 001/MSI/VI/2024                              |
| 73 | PT PAN PACIFIC INSURANCE            | ASURANSI   | 31 Agustus 2020   | 31 Agustus 2023       | PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN | 017/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020                | 0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS-<br>PHMS/VIII/2020 |
| 74 | PT PANCAMAS ELITE                   | PERUSAHAAN | 12 Juni 2024      | 12 Juni 2027          | Pelayanan Kesehatan                | 172/DPM/E-<br>PKS/DIV/VI/2024                 | -                                            |
| 75 | PT PANCAMAS ELITE                   | PERUSAHAAN | 01 Juli 2020      | 01 Juli 2025          | PELAYANAN KESEHATAN                | 032/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2020                |                                              |
| 76 | PT PLN (Persero)                    | ASURANSI   | 02 Juli 2024      | 31 Desember 2025      |                                    | 261/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2024               | 0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022           |
| 77 | PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS | ASURANSI   | 17 September 2018 | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan                | 735/E-<br>PKS/DIR/IX/2018                     | 296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018                   |
| 78 | PT Prudential Life Assurance        | ASURANSI   | 28 Januari 2021   | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan                | 047/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2020               | 1578/PMN-PLA/XI/2020                         |
| 79 | PT Suprima Mitra Adihusada          | ASURANSI   | 26 Agustus 2019   | Perpanjangan Otomatis | Asuransi                           | -                                             | 640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019                |
| 80 | PT TASPEN (PERSERO)                 | ASURANSI   | 11 Juni 2024      | 10 Juni 2026          | Program Jaminan Kecelakaan Kerja   | 110/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2024                 | JAN-09/C.5.1/2024                            |
| 81 | PT TASPEN (PERSERO)                 | ASURANSI   | 01 Januari 2023   | 31 Desember 2025      | Program Jaminan Kecelakaan Kerja   | 008/E-<br>PKS/DIR/II/2023                     | JAN-01/DIR/2023                              |
| 82 | PT TIRTA INVESTAMA                  | PERUSAHAAN | 31 Agustus 2020   | 31 Agustus 2025       | PELAYANAN KESEHATAN                |                                               |                                              |
| 83 | PT Tonggak Ampuh                    | PERUSAHAAN | 31 Agustus 2024   | 31 Agustus 2027       | Pelayanan Kesehatan                | 263/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2024               | -                                            |

|    |                                               |                    |                  |                       |                     |                                   |                                |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 84 | PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA                   | PERUSAHAAN         | 01 Agustus 2023  | 31 Juli 2026          | Pelayanan Kesehatan | 150.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2023 | 050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023  |
| 85 | PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT    | PERUSAHAAN         | 27 Oktober 2020  | Perpanjangan Otomatis | Pelayanan Kesehatan | 1076/RSPHS/E-<br>PKS/DIR/IX/2020  | 002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020   |
| 86 | PT Unggul Anugrah Sejahtera                   | PERUSAHAAN         | 04 Juni 2024     | 04 Juni 2027          | Rujukan Pelayanan   | 160/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024     | -                              |
| 87 | PT Uniplastindo Interbuana                    | PERUSAHAAN         | 29 Juli 2024     | 29 Juli 2027          | Pelayanan Kesehatan | 224/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024    | -                              |
| 88 | PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA | PERUSAHAAN         | 04 Januari 2021  | 04 Januari 2024       | PELAYANAN KESEHATAN | 303/DPM/I-<br>PKS/DIR/VI/2021     | 002/PKS-COB/I/2021             |
| 89 | PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA | PERUSAHAAN         | 22 Maret 2024    | 22 Maret 2027         | PELAYANAN KESEHATAN | 183/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024     | 014/PKS-COB/III/2024           |
| 90 | PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)   | PERUSAHAAN         | 01 Juni 2022     | 01 Juni 2025          | PELAYANAN KESEHATAN | 004/DPM/E-<br>PKS/VI/2022         | /YMPI/II/PKS/VI/2022           |
| 91 | PT Yanmar Diesel Indonesia                    | PERUSAHAAN         | 15 April 2024    | 15 April 2027         | Pelayanan Kesehatan | 108/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2024     | 107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024      |
| 92 | PT Zurich Asuransi Indonesia TBK              | ASURANSI           | 25 Juni 2024     | 24 Juni 2029          | Asuransi            | 151/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024     | 268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024        |
| 93 | RS Islam UNISMA Malang                        | INSTANSI KESEHATAN | 01 Januari 2024  | 31 Desember 2026      | Rujukan Pelayanan   | 222.11/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2023  | 08/PKS/RSI-4/I/2024            |
| 94 | RS Lavalette                                  | INSTANSI KESEHATAN | 07 Agustus 2024  | 07 Agustus 2027       |                     | 236/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2024   | DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138 |
| 95 | RS Prima Husada Sukorejo                      | INSTANSI KESEHATAN | 01 Oktober 2022  | 01 Oktober 2025       | Pelayanan Kesehatan | 1376/E-<br>PKS/DIR/X/2022         | 1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022    |
| 96 | RS Siti Miriam Lawang                         | INSTANSI KESEHATAN | 31 Agustus 2024  | 31 Agustus 2027       | Pelayanan Kesehatan | 264/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024    | 566/HMS/RSSM/VIII/2024         |
| 97 | RSIA Puri Bunda                               | INSTANSI KESEHATAN | 06 Februari 2024 | 06 Februari 2026      | Rujukan Pelayanan   | 020/DPM/E-<br>PKS/DIR/II/2024     | 001/PKS/PB/II/2024             |

|     |                                                  |                    |                   |                     |                                                 |                                  |                                  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 98  | RSUD Bangil                                      | INSTANSI KESEHATAN | 22 Juli 2024      | 22 Juli 2027        | Rujukan Pelayanan                               | 222/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024   | 400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024 |
| 99  | Yayasan Bhakti Luhur                             | AKRE               | 05 Desember 2022  | 04 Desember 2025    | Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen              | 1753/E-<br>PKS/DIR/XII/2022      | -                                |
| 100 | RS PANTI NIRMALA                                 | INSTANSI KESEHATAN | 07 Oktober 2022   | 06 Oktober 2025     | PELAYANAN RUJUKAN                               | 152.44/DPM/E-<br>PKS/DIR/XI/2022 | 3740/069/RSPN/X/2022             |
| 101 | PKM SINGOSARI                                    | INSTANSI KESEHATAN | 12 April 2022     | 12 April 2027       | TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS               | 593/I-<br>PKS/DIR/IV/2022        | 440/894/35.07.103.135.2022       |
| 102 | KLINIK IDAMAMUK                                  | INSTANSI KESEHATAN | 16 Juni 2021      | PERPANJANG OTOMATIS | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG | 347/DPM/I-<br>PKS/DIR/VII/2021   | ..../005/VI/2021                 |
| 103 | KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI             | INSTANSI KESEHATAN | 15 April 2023     | 15 April 2026       | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG | 107.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/IV/2023  | 031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023      |
| 104 | KLINIK TIRTO HUSADA                              | INSTANSI KESEHATAN | 18 September 2023 | 18 September 2026   | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG   | 176.3/DPM/E-<br>PKS/DIR/IX/2023  | 015.004/KTH/IX/2023              |
| 105 | KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG         | INSTANSI KESEHATAN | 01 Desember 2023  | 32/11/26            | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG   | 241.2/DPM/E-<br>PKS/DIR/XII/2023 | 023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023   |
| 106 | DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA              | INSTANSI KESEHATAN | 02 Desember 2024  | 02 Desember 2029    | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                     | 347/DPM/E-<br>PKS/DIR/2024       |                                  |
| 107 | DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO      | INSTANSI KESEHATAN | 02 Desember 2024  | 02 Desember 2029    | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                     | 348/DPM/E-<br>PKS/DIR/XII/2024   |                                  |
| 108 | RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG            | INSTANSI KESEHATAN | 30 Oktober 2023   | 30 Oktober 2026     | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                     | 220.1/DPM/E-<br>PKS/DIR/X/2023   | HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023    |
| 109 | RSUD DR SAIFUL ANWAR                             | INSTANSI KESEHATAN | 01 November 2024  | 01 November 2026    | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                     | 234/DPM/E-<br>PKS/VIII/2024      | 400.14.5/7499.1/102.7/2024       |
| 110 | KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA | INSTANSI KESEHATAN | 23 Januari 2024   | 22 Januari 2027     | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG   | 001.34/DPM/E-<br>PKS/DIR/I/2024  |                                  |
| 111 | PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T         | INSTANSI KESEHATAN | 05 Agustus 2024   | 05 Februari 2027    | RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG   | 221/DPM/E-<br>PKS/DIR/VII/2024   |                                  |



---

|     |                                                                |                    |                 |                 |                                            |                                 |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 112 | RSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG                            | INSTANSI KESEHATAN | 05 Agustus 2024 | 22 Agustus 2027 | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                | 248/DPM/E-<br>PKS/DIR/VIII/2024 | 081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024 |
| 113 | IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH                     | INSTANSI KESEHATAN | 14 Juni 2024    | 14 Juni 2027    | RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN                | 180/DPM/E-<br>PKS/DIR/VI/2024   |                              |
| 114 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG | INSTANSI KESEHATAN | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 | PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT | 2053/E-<br>PKS/DIR/XII/2024     | 100-3-7/103/35-07-313/2025   |
|     |                                                                |                    |                 |                 |                                            |                                 |                              |